

闻过喜辑

蒋心华题



田爱华等著

刘燕玲 马璇卿

马继松 彭绍荣

香港天马图书有限公司

闻过喜医辑

WEN GUO XI YI JI

责任编辑：洪光林
特约编辑：王贵森
封面设计：顾平
责任校对：马继松

内容简介

本书分经典著作研究、前贤学术评析、名医经验精华、内、五官科求索、古今方剂应用、奇难医话医案6卷，大多为作者们发表在省级以上学术刊物及学术会议上的交流之文，翔实地记载了他们临证与教学之心得及师随当代一些名医学习的体会。既有对中医传统理论之新见，更不乏对内科、五官科、妇科等一些常见、多发及疑难病证辨治之高招，可供临床、教学与科研方面的中医药工作者借鉴，尤适合初涉医海的青年中医药者或中西医结合医生。

ISBN 962-450-183-1



9 789624 501834

ISBN 962-450-183-1/D.41278

定价：17.00 元

闻过喜医辑

蒋心年题



马继松 彭绍荣

刘燕玲 马璇卿

田爱华等著

香港天马图书有限公司

内容简介

本书分经典著作研究、前贤学术评析、名医经验精华、内、五官科求索、古今方剂应用、奇难医话医案 6 卷,大多为作者们发表在省级以上学术刊物及学术会议上的交流之文,翔实地记载了他们临证与教学之心得及师随当代一些名医学习的体会。既有对中医传统理论之新见,更不乏对内科、五官科、妇科等一些常见、多发及疑难病证辨治之高招,可供临床、教学与科研方面的中医药工作者借鉴,尤适合初涉医海的青年中医药者或中西医结合医生。

闻过喜医辑

马继松等著

出版发行:天马图书有限公司(香港上水新成路 93 号)

电 话:26706633 26701382 传真:26701382

书名题字:蒋正华

印刷单位:核工业华东二七一印刷厂

(安徽省芜湖市 502 信箱,邮编:241000)

规格开本:1092×787 毫米 1/32

印 张:10.2

字 数:238 千字 插页:2

版 次:2000 年 9 月第 1 版

印 次:2000 年 9 月第 1 次印刷

册 数:1800 册

国际书号:ISBN 962-450-183-1/D. 41278

定 价:17 元

翻
印
必
究



版
權
所
有

健松耽勤奋如学，博览医籍，钻研
经典，深究岐黄，理论联系实际，讲学
引人入胜。又致力於临床，力挽沉
痾痼疾。并予友子，临证之论，奋笔
著述，佳稿叠呈，理迪良友。今汇集
成册，名《句已喜医粹》，刊梓梓印问世，
喜其道之不孤，愿书数语，以为同道
介也！

一〇四
李士杰题
个德新二月于海内



大作出版誌禧

繼松匠師勤奮政
著述撰文抒新意
教者育人才傳技
聞過喜匡輟廣流傳

謝海州  敬賀
二〇〇〇. 三. 三.

序 一

马君继松，早年毕业于安徽中医学院，后执教于安徽芜湖中医学校，现任该校高级讲师。他在三十多年间；一方面手执教鞭，精心培育桃李，一方面坚持临床探索，理论联系实际，将刻苦钻研、勤于笔耕贯穿于始终，先后撰写了大量的中医药学术论文，陆续发表于全国各地中医药学术刊物，其中不乏真知灼见，独到见解，颇能启迪同仁思路。

今马君收集过去发表的部分论文，参入自己未曾发表的新著和临床经验实录，编纂为《闻过喜医辑》见示于余，首先感到此辑命名为《闻过喜》，体现了作者乐于接受批评和意见的谦虚态度。细究该辑内容，具有很多特色：就其医论而言，不拘格调，分列专题讨论，说理比较透彻；就其医话而言，是在实践医事基础上的升华，语言活泼而贴切；就其方剂应用而言，无论古方或新方，均能法古而会今；就其疑难杂证病案而言，案案辨析入微，理法方药击中肯綮，颇能启发临床者的灵思。总之，该辑有理论阐述，有实践体会，有解难答疑，亦有直接师从当代名老中医的学习心得，故很适合中医药院校学生和初涉临床的中医师作参考。

我与马君文字交往始于八十年代初。那时我在《江苏中医》任职，马君撰写《“乌头(或附子)反半夏”析疑》一文投寄本刊，读后颇觉有新意，即于1981年录用发表。该文列举文献和临床的实例，论证了乌头或附子与半夏配伍应用，非但没有反作用，而且有相得益彰之功，从而对于垂传千年的“本草十八反”之说，重新作出了切合实际的评价，实令读者耳目一新。

后来，鄙人主编《实用方剂辞典》，曾邀马君参加编写，他在编写过程中虚怀若谷，反复发问，几番试写样稿，表现了脚踏实

地、一丝不苟的精神。

马君给我最深的印象是“笃实”二字，有时言辞虽有偏激之处，但毕竟其人耿直无邪，这与当今四面玲珑、左右逢迎者相较，大有天壤之别。

读罢《闻过喜医辑》有诸多感想，今略疏一二如上，权充作序。

缪正来

二〇〇〇年五月写于南通

序 二

我的朋友中，有原先关系不错，后因升官、调动，联系很少，直到冷落的；有不因你升迁而奉承，不因你落魄而疏远的，马继松就属于后者之一。

认识马继松，是1988年在全国第二届中医治则学术研究会上，他作为安徽省代表在大会上交流，只见年近半百的他，庄严的额上分布着气概不凡的纹缕，丝丝过早显现的华发，反映出其人生经历的坎坷和对事业的执着追求。由于我俩都是中专卫校讲师，同样的中医专业，同样的爱动笔墨的志趣，加上相互已闻其名，互相认识作品，虽初次谋面，却一见如故，畅所欲言。

毕竟是全国性会议，个个西装革履，风度不凡，继松却衣着朴素。同行告诉我：“马老师不仅医术高明，且有一副乐于助人的热心肠，早年在基层医院工作时，常用微薄的工资解决病人的医药困难，而他自己则过着俭朴的生活。对病人却待如亲人。有一次一位来自上海的精神病患者，精神和肉体的折磨，加上多方求医未效，使她失去治疗信心，几次欲走轻生之路。陪同来诊的姐姐也是抱着“死马权当活马医”的侥幸心态。马医生在问诊中，发现病人反应冷漠，闷声不语，意识到在如此心态下进行救治，是十分困难的。为此，他从侧面打听病人的兴趣爱好，动之以情，晓之以理，使患者高度紧张的戒备心理放松了，终于敞开心扉，打开话匣，畅快地叙述发病情况。由于医患的密切配合，加上对症下药，这个缠绵难愈的老大难获得了治愈。同行一席话，使我领悟到马医生那“功夫在诗外”的技巧，和治病救人的满腔热忱。

医之为道，道长无尽。渐渐在医坛声誉鹊起的马继松，不辞年近，雄心勃勃，为编《伤寒论》教材，他战三伏，冒严寒；为整理

《现代名医医案选析》，兴致高涨时，竟忘了晨昏朝暮，走过了十年辛苦不寻常的历程，出版后很快销售一空。

在芜湖中医学校，师生们称马继松一家是“写作专业户”，妻子田爱华、女儿马静卿都乐于笔耕，夫妻专于论文，女儿强于散文，（88年高考中，曾以抒情散文形式撰写《习惯》，作文竟获满分，被母校安徽师范大学附属中学一时传为佳话）。其子马璇卿92年电大毕业后，舍工学医，已获中医自考大专文凭，现正利用上班余暇，攻读西医大专，受家人影响，亦时有文章见诸报端。

马继松早在1983年就参加中国农工民主党第九次全国代表大会，与中央领导合影，1989年被评为市级政协先进个人，1995年被推选为安徽省第一个少数民族知识分子联谊会副会长，事迹被编入中央统战部主编的《中国少数民族专家学者辞典》等大型工具书中。

伴随着改革开放的洪流，人们的价值观、金钱观都在发生剧变，马继松这位高级讲师却不改初衷，以奉献为毕生愿望，继续在人生的轨辙上寻找自己的归宿。

（王贵森摘自所著《红叶情思》以代序。德宏民族出版社，1997年6月第1版，86页）

序 三

马继松是皖南较杰出优秀的中医人士，从事中医医疗、教学工作三十余载，博览群书，海人不倦，对待中医事业更多热诚之至。继松学兄自幼工文，治学严谨，笔力雄健，暇时即将其心得整理成文，载诸医刊；其医论医话有理有证，古方新用巧验临床。今《闻过喜医辑》所集之文，采各家大论，师古不泥古，补前贤之不足；且锐意独创，求新不求奇，发翔实之可信。其阐释中医真谛，介绍独特效验，将大助于仁人学者。所作所为有利于中医药学的振兴和发展，诚可谓医界上乘之作。

蒙继松学兄不弃，问序于余，写数言，虽有滥竽之嫌，然致钦敬之意，并为其广荐之。

安徽中医学院 吴华强

两千年于合肥

前 言

余心仪中医久矣！缘少幼每当咽喉肿痛发热，咽饮困难时，家母便携余至长街一老妪处，她用根短银针，将耳垂与大姆指甲旁刺破挤出点血，又用张加了点蝎粉的小膏药贴于项后，半日许则愈，令余惊奇难已。故60年高考便欲报考中医学院，憾长文短理，在班主任多次劝阻下报考了文史类。62年有幸二次参加高考，实现了夙愿，故大学中的努力是可想而知了。64年9月后，去蚌埠医学院实习，见中医之患者如云，9月30日钟平石、朱希亨两位教授竟看了310人，益增我学好中医之信心，此时余常去爱生如子且藏书数千册的钟老家，在他指导下开始了对教材外医书的阅读，抄录了他的大量病案和一部以赋体所写的《证治针经》，憾文革中均被付之一炬。

68年底，余被分至与江苏接壤的郎溪县毕桥公社医院，在老药师谢光禄和其弟子尹维华指导下，不仅认识了400多种中药饮片，也初步掌握了“溧水帮”的中药炮制技术，了解了“医药一家”之理。并有幸结识了名噪宣（城）、郎（溪）、广（德）的胡翘武老中医，向他学到了诸如诊脉当“男右女左”等不少书中鲜见提及而于临证却大有裨益的知识。

70年调芜湖县后，得以利用去市内探视父母之机而光顾书店。随购书之日增，渐生撰文投稿之想。经八年艰辛，处女作《“乌头（或附子）反半夏”析疑》蒙缪正来编辑青睐，终被《江苏中医》刊用。将首笔稿酬购得《章次公医案》，章公脉案对主症之突出，辨治之清晰，用药之奇妙，令余拍案叫绝，故连写7篇读后感，邮该书执笔者朱良春老中医。他在百忙中对每篇都提出修改意见，使余写作水平有较大提高。

82 年余正式调入芜湖中医学校，一直难以安定的小家（我和爱人各调动了 5 次单位）总算团聚了，随着对名医医案阅读及发表文章之增多，我遂约数名同道著编了《现代名医医案选析》，不仅销售之快出乎意料，且收到很多读者所寄热情洋溢的鼓励、鞭策之信，结交了不少道友。故后来只要在临床或读书中有了体会，即笔之于文。92 年后由于多种使杂志社难言之苦衷，投稿得交版面费，且有与年俱增之势，故此后所写之文均束之高阁矣。去年暑假家中打扫卫生，对数十斤杂乱文稿之处理颇伤脑筋，恰彭绍荣造访，言不如将未收入书中之文汇编成册，且表示愿助一臂。我以为善，又致函任北京中医药大学硕导之外甥韩刚，其爱人刘燕玲亦愿参与。故经年余努力，这本原只能孤芳自赏的小册子终于即将付梓。然余自知水平有限，加之参写者较多，书中谬误定不会少，思及《孟子·公孙丑》言：“子路，人告之已有过则喜”，故尔命名《闻过喜医辑》，乃恳望读者能不吝赐教，幸甚！幸甚！

浙江中医学院林乾良教授赴日讲学时，“深感日本汉方是顽固的经方派，如果不是以条文来说话，他们就认为水平不高”^{〔注〕}，中医若想走出国门，必需加强对经典和前贤著作的学习，故有了拙著的一、二卷之作；卷三除关幼波治痰文外（因余临证对痰的辨治饶有兴趣，故将这篇读书体会亦收入），均为笔者们随师学习之真实笔录；后三卷皆为余全家临证一己之得失。

友刘旭曾赠我与爱人一付对联：“继岐黄澡雪精神，用仁术、济世人，寿柏永松；爱百草疏瀹脏腑，研本经、穷方药，含英咀华”，在拙著面世之际，即将退休且数病缠身之余愿以此联与中医药界道友共勉之；并衷心祝愿中医药界莘莘学子，乘世界医药回归自然之风，给祖国中医药事业增添更大之辉煌。

承蒙全国人大副委员长、中国农工民主党中央委员会蒋正

华主任委员,著名中医药家朱良春老恩师、中国中医研究员谢海州教授,在百忙中为拙著题签书名或题辞;原南京中医药大学教授、缪正来主任医师、浙江省文成县卫校原校长王贵森高级讲师、安徽中医学院原科研处处长吴华强教授拨冗作序;南京中医药大学周仲英老校长的博士生陶夏平主治医师欣然写跋;南京艺术学院美学系顾平博士挥毫设计封面,在此一并表示衷心谢意。芜湖卫校退休老中医承忠委高级讲师、中国中医研究院西苑医院陈立华主任医师、北京中医药大学张秋霞博士、曾任《健康报》祖卫版编辑、现在美工作的冉铁中医、我校储成志老师、谢祖俭主治医师以及曾是我学生的湖南中医学院毛以林博士、马鞍山市医院李开屏硕士、宁国市卫生局副局长王世峰、南陵县卫生局副局长朱华、合肥仁和医院贺建军三位主治医师、武汉武警部队 05 医院郎晓闽、天长市医院赵庆元、南陵县黄塘医院孙秋生、宁国市港口医院黄宗炎、怀宁县三院方六文、南陵县中医院钱斌、太湖县徐桥区医院孙华荣、庐江胜岗医院夏小艾、六安市城南医院汪晓辛、阜南县白鹤鸣等医师参与撰文或整理,在此一并致谢。并同时向犬子马璇卿医师的带教老师李行安、蔡云生、朱琬华、蒋熙、朱建平、戴俭国、余建华、来忠、强刚、李振等临床医家致以衷心谢忱。

[注]:王贵森著《岁月涛声》59 页。香港天马图书有限公司,1999 年 4 月第一版。

(马继松丙辰仲秋于芜湖市邢家山 7 号安徽中医药学校)

目 录

卷一 经典著作研究

- 一 “乌头(或附子)反半夏”析疑…………… (1)
- 二 论肝咳…………… (5)
- 三 “三因论”病因分类法之质疑…………… (9)
- 四 少阳病病位之索隐…………… (15)
- 五 浅论张仲景的活血化瘀法及对后世之贡献…………… (21)
- 六 对张仲景运用细辛组方的学习札记…………… (29)
- 七 张仲景应用厚朴的经验发微…………… (33)
- 八 试论张仲景对牡蛎的运用…………… (40)
- 九 张仲景用黄芩清热作用之初探…………… (44)

卷二 前贤学术评析

- 一 程钟龄治痰探析…………… (48)
- 二 吴鞠通治痰饮病浅探…………… (52)
- 三 金子久辨治痰饮病特色…………… (59)
- 四 雷少逸治痰病纲要…………… (62)
- 五 雷少逸治泻痢说约…………… (67)
- 六 陈素庵调经学术思想咨諏…………… (71)
- 七 章次公先生治胃病萃要…………… (77)

卷三 当代名医精华

- 一 朱良春对痹证辨治之建树…………… (82)
- 二 关幼波治痰经验撮粹…………… (90)
- 三 关茂会治慢性肝炎综合疗法之剖析…………… (94)
- 四 聂惠民用小柴胡汤治内伤杂证之钩元…………… (98)
- 五 聂惠民用经方治慢性萎缩性胃炎的几个法则……………
…………… (103)

六	聂惠民用“合方”治冠心病之辨义·····	(107)
七	胡翹武临床经验鳞爪·····	(110)
八	李传方对尿石病辨证与辨病相结合的治疗思路·····	(117)
九	朱良春用牛角腮经验发微·····	(125)

卷四 内、五官科求索

一	寒热错杂症的辨证论治·····	(131)
二	从肾论治汗证管见·····	(136)
三	辨治老年人咳嗽之浅见·····	(142)
四	100例肝硬化相关因素分析·····	(147)
五	浅谈脂肪肝的中医药治疗·····	(151)
六	前列腺炎勿忘治肝·····	(156)
七	刍议泌尿系结石·····	(159)
八	大黄在中医五官科疾病中的应用·····	(163)
九	健脾益气法治五官科病拾零·····	(170)
十	“上病下取”治则在眼科的应用心悟·····	(174)
十一	理气法在眼科的应用举隅·····	(179)
十二	益肾健脾治外障·····	(184)
十三	从角膜炎外治引起反复试析冰片非寒·····	(188)
十四	喉暗治验四则·····	(191)

卷五 古今方剂应用

一	桂枝芍药知母汤应用体会·····	(196)
二	温脾汤应用心得·····	(202)
三	全真一气汤运用述要·····	(207)
四	复方四逆散运用摭拾·····	(215)
五	新制八白汤应用掇英·····	(224)
六	清化活血汤运用琐言·····	(232)

- 七 附马芪鹿二藤汤治痹症之发挥…………… (237)
- 八 昆蛎桔半汤治疗梅核气…………… (245)
- 九 清肺益肾汤治小儿遗尿…………… (247)

卷六 奇难医话医案

- 一 药得奇效话“瞑眩”…………… (250)

二 癫狂医话四则

- 1、细询病因，巧配开导，疏肝活血愈病…………… (254)
- 2、耐心观察，结合季节，芳化淡渗收功…………… (255)
- 3、“成竹”横梗，误虚为实，苦寒迭进症剧…………… (257)
- 4、过于“夺食”，医嘱欠详，狂证衰竭而亡…………… (258)

三 医难为医话十四则

- 1、湿温未尽愈，违医嘱，“食复”骤变…………… (258)
- 2、已孕斑经至，投活化，误使胎坠…………… (259)
- 3、处方潦草，乳香过量致呕…………… (260)
- 4、药物霉变，大黄下咽即吐…………… (261)
- 5、5剂附子一剂服，病人腹泻难起…………… (262)
- 6、6帖乌头分未均，患者鼻衄如注…………… (263)
- 7、广地龙未洗净，忘炮制，欲降压反升…………… (263)
- 8、马钱子没写“制”，付生品，治痿证生疑…………… (264)
- 9、忽视旋复花降车速，治呃逆却气坠欲脱…………… (266)
- 10、未料苦桔梗升散猛，疗咽疼致耳胀流脓…………… (266)
- 11、不知茯苓会过敏，重用其安神，更心烦意乱…………… (267)
- 12、畏于蜈蚣过峻烈，坚辞不服用，使顽痹难痊…………… (268)
- 13、误认药有效求再服，肿虽消却致母嬰亡…………… (269)
- 14、患眼疾失治视力降，服偏方加速双目盲…………… (270)

四 疑难病案二十五则

- 1、哮喘(肺气肿)…………… (271)

2、咳血(支气管扩张,肺结核)	(272)
3、口疮(复发性口疮)	(275)
4、嘈杂(返流性食道炎)	(277)
5、呕吐(贲门失弛缓症)	(278)
6、胃痛(胃下垂)	(279)
7、泄泻(慢性结肠炎,肠痉挛)	(280)
8、便秘	(283)
9、腹痛(慢性附件炎、虫证)	(284)
10、胁痛(胆道结石)	(285)
11、急黄(急性黄疸性肝炎)	(287)
12、胸痹(冠状动脉粥样硬化性心脏病)	(288)
13、不寐(失眠)	(290)
14、中风(脑血栓形成)	(291)
15、水肿一(急性肾炎?)	(292)
16、水肿二(肾性高血压)	(293)
17、热淋(急性尿路感染)	(294)
18、石淋一(输尿管结石)	(295)
19、石淋二(输尿管结石)	(296)
20、消渴(糖尿病)	(297)
21、鼻咽癌	(299)
22、颈痈(急性淋巴结炎)	(300)
23、瘰病(甲状腺功能亢进)	(301)
24、乳房(少男乳房发育症)	(302)
25、面尘(黄褐斑)	(303)
跋 医道修远 执着求真——记马继松高级讲师	
..... 陶夏平	(306)

卷一 经典著作研究

一 “乌头或附子反半夏”析疑

中药十八反是一个传统的中药配伍禁忌问题。记载十八反具体药物的古典医籍不下数十余种,所列相反药物也各有出入,但都认为:“凡属相反的药物不宜合用,否则会发生剧烈的副作用(即剧毒反应)^[1]。”解放后出版的《中医学概论》、《中药临床应用》等书,甚至在全国高等医学院校统一教材中,也都提出了同一看法。虽然近来杂志上关于“相反”药物可以同用的报导日益增多,但很多同道对十八反药物的同用问题仍心存疑虑。为进一步促进中药药性理论研究的开展,并为某些沉痾痼疾挖掘新的有效治疗方药,对十八反中相反药物同用问题,有必要认真作一深入细致的研究工作。由于不论哪本书所论十八反的内容中,均有乌头(或附子)反半夏,且二药又是最常用的中药,故笔者不揣浅陋,就此二药是否“相反”略陈管见。

一千八百年前,杰出的医学家张仲景就曾大胆地将此二药同用于一方中。在《金匮要略》中,除创制了治腹痛呕吐的附子粳米汤外(此方系附子和半夏同用),还创制了治寒气厥逆的“赤丸”(此方系乌头和半夏同用)。后世医家根据仲师之意,将二药同用以治“寒疝”和腹痛呕吐证者不乏其人。如陈修园创制的“疝症统治方”,即由二陈汤合五苓散加小茴、木通、金铃子组成;加减法中则云:外寒重者,加干姜、附子(注意,此处在加附子的同时,未云去半夏)。在其所著《南雅堂医案》中,就载有此类验案。《清代名医医话精华》中,亦载有许珊林用理中汤加生附子、半夏、吴萸,治何世全寒疝一案;《柳选四家医案》中,也载有曹仁

伯用大建中汤加附子、半夏、桔饼,治“中阳虚弱,厥阴寒疝潜逆,腹痛筋急,便坚呕吐”一案。至于二药同用治腹痛的验案则更多,仅《王旭高医案》脘腹痛门 22 案中就有四案是附子和半夏同用的。

随着医学的不断发展,很多医家还认为此二药同用有“相反相成”之功,将其合用治多种疑难杂证。如许叔微之治中风^[2],张石顽之治哮喘^[3],林佩琴之治遗精^[4],张仲华之治奔豚气^[5],王旭高之治噎膈和痰饮^[6],吴谦之治外科溃疡后导致的呃逆^[7],徐小圃之治儿科麻疹内陷、麻疹并发肺炎及湿温^[8],付仁宇之治眼科绿风内障^[9],近代中医名家李继昌之治疟疾^[10],蒲辅周之治高血压^[11],叶桔泉之治胃积水^[12],马龙伯治妇科经闭^[13],以及高乐众之治痹证^[14]等均属之。亦有将二药合用以治积聚^[15]、内伤虚劳^[16]、癫痫^[17]及合它药做成膏药外敷治关节麻木疼痛^[18]等证,或外敷作麻醉药用的^[19]。近贤丁甘仁尤善将此二药相合,不仅广泛用治内伤疾病,且大胆用治各类急性时令病,取桴鼓相应之效。在《丁甘仁医案》伤寒门十六个治案中,就有五案是二药合用的。

笔者 1968 年在郎溪县亲见我省名老中医胡翘武将乌头、半夏和瓜蒌同投于一方,连用二十余剂,治愈一例因风痰阻络导致肢体麻木不遂而有猝发中风之虞的老年患者。为了进一步验证,遂亲将制川乌、姜半夏、全瓜蒌各 10 克同煎顿服,除微觉脘嘈外,未感任何不适。此后即放胆将此二药广泛同用以治临床多种疾病,并取得一些疗效。个人体会,对风痰客于经络引起肌肉顽麻不仁或酸痛不已者,此二药同用常能增强疗效。此外寒痰挟风留滞脏腑或阻于皮里膜外导致的哮、喘、呕、泻、积、聚等常见内伤杂证,阳虚痰甚又猝受外寒的时令疾患,阳虚湿浊下注之白带,素体虚肥痰湿客胞的不孕等妇科病,脾虚痰湿中困的小

儿慢惊,以及阳虚之体又患癰瘤、瘰癧等外科证候,均可将二药同用。

有人认为乌头和附子虽属同根生药物,但二者毕竟有别;它们的化学成份虽相近,但不全然相同。故提出附子不反半夏,而乌头反半夏^[12]。笔者对这种说法不能苟同:因附子、乌头、天雄不仅都为同株植物的同一部份(根),所含成份和药理作用基本一致,且对人体的毒性反应是没有什么明显差别的,只不过天雄、乌头所含乌头硷比附子略多,祛风止痛之功及毒性反应均大些罢了。故附子如不反半夏,那么乌头、天雄也不会反半夏的。上面所举的方案中,不仅有附子,也有乌头,甚至有天雄和半夏同用的。云南百岁名老中医李继昌则常喜将天雄和半夏同用,且用量常在 30 克以上,而未见僨事者。至于有时二药同用,偶而出现一些中毒反应^[20],个人认为不一定为二药同用之咎。因单用乌头或附子若炮制未能如法,用量过大,加上患者特异性体质或身体过弱时,也可产生头目昏眩、不能站立、周身麻木、牙关紧急等毒性反应的^[21],有的过敏体质外用也会引起明显毒性反应^[22]。何况半夏也有着一定毒性,炮制不好也有戟喉麻舌之感呢?故二药同用时,难免有时会发生较强的毒性反应。但这和两药同用时因两药本身发生明显的毒性化学变化而引起人体剧烈毒性反应,似乎不可同日而语。

综上所述,个人认为制附子、制乌头、制天雄都可与半夏同用,有时可以相反相成,提高疗效。至于一般汤剂中生附子等能否和生半夏同用,笔者无这方面经验,不敢侈谈。所谓二药“相反”是否指均为生用,值得进一步探讨。虽然局方青州白丸子方中,乌头、半夏全系生用,但毕竟采取了相当复杂的加工程序,且是丸剂,故用之无碍。另南通丁明君虽亦善用生半夏合附子治痰厥头痛,但仅是个案报导^[23]。故临床若非特殊必要,为防止

意外,乌头或附子与半夏三者生用相伍,总应慎重为宜。

参考文献

- [1]高晓山等:《中医杂志》(3):7,1980。[2]许叔微:《普济本事方·星附散》,上海科技出版社,1959年新一版2页。[3]张石顽:《张氏医通·冷哮丸》,上海科技出版社,1963年第一版770页。[4]林佩琴:《类证治裁·鹿茸大补汤》,上海科技出版社,1959年新一版462页。[5]柳宝诒:《柳选四家医案·爱庐医案》,第348页。[6]王旭高:《王旭高医案》,上海科技出版社,1955年第一版190页、198页。[7]吴谦:《医宗金鉴·外科心法要诀·清震汤》,上海人民出版社,1973年第一版77页。[8]上海中医学院:《近代中医流派经验选集·徐小圃儿科经验简介》,上海科技出版社,1962年第一版232~233页。[9]付仁宇:《审视瑶函·半夏羚羊角散》,上海人民出版社,1977年新一版217页。[10]《李继昌医案·牝疟案》,云南人民出版社,1978年第一版24页。[11]中医研究院:《蒲辅周医疗经验阳虚水逆案》,人民卫生出版社,1976年第一版214页。[12]李华:《浙江中医药》(3):101,1979。[13]《老中医经验汇编》第一集:“马龙伯妇科医案选”,人民出版社,1978年第一版152页。[14]高乐众:《赤脚医生杂志》(1):48,1978。[15]转引南京中医学院:《简明中医内科学》,上海人民出版社,1971年新一版199页载《证治汇方·散聚汤》。[16]同上,179页载《续名医类案》治倪某人“劳倦内伤案”。[17]上海中医学院附属龙华医院:《医案选编·癫痫案》,上海人民出版社,1977年,第一版79页。[18]陈实功:《外科正宗·追风逐湿膏》,人民卫生出版社,1964年第一版159页。[19]广东中医学院主编中医学院试用教材:《中医喉科学讲义》,人民卫生出版社,1960年第一版48页,转引《喉科紫珍集方·麻药方》。[20]董广海:《浙江中医药》(3):100,1979。[21]李宗浩:《实用急救学》,人民卫生出版社,1975年第一版326页。[22]朱钵:《中医杂志》(10):27,1963。[23]丁名君:《中医杂志》(2):26,1965。

(马继松。原载于《江苏中医》1981年第2期)

二 论 肝 咳

《内经》所谓“五脏六腑皆令人咳”，为后世以脏腑辨证治疗咳嗽，奠定了理论基础。张景岳认为：“咳证虽多，无非肺病”，而“五脏之咳”乃各有其“兼证耳”。《素问·咳论》所说“肝咳”，主要系指咳嗽而见有肝经之形证。考诸医籍，有关“肝咳”的论述和验案颇多，兹结合临床管窥之见，简要分述如次。

肝气犯肺 咳嗽胁痛

尤在泾曰：“久咳胁痛，不能左侧，病在肝，逆在肺”。肺居高位，司呼吸，主肃降；肝主疏泄，其气升发；二者相互制约，升降有序，维持其生理机能。今肺病气郁，失其清肃之令，不足以制服强肝，则肝木反乘肺金，以致出现咳嗽频作，胁肋胀痛，脘闷噎逆，脉弦诸证。此时当以轻清辛散之品疏肝解郁，以遂其条达之性，方如四逆散加浙贝、桑叶、杏仁。它如前胡可“止咳嗽，升降肝气”，白蒺藜可疗肝郁“咳逆伤肺”，二药有肝肺同治之妙，可以随症选用。若气郁甚而久者，可酌加青陈皮、娑罗子、旋复花、郁金、佛手等。近贤张聿青和章次公治咳善用此法，现录张氏医案一则如下。

陈，久咳不已，肺金无权，不足以制服强肝，腹中作痛，故以平肝疏木法：

金铃子，青陈皮，砂仁，桑叶，制香附，广木香，郁金，查炭，茯苓，镑沉香。

肝气横逆犯肺，固可并发胁痛，然而肝咳则木郁侮土，亦可见腹中作痛之症。故用疏肝平降之品，克制强肝，一以疏解肝之气郁，一以畅调脾胃，则咳嗽诸症可以自除。王好古说：“白芍可疗肺急胀逆喘咳”，朱良春说：“柏子仁有清肺滑痰之用”，《现代

实用中药》云：“桑椹子可清凉止咳”，皆可随证选用。

木火刑金 咳呛目赤

陈修园曰：“肺为脏腑之华盖……只受得脏腑之清气，受不得脏腑之病气，病气干之，亦呛而咳矣。”由本脏蕴热或肝气郁久而产生的肝火，冲激犯肺，多见咳呛频作，声高气急，牵引两肋下痛，烦躁易怒，咽喉干燥，渴欲饮冷，脉弦细劲，苔黄少津等一派“本火刑金”之证，甚至上逆之火灼伤肺络而致咳血、鼻衄。治当急以清肝泻火为主，佐以肃肺止咳。《医醇賸义》之丹青饮、《统旨方》之清金化痰汤、景岳化肝煎、钱乙泻白散以及黛蛤散等均可增损而用。它如代赭石、金沸草、山梔、黄芩、青黛、杏仁、杷叶、郁金、桑葚皮、天麦冬皆可法活机圆地随症选入。近贤丁甘仁、姜春华善治此症，爰引姜案一例如下。

王××，男，48岁。

肝气郁而化火刑金，面红目赤，痰少咳剧，咽干胸胁痛，苔薄黄而干，脉弦，治以清肝护肺：

丹皮9克，山梔9克，木蝴蝶3克，百部9克，蛤粉9克，全瓜蒌15克。

邪热蕴肺和燥气袭肺也会出现类似“痰少咳剧、咽干胁痛、苔薄黄干”等症，需要辨治。肝经气火循经上逆致咳，目赤多为必见之症，又常伴见眩晕头痛，额胀耳鸣，面部烘热，故方中当参入苦寒直折火势之品，如胆草、山梔、青黛、黄芩等泻木以宁金。邪热蕴肺多有风温袭肺史，治当辛以散之，凉以清之，甘以润之。至于燥气袭肺又必有明显的秋令发病的季节性，非润燥结合疏化则难以为功。

肝脉瘀阻 咳逆胸窒

唐容川说：“木气冲和条达，不致遏抑，则血脉得畅。”若肝气郁滞，则会导致瘀血内阻，使肺气的正常肃降受碍，咳遂作焉。

常见在咳逆的同时，伴见胸室和胸胁刺痛，甚则不能转侧，痛甚咳益剧，吸气咳尤加，更重者则咳血，多兼有外伤史。施治当以化瘀为要，佐以肃肺。清代名医曹仁伯曾创瘀热汤，以仲景旋复花汤加芦根、杷叶组成，专治此类瘀血内阻、化火刑金，使肺气难以肃降之咳症。对瘀甚者增伍苏子、郁金、三七。《继志堂医案》出血门中，此类验案颇多，今摘个案如下。

阳络频伤，胸前窒塞，咳逆不爽，舌红苔黄，脉形弦数，此系瘀血内阻，郁而为热。肺胃受伤，极易成损，慎之。

旋复，猩绛，葱管，芦根，枇杷叶，苏子，桑皮，川贝，知母，忍冬藤，广郁金，参三七，竹油，地骨皮。

此类证候虽宜活血，但仅可辛通肝络，不可峻逐破瘀。观曹氏用药颇有分寸，只取旋复、猩绛、郁金、三七，摒弃了三棱、莪术、红花及虫类药。它如桃仁、当归、赤芍、瓜络既可活络理肝，又能止咳化痰，尚可灵活配入。

肝阴受损 咳嗽潮热

清代名医王九峰曰：“肝脏阴虚阳僭，是以呛咳咽痛，动劳则喘，”此因肝血不足而生风，风火上炎，灼伤肺阴之故。其特点是病发较缓，呛咳时作时辍，其声不扬，多伴潮热盗汗，腰酸失精，脉弦细数，舌红少苔。延久则胁肋隐痛，目眩头晕，两耳蝉鸣，烦扰梦频等一派阴虚阳扰之症，多见于病久肝肾渐虚或癆瘵患者。治疗当在养肝阴的同时兼滋肾阴，使水木并荣，方为两全。王九峰主张用金水六君煎，但陈皮、半夏毕竟失之温燥，不及沈金鳌之滋阴清化丸更为合拍。此方由生熟地、天麦冬、知贝母、茯苓、山药、花粉、五味子、甘草组成，不仅能滋养肝肾之阴，且可清燥润肺，使上下同治，标本兼顾，取效颇捷。若脾虚纳差者，为防膩膈，可在青陈皮、橘叶、娑罗子中略选一、二味参入，以助脾运而止咳。清末名医柳宝诒对肝阴不足致咳者，诊治颇具卓见，姑录

一案如下。

章：木火左升，肺胃不降。升多降少，气逆于络，则血随之而上溢，此贵恙之病源也。血后而咳不止，以及晚热不寐，皆肝肺两经不足所致。受病在肺，而病本在肝。调治之法，只宜清养肝阴为主，少佐肃降肺胃之品，便已足矣。

北沙参，白芍，大生地，制女贞，旱莲草，茯苓，苡仁，炙甘草，川百合，枇杷叶，丹皮炭，蛤壳。

在一般情况下，治咳很少用血肉有情之品，恐碍肺气的宣发肃降。但若遇到叶桂所言：“肝阳化风，旋扰不息，致呛咳不卒期”的这类患者，则不可墨守陈法，必要时须投大剂阿胶、牡蛎，甚至鳖甲、龟板以峻补将涸之真阴，否则阴不敛阳，阳不抱阴，虚风不息，咳终难愈。

胆火上逆 咳呕胆汁

《素问·咳论》曰：“胆咳之状，咳呕胆汁”；叶桂曰：“少阳郁热，上逆于肺，证见两寸脉大，咳甚脘闷，头胀，喉痒，应先解木火之郁”。均说明胆因附于肝，与肝相表里，同为相火之脏，性温而主升发之气，受邪后常易使气上逆冲肺而致咳。稽其邪之来路，正《咳论》所指：“肝咳不已，则胆受之”。考其治法，李冠仙说：“肝气上逆，必夹胆火而来，平其胆火，则肝气亦随之而平”。胆秉木之余气，所以清胆不宜象清肝而用大剂苦寒和重镇之剂直折其火，必须配入适量的祛湿利胆之品，当以俞根初《通俗伤寒论》中的蒿芩清胆汤为主方，其它如矾郁金、夏枯草、金钱草、蒲公英、冬瓜子、车前子等均可辨证增入。

另吴鹤皋《医方考》有柴前连梅饮一方（柴胡、前胡、黄连、乌梅、薤白、猪胆汁、童便、猪脊髓），主治“咳嗽，时盛时衰，粉红痰后变为青黄”。曹仁伯认为系“肝胆留邪”之症，治胆火上逆的咳嗽时，亦可使用。

结 语

肝咳属中医内伤咳嗽的范畴,是肝病影响到肺而引起的咳症。根据其病机不同,约可分为上述五种证型。肝咳病本在肝,继发于肺,故发病时常先见肝病症状。治疗大法需遵秦伯未所说“治肺止咳,佐以调肝”,双管齐下。肝气性升,风木易燃,肺为娇脏,不耐邪侵,故治肝咳之药最宜清凉潜降,切忌燥热升散。非但麻黄、细辛、干姜等不宜投,即使半夏、远志、桔梗、橘红亦须慎用。前贤治肝用药有六忌:“疏泄不可太过,补脾不可太壅,祛湿不可太燥,清热不可太寒,逐瘀不可太破,养阴不可太腻”,在治疗肝咳时,也应参考遵循。

(马继松、魏馨文。原载于《中医杂志》1983年第5期)

三 “三因论”病因分类法之质疑

在漫长的中医发展史中,历代前贤对病因的分类可谓精彩纷呈,仁智各具。如《素问·调经论》将病因概括分为阴、阳两类;张仲景在《金匱》中则提出:“千般疾难,不越三条”;而金代张子和又主张全部病因应分为四类、四因:在《儒门事亲·证分内外》中曰:“外有风寒暑湿,属天之四令,无形也;内有饥饱劳逸,属天之四令,有形也……”;清代程钟龄在《医学心悟·医门八法》中又提出“两因论”:“论病之源,以内伤、外感四字括之。”而在给病因进行过分类的所有医家中,对后世病因学说影响最大的乃宋人陈无择,他在《三因极一病证方论》中指出:“六淫天之常气,冒之则先自经络流入,内合于脏腑,为外所因;七情人之常性,动之则先自脏腑郁发,外形于肢体,为内所因;它如饮食饥饱,叫呼伤

气,尽神度量,疲极筋力,阴阳违逆,乃至蛇狼虫毒,金疮踈折,疰忤附着,昇压溢溺等,有背常理,为不内外因。”这种“内因、外因、不内外因”的病因分类的“三因论”学说,由于较能执简驭繁,逐渐被后人公认而沿用至今。

然而,我们知道,任何疾病的发生,至少都是由正(指人体的抗病能力)、邪(外界的致病诱因)两方面因素共同起作用所造成的,它是一个由外部致病诱因刺激人体,并使人体产生一系列病理反应的过程。而陈氏三因论的病因分类命名法,则没有很好注意到人体正气和外来诱因在发病中的相互关系。为进一步提高防治疾病的水平,故有重新研讨的必要。今陈管见,望同仁教正。

一、名为“外因病”,与实并不符

在“三因论”中,为风、寒、暑、湿、燥、火六淫之邪诱发的病证,被统称为“外因病”,这里单纯强调发病的体外诱因,忽视了病程中起重要作用的体内因素,没有全面地如实反映出发病的客观情况,在理论上欠严谨,对指导临床亦不利。

《素问·百病始生篇》曰:“风雨寒暑不得虚,邪不能独伤人。卒然逢疾风暴雨而病者,盖无虚……此必因虚邪贼风,与其身形,两虚相得,乃客其形。”这就明确指出,只有在正虚的前提下,六淫才能成为致病因素。由于“人之生也,有刚有柔,有弱有强,有短有长,有阴有阳”(《灵枢·寿夭刚柔篇》),这种体质的特异性,对六淫为人感受后能否成为致病因素有很大关系,即感受同样强度的六淫之邪,不仅有“勇者气行则已,怯者则着而为病”之别,且还有一些病者,由于“皮肤的厚薄,肌肉之坚脆”不同,病变也有轻重之异。另须注意的是:由于禀赋之异,其脏腑组织对六淫中的某些诱因有明显易感性,而对另几种诱因的反应却不明显,而使有易感性那种诱因能成为致病因素。如《灵枢·五变篇》

曾曰：“肉不坚腠理疏，一则善病风……小骨肉弱者，善病寒热。”等即是指此而言的。临床上还常会发现：素体阳虚或阴盛之人，对六淫中寒湿二邪颇为敏感，虽触之较轻，亦易发生胀满、呕吐或洞泄寒中；而对六淫中的风、暑、燥、火等邪，即使感受得很重，有时却反安然无恙。另外，即使在同一季节，体质不同的人感受了六淫中相同的诱因而发病，他们却“或病此，或病彼”，“同时得病，其病各异”（《灵枢·五变篇》），使同一诱因明显成为不同的致病因素。如薛雪在论述感湿后的不同机转时就指出：“湿热病，属阳明太阴经居多。中气实则病在阳明，中气虚则病在太阴。”叶天士则更强调：“大风六气伤人，因人而论”，均证明了正气的盛衰在整个发病过程中的重要性。故而六淫只能作为发病的诱因，绝不是外因病的唯一因素。外因病的发病因素并不仅存在于体外，在六淫证的发病机理中，外邪和正气具有同等重要的意义，有时后者甚至更重要一些。故陈氏将由六淫作为诱因而导致的疾病一概强调成“外因病”，是与发病机理显然不符的。

二、诱因既在外，难称“内因病”

在“三因论”中，由喜、怒、忧、思、悲、恐、惊七情变化而引起的疾患，陈氏概称为“内因病”。在这里，陈氏只看到情感变化的发展是在体内进行的，而却未曾看到，这种变化是通过人的感官接触外界时，被某种现象刺激后产生的。也就是说，陈氏没有认识到，七情之变已经是病变，被人感官感知的外界事物，才是真正的诱因，它们能使人的七情出现剧烈变化，导致情感疾患的发生。

实践告诉我们：人的感情不可能与生俱来，而是萌发于后天的生活经历中，当外界刺激为人的感官接受后，才能产生感情的变化。虽然《素问·阴阳应象大论》说：“人有五脏化五气，以生喜、怒、悲、忧、恐”，但人的感官如不能感知外界刺激的话，也是

不会有喜、怒、悲、忧、恐的情感变化的。一般情感疾患的发病率以青、中、壮年为高，正是因他们感受外界刺激的机会和程度较儿童或老年要多和重。由上可见，情感病的诱因是来自体外的。

实际上，祖国医学早已认识到这其中的真谛，如《灵枢·癫狂篇》说：“狂始生，先自悲也，得之忧饥”；“得之大恐”；“得之有所大喜”。后贤还进一步认识到：在正常情况下，七情是精神活动的外在表现，对健康并无妨碍，只有在外来因素引起的情感变化过于剧烈，而导致脏腑功能失常后，才会发生情感疾患。甚至连陈氏本人也无法否认这一点，如《三因极一病证方论·癫狂叙论》中说：“夫癫狂病，皆由惊动，使脏气不平，郁而生涎，闭塞诸经，厥而乃成。或在母体中受惊，或少小感受寒暑湿，或饮食不节，逆于脏腑。”在这里他已如实指出：外来诱因的刺激是产生情感疾患的首要条件了。

近来，有些人“谈癌色变”，是因为这些人通过视觉听觉了解到：癌症是目前尚难治疗的恶性病变。但如患者没有通过视觉、听觉而感知这一外来刺激，常可带病延年。笔者曾遇一农村妇女，患有恶性淋巴腺瘤，由于家务繁冗，使其无法顾及于病，加之保密性医疗制度执行得很好，使她根本不知道自己患了不治之症，在间断配服少量中药的治疗下，竟出乎意外地活了八年。而另一名中年妇女，系小学教师，其爱人曾患肺癌致死。当她略感不适经检查被疑为胃癌，当即昏厥于地。后情感发生极大变化，疑虑、忧郁、恐惧，终至拒绝服药而月余即死。可见任何疾病病程中所发生的情感变化，也大多由外来刺激作诱因而触发的。

情感病和六淫引起的疾患，虽诱因均来自体外，但两者有明显不同：即六淫证在发生时，人体的正气一般较虚；而情感病的发生，并非都有脏气虚损的前提。一些能耐受住六淫侵袭的体魄健壮之人，却常在外界突如其来的刺激下，引起较大的七情之

变而发病,甚至导致“……血之与气,并走于上,则为大厥,……气……不返则死”的意想不到的悲惨结局。对很多情感病的治疗,改变患者外界的生活环境(即减少外来的刺激),加以开导劝慰常能收到药物达不到的效果。笔者曾遇一例因女儿受她辱骂后自杀,遂患精神分裂症的中年妇女,在药物乏效后,劝其迁居外地,使其看不到女儿的住房和遗物,并让其多看喜剧片,断续配服疏肝解郁化痰之品,症遂减轻。而用此种方法治六淫症是很难获效的。由此看来,七情证的外来诱因,较六淫证外来诱因对疾病的影响,往往还更重要些。

综上所述:情感疾患既是以外来刺激为主要诱因的疾患,其发病的轻重程度与诱因刺激的强弱关系极大,除掉诱因的刺激,病变常会明显好转,外在事物对情感疾患的影响较之对六淫证的影响要大得多,故陈氏将情感疾患称为单纯“内因病”,完全忽略了作为诱因的外来刺激对情感疾患发病的重大影响,这是今人难以接受的。

三、“不内外因病”,令人难理解

致病因素中的饮食劳倦、房室不节、金刃虫兽、跌仆损伤等,在陈氏“三因论”中被划归同一类,称之为“不内外因”。但细考“内”、“外”二字,原是用以描述一物体本身和它物体所处空间位置关系的概念之一,用在这里是指致病因素相对于人体的位置而言。不言而喻,任何一种致病因素,在体内、外两个位置中,都只能居于其中的一个位置,即如不在内,则必然在外,反之亦然。至于那个既不在内,也不在外的位置,是绝对没有的,因为它们不能存在于超空间之中!形式逻辑的排中律告诉我们:对于互相矛盾的论断,只能肯定或否定,不能模棱两可,绝没有第三种可能。可见,“不内外因”的提法是完全违背科学的。因其名不正,故尔其言也不顺。请看:跌仆、金刃、虫兽所伤,分明由来自

体外的物理性损害所造成的,称它们为“外因病”才理所当然,这比称六淫证为“外因病”还更贴切些呢。而饮食劳倦、房室不节所致之病,乃是患者缺乏卫生知识或意志薄弱所造成的,按理依靠主观努力是完全可以防止的,比起七情证来,这类病证的病因倒更多发自体内。故“不内外因”的含义是很难令人理解的。如果说,为了和“内外因”区别才创出这一名词,也是不能成立的。因为金刃、跌仆、虫兽所伤的疾病,多是开放性创伤;饮食劳倦、房室不节导致的病证,乃是体内某脏器功能的异常,二者之间,在病因和病机方面都极少有共同之处,也没有混为一谈的道理。

结 语

如前所论,任何疾病(除跌仆、金刃、虫兽伤外)的发生,都很少是一方面因素造成的。如果在论及病因时只单纯强调一方面,就会造成认识上和理论上的谬误,而科学则要求我们尽可能的精确。“三因论”分类命名法不足之处,就因为很不精确,故似有给病因重新进行分类命名的必要。对这项工作,很多近贤都纷纷予以尝试,笔者在此亦略妄作刍议:在分类命名时能否既考虑发病诱因来自人体内、外的何处,也兼顾各种疾病在病情上的某些共同点。即将以六淫之邪、疫疠、瘴气等为诱因,症状从表入里,自上而下进行传变的疾病统称为“外感病”;将由七情之变、饮食劳倦、房室不节等为诱因,初起即见里症的疾患,统称为“内伤病”;将由金刃、虫兽、跌仆等物理性损伤所导致的单一外因所引起的病证(创伤性疾患)称之为“外伤病”。这里借用了感伤于何种邪物所引发的概念,在措词上避免使用显得突出强调病因一方面的“因”字。对这种分类命名法的必要性和正确性,请同仁们不吝教诲。

(冉铁、马继松。原载于《芜湖市中医药资料汇编》,1985年)。

四 少阳病病位之索隐

对少阳病病位问题，医界前贤仁智互见，争议颇烈，兹不揣浅陋，略陈管见，高明正之。

一、前贤对少阳病病位的不同意见

《伤寒论》153条说：“伤寒五六日，头汗出，微恶寒，手足冷，心下满，口不欲食，大便鞭，脉细者，此为阳微结，必有表，复有里也。……此为半在里半在外也，……可与小柴胡汤”。金代成无己则由此引伸出：“邪出少阳为半表半里”，“往来寒热者，邪在半表半里之间”之说，遂开少阳病病位在“半表半里”或“表里之间”的先河。明·方有执则曰：“邪入躯壳之里，脏腑之外，两夹界之隙地，所谓半表半里，少阳所主之部位”；清·尤怡又曰：“少阳居表里之间，当盲膜之处，外不及于皮肤，内不及于脏腑”；而程郊倩更强调：“少阳在六经中典开阖之枢机，出则阳，入则阴，……，故云半表半里之邪”。诸贤虽对少阳病的具体病位认识不同，但对其病位在“半表半里”或“表里之间”的看法却是一致的，并形成定论，沿传至今。

然表里的含义究系何指？《伤寒论》中却至少有四种看法：(1)以太阳为表、太阴为里，如168条桂枝人参汤证；(2)以太阳为表、少阴为里，如里虚证急时采用先里后表之法的93条；(3)以太阳为表、阳明为里，如56条“伤寒不大便六七日，头痛有热者，与承气汤；其小便清者，知不在里，仍在表也，当须发汗”；(4)以太阳经证为表，太阳腑证为里，如128条：“太阳病六、七日，表证仍在，……，以太阳随经，瘀热在里故也。”那么，少阳病的病位

究竟在哪个“半表半里”或“表里之间”呢？

历代前贤对此争议不外三端：其一认为：少阳病位处在三阴三阳的表里之间，即在阳明之后，太阴之前。理由有四：(1)从《素问·热论》六经热病的传经须序看，少阳病病位当在阳明之后，太阴之前；(2)从《伤寒论》原文排列顺序看，少阳病篇也在阳明病篇之后，太阳病篇之前；(3)从少阳病主症寒热往来的机理（正胜邪退，出而与阳争则热；邪进正退，入而与阴争则寒）及少阳病主方小柴胡汤中用人参、草、枣补虚来看，少阳病亦应在阳明病和太阴病之间；(4)从伤寒六经病的越经传、表里传的多种传变方式看，太阳之邪既可越过阳明而传入少阳，而任何一阳经又必然在任何一阴经之前，故少阳当在阳明、太阴之间。明·喻昌曰：“风寒之邪从阳明传入少阳”；清·魏荔彤曰：“半表者，指对太阳之全表言；半里者，对太阴之全里言”；吴谦更明指：“半表者，为在外之太阳也；半里者，为在内之太阴也”；“少阳之邪，进可传太阴之里，退可还太阳之表，中处于半表半里之间”。他们都是持这种认识的典型代表。

其二认为：少阳病病位应处在太阳和阳明表里之间，理由亦有四：(1)由少阳病条文分布看，本篇很少，多数在太阳病篇，而阳明病篇却一条没有，显见病是由太阳经过少阳向阳明传变的；(2)从少阳经的循行部位看，它正介于太阳和阳明两经之间，而六经证候与经脉的循行又密切相关；(3)从《素问·阴阳离合论》中的“太阳为开，阳明为阖，少阳为枢”的观点看，少阳病是既可内传阳明，亦可外出太阳的；(4)从少阳病主症寒热往来的病机和小柴胡汤方义看，由于邪在太阳之表则寒，进阳明之里则热，而在未有定处的表里之间，遂往来寒热。其治疗非在太阳，故忌汗；又非在阳明，故忌下。只得用柴胡疏木，外宣半表之邪；黄芩清火，内彻半里之热，组成和解一法。此法介于太阳经证的汗法

和阳明经、腑证的清、下法之间，乃可推测出少阳病病位亦应在太阳与阳明之间。清·柯琴曰：“太阳主表，头项强痛为提纲；阳明主里，胃家实为提纲；少阳为半表半里之位，仲景特揭口苦，咽干，目眩为提纲。盖口、咽、目三者，不可谓之表，又不可谓之里，是表之入里，里之出表处，所谓半表半里也。”近贤陆渊雷在《伤寒论今释》中亦曰：“伤寒论中，……六经之名，原虽出于内经，意义已非内经之旧，不宜以此释彼”，即是说，伤寒论中六经病证的传变和《内经·热论》是有别的。他们都是持少阳病位应在二阳病位之间的代表。

其三认为：以上两种争论没有意义，故提出了持中之论。如近贤张锡纯曰：“介于太阳、阳明之间者，手少阳也；传经在阳明之后者，足少阳也。……是以内经谓少阳为游部”。清·徐大椿说得更为明确：“按伤寒传经次第，先太阳，次阳明，次少阳，然则少阳虽在太阳、阳明之间，而传经乃居阳明之后，……盖以所居之位言，则少阳在太阳、阳明之间；以从此入道言，则少阳在太阳、阳明之内”。今贤王琦更指出：“三阴三阳六病的发生和传变是由病邪的质、量和体质的从化、治疗的恰当与否这三个因素所决定的；……。而绝不是按照那种固定的传经次序及日期进行变化的，因而少阳病也就不存在是位于太阳、阳明之间，还是位于阳明、太阴之间的问题”。

二、我们对少阳病病位之管见

我们认为：少阳病所处的“表里之间”，主要是指它既处在太阳经证与腑证的表里之间，又处在阳明经证与腑证的表里之间，即是处在太阳、阳明两经证之里和太阳、阳明两腑证之表。换言之，即相对于太阳、阳明两经证而言，则少阳病是里证；而相对于太阳、阳明两腑证而言，少阳病则又是表证了（请参考附图）。少阳病的病位正是处在这四组相互联系的表里病证的焦点中心，

四组中每一组病证的发展和演变都和少阳病有密切关联,少阳则成了这四组病证运动的关键部分,因此《内经》说:“少阳为枢”(“枢”,《辞海》解释为“门的转轴,指事物运动的重要部分或中心部分,枢机比喻为事物运动的关键”)。如把这里的“枢”单纯理解为太阳、阳明之“枢”,就未免太狭隘了。

我们提出上述观点,是因为:

(1)从伤寒六经病的传变顺序看:疾病通常是由太阳经病的麻黄汤证或桂枝汤证,经大青龙汤证(主症以太阳经证居多,阳明经证居少)、梔豉汤证(主症以阳明经证居多,太阳经证居少)、传变为纯阳明经的白虎汤证。此时体表仍有一定的邪热,故取石膏为君以透泄阳明之肌表壮热(《本经》曰:“石膏主中风寒热”)。而太阳腑病的蓄水、蓄血二证及三承气主治的阳明腑证,乃均为里实之证(五苓散和桃核承气汤之用桂枝,分别重在宣化膀胱浊气和温通血脉,非为解表而设)。至于小柴胡汤主治的少阳病,取柴胡疏表、黄芩清里,故知既非全表之证,亦非全里之证,显见少阳病之病位是处在太阳、阳明两经证之里和两腑证之外的“表里之间”了。

(2)从《伤寒论》中有关合、并病的原文看:在六种合、并病中,除二阳合病、二阳并病外,余均涉及少阳。如177条的太、少合病;261条的阳明、少阳合病;224条的三阳合病及147、176条的太、少并病等。由于少阳最多合、并病,且对合、并病的施治常用承气汤(261条)和白虎汤(224条),故少阳病病位应在阳明经证、腑证之间。而太阳经证又在阳明经证之外,太阳腑证和阳明腑证病位相近(因均为可用大黄的纯里证),由此推证,少阳病病位亦可看作是在太阳、阳明经证之里和太阳、阳明腑证之表了。

(3)从《伤寒论》和后世治伤寒病的方剂看,小柴胡汤不仅是治少阳病的主方,且常可通过加减或和它方相合,组成治疗由太

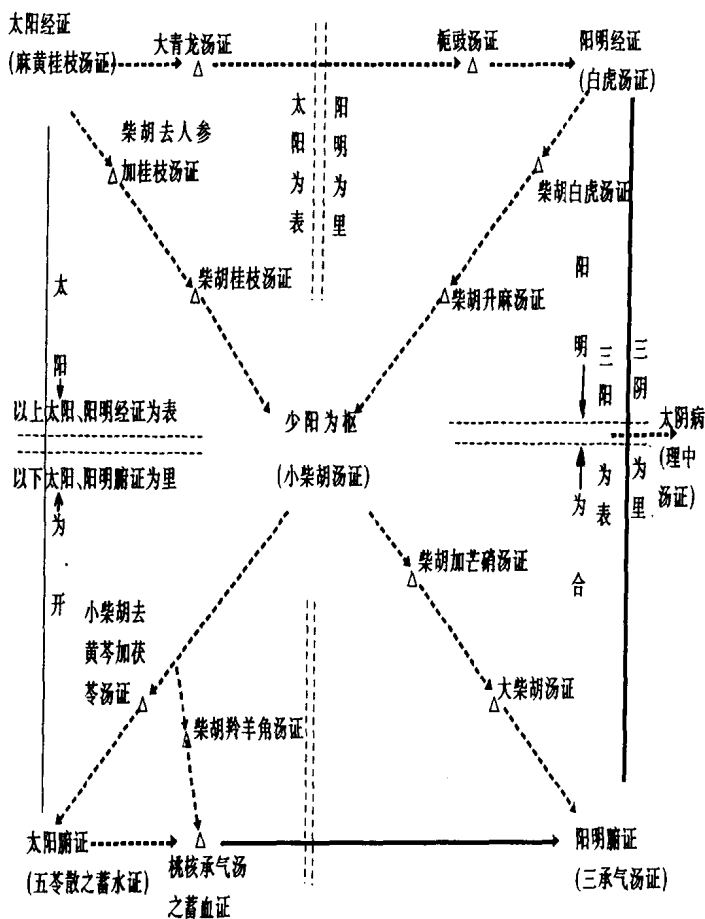
阳经证或阳明经证向少阳病传变以及少阳病向太阳腑证或阳明腑证传变的复方,以应病情错综复杂之需。如邪从太阳经渐入少阳而正气未虚时,用小柴胡去人参加桂枝(98条);正虚改用柴桂汤(151条);若邪从阳明渐入少阳,用柴胡白虎汤(徐荣斋《重订通俗伤寒论》:柴、芩、膏、知、草、花粉、粳米、荷叶)或柴胡升麻汤(沈金鳌《杂病源流犀烛》:柴、芩、膏、草、升麻等);当少阳之邪向太阳腑病的蓄水证发展,现膀胱气化失宣致“心下悸,小便不利”之症时,可用小柴胡去黄芩加茯苓(98条);当少阳之邪向蓄血证发展,有血瘀之状,现热入血室之证时,可用柴胡羚羊角汤(《重订通俗伤寒论》:鳖血炒柴胡、羚羊角、炮甲、人参、大黄、归尾、桃仁、红花等,亦可看作系小柴胡与桃核承气之复方);若邪从少阳传阳明腑证而里证不甚时,用小柴胡加芒硝汤(107条),里结已甚用大柴胡汤(106条)。综上所述,少阳病主方既然能在太阳、阳明两经证和两腑证之间起斡旋治疗作用,那么,少阳病病位当然可看作在太阳、阳明两经证和两腑证之间了。

(4)从柴胡的效果来看:《本经》谓其“主心腹,去肠胃中结气,饮食积聚,寒热邪气,推陈致新”,指明其不仅能治脾胃之病,且还可外退寒热,内通腑气,所以它成为治疗少阳病及少阳与它经合病、并病的主方之主药。近贤章次公通过大量临床,证实其能一祛瘀(故可合桃核承气治蓄血证);二解热(故可合桂枝汤或白虎汤使少阳之热由太阳或阳明经证肌表而解);三泄下(故可合硝、黄治阳明、少阳的合、并病偏于阳明腑实便秘者)。他们均为该药所主治少阳病的部位是在太阳、阳明两经证之里和太阳、阳明两腑证之表作了很好的说明。

(5)从药理实验对柴胡作用的分析研究来看:实验证明,柴胡有使毛细血管扩张而发汗之功能,它所含皂素有解热作用,这与柴胡配桂枝或石膏,可将少阳邪热转从太阳或阳明经证之表

而解正相吻合。小剂量柴胡有很强利尿作用,此正是小柴胡汤去黄芩加茯苓治蓄水证之理;大剂量柴胡(30克以上)有泻下作用,这为其配芒硝、大黄攻阳明腑实亦作了注脚。

少阳病位示意简图



结 语

综上所述,少阳之病位是介于体表和内里之间(即半表半里,病变由表向里的发展或由里向表的退出均要经过的这一部位)的抽象概念,并非某一具体特定的解剖部位。若能基于这种认识,必将能较有效地提高临床诊治少阳病的水平,并拓宽和解剂的临床应用范围。

注:本文所引《伤寒论》原文条数系依成都中医学院主编的《伤寒论讲义》(上海科技社 1964 年版)。

(马继松、王世峰。原载于《中医药研究》1986 年第 5 期)。

五 浅论仲景的活血化瘀法及其 对后世之贡献

痰饮和瘀血既是病理性产物,又是致病因素。然张仲景在《金匮要略》中对痰饮的辨治列专篇 41 条予以系统论述,而对瘀血的辨治,该书《惊悸吐衄下血胸满瘀血篇》中仅有 10、11 两条,余均散见于它篇和《伤寒论》,为不致使其治瘀学说有鳞爪之嫌,今将两书中的治瘀内容综合论之,并通过后人对其活血化瘀(简称活化)法的发展应用,以示仲师对该学说的伟大贡献。

一、瘀热互结,急投清热活化

热邪灼血为瘀或血因热迫外溢致瘀及瘀久化热等,均可成瘀热互结证。仲师本《内经》“留者攻之”之旨,立瘀血宜下之法,首创桃核承气汤(硝、黄、桂、草)治瘀热蓄结下焦的蓄血证,使瘀

热随畅泻而解。清·吴瑭以归、芍、丹皮易桂、草名桃仁承气汤，更增清热活化之力，遂成苦辛咸寒活化法的代表方。宋·陈自明、晚清·俞根初均以仲师方为基础，嬗变出同名三方剂，用治妇人小腹瘀血急痛，谵语如狂等症。对病久瘀入经络之急者，硝、桂难逐其邪，仲师改虻、蛭配桃、黄成抵当汤，猛攻而获速效。若势较缓者，他减虻、蛭量且改汤为丸，成轻剂缓攻瘀热了。另《金匱·妇人产后病篇》中，他又以蜚虫与桃、黄组成下瘀血汤，疗“产后腹中有干血着于脐下”。这种“瘀热在里”“下血乃愈”的治法，颇受后贤赞赏。如隋·巢元方也谓：“若血热搏而生瘀……宜下之”；隋唐的孙思邈宗抵当汤可治太阳病发黄之理，每用硝、黄、桃、归、人参、桂心清热益气下瘀治寒热发黄；金·张子和治瘀结亦每将活化寓于攻下法中。而今人不仅用桃核承气汤治大面积阴道血肿，还将上四方治瘀热互结之痛经，女性周期性精神分裂症、多种急腹证、腹腔肿瘤、胆汁郁结型病毒性肝炎等，大大拓宽了此法的应用范围。

对素嗜醇酒炙煇，湿热灼络致瘀，腹痛寒热成痼者，只要未化脓，仲师即以大黄牡丹汤（硝、桃、冬瓜子）泻热破瘀，消肿散结。实验证实其能增强阑尾蠕动，促进血循，故今人将其作为治急性阑尾炎之首方，或引伸治肝、胃脓疡、盆腔炎属实热者。元·朱丹溪习用归、芍、桃、红、丹皮、大黄、瓦楞、香附治一切瘀痛，显系得益于此方。

妇人经期感邪患“热入血室”证，仲师予小柴胡汤，虽化瘀力欠足，但他倡用清热活血佐透邪的治法，为后世疗此证打开了法门。如金·李杲创泻血汤治该病，除用柴胡等透邪药外，还用了生地、防己、蒲黄、丹参、归、桃等凉血化瘀。近有黄康泰在《神经与精神疾病》书中，将精神分裂症分为五型，气滞血瘀型（女性多）主方，即由柴、芩、桃、红合以清热活血理气药，明显提高了疗

效。

二、寒凝血瘀，力主散寒活化

经曰：“血得热则行，得寒则凝”，故对寒凝成瘀所致之病，仲师力主散寒活化，具体应用又分三途：

1、温经汤温阳活血

对女人年五十而下血数十日不止，他认为系“曾经半产，瘀血在少腹不去”，至冲任血虚之老年而发病，故予温经汤（归、芍、芎、桂、参、草、吴萸、半夏、丹皮、阿胶、麦冬、生姜）散寒益气，温经活化，使血得温而行，不专逐瘀却瘀去血止，乃治病求本之佳方。《医宗金鉴》曰“……瘀血未尽，风寒客于胞中，为带下，为崩中，为经水愆期，为胞寒不孕”，均可投之。明·张景岳的菟花煎、傅青主生化汤、清·王清任少腹逐瘀汤等治宫寒瘀滞之名方，皆脱胎于此。宋·《校注妇人良方》以本方去萸、半、胶、麦、姜，加牛膝、莪术，名良方温经汤，更增祛瘀之力。近贤章次公对仲师温经汤应用尤独俱匠心，其《医案选》月经不调门载 48 案，9 案均以炮姜、肉桂易此方中的麦、姜、桂枝，且佐峻补冲、任、督脉药而效。更有四川彭履祥教授妙用该方治寒疝，还有人拓展治前列腺病，均深得异病同治之妙。

2、当归四逆汤温经通脉

该方为《伤寒论》厥阴病中治血虚寒逆而厥的要方。清·吴仪洛《成方切用》曰：“当归辛温，血中之气药为君；通络散逆，必先去血中之邪，故以桂枝散太阳血分之风，细辛散少阴血分之寒为辅；未有营卫不和而脉络通者，故以芍药、草、枣调和营卫；通草利九窍、通血脉关节。诸药籍之以破阻滞而厥寒散矣。”已故名医岳美中以该方疗冻疮颇佳。今人还有用治肢端青紫症、雷诺氏病、血栓闭塞性脉管炎及寒凝血阻之痛经、闭经者。

3、胶艾汤温补行血

血虚寒凝,冲任损伤之妇女,常会患崩漏、胞阻(乃妊娠胞脉阻滞,血少气不行致腹痛之症)、妊娠出血或流产后血出不净等疾,仲师指出:均与兼挟瘀血有关,遂创胶艾汤主治之。取地、芍、归、芎补血养血(归、芎又可行血中瘀滞),阿胶养阴填精,艾叶温经止血,甘草调和诸药,清酒同煎助行药势,共收温补行血之功。自北宋《局方》去胶、艾、草遂成治一切血病的四物汤后,元·王好古又在《医垒元戒》中,以其为基础,创立了妊娠六合汤(即再加一药对)这一多种变化之系列方。其中的胶艾六合汤可治妊娠血海虚寒之腹痛或冲任虚损、血漏等,虽比仲师原方仅少味甘草,但王氏将变化之诸方冠以“妊娠六合”总名,系统且实用,颇为后贤称道。明·王肯堂《证治准绳》治滑胎的阿胶汤,仅以白术、杜仲、红枣易仲师方中的芍、草,但安胎却更胜一筹。另《古今医鉴》亦有胶艾四物汤,由阿胶珠、炒艾叶、地、芍、归、芎、连、芩、梔、榆、蒲黄、白术组成,虽方名和主治(崩漏)与仲师方同,然选用了较多清热凉血药,只适用于寒热错杂之夹瘀者。今贤还有以仲师此方损益治子宫内膜异位症、席汉氏综合征、不孕及少女发育迟缓等病,甚至有合化痰软坚、解毒抗癌药治生殖器肿瘤,此方造福妇女,功莫大焉!

三、气滞络瘀,宜用行气活化

有些肝气失疏,经络瘀滞之患者,可现“常欲人蹈其胸上”之症,仲师名之为“肝着”,创旋复花汤(新绛、葱白)治之。但后人对新绛,难考其详,故遇此症之热较显者,以茜草代新绛;寒较著者,以红花代新绛,取效皆佳。清·叶桂凡遇营气痹窒,脉络瘀阻之症,以此方加桃、郁、归须、泽兰等,组成辛温通络、辛泄通瘀之法,疗效历历可稽。稍后的吴瑭创香附旋复花汤(陈皮、半夏、茯苓、苏子、苡杏仁),专治络气痹阻之胸痛、悬饮,显受仲师之启迪。和吴同期的曹仁伯以旋复花汤加芦根、杷叶组成瘀热汤,治

瘀阻化火，刑金致咳，并云瘀甚增苏子、郁金、三七等，对努挣负重，络伤咳血者极妙。同时期的王清任更以桃红四物汤合升降气机的柴胡、枳壳为基本方，组成血腑逐瘀汤和解毒活血汤，前方因还有桔梗、牛膝，故成为今人最喜用的行气活化名方；后方中还有连翘、葛根，今人有用治感染性疾病及感染性休克，为行气活化法的应用拓展了新途。另已故中国中医研究院郭士魁研究员，遵仲师此法研制的心痛丸、丁桂香丸等药，投放市场，使无数冠心病者带病延年。今人对体内各部位因气滞血瘀导致的痛证，习本“通则不痛”之理，投以行气活化法，每收良效。

四、气虚血滞，最应益气活化

气虚则无力行血，血滞必痹而不通，痛遂作矣！故对“血痹阴阳俱微……外证身体不仁，如风痹症”者，仲师立黄芪桂枝五物汤，取芪补元气，率血以运，合桂、芍温阳活血，和营通滞，姜、枣调和营卫，遂开后人益气活化法之先河。如李杲以芪、桂合归、草、升、葛、红花、苏木、黄柏组成清阳汤，治风中经络，口眼歪斜，筋脉紧急之症；又以芪、桂合柴、羌、芩、翘、红、归、参、草组或托里荣卫汤，治痈疽内痛，不能消散者。尤其是王清任常重用黄芪（30～250克）略配桃、红、芍、归及虫药（总量仅有黄芪量的数分之一），组成不少益气活化之妙方，如补阳还五汤等，治多种心、脑血管疾病及其后遗症，常获佳效。张锡纯将人参、白术合乳、没、归、蜈蚣、炮甲、马钱子制成振颓丸，时起肢痿偏瘫。已故名医王季儒予自拟通络益气汤（重用参、芪合归、芍、蝎、蚕、地龙、熟地、寄生、灵仙、鸡血藤、白附子）治中风后遗证颇效，该方虽由补阳还五汤化出，考其源仍得益于仲师。

五、血滞水（湿、痰）阻， 理当利水（祛湿、消痰）活化

前哲曰：“血不利则为水”，“水阻则血不行”，故仲师对水、

湿、痰所化生之瘀，悉与祛邪活化。如他曾创制逐水消胀的大黄甘遂丸(为防两药过峻，还佐以阿胶)，攻逐“妇人少腹满如敦状，小便微难……为水与血俱结在血室”之病。北宋《圣济总录》治疝气的甘遂丸，《证治准绳》治臌胀之调营饮，皆本此方立意。他还拟当归芍药散治胎动腹痛，但茯苓、泻、白术皆利尿，亦可看作活化利水要方。今人常用该方治肾性、肝性及女性内分泌紊乱所致水肿，亦有以其治女性更年期综合症、卵巢功能低下及单纯性肥胖症等。另《金匱·妊娠病篇》的桂枝茯苓丸(桃、芍、丹皮)，原为消瘕而设，但桂枝亦擅利水(《本草再新》曰其可“消肿利湿”，《本经疏证》言桂枝：“用之之道有六：……曰利水……”)，故今贤则宗本方瘀水并治之理，引伸其疗臌胀、肾或输卵管积水，女性特发性水肿，风心浮肿者。仲师的栝蒌瞿麦丸(茯苓、山药、附子)原为“小便不利者，有水气，其人苦渴”而设，除瞿麦可利水活血外，天花粉亦能活血利水(《别录》曰“通月水”；《医林纂要》言“治热淋，小便短数”)，故今人将本方用治多种泌尿系疾患导致的尿频、淋沥、小便涩痛，甚至肾衰，值得研探。

仲师在《金匱·痰饮病篇》中又创已椒苈黄丸，治“腹满，口舌干燥，肠间有水气”，考《本草再新》言防己可“破血”，而《纲目》曰葶苈子“通月经”，故该方实乃典型的水湿痰瘀并治之方。今人不仅用其治阳水，喘息性慢支伴感染，还以其合真武汤、生脉散抢救晚期肺心者。

以栝蒌薤白为主组成的系列方，乃仲师创用治胸痹的痰瘀并治方，均重用苦辛温通的薤白合瓜蒌与它药，共收散结涤痰、化瘀生新之效。因实验证明，化痰药与活血药并用，可使冠状动脉血流量增加，消溶血栓，预防和减少梗塞，较纯用化痰通阳或活化药效好，故今人将此系列方广泛用治冠心病、心梗等危重病，周仲瑛教授等还以此类方化裁治高脂血症。仲师所创痰瘀同治

之法，于后人功莫大焉！

六、瘀结成积，妙创消症活化

血瘀久不去，逐渐成症积，《内经》中肥气、伏梁等皆此类病也。症母亦症积之一，因久病正虚，且进展较缓，故仲景妙拟鳖甲煎丸，取鼠妇、蜃虫、蛭螂、蜂窝等虫药蠕行入络，合鳖甲、丹皮、瞿麦、紫葳、射干、大黄、凌霄花等咸苦酸寒之品，消症磨积，逐瘀化滞，略佐人参、阿胶益虚扶正，且助它药祛邪。为使峻药久服不伤正，遂制成丸药以缓图之。叶桂治“积聚症积，气钝血滞，病久入络之痼疾”，亦每取土鳖虫等虫药飞走诸灵，合归须、桃、红、芍、郁等活血化瘀，今人也常宗仲师此法，治各种肿瘤。另李东垣宗仲景此法，在《医学发明》中立复元活血汤（桃、黄、归、柴、红、草、炮甲、花粉）治因跌仆损伤，瘀血留积胁下，致痛不可忍，实为骨伤科要方，如辽宁中医学院在抗震救灾中用此方治挤压综合症取得满意疗效，今贤更有用此法治卵巢囊肿等妇科肿瘤，可收缓消渐化之功。

七、正虚兼瘀，巧设扶正活化

病久正损者，多血流欠畅，故久病必多致瘀。但祛瘀则伤正，补虚恐恋邪，故仲师巧设扶正活化，对“五劳虚极羸瘦，腹满不能饮食……内有干血，肌肤甲错，两目黯黑”者，妙用大黄蜃虫丸以“缓中补虚”。取桃、杏仁润以濡其干，大黄、干漆通以去其闭，更用虻、蛭、蜃虫、蛭螬等虫药以动其瘀，仅用地黄、芍、草以养其正，虑药峻于久病之体难合，遂制丸缓图，并佐酒饮服以行药势，面面俱到，用心良苦。张锡纯治虚劳挟瘀，予补气养血药合棱、莪组成十全育真汤，盖取法仲师也。当代最擅用虫药的大师朱良春，用地鳖虫、炮甲、内金合三七、郁金、姜黄，佐以参须、紫河车共末，以虎杖、石见穿、糯稻根煎浓汁泛成益肝丸，用治慢性肝炎、早期肝硬化，可使虚弱、胁痛、瘀块等诸症消失。

对“虚劳诸不足，风气百疾”(日医丹波元简曰：“风与气盖是两疾”，《唐书》张文仲曰：“风状百二十四、气状八十”，足见风与气致虚症之多也。)因不可独补其虚，亦不可着意去风气，故仲师以大剂山药、甘草合参、术、芍、地、阿胶补虚，用柴、桔、防风、豆卷祛风调气；尤妙者，少佐归、芎、桂枝活血化瘀。张锡纯曰：“补药剂中以为佐使，将瘀者，瘀可消除；既无瘀者，亦可借其流动之力，以行补药之滞，而补药之力愈大也”，深知仲师组方之真谛。已故肾病专家邹云翔治诸多“肾劳”症，每以补肾救本与活血和络药(桃、红、归、膝等)相合，常使这些晚期尿毒症患者转危为安。

结 语

由于时代的局限，仲师的活化法尚欠尽善尽美，如补虚活化法中，他长于将补气、养血、温阳之品与活化药相合，却短于滋阴活化。有鉴于此，金·刘完素遂创二丹丸，取活血化瘀的丹参(重用)、丹砂(《医学入门》曰朱砂：“破症瘕，下死胎”)与大剂二冬、熟地等滋阴药相合，略佐益气安神，用治心阴不足使心血瘀缓而致的心悸、不寐、健忘者，匡补了仲师学说之不足。今人每宗刘氏立法之旨，以其方进退，配适量清热解毒药，用于病毒性心肌炎，常获显效。另名老中医祝谌予治糖尿病最喜将山药、黄芪；生地、熟地；丹参、葛根；元参、苍术四组“药对”合用，亦是妙用了滋阴活化法。

限于学识和篇幅，本文仅就仲师十分宏富的活血化瘀方、论，撮其精要而简述之，错误和不逮处，恳望明哲正教。

(彭绍荣、马继松、毛以林)

(本文系参加省中医学会二届活血化瘀研讨会之文，部分内容被综述这次会议的文章所引用)。

六 对张仲景运用细辛组方的学习札记

《本经》谓细辛“主咳逆上气，头痛脑动，百节拘挛，风湿痹痛，死肌……利九窍。”然仲景却通过巧妙配伍，有效地扩大了它的运用范围。在《伤寒论》和《金匱要略》中，有15方22处用了细辛（不包括三黄汤和侯氏黑散），本文试对应用该药的主要方剂作一浅析，以图更好地发掘细辛的临证价值。

配温肺降逆药化饮平咳喘

1、入小青龙汤解表化饮以止咳

《伤寒论》40条“伤寒表不解，心下有水气……”和《金匱·痰饮咳嗽篇》“咳逆倚息不得卧”，仲师均用小青龙汤主之。方取细辛助麻、桂解散表寒，协干姜、半夏温化痰饮，一味药竟收表里兼顾之伟功。诚如周禹载所说：“本方尤妙在用细辛为少阴经之表药，乃以细辛搜豁伏邪，走而不留……”故能成为治表寒里饮咳喘证的首选之方。后贤还将其引伸治百日咳及风水证表寒现象较著者，若寒饮郁而化热，出现烦躁，即改用小青龙加石膏汤，或创厚朴麻黄汤对症施治。两方中均选用细辛配石膏，一温一寒，互相激发，各奏其功，使蠲饮清热之力更著。

在小青龙汤的组方中，仲师还首创细辛、干姜、五味子同用以止咳平喘之妙法，开后世散、敛并用之先河。如《金匱》痰饮篇37~40节，分别选用苓甘五味姜辛汤及其加减方，另在真武汤的变法中，亦有“若咳者，加五味子、干姜、细辛”之明训。盖细辛辛温而形细，能开通肺气，疏泄腠理，助肺宣降；干姜温中健脾，散寒化饮；五味子酸收敛肺，正可防辛、姜之过散也。《本草求原》曰：“五味子为咳嗽要药，……先贤多疑外感用早，恐其闭气

太骤,不知仲景伤寒咳嗽小青龙亦用之。然必合细辛、干姜以升散风寒,用此以敛之,则升降灵,咳嗽自止。”陈修园更明言:“干姜以司肺之开,五味以司肺之合,细辛以发动其开合活动之机,小青龙汤中当以三味为主,故它药皆可加減,此三味则缺一不可也。”因三药合用其妙无比,故《本事方》中治“肺气虚寒,痰饮咳嗽”的五味子丸,《太平圣惠方》治“气嗽,呼吸短气”的干姜散,均仿此扩充而成。近世还将三药作为固定配伍的药组,用于治疗多种疾病。

2、入射干麻黄汤调饮降逆以平喘

寒痰壅肺,气道受阻则喘,气触痰动则喉中痰鸣如水鸡声,此乃哮喘典型症状,故仲师在《金匱》中创射干麻黄汤以治之。方取细辛佐麻黄与射干相合,辛开苦降,使痰消逆平,且细辛之温可制射干之寒而存其逐痰之力。再配冬花、紫菀平逆定喘,半夏、生姜消寒散饮,五味子敛肺,大枣和中,共奏散寒化饮、降逆平喘之功,成为治寒痰喘逆之要方。后世治喘名方由此化出者甚多,如《圣济总录》射干丸等。

配助阳解表药治太少两感

《伤寒论》301条云:“少阴病,始得之,反发热,脉沉者,麻黄附子细辛汤主之。”此乃阳虚之体,复为风寒之外邪直中,而成太少两感之证,较一般外感严重得多,施治也不易。若仅发汗则更伤肾阳,纯助阳难免表邪内陷,而仲师寥寥三药,却将发汗、温经两法熔为一炉。对细辛之用尤妙,其通彻表里之功,既能助麻黄解表发汗,又可佐附子温经散寒。难怪钱天来赞曰:“三者合用,温散兼施,无损于阳气矣,故为温经散寒之神剂云”。清末俞根初用此方合五皮饮组成麻附五皮饮,且在其名著《通俗伤寒论》中创麻附细辛汤治冬月夹阴伤寒;今贤更有以此方治暴受风寒之失音者,足见对后世影响之大。若将此方看作温阳解表之祖

方,实不为过。另《金匱》水气病篇中有一阳虚阴凝,水饮不消,积留胃中,痞积而坚,如盘如杯之证,其用桂枝去芍药加麻附细辛汤治疗,亦是取细辛通阳散水,配附子温阳祛寒,加麻桂驱饮由汗作解,为该方治杂证又拓一新路。近贤朱良春更妙取本方强心利水的作用,引伸治肺心病、风心病发作期的咳喘、心悸、腹水等证,扩大了本方用途。

配破阴行血药通阳回厥逆

《伤寒论》所论厥证病因极多,然寒厥皆因阳气不能贯通外达于四肢,使“阴阳气不能顺接”所致。仲师对“手足厥寒,脉细欲绝者”,特创当归四逆汤为治。《医方集解》曰:“四逆之名多也……此则因风寒中血脉而逆,故以当归细辛血中之气药为君……以桂枝散太阳血分之风,细辛散少阴血分之寒为辅……以芍药、甘草、大枣调和营卫,通草利九窍,通血脉 关节,诸药藉之以破阻滞,而厥寒复矣。”指明了其与四逆汤所主的阴盛阳虚之厥,四逆散所主的阳郁不伸之厥,判然有别。“若其人内有久寒者”,更加吴萸、生姜以增暖肝和胃之功。今贤岳美中以此方治冻疮,还有人用该方略予化裁,治肢端青紫症,雷诺氏病,拘挛病,血栓闭塞性脉管炎,小儿麻痹后遗症,周围神经炎,风寒湿痹,身痛,以及妇科经闭、痛经等,正是取细辛温消寒凝之功。

在《金匱·腹满寒疝宿食病》篇中,仲师又创赤丸治“寒气厥逆”,但因叙证过简,医家之看法仁智互见。然以方药测症,应有腹痛、呕逆、心悸等中阳不振,寒饮上逆之象。故黄坤载曰:“(此方)茯、乌泄水而驱寒湿,辛、夏降浊而下冲气,真朱保护心君而止疼痛也。”分析颇得要旨。若和当归四逆汤治厥相比较,虽均治寒邪阻滞脉络不通,却一为水寒互结之厥,一为血虚寒阻之厥,由此可见其组方之微妙,临症当细辨而用。

配辛通攻下药疗阴结胁痛

仲师不仅在《伤寒论》中创三承气汤治阳结便秘证,还在《金匱·腹满寒疝宿食病》篇中创大黄附子汤治阴结便秘证。方以细辛合附子辛通散寒,配大黄宣闭开结,辛、附并制大黄苦寒之性而存其走泄之力。徐忠可曰:“附子、细辛与大黄合用,并行而不悖,此即伤寒论大黄附子泻心汤之法也。”本方与麻附细辛汤均用细辛配附子,以增其温阳驱寒作用。所异者,彼方配麻黄侧重外散,属温经解表法;本方伍大黄偏于里下,属温通导便法,同中有异,非对药性了如指掌并有丰富临证经验者,难有如此奇妙之组方。自仲师倡此类寒温并用,苦辛通降之法以治消化系统疾病以来,从者如云。如《痧胀玉衡》细辛大黄丸等方均是宗此法而制成的代表方。它如《千金方》、《本事方》中诸温脾汤虽未用细辛,若细析方义,仍未离苦辛温通法,如能很好掌握该法之运用,于临证裨益大焉。

配苦降辛开药安蛔止久痢

仲师在《伤寒论》和《金匱》中,均创乌梅丸以治蛔厥证。汪切庵曰:“蛔得酸则伏……蛔得苦则安……蛔得寒则动,故以附、桂、辛、姜温其中脏,而以细辛、当归润其肝肾……”细辛在方中既可合川椒温中杀虫(药理试验证实,细辛挥发油对动物初呈兴奋,继则麻痹,终致死亡),又能合人参、当归收补养之功,较细辛组成的其它方剂作用明显不同。程郊倩亦云:“名曰安蛔,实是安胃,并主治久痢,见阴阳气不相顺接,而下利之证皆可以此方括之也”。久痢虚多邪少,既可用乌梅丸主治,则为细辛有一定补益作用作了较好的注脚。《别录》曰细辛:“安五脏,益肝胆,通精气”,并非无稽之谈,若将其纯粹作为祛邪之品,则为谬矣。

结 语

仲景使用细辛的剂量,可分轻重两种情况:当以祛邪为主,治寒饮和血虚厥寒时,都重用至三两,如小青龙汤、当归四逆散

及其类方;如治虚实夹杂之患,且阳虚较前为重,取其通阳又防其发散太过时,即轻用二两,并和附子相伍,遂无大汗之虞,如麻附细辛汤和大黄附子汤等方。然九剂中细辛用量悬殊较大,乌梅丸中用六两,而赤丸中仅用一两,因配制成丸剂,每次服用较少,则无深究之必要。但据近贤柯雪帆考证,东汉一两约等于现在16克,故仲师用细辛可重达48克,似乎过大。由于该药偏于香燥温散,后人又有“细辛不过五,多则闷死人”之说,而陈修园却曰:“细辛,神农列为上品,无毒可以常服,辛香走窜之品,岂能气闷而死?”已故黑龙江中医学院华廷芳教授为验证药性,临床从小量试加,服用9克亦未见不良反应,指出超过1.5克毒死人之说不足为凭。安徽中医学院周玉朱教授曾将细辛同麻黄并用,均为30~40克,治慢性鼻炎、慢性支气管炎、关节炎与缩窄性心包炎等,未见有不良反应与日久积蓄中毒现象。因此,笔者认为剂量当据证而定,若胶柱于仲景用量或绝对不能超过1.5克之说,恐欠妥贴。

(彭绍荣、马继松。原载于《国医论坛》1988年第3期)

七 张仲景运用厚朴的经验发微

《神农本草经》虽仅言厚朴“主中风,伤寒,头痛,寒热,惊悸,气血痹,死肌,去三虫”,但通过仲景将其与它药巧妙配伍,却有效地扩大了它的运用范围。为了进一步探讨仲景的学术思想,并更好地发掘厚朴的临证价值,故不揣浅陋,试就仲师对厚朴的运用做一浅析。然管窥之见,谬误难免,敬请明哲教正。

一、巧配灵变 法度谨严

仲景对厚朴与它药的配伍组方,绝非随手凑合,而是法度谨严,不仅寓奇巧于寻常,且能开无穷之悟境。归纳可为以下八法:

1、配泻下药泄肠中燥实

燥实积滞于胃肠,不仅阳明腑证多见,内伤杂证亦每有之。此病发作较急,若痞、满、燥、实、坚俱备,常有化火攻心之危。故仲师急用厚朴配大黄、枳实、芒硝,组成大承气汤,峻下以承接一线将绝之气。虽然大黄、芒硝皆为苦寒泻下之峻药,然无厚朴行气除满、宽中消胀为佐,则难以有效地发挥泻下功用,诚如柯琴所云:“……秽物之不去,由于气之不顺也。故攻积之剂,必用气分之药。”^[1]当阳明腑证痞满重于闭实,而无燥坚之象时,却改用小承气汤轻下之,用枳实助厚朴宽中行气、消痞除满为主,以大黄攻下为辅。柯琴谓方分大小有二义:“味多性猛制大,其服欲令泄下也,因名曰大;味少性缓制小,其服欲微和胃气也,故名曰小。”^[1]可见随厚朴和它药配伍的不同,方剂的主治功用则大不一样。至于因胃强脾弱、脾不为胃行其津液而致的脾约(太阳阳明病),仲师又创麻子仁丸。方有执曰:“麻子、杏仁能润干燥之坚,枳实、厚朴能导固结之滞,芍药敛液以辅润,大黄推陈以致新”^[2],诸药共奏润燥通幽之效,与二承气虽均用了厚朴、大黄、枳实,但峻下、润下功效显异。方中的芍药和麻仁、杏仁均为滋液润燥、缓下导滞之品,有一定补益作用,故虚体患燥结症,每为首选之剂。后世很多医家根据该方的组方原则,创制了不少将厚朴和补益药共用治燥结症的佳方,如陶节庵的黄龙汤、吴又可的承气养营汤等,故若将麻子仁丸看作攻补兼施以治燥结症的祖方,实不为过也。

2、配解表药治二阳合病

《金匱》腹满寒疝宿食病篇载:“病腹满,发热十日,脉浮而

数,饮食如故,厚朴七物汤主之。”该证病机为表证未解,而邪复入里,与腹中食滞相合,实际是典型的太阳阳明合病。故仲师用厚朴半斤为君,取其行气化散辛开发泄(张锡纯云“厚朴能上升外达”^[3])之力,外助桂枝以祛表邪,复伍大黄、枳实,共同平满逐滞以除里实,使“表解则里自和,里通则表自解”,并行不悖,互助成功,而开后世表里两解之先河。

3、配降逆药平咳喘、支饮

厚朴有明显降逆平咳喘之效,故仲师不仅在新寒引动宿喘时取桂枝汤解新寒,配厚朴、杏仁宽胸降气、止咳平喘(桂枝亦有降逆平冲作用),标本兼顾而获捷效(《伤寒论》19、43条),且更在《金匱》肺痿肺癰咳嗽上气病篇中创制厚朴麻黄汤,专治“咳而脉浮者”。该方将辛温发散之麻黄、细辛、厚朴、半夏、干姜、杏仁与甘寒凉泄之峻药石膏同用,并伍入酸收之五味子和养心阴的小麦,粗看似嫌杂乱,但细析却知用药曲尽周详。正如李杲所云:“麻黄去风散肺逆,与半夏、姜、辛、五味、石膏同用,为解表行水之剂也。然土能制水,而地道壅塞则水亦不行,故用厚朴疏敦阜之土,使脾气健运而水自下泄矣。杏仁下气去逆,小麦入心经能通火气,以火能生土助脾,而共成决土之功也。”^[4]故该方对寒水浸脾射肺、气机上逆引发的痰浊咳喘,洵为对症良剂。后世一些治气逆痰浊犯肺的咳喘妙方(如《局方》苏子降气汤等)对厚朴的配伍运用,无疑受本方一定影响。另在《金匱》痰饮病篇中,仲师还将厚朴配大黄、枳实组成厚朴大黄汤,用治“支饮胸满者”,为厚朴临床应用又开拓了一条新路。

4、配温通药止胸痹疼痛

仲师据《本经》厚朴主“气血痹”,而将其与温通开结、宣痹镇痛要药配伍,组成薤白桂枝汤,主治“胸痹心中痞气,气结在胸,胸满,胁下逆抢心”之证(《金匱》胸痹心痛短气病篇)。该方以桂

枝、薤白通宣心阳，枳实下气泄痞，瓜蒌涤痰散结；而用厚朴，既可借助桂枝、薤白通宣心阳之功，又可促进枳实、瓜蒌豁痰散痞之力，使阳通气行，痰消痞散，胸痹自解。

5、配和胃药消脘腹胀满

厚朴虽为消胀平满之要药，但因辛温且破散之力较甚，只宜于寒湿壅滞中宫而导致的实性胀满。而仲师却匠心独运，将其用于热证和虚胀。如《伤寒论》79条：“下后心烦腹满，卧起不安者，栀子厚朴汤主之。”则是因邪热客于胸中，不应下而下，致热与气结，壅于胸腹之间，而成实热之胀满，故取栀子以快涌其邪，而合厚朴、枳实以泄腹中之满，亦表里两解之法。而对“发汗后，腹胀满者”，却断为系汗出过多，使胃气虚不能敷布诸经所致，改予厚朴生姜甘草半夏人参汤。程郊倩指出：“发汗后阳虚于外，并令阴盛于中。津液为阴气搏结，腹中无阳以化气，遂壅为胀满。”^[5]故取厚朴宽中除满为君，甘草、人参培补中焦为臣，佐以半夏开结降逆，使用生姜宣通阳气，共奏“益胃和脾培其阳，散滞涤饮遣去阴”^[4]之效。此两方虽皆用厚朴，但一治热实之胀，一治虚寒之胀，泾渭分明，极见仲师配方之妙。另厚朴生姜甘草半夏人参汤所治系“塞因塞用”之法，对后世启悟极大，如李东垣所创枳实消痞丸即此方以干姜易生姜，并加白术、茯苓、黄连、枳实、麦芽组成。

6、配化痰药治梅核气

梅核气是由七情郁结，痰凝气滞上逆于咽而形成，故仲师创半夏厚朴汤。此方用“半夏、厚朴、生姜辛以散结，苦以降逆；茯苓佐半夏利痰气；紫苏芳香，入肺以宣其郁气。”^[6]虽《金匱》将此方列入妇人杂病篇，主治“妇人咽中如有炙脔”，其实男子如患此证，投本方行气化痰、解郁散结，亦可使气舒涎消而炙脔若失。

7、配祛瘀搜痰药治疟母

如疟疾日久不愈,正衰邪恋,反复发作,疟邪假血依痰,结成痞块,居于胁下,即为疟母,证颇难疗。仲师根据本经治疟药多有化痰作用,而取厚朴配半夏、射干、干姜、葶苈等化痰,伍鳖甲、桃仁、大黄及鼠妇等虫类药活血逐瘀,创制鳖甲煎丸,用治疟母,颇能丝丝入扣。因病急邪实,故药多峻猛,但又虑其正虚,复又制成丸剂缓图。仲师这种心小胆大、行方制圆的治方法则,可师可继。后贤治疟母,效法者良多,如严用和《济生方》中的鳖甲饮(鳖甲、厚朴、槟榔、草果、陈皮、乌梅、黄芪、白术、白芍、甘草、生姜、大枣)即是明证。

8、配固涩药治阴吹

仲师还大胆利用相反相成的理论将厚朴和性味功效迥然有异之药共用组方,使相得益彰,更增其效。如《金匱·杂疗方》中将辛温而散的厚朴、陈皮配酸凉敛涩的诃黎勒组成“诃黎勒丸”,主治肾气虚、谷气实的阴吹。取厚朴、陈皮平内实之谷气,用诃子固涩下泄之肾气。(吴仪洛《本草从新》云:“诃黎勒同乌梅、倍子则收敛,同厚朴、陈皮则下气。”)一散一收,并行不悖,实为后世用反佐法组方之滥觞。

二、量变锱铢 组方各异

仲师遣药配方时,对药量极其考究。如厚朴三物汤、厚朴大黄汤、小承气汤三方,尽管药物相同,但因药量的锱铢之异,使方名、方义、功效、主治都发生了重大变化。

在厚朴三物汤中,厚朴重用八两,昂然居君;大黄为其半数,卑然作臣;枳实五枚,悄然为佐使。主治“腹满痛而闭”症。此因气机阻滞,腹部胀满疼痛颇甚,但便秘较轻,故用枳实助厚朴行窜破气为主,而以大黄通便为辅,故方名仅言厚朴而不及大黄、枳实。厚朴大黄汤中,厚朴重用一尺,大黄增为六两,枳实却减为四枚。厚朴虽仍居君为主,但大黄却因剂量之增一跃而大有

与其相平之势，四枚枳实不过助厚朴、大黄除满通便之力而已，故方名为厚朴大黄而不及枳实。两方相比，此意在增加大黄通便之力，使上逆凌肺引起胸满的支饮，通过肺与大肠相表里关系，由大便外泄，饮去则胸满自畅矣。小承气汤中，大黄倍厚朴用四两，厚朴仅二两，枳实更降至三枚，使大黄跃而为君，厚朴屈而为臣，枳实仍为佐使。其主证是肠中腑气积结较甚，但大便并非十分坚硬（故去大承气中的芒硝），且胀满仅局限于下腹而未散逆至全腹，更未影响至中上脘，与厚朴三物汤证相比，满痛明显为轻。故用枳、朴助大黄之攻下，若大便畅行则满痛当随之而减。由于本方主治之症与大承气汤证颇似，方义亦相近，惟因症状较轻而功力亦略轻缓，且厚朴并非主药，故方名小承气而不以厚朴命名。三方对比，正如尤在泾所云：“厚朴三物汤与小承气汤药虽同，但承气意在荡实，故君大黄；三物意在行气，故君朴、枳。”^[7]陈元犀亦曰：“小承气汤是气药为臣，此汤（厚朴大黄汤）是气药为君，其意以气行而水亦行，意深矣。三物汤、小承气汤与此汤药品俱同，其分量主治不同。”^[8]二人所言极是。故研究仲景之方时，不重视其对药量的锱铢之求，是无法掌握他组方的奥秘的。日医矢数道明等曰：“汉方之秘不告人者，即在药量”，信不诬焉。

三、剂型用法 因病制宜

仲师组方时，对剂型和用法也非常重视。在用厚朴组成的十四方中，大抵病情较缓、病程较长、须长期服药者，多用丸剂，如脾约麻仁丸、鳖甲煎丸、诃黎勒丸等。反之则用汤剂（共11方）。而在汤剂的煎法上，厚朴又有同煎、先煎、后煎之异。如在大承气汤、厚朴大黄汤及枳实薤白桂枝汤中厚朴均先下，取其气药先行也；而在厚朴麻黄汤中厚朴却后下，独用其降逆之功（其余七方厚朴均和它药同下）。在服法上，除按常法每服一升，日

三服外,还有“以水七升,煮取四升,分温四服,日三夜一服”,以冀较长久保持药效者(如半夏厚朴汤);更有“以水五升,煮取二升,分温再服”,希图速效者(厚朴大黄汤);另有在方后标明“得吐者,止后服”(梔子厚朴汤)和“呕者加半夏五合,下利去大黄,寒多者加生姜至半斤”(厚朴七物汤)等随症加减法,这些均说明仲师用厚朴的制方,既给人们以准绳大法,又示人以灵活变化,其精微曲折奥妙处,均值得我们认真研讨。

另外,在仲师用厚朴的十四方中,有八方系厚朴与枳实同用,尤其在行气通便的六方中均是两药共投的。由此可知,厚朴配枳实能相得益彰,增强疗效,后贤将二药列入药对,是不无道理的。

结 语

综观仲师用厚朴诸方,大多有气机阻滞、腹胀胸满之症,然其虽以行气除满为主旨,但通过不同的配伍,则可表可里、可气可血、可虚可实、可散可收,不仅能适应疾病的千变万化,且皆获卓而不凡之效。沈孔庭云:厚朴“与陈皮、苍术同用,则除湿满……;与人参、白术、麦芽同用,则治虚满……。又同半夏、胆星,能燥湿清痰;同甘草、白术,能和中健胃;同枳壳、萝卜子能下气宽肠;同紫苏、前胡能发散风寒;同山楂、枳实能疏气消食;同吴茱萸、肉桂能行湿燥阴……”^[9]虽较全面地总结了仲景以后医家对厚朴的运用,但只不过是仲师对厚朴运用的某些延展而已。故在祖国医学史上,最善用厚朴者,张仲景也!我们一定要从仲师对厚朴的应用上,进一步探索他的学术思想,以便更好地造福于人类!

参考文献

- [1]柯琴:《伤寒来苏集》,124页,上海科学技术出版社,1978年。[2]

吴谦等:《医宗金鉴·订正伤寒论注》,133页,人民卫生出版社,1964年。
[3]江苏新医学院:《中药大辞典》,1928页引《医学衷中参西录》,上海人民出版社,1977年。[4]江苏省中医学校金匱教研组:《金匱释义》,79页,江苏人民出版社,1958年。[5]黄竹斋:《伤寒论集注》,85页,人民卫生出版社,1965年。[6]尤怡:《金匱要略心典》,153页,上海人民出版社,1975年。[7]同6,65页。[8]同4,134页。[9]同3,1628页引《本草汇言》。

(马继松、王世峰。原载于《安徽中医学院学报》1985年第1期)。

八 试论张仲景对牡蛎的运用

牡蛎味咸涩,性微寒,归肝、胆、胃三经,《神农本草经》列为上品,谓其“主伤寒寒热,温疟洒洒,惊悸怒气,除拘缓、鼠痿、女子带下赤白,久服强骨节。”张仲景却根据自己的临床经验,有效地扩大了对该药的应用范围。现就《伤寒杂病论》中用该药组成的八首主要方剂试作浅析,不逮之处,明哲正之。

一、配温阳益气药重镇安神,敛汗固脱

伤寒表证的治疗本当遵“其在皮者,汗而发之”之法,然汗为心液,若汗不得法,汗出过多,不仅使心阴丢失,心阳亦将随液外泄,心神失去阳气的温养固护则空虚无主,悸动难宁,甚至形成大汗亡阳、肢厥神昏的虚脱证。此类太阳变证,仲师概称之为“火逆证”,采用桂枝合甘草辛甘化阳,补心益气,组成强心阳的基本方剂以治,其它兼证,随证加减。若心神浮越而现烦躁不宁者,则治以桂枝甘草龙骨牡蛎汤,该方以牡蛎合桂枝、甘草温通心阳,收敛心气,心气因护则汗液自收;牡蛎伍龙骨能重镇安神,摄纳浮阳,则烦惊自除。且龙骨亦有固涩之性,亦能助牡蛎敛

汗,二药相合,组成一绝妙的药对。若汗出太多,心阳亡失致神识失常、烦躁惊狂者,进一步予桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤。本方在上方基础上加生姜、大枣补益中焦而调和营卫,并重用牡蛎至五两(上方仅用二两)以增强潜镇安神、定惊止狂的作用;以蜀漆与牡蛎合用而消痰解郁。上述两证虽皆属误汗耗伤心阳,但证情有轻重之异,故虽同用牡蛎,而剂量与配伍却有较大区别,值得我们重视。后人在治疗亡阳虚脱证时,常用牡蛎,显系受到仲师治火逆证的启悟。

二、配化饮行水药软坚开结,攻散水饮

《伤寒论》394条云:“大病差后,从腰以下有水气者,牡蛎泽泻散主之”。本证是因大病后余邪未尽,下焦湿热壅滞,膀胱气化失常而导致水饮内蓄,发生小便不利,下肢浮肿沉重等一派水气互结之实证。与病后体虚气弱所致的虚肿迥然有别。《金匱·水气篇》云:“腰以下肿,当利小便”,故本方选用牡蛎咸寒入肾,合泽泻可下行水道以渗利,导水壅而除湿消肿;牡蛎伍葶根不仅可涤饮解郁去水气之结,且能滋阴降热,生津止渴,使水热除而阴无伤;葶苈子、商陆、海藻、蜀漆以逐水开结,润下散热。前人虽不常用蜀漆,仲师却两次用牡蛎伍之。考《本草经》虽并未明言蜀漆有化痰之功,然却谓之“味辛、平,主疟及咳逆之寒热,腹中癥坚痞块,积聚邪气,蛊毒鬼注。”《名医别录》亦谓蜀漆“主治胸中邪结气,吐出之。”可见其确有开结消痰的作用,仲师取牡蛎伍蜀漆组成治疗痰气郁结致疟的药对,是值得学习的。今贤有用此方治疗肝硬化腹水证,殆取其逐水软坚双重作用。仲师这种取咸寒药相须为用治疗水饮证的独特方法,极为后贤赏识,如清代程钟龄所创消癰丸,即取牡蛎伍玄参咸寒软坚,滋阴降火,合贝母散痰开结,配伍灵巧,成为治疗痰核、癰疔的著名方剂,恐即悟于此耳。

三、配育阴泻火药平肝潜阳，除热定惊

清代吴仪洛在《本草从新》中称牡蛎“微寒以清热补水，治虚劳烦热”。张仲景在《伤寒杂病论》中取牡蛎组方治疗多种热性疾病，正是取其咸寒沉降，能导热下行之功。如《金匱·百合狐蜚阴阳毒篇》中云：“百合病渴不差者，栝蒌牡蛎散主之。”该病是一种心肺阴虚内热的病证，日久热邪燔灼津液而导致渴症。本方取牡蛎咸寒引热下趋，栝蒌根甘寒生津止渴，二药相伍正可使肺胃热除而津回渴愈。又如太阳伤寒误下，致邪热内陷，弥漫全身，表里俱热，虚实互见之证，虽然三阳皆受邪气，而少阳胆气被郁，相火上炎是其关键，治疗重点是泻肝胆之火而重镇安神，仲师创用柴胡加龙骨牡蛎汤。方取小柴胡汤去甘草和解少阳，桂枝宣表通阳使内陷之邪从外解，茯苓甘淡宁心利水，牡蛎咸寒而定惊，大黄通里泻热，使热邪由大便清泄。清·柯琴释本方证时指出：“龙骨重镇而平木，蛎其体坚不可破，其性守而不走，不特静可以镇惊，而寒可以清烦热，且咸能润下，佐茯苓以利水。又能软坚，佐大黄以清胃也。”后人常用本方治相火上炎、神识失常之癲、狂、痫证均有良效，这显然是与牡蛎泻热镇惊的功用分不开的。吴鞠通仅取牡蛎一味为一甲煎，或将其与滋阴潜阳药相合，组成一甲、二甲、三甲复脉汤及大定风珠以治疗温热余邪未尽致心神失守，谵妄难眠等证。今人常取牡蛎伍龟板、龙骨、赭石、珍珠母、杭芍、菊花、龙胆草等治阴虚肝阳上亢之证，可看作是对仲师运用此法的开拓和深化。

四、配平调阴阳药固阴涩精

牡蛎虽有收敛之功，可治失神诸证，然若单用则效果不佳，故《金匱》云：“……男子失精，女子梦交，桂枝加龙骨牡蛎汤主之”。此方为精亏肾虚阴阳双馁而设，方用桂枝汤补虚调阴阳，牡蛎合龙骨潜阳入阴，交通心肾，阳固阴守，则精自难外泄。徐

忠可云：“桂枝汤外证得之能解肌去邪气，内证得之能补虚调阴阳，加龙骨、牡蛎者，以失精梦交为神情间病，非此不足以收敛其浮越也。”仲师用牡蛎治疗遗泄诸证时常与龙骨伍用，使其效更增。在仲师用牡蛎的十二首方剂中，与龙骨相合之方就有五首，可见仲师对二药合用的重视。这期间的精旨妙义已引起后贤的穷探深研，并不断地有所发挥，如张锡纯对虚劳所致的各种滑脱证常配用牡蛎治疗，其著名的十全育真汤即是典型例证。

五、配养血祛湿药调肝护胎

《金匱》妇人妊娠篇云：“妊娠养胎，白术散主之。”此因胃虚寒湿之邪内扰而致胎动不安，牡蛎既可调肝解郁，又能除湿祛邪，合白术健补脾胃，川芎养血燥湿，蜀椒温中散寒，对于肝脾失和，寒湿中阻者可伺机选用而保胎。《金匱要略悬解》亦称“牡蛎主固胎为使。”其实牡蛎本身并无安胎之功，且《中药大辞典》更谓“蜀椒辛温，有毒，孕妇慎服”，然此处二药相合，可使水邪蠲除而胎自安，亦即《内经》所谓“有故无殒，亦无殒也”之意，不过只可对妊娠期间遭寒湿为害者作权宜之计而服之，不可作一般通用的保胎方。

六、配温阳消痰药治疗牝疟

仲师治疗疟疾有丰富经验，虽然喜用蜀漆这类抗疟特效药，但主要还是通过《本经》牡蛎条“温疟主之”和《别录》云治“虚热去来不定”，而将其辨用于不同疟证，这在牡蛎汤及柴胡桂枝干姜汤中得到了充分体现。牡蛎本身有消痰除湿的作用，而祖国医学又认为无痰不成疟，故牡蛎对消除疟邪应有一定的功效，在和其它化痰截疟药配伍后，其治疟作用则更为增强。今之贤者，根据这种相须为用的原理，创制了不少含有牡蛎的治疗疟疾及肝脾肿大的方剂，这无疑是受了仲师应用牡蛎治疟的启发。

除上述之外，《金匱》中治疗风痰诸疾的侯氏黑散及风引汤

中均用到了牡蛎,无非取其配伍后有祛风、除热、补虚、下痰的作用。此二方现已少用,但若投之得当则效如桴鼓,何任教授曾介绍过他运用候氏黑散治高血压病和风引汤治疗癫痫病的经验,这对我们正确应用此二方启迪良多。

(彭绍荣、马继松、承忠委。原载于《国医论坛》1989年第6期)。

九 张仲景用黄芩清热作用之初探

一、清肺热

黄芩虽为降热之品,却偏清上焦之火。《金匱》曰:“脉沉者,泽漆汤主之。”本方用泽漆、黄芩配桂枝、半夏、人参等温清并用,虚实兼顾,对水饮郁于肺经,久久化热所致痰嗽可望获效。近贤在治肺癌方中常辨证地加用黄芩以清热解毒。《伤寒论》357条中之麻黄升麻汤,用治“咽喉不利,吐衄血”,方取黄芩助石膏、知母清泄肺胃之火,李东垣受其启迪,故“治肺热如火燎,烦躁引饮,昼甚者,宜一味黄芩以泻肺经气分之火,遂按方用黄芩一两煎服,次日身热尽退,痰嗽皆愈。”罗天益遵其师训,指出:“肺主气,热伤气,黄芩能泻火益气利肺。”明代李时珍也因痰热壅肺久嗽,经治罔效,后用一味黄芩而获痊愈。这些验证,殆获益于仲师对黄芩的妙用。

二、清肝(胆)火

黄芩与其它药物相伍,可清肝胆经之火,发越少阳郁热。主要体现在小柴胡汤及其类方中。柴胡气轻擅疏,黄芩味厚擅清,两药相伍,既能疏利肝胆气机,又可清解少阳邪热。汪切庵在分

析该方方义时说：“柴胡味苦微寒，少阳主药以升阳达表为君；黄芩苦寒，以养阴退热为臣。”李时珍也说：“盖黄芩苦寒入心，泻热，除脾家湿热，使胃火不流于肺，不致刑金，即所以保肺也。脾虚不宜者，苦寒伤土，损其母也。少阳证虽在半表半里，而心膈痞满，实兼心肺上焦之邪，心烦喜呕，默默不欲食，又兼脾胃中焦之证，故用黄芩以治手足少阳相火，黄芩亦少阳药也。”又说：“柴胡乃苦以发之，散火之标也；黄芩乃寒能胜热，折火之本也。”杨士瀛更有“柴胡退热不及黄芩”之语，可见柴胡剂中黄芩清肝火的作用，非其它寒凉药可以替代。

黄疸一证，本为瘀热阻于肝胆，外溢于肌肤，或下渗于膀胱所致。《本经》谓黄芩“主诸热黄疸”。因柴胡可引黄芩入少阳而清其邪热，尤其在大柴胡汤中，不仅用柴胡、黄芩相伍，更增入涤荡蕴热的大黄，则清泄肝胆郁热之功更著。今人常以柴胡、黄芩、大黄三药为主，配合疏泄肝胆，清热退黄的药物，治疗肝炎、胆囊炎、胰腺炎等屡见奇功。治疗急腹证的清胰汤、胆道排石汤，均由大柴胡汤化裁而成。

三、清脾热

黄芩有“除脾家湿热”之功。脾家，乃泛指患脾、胃、大小肠等消化系统疾病之患者。这类患者，每因自觉胃脘部塞胀不通，此即所谓痞证。《伤寒论》在太阳病的误治变法中，创苦辛通降一法，作为治痞之大法，代表方为半夏、生姜、甘草三泻心汤。方中取黄芩、黄连清中焦湿热，配干姜、半夏等辛散燥湿，佐参、草益气运脾，故对急慢性胃肠炎，消化道溃疡，消化不良等病投之得当，效如桴鼓。

以黄芩、白芍为主药的黄芩汤，是仲师治疗太少合病兼下利的要方。汪切庵说：“盖合病而兼下利，是阳邪入里，则所重者在里，故用黄芩以彻其热，而以甘芍大枣和其太阴，使里气和则外

证自解。”可见黄芩汤治下利确有显效。后人在此方基础上,又化裁出不少治痢良方,如张洁古的“芍药汤”,即由黄芩汤再加木香、槟榔、黄连、当归、官桂等组成。该方宗“调气则后重自除,行血则便脓自愈”立法,已成为湿热痢疾的首选之方。

四、清血热

《金匱》有:“心气不足,吐血、衄血,泻心汤主之。”尤在泾解释此条曰:“心气不足者,心中之阴气不足。阴不足则阳独盛,血为热迫,而妄行不止矣。”吴鹤皋也说:“治病先求其本,阳毒上攻出血,则热为本,血为标,能去其热,则血不治而自归经矣。”仲师用黄芩协助大黄、黄连清血热,降心火,而达止血之功。由于方简而效捷,故后世宗法者颇多,皆遵仲师之意,咸取黄芩直折火热,以从本求治而达止血目的。又《金匱妇人妊娠篇》曰:“妇人妊娠,宜常服当归散主之。”方中黄芩、白术相伍,不仅可清血热,且能除湿健脾,使邪去而正无伤。尤在泾指出:“妊娠之后,最虑湿热伤动胎气,故于归、芍、芍药养血之中,用白术除湿,黄芩清热。丹溪称黄芩、白术为安胎之圣药。夫芩、术非能安胎者,去其湿热而胎自安耳。”故当归散仅宜于脾弱血热,湿热不化导致胎动不安之证,非泛治一切动胎之方也。后人由此方变通而更多发挥,如王肯堂用本方加生地名当归饮,治疗阳盛血热经水过多,胎动不安证;《奇效良方》用本方加山萸肉以清热调经。这些宝贵经验均值称道。

五、清虚火

黄芩泻实火人所共知,平虚火则易被忽视。然仲师巧将其与滋阴养血药相伍,组成治伤寒少阴病热化证的黄连阿胶汤以疗阴虚火旺所致的“心中烦,不得眠”之证。成无己曰:“阳有余,以苦除之,黄连黄芩之苦以除热;阴不足,以甘补之,鸡黄阿胶之甘以补血;酸,收也,泄也,芍药之酸,收阴气而泄邪热。”虽芩、连

苦寒之品易化燥伤阴,然有阿胶、鸡子黄等血肉有情之品滋阴填精以相伍,则仅有清虚火之功而无伤阴津之弊。本方所倡滋阴清热大法,对后世温病学的治疗产生了很大影响。如吴鞠通三甲复脉汤,大、小定风珠等方的创制,殆缘于仲景也。

六、清瘀热

黄芩是仲景用来清瘀热的常用药物,如治疗瘧疾母的鳖甲煎丸及治疗“内有干血,肌肤甲错,两目黯黑”的“五劳虚极羸瘦”之证的大黄蛰虫丸,即用桃红、蛰虫等活血化瘀药的同时,又配以黄芩、丹皮、大黄等寒凉药而清其瘀热。正如李士材所云:“劳伤之症,未有无瘀血者也。瘀之日久,则发为热,热涸其液,则干粘于经络之间,愈干愈热,愈热愈干,而新血皆损。”可见瘀热是气郁血滞日久的必然结果,祛瘀当莫忘清热。大黄蛰虫丸及鳖甲煎丸,至今仍用于脑血栓形成,再障及肝肿大等病证的治疗,其机理即因此焉。

七、反佐

仲师在《伤寒论》333条中虽指出:“伤寒脉迟”者若用黄芩汤清其热,可引起“除中”之危证。然《金匱》中治脾气虚寒之远血证的黄土汤却用了黄芩,显然,黄芩在该方中的作用和在其他方中所起作用已相去甚远了。尤在泾在《金匱心典》中指出:“下血先便后血者,由脾虚气寒,失其统御之权,而血为之不守也。脾去肛门远,故曰远血。黄土温燥入脾,合白术、附子以复健行之气,阿胶、生地黄、甘草,以益脱竭之血;而又虑辛温之品,转为血病之厉,故又以黄芩之苦寒,防其太过,所谓有制之师也。”用小量黄芩以取反佐之功,此又为一法,值得学习应用。

(彭绍荣、承忠委、马继松。原载于《浙江中医学院学报》1990年第4期)。

卷二 前贤学术评析

一 程钟龄治痰探析

程国彭,字钟龄,别号普明子,清·康熙、雍正年间天都人(今安徽歙县)。他“博极群书,自《灵》《素》《难经》而下,于先贤四大家之旨,无不融会贯通”,并将“平日所得者,一一笔之于书,间有未缜细者,必绳削之,至于尽善而后已”,如此历经三十余年,乃编成《医学心悟》一书。书中对不少病证的辨治都提出了超人之见,对痰证论治多有阐发。今试就此作蠡测之析,不逮之处,请明哲正之。

运脾阳 和胃气 以绝生痰之源

痰由湿生,湿由脾运,故前贤有“脾为生痰之源”之说。丹溪亦云:“治痰不理脾胃,非其治也。”程氏宗之,认为:“治痰须理脾,以痰属湿,脾土旺则能胜湿耳。”从而提出“湿痰滑而易出,多生于脾,脾实则消之,二陈汤,甚则滚痰丸;脾虚则补之,六君子汤,兼寒、兼热,随症加药”的治法。

二陈汤出自《局方》,至程氏已习用六百多年,但他对该方的运用,既循仲景“病痰饮者,当以温药和之”,又能灵活化裁,赋予新意。如对类中门的湿中,他指出:“湿中者,即痰中也。凡人嗜食肥甘或醇酒乳酪,则湿从内受。或山岚瘴气,久雨阴晦,或远行涉水,坐卧湿地,则湿从外受。湿生痰,痰生热,热生风,故卒然昏倒无知也。苍白二陈汤主之。”因湿邪聚脾,上干清窍而致类中者,徒清神舍是难以建功的,故用二术合二陈汤健脾燥湿以断生痰之源,病自可愈。另对身痛因湿困所致者,亦主此方。在

中风门不语条中,他指出,“若因风痰聚于脾经,当导痰涎,二陈汤加竹沥、姜汁,并用解语丹”以健脾燥湿、豁痰醒窍,标本兼顾;对“腰间肿”、“胸膈不利”、“神志昏愤”以及嘈杂诸证,均有从痰辨治之法,方以二陈汤加减。对妇人恶阻伴“眩晕呕吐,胸膈满闷,”多断为“中脘停痰”,对体质不虚者,大胆的投以二陈汤加枳壳,并自云:“其半夏,虽为妊中禁药,然痰气阻塞中脘,阴阳拂逆,非此不除,以姜汤泡七次,炒透用之,即无碍也”。其对半夏的炮制可谓独辟蹊径。另程氏多取六君子汤健脾化痰,如眩晕门云:“有气虚夹痰者,书曰清阳不升,浊阴不降,则上重下轻也,六君子汤主之。”前贤论眩晕之因,虽有主痰主虚之异,然程氏则融各家之说于一炉,以六君子汤既补脾虚又化痰湿为主方,随证加减,妊娠子眩、子痫、产后不语等病,程氏在各病主方后,常佐此方,以治病兼脾虚夹痰者。

宣上焦 润肺燥 以清贮痰之器

程氏云:“肺体属金,譬若钟然,钟非叩不鸣”,内外邪气袭肺鸣钟,则当去其鸣钟之具也,所谓鸣钟之具,以痰湿为多,故其对痰湿犯肺致咳者,多以所创名方止嗽散祛痰为先。该方由桔梗、荆芥、紫菀、百部、白前、陈皮、甘草组成,重在止咳化痰,兼以疏表宣肺。其自云:“本方温润和平,不寒不热,既无攻击过当之虞,大有启门驱贼之势。”唐容川亦谓此方“温润和平,不寒不热,肺气安宁”,故加减变化,能治“诸般咳嗽”。程氏对该方不仅按风、寒、暑、湿、燥、火六淫之邪进行加减,还根据外感之咳久不已则移于五脏六腑的特点,按《内经》十二经见证予以加减,对内伤七情之咳亦有很多恰如其分的加减法,可谓曲尽周详。

程氏还云:“大抵痰以燥湿为分……燥痰涩而难出,多生于肺,肺燥则润之,贝母瓜蒌散。”考燥痰之生,多因阴虚化火,灼津为痰,伤犯肺金所致。程氏遵“燥者濡之”之理,取贝母、瓜蒌甘

润苦泄、止咳化痰；花粉清热生津而润燥；配茯苓、橘红、桔梗共收热清痰消、肺润气肃之效。在类中风篇中，程氏另列贝母瓜蒌散（贝母、瓜蒌、黄连、山栀、胆星、橘红、甘草），以其主治“肺火壅遏而致火中”之证，但略予加减，还可借用治燥痰犯肺的咳嗽及痰火导致的神志病变。两方虽主药相同，却因佐使药物之异，主治、功效均判然有别，最须学者细细玩味。

温肾阳 滋肾阴 以治主水之脏

经曰：“肾者水脏，主津液。”又曰：“痰之本，水也，源于肾。”可见肾阳的盛衰与水液的蒸化、痰浊的生成关系密切。程氏指出：“若肾虚水泛，为痰为饮者，必滋其肾。肾水不足则用六味，若命门真火衰微，寒痰上泛者，则用八味肾气丸，补火生土，开胃家之关，导泉水下流而痰饮自消。”对癆证引起音哑，即“金破不鸣”之证，亦用六味滋肾水，更佐通音煎（胡桃、川贝、款冬、白蜜）温肾阳、益肾阴，辅以润燥化痰。对久咳恐成癆瘵者，常取知母、贝母、柴胡、前胡、杏仁合团鱼制成团鱼丸，用麦冬汤送服，不仅使肺肾之阴皆补，且能疏肝化痰，其丸药的制法和服法均具巧思。对阴虚发咳服一般药鲜效者，又创用月华丸，取二冬、二地、山药、沙参滋肾益阴，使金水相生；用贝母，百部润肺化痰；桑叶、菊花载药上行；茯苓培土生金、健脾化痰且防阴药之滞；三七祛瘀止血，更助滋补之力；尤独取獭肝合阿胶等血肉有情之品，既填精润燥以固本，更可杀瘵虫、止血出而顾标；全方从上、中、下三焦同时入手，面面俱到，实为程氏匠心之作，其自云该方为“阴虚发咳之圣药也”，实不为过。

搜经络 涤窍舍 以祛顽痰痼疾

李时珍说：“痰涎为物，随气升降，无处不到，入心则迷成癲痫……入经络则麻痹疼痛……入皮肉则瘰癧痂疽。”故前贤有“百病皆为痰作祟”之说。程氏针对痰邪致病的这种特点，拟出

了多首相应的治痰之剂。

丹溪云：“无痰不作眩”，程氏更云：“眩晕有湿痰壅遏者，书云头旋眼花，非天麻、半夏不除是也，半夏白术天麻汤主之。”本方在二陈汤基础上配白术健脾和胃以畅枢机，合天麻平息掉眩之肝风，于证极合。癫痫为临床棘手之证，前贤从痰立论者虽多，而程氏却进一步指明乃“痰涎聚于经络也”，并创定痫丸，不仅主治“男、妇、小儿痫证”，还云：“癫狂者亦有服此药而愈者。”方中菖蒲、远志豁痰开窍；川贝、南星、竹沥清痰热而除惊烦；天麻、全蝎、僵蚕熄风化痰通络；茯神、丹参、麦冬、琥珀宁心安神；辰砂“重可去怯”；二陈健脾化痰。共使痰去神清，痫证自宁。另一治痰名方“神仙解语丹”，亦是由化痰通络药为主所组成，专治风痰阻络不语证。而由定痫丸损益组成的生铁落饮，则更是独出心裁的治狂名方。对痫证发作后精神不振，久而不复，他又在大补精血、益气养神的同时辅以化痰，所创河车丸亦为后人常用。他还用由细辛、皂角、半夏所组成的搐鼻散取嚏，治“一切中证，不醒人事”的厥证，从而为中医治疗痰厥急证又开辟一条新路。

程氏还擅长从治痰入手，治一些外科顽疾。如“瘰癧，……乃肝火郁结而成，宜用消瘰丸，兼服加味逍遥散”，方中贝母消痰散结；牡蛎软坚散结；玄参滋阴降火。自云：“此方奇效，治愈者不可胜计。”由于程氏考虑到很多顽痰怪证系痰阻经络窍舍而生，而丹溪又有：“痰夹瘀血，遂成窠囊”之论，故常将活血化痰药配入治痰方中，如前所分析的定痫丸、解语丹、生铁落饮、河车丸中均有祛瘀之品。程氏这些宝贵的经验值得借鉴。

（马继松、朱华、冉铁。原载于《中医杂志》1984年第12期）

二 吴鞠通治痰饮浅探

吴鞠通氏,不仅为温病学之大家,且对内伤杂证颇多创见。兹不揣浅陋,仅就《温病条辨》(简称《条辨》)和《吴鞠通医案》(简称《医案》)中有关痰饮的论治,试作蠡测之析。

一、治内饮,宗“饮属阴邪,非温不化”

1. 辛散逐饮

吴氏认为:“饮家反渴,必重用辛,上焦加干姜、桂枝,中焦加枳实、橘皮,下焦加附子、生姜”。其中精神虽仍为“病痰饮者,当以温药和之”,然却更为具体化了。其对半夏、桂枝、干姜、附子、细辛、麻黄等不仅用之极频(如在痰饮门 38 案 346 诊次中,用半夏 219 次,桂枝 135 次,干姜 73 次),且用量之巨亦属罕见。《医案》痰饮门第 10 李案:“脉弦细而沉,咳嗽倚息不得卧,胸满口渴,用小青龙去麻、辛法:桂枝六钱,小枳实七钱,白芍四钱,干姜五钱,半夏一两五钱,五味子二钱,茯苓一两,广皮三钱,炙草三钱。”所用方药和他强调指出的“饮属阴邪,非温不化”的理论十分吻合。其对外寒内饮者,总投以小青龙汤为治,但又云:“脉微有汗,小青龙汤去麻、辛主之;大汗出者,倍桂枝减干姜加麻黄根”,“恐成漏汗,则阳愈虚,饮更难愈”。较仲师对小青龙汤的运用,更为细致入微。近贤蒲辅周治冬令外感寒邪,失于及时辛散,使寒郁表闭,表郁化热,咳呛汗多者,在运用麻杏石甘汤时,亦常配麻黄根,取其和卫止汗,能通能涩。认为麻黄根味辛涩,有宣通肺气、固正达邪之功。此种用法,颇为精巧,然考其源,殆出自吴氏。

2. 温中蠲饮

《条辨》中焦篇 50 条所列“寒湿伤脾胃两阳,寒热不饥,吞酸

形寒,或脘中痞闷“的痰饮症状,吴氏倡用苓姜术桂汤。此方乃系苓桂术甘汤化裁,考原方为仲师治中脘痰饮的代表名方,但甘草未免有“甘满壅中”之嫌。后学因过尊仲师,无人敢越雷池一步,独吴氏却以生姜之辛温易甘草之甘壅,虽一味之异,既避免了“中满忌甘”之弊,又与“饮当和以温”之旨甚合,非学验俱丰者难如此贴切。再以其创制的蠲饮丸,药用桂枝半斤,小枳实四两,干姜六两,苍术炭六两,茯苓半斤,半夏半斤,益智仁四两,广皮十二两,炙草四两,共末以神曲糊丸。药虽十味,却熔《金匱》干姜半夏散、橘枳生姜汤、苓桂术甘汤(以苍术易白术)、局方二陈汤为一炉,加益智仁温肾水而暖中土,方以大剂桂枝为君,取其温肾通阳、利水下气之功(邹澍《本经疏证》云桂枝“温通经脉此其本也”。其用有六:和营,通阳,利水,下气,行淤,补中),亦中下二焦同治之法。北宋名医许叔微曾以一味苍术自愈膈中停饮之宿疾(许称之为“癖囊”),李时珍谓苍术能燥“湿痰留饮”。《玉楸药解》更云:“白术守而不走,苍术走而不守,故白术善补,苍术善行。”吴氏以苍术易白术,盖得之三家之说,并予以发挥,可谓善学者也。且对此方的运用,亦灵变巧思,曲尽其妙。如《医案》便血门陈案中,他将蠲饮丸中的干姜炮制成炭,加苡仁用治“阳虚脉弦,素有寒湿痰饮”,收“通阳渗湿而补脾胃”之效。叶桂在《临证指南医案》中,对“脾胃俱伤,食物少运,怯冷畏寒”者,指出“中焦阳气已虚,虽有痰饮留伏,不宜过于克削”,药用人参、白术、甘草、益智仁温补脾阳,半夏、陈皮、茯苓、木香和胃蠲饮,以求补中有泻,标本兼顾。吴氏蠲饮丸和叶桂上方虽有一脉相承处,但因重用了桂枝、干姜、苍术,故温阳化饮,健脾燥湿之功明显提高。可见吴氏不仅在治时令病时取法叶桂,对杂病的施治受其影响亦颇多。

3. 壮肾化饮

对肾寒特甚者,他又常用真武汤化裁,温肾以助脾。如《医案》痰饮门颜某二诊:“呕凉水,于前方(真武汤)内加干姜二钱(合前为五钱)、广皮三钱以消痰气”。并谓:“兹证不惟不渴,反呕凉水不止,其为寒饮无疑。既真知其为饮,虽重用姜桂何惧乎?”又如治邵案:“其少阴独盛,水脏盛而土气衰也。”明确指出“治在胃肾两关”,用“真武汤法”而变其方,将熟附用至五钱,细辛用至一钱半。其治痰饮,用药虽偏善温散,但却极有分寸,从不浪投。如邵某复诊案云:“内饮用温水脏法,已见大效。但药太阳刚,不可再用。所谓一张一弛,文武之道。”在疾病缓解以本虚为甚时,又常以培补脾胃为主,参以温阳化饮,取金匱肾气丸、苓桂术甘汤,外台茯苓饮以缓收良效。足见其不但行方智圆,且更胆大心细。

二、治外饮,持“甘寒肃降,宣肺利导”

1. 外饮肺热宜清宣

吴氏治饮,从不拘于一法,对热饮则投以寒凉。自云:“饮病当温者十有八九,然当清者亦有一二”。在《条辨》下焦篇 48 条曰:“喘咳息促,吐稀涎,脉洪数,右大于左,喉哑,是为热饮,麻杏石甘汤主之。”又如《医案》痰饮门第十九吴案:“六脉洪数,右寸独大,酒客痰多”,断为“肺热之至”,投生石膏一两,半夏五钱,苡仁五钱,杏仁五钱,茯苓五钱,防己三钱,前后十余剂,用石膏三百数十两。对用小青龙治饮获效,但“喉哑知渴,脉现微数,为饮欲去”的患者,他常转用麻杏石甘汤,宗辛凉开提肺气而涤余饮。吴氏还喜将大青龙汤与木防己汤相合去麻黄,治“风寒解而饮未除,脉复洪大”者,并参入淡渗之滑石、木通、茯苓皮,理气化饮之陈皮、半夏、枳实而获效更捷。

其治外饮极喜用石膏,取甘寒肃降,宣肺利导(《本草再新》云:“石膏可利小便”)之功。但用量均据症而定,如第五十二诊

中云：“脉之洪大者，得石膏一斤病大减，病减者减其制，俟脉复洪大有力再酌加其制”；另外他还宗丹溪“大凡治痰，用利药过多，致脾气虚，则痰易生而多”之理，强调“痰饮误用苦寒，易致胸闷短气，便闭不食”，故其虽重用生石膏，却极少同时配知母，恐成白虎汤，于饮不合（他曾立白虎汤之四禁：即脉浮弦细；脉沉；不渴；汗不出不可用）。真乃善用石膏者也！

痰饮兼挟风温症者，吴氏每先投疏解卫分邪热之辛凉表药。如痰饮门最后某案，因“其人本有痰饮喘咳，又感风温”，便“暂与辛凉清上”，投银翘散。此虽系“急则治其标”法，然内里之饮，常可随汗出而缓解，即前贤所谓“表解里自和”之意也。若以治饮为急，反有引邪内陷之虞，学者亦须重视。

2. 外饮内结需下导

吴氏对“三焦俱急，大热大渴，舌燥，脉不浮而躁甚，舌色金黄，痰涎壅盛”者，又不过囿于甘寒，或用承气合小陷胸汤，荡涤三焦，或用葶苈大枣泻肺汤，甚至控涎丹（又名“妙应丸”、“子龙丸”）。如第27“酒客痰饮哮喘”觉罗案中，因“脉弦紧数，急予小青龙去麻、辛加枳实、橘皮汤，不应，右胁痛甚”，故断为悬饮，而用“甘遂、大戟、白芥子各五钱共末，神曲糊丸如梧子大，先服十三丸，不知，渐加至二十一丸，以快便下绿黑水为度”，终于“三服而水下喘止，继以和胃收功”。该案对控涎丹的运用极具匠心，此乃“必伏其所主，而先其所因”耳。可见吴氏仍时时以辨证为念的。

三、涤悬饮，主“攻下逐饮，疏肝通络”

1. 逐饮亦需理气血

肝主疏泄，体阴用阳，疏泄太过与不及均可影响水液的输布与运化。正如李时珍所云：“风木太过，来制脾土，气不运化，积滞生痰。”朱丹溪更指明：“善治痰者，不治痰而先治气。”可见前

贤对痰饮求治于肝早有认识,并为气郁生痰立下规范性治则。吴氏探究其理,认为“有肝郁者必克脾,脾受克者必停饮”。并提出“病悬饮者,治在肝也”,将悬饮的病位更加明确在胁肋的范围,这为临床施治提供了极大的方便。在用药上,他不仅宗蒋宝素“六淫外人之痰,可攻可伐”之理,对体壮饮盛者,时用十枣汤荡涤攻饮,逐水化淤(《药性论》大戟“善治淤血;”《本经》甘遂“破症坚积聚”;《药性论》芫花“主通利血脉”),而且还自创香附旋覆花汤,取二药理气血,逐胁下之饮;辅以杏仁、苏子降气化饮,建金平木;佐陈皮、半夏、茯苓、苡仁健中化浊以杜生痰之源。腹满者加厚朴以行气,痛甚者加降香末以降逆。本方“宣肝络以开郁,和胃气以化饮”,有“两和肝胃”之妙,加减可治伏暑,湿温,积留支饮悬于胁下而成的胁痛之证,还可治肿胀、积聚、痰饮、胁痛等杂病,验案累累,得心应手。该方比仲师旋覆花汤既药众力逮,照顾全面;又较十枣汤持之以平,有执中之美。更须提出的是,其对该方的化裁亦颇精究,常进一步配理气降逆、活血化淤之青皮、枳实、郁金、当归、白芍、新绛、桃仁、桂枝等,使收效尤捷。如第22舒氏案:“痰饮喘咳夜甚,胁痛少腹亦痛,溺浊,水在肝也,经谓之悬饮。悬饮者,十枣汤主之,恐其太峻,宗其法而不用其方”,以香附旋覆花汤去杏仁加枳实、降香。这种遵先圣之理而广先圣之用的精神,值得吾侪学习。

2. 搜络逐淤以祛痰

对诊为“肝经络淤挟痰饮”者,又创新绛旋覆花汤。因此证多系肝气郁滞,久病入络,导致津液不布反化痰,血行不畅凝成淤,引起患者常咳嗽呕吐。故吴氏本仲师肝着之意,悬饮之论,参照叶桂辛润通络法的用药经验(轻者旋覆、新绛,归尾、葱管;重者桃仁、红花、柏子仁;有热加丹皮、焦栀、川楝子、青蒿根、夏枯草),在“饮当温药和之”前提下,取新绛、桃仁、归须、旋覆花,

活血化淤专治标；陈皮、半夏燥湿健脾兼顾本；独取辛酸寒之丹皮，既可反佐以防它药辛温燥散，又能疏肝和血而通经络。若与香附旋覆花汤配用，更有珠联璧合之妙。

四、防留饮，需“攻补适中，圆机活变”

1. 避甘壅之碍脾运

周学海曰：“饮者水也”，故知饮皆由湿化生。湿性粘滞重着，最难速去。化生饮后，又能变生百疾。使饮之为病，既复杂多变，又难短期痊愈。然前人习遵仲师之法，治饮时喜投参、草，使脾健而饮消，然有效有无效。吴氏有鉴于斯，通过长期实践，认为饮证不宜早补，中肯提出：“古人云劳者温之，是甘温调营卫而复胃气，胃旺进食，久久自愈。”故不仅大胆地以生姜易苓桂术甘汤中的甘草，蠲饮丸立方时取苍术弃白术，且在用仲师木防己汤时，均去人参，皆唯恐壅遏中土，使饮留不去。对虚实夹杂、虚多实少之证，多宗景岳“两虚一实，先治其实，网开一面”之言立法，先实后虚，井然有序。如在“饮愈八九，服参加剧”的第29钱氏案中，认为前医“所用之药，大抵不出乎补中焦之外，愈治愈胀，愈治愈痛，以致胸高不可以俯，夜坐不可以卧”，大声疾呼：“势急矣，断非缓药所能救”，而用巴豆霜三分，下黑水近一桶，俟势稍平，方以和脾胃调之，给治饮蛮用温补者以当头棒喝。在第30赵案44诊中说，“服石膏至五十斤之多，而脉犹浮洪，千古来未有如是之顽病，皆误下伤正于前，误补留邪于后”，进一步针砭了误补使留饮不去之弊。在《医案》痰饮门246诊次中，从未用人参，仅有两案三诊在逐去饮邪改用外台茯苓饮调理时才参入洋参二钱，略予补益，恐饮去过多而阴伤燥烦也。

2. 诚阴柔防助生饮

至于滋腻柔润之补阴药，除益脾而能于土中泻木，又能敛肺止嗽的焦白芍外（王好古云：白芍“治肺急胀逆喘咳”），麦冬在饮

去后调理方中仅用数诊,余几乎未见其用。在第24董案中云:“脉沉细弦弱,咳嗽夜甚,久而不愈,饮也”,强调“最忌补阴,补阴必死,以饮为阴邪,脉为阴脉也”。在痰饮咳嗽又吐血三年不愈的第20严案中:“经谓阳络伤则血上溢,要知络之所以伤者,有寒有热,并非人之络只许阳火伤之,不准阴火伤之也”。痛切地指出:“今人见血投凉,为医士一大痼疾。医士之疾不愈,安望病家之疾愈哉!”而用炮姜三钱,桂枝三钱,姜夏六钱,陈皮三钱,焦白芍三钱,茯苓五钱,五味子二钱,枳实二钱取效。在第21壮年阳痿陈案中,通过“眩冒昏迷,胸中如伤油腻状,饮水多则胃不快”,断为“伏饮眩冒证”,痛斥前医:“岂有脉俱弦细,而恣用熟地久服六味之理哉!”并根据弦为饮脉,先予白芍泽泻汤逐其饮,再议治湿热愈阳痿。上数案的辨证立方,均卓尔不凡,给人良多启迪。

尾 语

众所周知,吴瑭为温病学大家,其创制的名方后世所熟悉者,皆系桑菊饮、清营汤、沙参麦冬汤、大小定风珠等辛凉滋阴之类。其实从其临证治案中可以窥见其学说全是继承仲师学说而来,并予以发展的。笔者通过其对痰饮的治疗,将吴瑭的学术渊源作一简介。由于水平有限,难免挂一漏万。如其治痰饮,常宗仲师宣畅胸阳的萎薤桂枝汤法;遇痰饮又有须下之症,则常将下法寓于清宣之中,取仲师白虎、小陷胸、承气三汤之意,创宣白承气汤(石膏、大黄、杏仁、瓜蒌),这些均值得很好重视。另他不仅用《金匱》泽泻汤治伏饮眩冒,还将该方加半夏、茯苓、竹茹、枳实、天麻以治此病,此法与程钟龄治湿痰眩晕的半夏白术天麻汤各臻其妙。又如对仲师责之胃肠津枯,而用猪膏发煎治疗的妇人阴吹病,他却指出:“脉弦而迟者”,当从苦辛淡立法,创橘半桂苓枳姜汤,这些又是对仲师学说的发展了。总之,吴鞠通之所以

能成为一代医家,和他“抗志以希古人,虚心而师百氏”有极大的关系,这也正是我们这一代人需要从他身上汲取的精神食粮。

(马继松、朱华。原载《安徽中医学院学报》1985年第4期)

三 金子久辨治痰饮病特色

清末名医金子久,名有恒,大麻人(今浙江桐乡县),学验俱丰,医德高尚,尤擅辨治痰饮。据笔者粗略统计,《金子久专辑》(简称《专辑》)录其案110则,涉及痰饮辨治达87处。《清代名医医案精华·金子久医案精华》(简称《医案》)中,录151案,论及痰饮之辨治达74处。他常通过对痰、饮之量、质、色、味的详察细审,结合其它症状,作出正确之诊断。今就《专辑》和《医案》中诊断痰、饮的经验作刍议于后,望高明正之。

一、辨痰、饮之量,当视有无多少

金氏认为痰量较少,质粘难出,甚至无痰者,大多系阴伤液少或感受温邪。如《专辑》风温门4案曰:“大衍余年,阴液始衰,风温病将经月,咳逆反复蝉联。痰粘难咯,肺气无肃化之权;唇焦齿干,胃液有枯槁之象。”结合患者大汗伤戕真元,脉重按无神韵,舌中腻而边尖光绛,认证为“虚多邪少,调治极幻”,实乃风温伤津化燥之故,未妄用治风温之通套方药,而亟投润燥生津,涤痰调气之品。有时患者虽一时痰量较少,但他未一概断为燥热或阴虚,而是细辨它证。如系有痰而未能畅快排出者,反佐用排痰之品。如《专辑》伏暑门1案,虽见“气逆咳多痰少”,但他由病者“先厥逆反昏乱,脉弦劲数大,苔糙燥不润,大便水多粪少”,遂指出“腹上之痰未删,腑中之垢未尽,今夜当虑变端”。故在投俞

氏羚羊钩藤汤的同时,以胆星、杏仁、郁金等清涤痰热之品易去生地,出险化夷。

《金匱》曰:“水走肠间,沥沥有声,谓之痰饮。”金氏在《医案》温病门1案中,即根据“腹笥转侧有汨汨之鸣响,”并参合脉滑,断为“下焦肠部为痰所阻”,显系温邪伤阴又夹痰浊,且刻诊“痰益聚益多”,用药颇难措手,思虑再三,以桑菊增液汤合石膏、西洋参沃液救焚,配入杷叶、桔红、竹沥以涤痰,可谓两全其美。

二、察痰、饮之质,须观稀薄稠浓

金氏对痰质之辨亦十分重视。如《医案》咳嗽门1案,即根据“晨起痰先浓后薄”,结合便溏,脉濡细滑,苔薄黄腻,断定为“脾胃湿痰”,予二陈汤扩充治愈。温病门1案,患者现“神识时常昏昏欲寐”,然细察之,“寐则手指并不动跃,醒则身体殊多展侧,”且脉滑、舌满苔厚腻润泽,大便四日未更,故金氏当机立断,认证为“胶固之痰,氤氲于内”(指肠道),而并非是热入心包。《专辑》暑湿门2案,因“疹痞赤白并现,遍体磊磊密布,身热蒸蒸如燎”,似乎应予清气化湿之法,但金氏进一步详询,始知患者“粘痰欠豁”,且烦扰少寐,唇燥舌干,便秘脉滑,方悟“阴液已受戕伤”。故在辛凉解肌的同时,佐入甘寒清邪。其辨证之精细,立法之周全,庸医焉可及也。

张景岳言:“痰之与饮,虽曰同类,而实有不同也。……饮清彻而痰稠浊。”以致多数后学咸以为凡痰质稀薄,均应遵“病痰饮者,当以温药和之”之大法遣药,然金氏对此说并未盲从。如《专辑》痰饮门12案,患者痰的“形色状似稀涎”,但却伴有音嘶声哑,茎缩洩沥,咽喉燥痛,脉弦滑,重按殊少神力,故尔认为,此声嘶“诚属金碎不鸣”,而造成“金碎不鸣”之因,却系金为火煨,木失水涵,他非但未用二陈、苓桂术甘等温化,反随证予以秋石、川贝、淮膝、杷叶等清养肺阴,这种时时不忘先全面辨证,后议法立

方的做法，亟值继承发扬。

三、望痰、饮之色，应别白黄绿红

金氏对痰色之辨亦极重视。如《专辑》咯血门1案，由“风邪伤肺，阻气作咳……已见痰血”，结合“脉象左缓右数”，断为阳络因咳剧而受损伤，故指出“当以清肃顺气为要义。”由于辨证准确，自然疗效显赫。再如《医案》咳嗽门曰：“痰秽带绿，肺热而兼胃热也”；而《专辑》热毒发斑门1案云：“先吐粉红色，后吐灰黑色，所吐痰水粉红……是酒热伤及胃络。灰黑者，是酒热伤及胃底。”故前案用白虎苇茎汤去桃仁，合犀角、石斛、败酱草、大青叶等；后案投银花、连翘、犀角、桃仁、丹皮、茅根、竹茹、人中黄、丝瓜络等。两方虽均用清热解毒，但一配以滋阴排脓，按肺痈论治；一伍以凉血祛瘀，仿血证投药，同中有异，显系由痰色带绿与粉红而确定用药大法的。这种不忽于细微症状之异，而又善于鉴别的做法，极值我们仿效。

四、鉴痰、饮之味，必重腥臭甘咸

金氏通过临证，更充分认识到辨痰、饮之气味的重要性。故有时虽痰“臭秽不可瞻视，人所恶见者”，他却能亲予闻诊。如《医案》咳嗽门14案：“咳嗽肋痛，痰出臭秽”，参合“脉滑数大，苔黄带白，冷热便艰”，认证系肝气夹痰火犯肺，并指出：“欲求治咳，必先顺气；欲求顺气，必先潜火。”所投清燥救肺汤的确十分合拍。《专辑》痰饮门7案则由“痰带甜气”伴“动辄短气……，肢冷而形寒，……咳呛而痰多，脉象沉弦，舌苔滑白”，遂断为“乃脾家外饮无疑”。他考虑命火衰微，则脾湿不化，气海少纳，则易致喘促。故在用二陈合苓桂术甘汤，温消脾饮的同时，更增入干姜、磁石、牛膝、五味子及青娥丸等温肾纳气，获效卓著。它如“痰有腥气，是膈上留饮化热”；“痰味非咸，定非水泛为痰，”均是以痰之气味为主症，结合它症，决定治则的。这为平素忽视闻诊

的医者,树立了良好的典范。

尾 语

由于金氏治学,既上宗《内经》、《金匱》之经旨,又旁涉金元明清百家之杂说,故在对痰、饮之量、质、色、味的辨证上,积累了较多经验。然因疾病之千变万化,故临证时他还每将痰、饮的量、质、色、味结合参看,以求提高辨证的准确性。如《专辑》痰饮门 11 案曰:“痰如稀涎,气味带咸,非特脾湿化饮而肾亦酿痰。”他参照咳呛纳少,形瘦便溏,舌苔薄糙微黄,左脉柔小,右脉滑大,认证为阴虚积饮,而予西洋参、麦冬、石斛、白芍合二陈汤扩充,方药可谓丝丝入箝。又如 13 案虽明言:“刻下喉中痰声如锯,颇不爽利,粘如胶漆,此痰非虚痰也……,抑且痰无咸味,气逆能卧,此气非肾气也。”似乎可判作纯实之证。然细诊“脉象滑大,不满五十至而代”,故断为“五脏真气已散,诸气逆乱以上,喘脱在即”。遂急投入参竹沥汤,扶正祛邪以双顾。因重视了这一“独处藏奸”之症,故而避免了虚虚之误。如此四诊合参之佳案,令人叹为观止。再如《医案》咳嗽门 14 案曰:“痰绿痰黄,乃胃家湿火所化;痰臭痰浓,亦胃家湿火所生。”13 案曰:“前日吐血盈盏,现在痰血夹杂,痰味或秽或咸,血色乍鲜乍紫”等,均是将痰的质、色、味结合辨证的。因限于篇幅,恕不再作细析了。如能细阅《专辑》和《金子久医案精华》,将使我们辨证痰、饮的能力,得到明显的提高。

(马继松、承忠委。原载于《北京中医学院学报》1987 年第 6 期)

四 雷少逸治痰病摘要

晚清名医雷少逸(1833~1888),名丰,父逸仙为名医程芝田(曾著《医法心传》)入室弟子,并辑《医博》四十卷。年幼时随父由福建移居浙江衢县,并从其学,且虚心请教他人,勤于临证,渐学验俱丰。因感“医书充栋,而专论时病者盖寡”,故谨承其父“若不于时病之法研究于平日,则临证未免茫然无据”之训,半百后著成《时病论》八卷。“是书以《素问·阴阳应象大论》中“冬伤于寒,春必病温……秋伤于湿,冬生咳嗽”八句经旨为纲,集四时六气之病为目”,自拟治法六十则(一法即为一方),附治案八十七则。其用药均仅数味,多价廉易得,极少冷僻怪诞之品,于组方之理,亦简明晓畅,易学易记。虽名《时病论》,但内伤杂病若辨证明晰后选用之,每能于平淡中见奇效。颇值后人一读,尤利于初学者。今仅就其对痰证的辨治,略陈学习心得,愿同道正之。

一、治痰先详辨证

1. 重视痰性体质

雷氏临证常根据病人的痰性体质处方用药,每收佳效。携李张某赴宴后腹痛作泻,伴暖气频作,断为伤食使脾胃升降失和所致,遵薛立斋治刘进士用六君子加木香法,佐山楂、枳椇子,但二剂痛止泻却未住。考虑患者“年逾五旬,素来痰体”,不仅伤食且夹痰邪为患,故于原方加苍术、厚朴以运脾燥湿化痰,果二剂即瘳。又如南乡余某,“年将耳顺,素体丰肥”,晨起猝仆无知,口眼歪斜。牙关紧闭,断为内有伏饮,又患中风急证,伏饮新痰狼狈为奸,病重且急。雷氏“诚恐痰随风涌”,未至痰声起,急以开关散先擦龈,随化苏合香丸频灌,后又以鹅翎探喉,使吐痰盈碗,方人事略清。其认为“多食瓜果油腻之人,易郁结成痰,或素系痰体,其痰据于太阴脾脏,伏而不发,一旦外感凉风,痰随风起,而变生它疾”。故大声疾呼:“肥盛之人,痰药更宜多用”。

2. 强调病因治疗

雷氏对前贤所提“见痰休治痰”之论十分服膺，临证每针对痰证形成之因而立法。城南程某咳嗽，曾服宣透化痰而未减，他接诊断为系虚体受湿，脾困不运，酿痰入肺所致。认为脾湿乃咳之本，肺中痰仅为标，故当补脾以治本，用六君子汤加苏子、苡仁五剂而效。其弟子江诚析本案时曰：“当知湿气未成痰之先，可以透发，既成痰之后，焉能向外而解耶？因痰之源在脾，故用六君子扶脾以去湿而化痰，苏子降气，毋使其痰上袭于脾，米仁渗湿，毋使其湿再酿成痰。倘用宣提之方，则痰益袭于肺，而嗽更无愈期矣”，可谓深得其师用方之妙也！

3. 有痰不可误补

对正亏痰未尽者，妄补易闭门留寇，造成实实之弊。一范某患风温，形容憔悴，苔类白根黄，发热缠绵不已，咳嗽动甚，痰中带血，雷氏诊为风温乘虚内袭，化火刑金劫络，主张先去邪治标，后扶正固本。立银翘散去荆、桔、豆豉，加贝、蝉、兜铃，但病人信补而未服，反服人参、燕窝，补肺滋阴而亡，令人扼腕。另一戴女，禀赋素亏，感秋凉燥气，微寒微热，乏痰而咳，曾服调营润肺，补气养血数十剂而胸膈更闭，咳逆益甚，寒热依旧，改邀雷氏，投蝉、萎、贝、前、苏梗、橘红，二剂而效。有感于斯，他曰：“邪不去则肺不清，肺不清则咳不止，倘惧散而喜补，补住其邪，则损必不可免……可见有是症当用是药，知其亏而不补者，盖邪未尽故也”。良言谆谆，喜补者安可不慎！

二、立法灵变路广

1. 痰火窜入心包，急投祛热宣窍

春温经久失治，邪即化火灼液为痰，痰火窜入心包，则现昏聩不语之危证。城东章某春温初起因辛温过汗，致热退而复热如火，渴喜饮冷若狂，更医用三黄解毒之剂，热未平，更添神昏瘕

痲、急邀雷丰。诊脉弦滑有力，苔黄燥无津，知其一误于过汗伤阴化燥，再误于苦寒遏热，已成“邪入心包，肝风内动”之危候。急投自拟清热宣窍法（连翘、川贝、犀角、鲜石菖蒲、合至宝丹）加羚羊、钩藤。痰火得以迅速清化，一剂则痲痲定，神识清。惟津未回，舌尚燥，去至宝、菖蒲加沙参、鲜地又三剂安然。雷氏指出：“凡邪入心包者，非特一火，且有痰随火升，蒙蔽清窍”，故此方在宗“火淫于内，治以咸寒”之旨，取犀、翘相配泻心火之同时，又伍入川贝及牛黄至宝丹清心化痰开窍，用治此类急症，能获桴鼓相应之效。

2. 风痰直中脏腑，立马宣窍导痰

中风为中医内伤杂病四大症之首，若风中脏腑，皆现昏不识人之危候。前贤治此症虽仁智互见，创方无数，但雷氏苦于从痰立法之佳方不多，故自拟宣窍导痰法：取远、菖、竹黄导痰开窍，清心解语；杏、萎化痰润肠，僵蚕化中风之痰，皂角通上下之窍，既价廉易得，又获效颇速。如前述南乡余某卒中，经用探吐法呕出大量痰涎，神稍清，但却“宁静而卧，鼻有微鼾，肤有微汗，稍有痰声”，一医谓为脱证，他却临危不乱，详加辨证，认为“体质颇实，正未大虚；汗出微微，谅不至脱；痰既涌出，谅不致闭，询其向睡亦有鼾声”，遂大胆投宣窍导痰法，加东洋参、姜汁。次日汗减痰平，口眼稍正，脉滑不浮，断为“风从微汗而去，痰尚滞留经络，改用茯神、柏子仁养心收汗；远、菖、二陈、桑叶、苏合香开豁经络之痰以宣窍机；更佐参、草辅正，标本兼治，五剂悉减纳进。患者病急而症又扑朔迷离，雷氏却认定因痰致疾，迭进呕痰、导痰、豁痰，井然有序。立马见功，颇值传法。

3. 痰气闭阻三焦，常选化痰顺气

雷氏认为：痰乃湿气而生，湿由脾弱而起，脾主运化，得温则健，若因寒湿劳倦，则饮食水谷悉化为痰，袭肺成痰嗽，移肠成痰

泻，留体内则三焦、气机俱受阻滞，故庞安常所言“善治痰者，不治痰而治气，气顺则一身津液亦随气而顺矣”甚为高论。他宗此理创化痰顺气法，治痰阻气滞所致痰嗽、痰泻等疾。方由二陈汤加木香、厚朴而成，使脾运湿除，共收“气行痰自消”之佳效。

4. 暑痰上蒙清窍，法当清暑开痰

中暑多因盛夏劳倦后，复伤于暑热之邪而得，暑邪鼓动痰浊上扰清窍，现昏仆身热，气喘不语，牙关微紧或口开，状若中风，但无口眼喎斜，脉洪濡或滑数，实即由痰所致暑厥证。雷氏创清暑开痰法，以四物香薷饮合益元散清暑宁心，荷叶梗透邪宣窍，二陈、杏仁顺气开痰，使暑清则痰难留，痰去则暑易清，共收相辅相成之功。

5. 痰食困阻中州，倡用查曲平胃

对临床现咽酸暖臭，胸脘痞闷，腹痛甚而不泻，得泻则痛缓，苔白腻，脉沉紧或滑等病，雷氏认证系脾虚失运，主张消食化痰并行，佐健脾祛湿，立查曲平胃法（平胃散合查、曲、内金），对喜啖甘肥而致消化道症状者，确大有裨益。他还常将枳椇子合入方中，《续药性赋》曰：“枳椇子有醉皆醒”，故对酒食积滞酿痰生变者，功莫大焉！

6. 伏湿酿痰袭肺，巧予加味二陈

遇久咳胸闷，痰白清稀，口不作渴，或泛吐涎沫，便溏等症者，雷氏认为系湿困中焦，酿痰袭肺而成痰嗽、痰泻。主张理脾为主，渗湿化痰为辅，创加味二陈法：取二陈汤健脾燥湿，和胃化痰，合入米仁助茯苓以去湿，配伍杏仁助陈皮以利气，稍加饴糖助甘草以和中，虽寥寥数味，于痰湿所致病证，却能恰到好处。如鉴湖沈某，孟冬初患痰嗽，前医误作冬温治，两旬未效。雷氏认为“冬温必脉数口渴”，此却脉极滞，无苔白滑，痰多而嗽，胸闷不渴，“乃秋伤于湿，冬生咳嗽”之病，治应在脾。遂用加味二陈

汤去米仁，加苏、芥子肃肺降痰，五剂嗽减，接用六君子汤出入而痊。

7. 热蒸痰郁于肺，妙施清宣金脏

雷氏认为肺为五脏华盖，位居最高，暑热袭人，肺先受之，暑中有火，肺体属金，火邪克金，则会导致熬液为痰，郁阻肺络之证。可取莠、贝、兜铃清肺化痰，杏、菱、桔梗宣肺豁痰、桑、杷、二叶肃肺降逆，共成清宣肺金法，用治身热口苦，咳逆少痰，便干胁痛，脉濡滑数，两寸有力而强者，颇能应手。他还强调，如“痰多不因暑而因湿，不名咳应名嗽，不在肺而在脾，不用清而用温”，“倘不细辨，以暑为湿，误用温药……而成吐血之病”，误治之咎，值得警惕。

结 语

综观雷氏六十方，近半有治痰药，足见其对因痰致病或因痰病痰的高度重视，其内涵非拙文所能尽述，故浓缩如斯，读者若能窥斑见豹，幸矣！

（彭绍荣、马璇卿）

五 雷少逸治泻、痢说约

清末名医雷少逸（1833年～1888年），在《时病论》中论述泻、痢病因、病机时，善于辨析六淫发病不同的季节、时令及其因、证特色，重视“风木乘土”之发病因素；在诊法方面，于参合四诊的同时，尤精于细辨脉象以指导临证立法遣方；其于治疗，融经方、时方于一炉，于平淡中见神奇，尤善于结合辨证以揭示治则，斟酌方药，对后世影响相当深广。今着重介绍其“源于前贤，

并有所变创发明”的泻、痢治法如下。

一、论治出新见

1. 自拟多种治法

雷氏虽博采前贤之说,但却能妙识玄通,结合数十载临证经验,巧于化裁,另创新法。仅对泻、痢病的施治,即自拟了十三法。另治霍乱的治乱保安、挽回正阳、芳香化浊三法,亦可变通用治泻、痢。其以理中汤加苍术、益智、茯苓、葛根、梗米组成的暖培卑监法;以平胃散伍山楂、神曲、内金组成的楂曲平胃法;以二陈汤配木香、厚朴组成的化痰顺气法;以痛泻要方合吴萸、炮姜、茯苓、甘草、荷叶组成的培中泻木法均较张仲景治寒泻、朱丹溪治食泻、李梴治痰泻、刘草窗治肝木克脾之泻,提高了疗效。其由六一散、香连丸分别扩充而成的清凉涤暑法、清痢荡积法;由五苓散、补中益气汤化裁而出的通利州都法、调中畅气法等,亦为医家所喜用。

对病同症异者,常选用不同之法:如同一飧泄,当“脉两关不调,或弦或缓,肠鸣腹痛,完谷不消”时,投培中泻木法;“尺脉沉迟,按之无力,乃属下焦虚寒”时,宜补火生土法(附片、肉桂、吴萸、芡实、菟丝子、益智仁、补骨脂);“倘脉细小而迟,手足寒者”,他认为:“不易治也,勉拟暖培卑监法”;“倘日久谷道不合,或肛门下脱,乃元气下陷也,急以补中收脱法”(东洋参、白术、白芍、黄芪、粟壳、诃子、粉草、石榴皮),随证变化,法度谨严。有时病异而病机同,又选同一法治之:如对“糟粕脓血杂下,腹中微痛,登圜频频,饮食少餐,四肢困倦,脉细缓无力,或关部微弦”的水谷痢,因其认为病机也属脾胃虚寒亦予暖培卑监法。异病同治,极具匠心。

对每一法的具体应用,雷氏亦能根据不同症状,灵活进退,如休息痢屡发屡止,久而不愈,考虑致病之因有过服寒凉、肝脾

内伤、元气下陷、肾虚不固之异，虽皆以调中畅气法为主方，但若腹中隐痛，配吴萸、炮姜以化中焦之寒；赤痢缠绵，佐秦皮、白芍以清肝脾之热；肛门重坠，合升麻、桔梗以升下陷之气；虚滑不禁，加龙骨、故纸以固下焦之脱。对患者的素体差异，如风痢本属木胜土亏之候，如体素寒者，宜用培中泻木法加木香、苍术；体素热者，宜本法去吴萸、炮姜，加芩、连、葛根。皆能药证相符，丝丝入扣。

2. 反对盲目利尿

有些医家，将前贤“治湿不利小便，非其治也”之论，套用治一切泄证，雷氏对此颇持异议，认为：“盖飧泄下利清谷，乃属脾土虚寒，不能运化而下陷”，“属虚寒者多，属实者少，如执治泄不利小便之偏，必致不起。”并告戒“如有湿邪相混，即有湿之见证，辨证明确，始可佐之通利。”还高度概括指出属实不虚的四可利之证（即暴注新病、实热闭涩、形气强壮、小腹胀满），功莫大焉。

二、遣药精配伍

1. 善于调和肝脾

因雷氏极重视肝木乘土所致泻、痢，故仿仲师“见肝之病，知肝传脾，当先实脾”之意，创培中泻木、调中畅气诸法，以参、芪、苓、草、白术实脾，而取白芍、防风柔肝，更以陈皮、腹皮、木香、荷叶等疏肝畅脾，调中健运，双管齐下，疗效卓著。

2. 喜用辛甘升阳

雷氏治泻、痢，常尊崇李杲，在自拟十六法中，有十五法（除清凉涤暑法）选用了附、桂、葛、防、藿、参、芪、陈皮、二术等辛甘升阳药中的部分药物，或配利水的苓、泽；或伍消食的楂、曲；或佐缓急的芍、草；或参清解的连、芩；或合酸收的煨诃子、罂粟壳；或加固涩的煅龙骨、补骨脂。因对药性了如指掌，故看似信手拈来，却能恰到好处。

3. 巧投苦降辛开

自仲师创诸泻心汤苦辛通降,以治消化道疾病以来,从者如云,对泻、痢用者尤多。雷氏亦妙将辛开健胃之木香、藿香、半夏配苦寒清解的黄连、黄芩、大黄,创清痢荡积法(葛根芩连汤加生军、枳壳、木香、白芍、荷叶)治热痢;调中开噤法(党参、黄连、半夏、藿香、石莲肉、陈仓米)治噤口痢。因调燮了肠胃之气机,使中焦恢复了平衡,清升浊降,诸证自除。

4. 妙配养阴清痢

对阴虚患湿热痢者,利湿则伤阴,滋阴则助湿,颇感两难。雷氏却巧用当归、生地、白芍、丹皮养阴不碍湿,配石莲子、泽泻止痢不伤阴(《纲目》曰泽泻“止泻痢”),且常参入既能止痢又可滋阴的阿胶,妙成养阴清痢之方,颇具机巧。

5. 倡导痰、食并祛

对痰、食互阻,纠结并下导致的痰泻、食泻,他创用楂曲平胃法,取平胃散运脾、燥湿、化痰,合楂、曲、内金消食导滞,共成痰、食并治效方。此虽脱胎于保和丸、越鞠丸,但力更胜一筹。

6. 敛、涩细分温凉

雷氏虽反对妄用敛涩,防闭门留寇,然遇滑脱不禁者,又细辨其寒热属性,对虚寒者,每以参、芪、术、草之甘温,补中州提其陷,配罂粟壳、石榴皮、白芍、诃子之酸平,涩肠道以止泻、痢,且敛其肛,共成温、涩佳方;对实热者,以益气补虚药与凉性固涩药相合,由于前贤已制苍术地榆汤、人参樗皮散,以榆、樗之苦寒收敛配参、术之甘温扶正,组成此类效方,故未再创立新法,其乐于传扬他人经验的谦虚精神,值得称道。

然因时代的局限,雷氏对急性菌痢及阿米巴痢疾的认识,似嫌不足。马齿苋、鸦胆子等专药未能提及,白头翁汤在备用成方中也未选入,但这毕竟为白璧之微瑕,若能认真学习应用雷氏治

泻、痢的经验,无疑将大大提高我们治肠道疾病的疗效。

(马继松、承忠委、彭绍荣。原载于《中医杂志》1990年第5期)

六 陈素庵调经学术思想咨诤

陈素庵,名沂,宋代开封人,其祖事妇科至素庵时,已传二百年。沂将家传与自己经验结合,著《素庵医要》,仕至翰林金紫良医。明末,由裔孙文昭加以修订、补充,编成《陈素庵妇科补解》,分调经、安胎、胎产、临产、产后众疾五门,共一百六十七论,新义颇多,而调经门五十三论,尤为后世赏识。今不揣浅陋,试对其调经学术思想作一评析。

一、妇科病首重调经

1. 调经应和通经有别

陈氏认为:“经闭而断绝不来则宜通,经来或先或后、或多或少、适来适断,则宜调。滞久则闭,通则行其滞也。不和则有过、不及,调者使之和”。由于经闭常因不调所致,故月经不调与闭滞不通,也仅是程度上的差异,如三焦火盛,灼血耗液致热结经闭;风寒冷湿客于胞门,损伤冲任致寒凝经闭;脾胃聚湿,生痰化饮,壅塞子宫致痰阻经闭,均由先月经失常、渐后期量少,终闭止不行的。故陈氏指出:“以上三症,始或精神未衰,其症似实;渐且营卫不调,总属不足,宜先用药以调之,调而仍闭则通之。至于血枯经闭,……惟有补脾生血,清心养志,加行气开结”。其根据辨证审因,而明“通”、“调”之异同,于后学启迪颇大。

2. 调经当辨纲目、主次

对错综复杂之疑难杂证,陈氏皆以阴阳为纲,表里、寒热、虚

实为目,以纲驭目,详审本源。并十分强调须辨别新病旧病的主次,标病本病之缓急,脏病腑病的归属,七情六淫之由来。反复告诫如因病而后经不调者,当先治病,病去则经自调;经不行而后病者,首在调经,经调则病自愈。

(1)辨表里:其认为“当经来之时,外为六淫所侵,内为七情所伤,则气血壅滞,聚于脏腑,渗于经络……七瘤八瘕,膨胀浮肿……血枯经闭,绝产不孕,种种变证”。虽由气血失调,脏腑功能失常,及冲任损伤等内因,导致的月经不调达过半以上,但也不可忽略六淫之为害。不仅对伴有表证之疾,强调六淫,且在没有明显表证的经水淋漓不止的病中,亦认为“风冷外感,使血滞经络”,可使血“点滴不已”。

(2)审寒热:他主张根据月经颜色辨寒热,如月经“红而成块者,血热兼风也,紫甚或黑色成块,血热有伏火……淡红而成块者,风冷客胞门致血凝聚也”。并认为:月经先至者,血热或营经有风,风生热故也。错经妄行,系“风热外乘,血为热迫”;经行发狂谵语,乃“素系气血两虚,多怒而动肝火”。另还注意到辨寒热的疑似,如云:“经水乍多乍少,有阴胜阳与阳胜阴之分。非先期来者定来多,……,亦有时而少,后期者,亦有时而多。但多则血必热”。告诫医者切勿将月经先期均作热证施治。

(3)决虚实:陈氏常将经痛时间和经色作为辨虚实之依据,认为经欲来或正来腹痛属实,经后痛属虚;经水适来或断者,“不痛者为血虚,痛者属血滞”。指出:经色“淡红者血虚也;黄褐者,湿痰兼脾虚也”。他还通过经量之多少,察虚实之间杂:若经来腹痛量少,为血虚气滞,予理气活血中参补血养血;经后腹痛伴所下余血淋漓不爽,为虚中挟实,于补药中略加一、二味行滞之品。

在实际临证中,陈氏还常将表里,寒热,虚实互参,以利确诊

而定治则：如认为实证经闭多因郁怒伤肝或犯寒冷；虚证系禀赋不足或后天失养，既主张“用辛温之剂逐寒邪”，治寒客胞门经闭，又指出，若沉寒久结蕴生内热时，则不可妄用。特别强调，若郁怒伤肝，思虑伤脾，致气郁、气结闭经者，初多为实证，久则化热耗阴灼血，遂为血枯，宜滋阴清热，调理气血。其对闭经由寒化热，由实转虚的分析，颇值临证参酌。

3. 调经药忌辛热寒凉

陈氏认为调经必须养血行气为主，一切大寒、大热，峻烈攻伐药皆当慎用。对因火盛致经闭者，反对“过用寒凉，先伤胃气，复阻经血”。对风冷寒湿致经闭者，强调若尽用乌、姜、附、桂等大辛大热，再加桃、红、棱、莪等峻厉驱逐剂，将“上为吐衄，下为奔败，不可救药”。

二、调经的四大法则

1. 和氣法

对因忧郁忿怒，化火损络，见腹痛、胁疼、乳胀、烦躁、且经事提前，色鲜量多者，倡“开郁行气，则血随气行，自不致阻塞作痛”。其裔孙陈文昭在《补按》中曰：“但于养血药中加香附行气开郁，配肉桂逐寒祛瘀，佐木香顺三焦，乌药利腰膝，辛温之性，能使旧血散而新血生”。这种在众多养血药中少佐行气之阳药，使静中有动，寓散于补的组方原则，不仅使补血之作用能更好发挥，且可防壅滞致瘀之弊。其对和气的运用，旨在使郁结的疏之、泄之，上逆的抑之、平之，阳亢的柔之、缓之，总宜使肝气冲和为要也。可见其强调“调经必以和气为先”的学术思想，诚为卓识矣。

2. 理血法

陈氏提出，对不同病因采用相应的理血药，乃调经之关键。

(1)行血：如经血成块有瘀，创八制香附丸（以酒、醋、泔水、

童便及红花、杜仲、黄连、半夏四汁所制的香附为君，合四物汤、丹皮、青皮、秦艽制成）主治之。有寒热湿痰者，又当审因佐治。它如治经欲来腹痛的调气饮（归、芎、远、续、查、艾、桂、青皮、乌药、香附、砂仁、大茴、生姜、红花），亦是代表之剂。

（2）活血：“对月水不通属瘀血凝滞”者，他指出有热结下焦和寒袭胞门两种情况，均倡用红花桃仁煎（桃、红、延、乳、归、芎、赤芍、生地、青皮、香附、丹参），热加酒炒大黄，寒加肉桂、熟艾，该方与调气饮同被收入二版高校教材中。

（3）破血：对癥瘕已成，而血气壮实者，他习以桃、红、棱、莪、炮姜、干漆、吴茱、肉桂、香附等合归、地、参、术而共成扶正温运破血之剂。对“经水先断，而后发肿”所成血分病，认为系“瘀血化水，散入周身…急调其经，则水自消”，制桃椒二仁丸，以缓消渐磨（以桃、红、归、芎、茯、苳、赤芍、生地、香附、椒目、黑丑、甘遂为丸）。

（4）凉血：对血崩大证，他认为：“当辨虚实，实者，清热凉血，兼补血药；虚者，升阳补阴，兼凉血药。宜服黑蒲黄散”（蒲黄、地榆、荆芥，三味炒黑，白芍、生地、阿胶皆炒，香附醋炒，当归、川芎、熟地、丹皮、棕炭、血余炭）。经行发狂谵语，亦倡清心神，凉血热之剂。

（5）止血：陈氏对出血证，一般不过用炭剂止血，防留瘀之弊。在调经门也未提出止血一法，但对血崩，仍倡用黑蒲黄散止血，对其它经量稍多之病，亦用炒蒲黄、棕榈炭、荆芥炭、血余等直接止血。但多配合适量之归、芎，以止、行兼举。

（6）养血：因暴怒伤肝，阳亢火动，崩注不止，气逆而厥，陈氏又拟柴胡抑肝散（由柴胡、青皮、丹皮、焦栀、香附、炒蒲黄、炒荆芥、陈棕炭合四物汤而成）以和肝气、清肝火、养肝血。此处所言养血，亦即是用酸敛、甘缓之品柔养肝体，防过亢伤血，以达补血

之目的。

3. 化痰法

本书认为“痰者百病之根”，“人身之病，皆生于痰”，故对妇科病陈氏十分重视治痰。

(1)健脾化痰：对经行滞下，他指出：“此脾虚兼湿痰，治当补脾祛湿，则滞自止”，以四君子汤与二陈汤相合，加苍术运脾燥湿，当归养血化痰，共成八君子汤，用之颇效（菖、郁、半、枳、苓、草、生地、赤芍、丹皮、木通、麦冬、神曲、金箔、石莲肉）。

(2)清热化痰：对经行发狂，更创金石清心饮，以清镇、化痰并行不悖。

(3)祛瘀化痰：对“痰久则下流胞门……占住血海，经水闭绝”及“积痰生热，热结则血不通”的素体丰肥妇女，主张以四物合二陈加味。若痰盛经闭渐成癥瘕，多以归地二陈汤合二术、南星、枳壳、苏子、香附、红花、泽泻等取效。另他还特别注意到“痰涎郁遏胸膈，清气不升，浊气不降，血不能归隧道”，亦可致血崩。多见色淡淋漓，白带混杂，胸满呕恶，取二陈汤加沉、枳、香附、阿胶、荆芥、棕炭、血余、炒蒲黄，收理气化痰澄其源，止血塞流顾其标之伟功。

4. 补益法

月经病的发生，大都和肾脏元阳真阴之亏损，脾脏生血统血之功的失职，肝脏调气藏血之权失司，以致奇经八脉（特别是冲任督带四脉）不够通盛有极大关系。加之妇女又多经产、失血之累，故补益法历来为治妇科病名贤所重视，陈氏亦不例外。

(1)培肾元：对房室过度致经闭及室女经来复断，他主张从肾论治，创补肾地黄汤（知柏地黄合龟、远、枣仁、元参、麦冬、螵蛸、竹叶）及大补二天膏（归芍六味加芪、术、远、枣仁、桂园），培益肾元。

(2)健脾胃:对脾胃虚,纳谷减,月经由色淡而少渐至闭绝者,主张“大补脾胃”,用补脾饮(异功散合归、芪、薯、地、香附、补骨脂)。若久欠纳谷,面黄肉削,在用补脾饮稍愈后,倡予二术丸(白术八两、苍术四两、生姜四两、枣肉百枚)缓调。

(3)滋肝阴:陈氏于经行交媾致病,辨治颇细,指出“轻则血沥不止……重则瘀血积聚,少腹硬起作痛,小便频涩,病似伏梁,甚则厥气上冲,奔窜胸膈,病似癰状,终身不愈”,主张予益肝汤(归、芎、膝、断、乳、远、熟地、山药、乌药、木瓜、白术芍),以滋肝阴。

(4)填奇经:在妇科证治中,一般医家常偏重脏腑、气血的辨治,故《临证指南医案》有“凡奇经八脉,医每弃置不论”的慨叹,而陈沂生在宋代,却能采取填补奇经,特别是冲任二脉,以治疑难大证,可谓独具慧眼。如认为有些癰瘦系“风冷寒湿伤冲任二脉”所致;经水淋漓,却常系冲任内虚,气不摄血。对诸经之血不能灌注血海致血枯者,方取八珍、山药调补气血,二冬、知、玄补肺清金,丹皮、银胡、梨汁,清肝肺虚热,更以龟、鳖甲胶、人、牛、羊乳等血肉有情的甘平之品滋填冲任,略用香附、红花理气血,终使冲任盈满,月经自通。此法还寓有食疗之义,在生活水平日益提高的今天,更有实用价值。

总之,该书虽不失为一本妇科名著,然因时代的局限,亦有美中不足之处,如书中方剂偏重于用辛温之品,对阴虚、血热之证,所出方剂较少,对草药运用尤少。另在用活血化瘀之品时,忽略了虫类药,学者须留意之。

(马继松、承忠委、彭绍荣。原载于《浙江中医学院学报》1992年第2期)

七 章次公先生治胃病萃要

章次公先生(1903~1959年),江苏镇江人,早年毕业于上海中医专门学校,长期在沪上从事中医教育与临床。解放后任卫生部中医顾问,兼任中南海保健工作,曾多次为毛泽东、朱德、周恩来、邓小平等老一辈国家领导看过病,是最早的中国医学科学院院务委员,乃现代最著名的临床中医学家之一。由其贤门人朱良春先生等整理的《章次公医案》,辑了内、妇、儿、外医案273则,拜读后获益颇丰,今将学习胃病门案所得的肤浅体会,约之为六点,公诸同道,以乞教正。

疏肝调气

肝为将军之官,风木之脏,若为郁怒或邪气所伤,失其条达疏泄之用,便可横逆克土,出现胃痛等症状。沈金鳌说:“胃痛,邪干胃脘病也。惟肝气相乘为尤甚,以木性暴,且正克也。”故治胃病多主张疏肝调气。章氏在此基础上,更注意到肝木体阴而用阳和多兼夹症的一面,常以金铃子散和越鞠丸为主方。大凡上膈隐痛彻背,两胁撑胀,呈放射状,与饮食无关,时缓时甚,且无明显呕哕症者,投以金铃子散。如痛甚者常配罂粟壳,取其明显的麻醉镇痛之效;对久痛者,多参入九香虫、五灵脂、炒蚕砂、刺猬皮等,从血伤入络着眼;对定时痛而饱食反瘕者,则配合建中汤,培土御木;因寒气便结者,又伍用槟榔、二丑或沉香化滞丸以破气通幽。然而对因胸襟拂逆导致的心下痞、胃脘胀、胸闷、善太息等症,则根据“凡郁病,必先气病,气得流通,郁于何有”之理,主以越鞠丸损益。观章氏治胃病,极少选用柴胡,而仅在“胸次窒闷已两月,胸襟怡悦则苦减”一案中放手应用四逆散(柴胡9克),是否囿于“柴胡劫肝阴”之说,尚待研讨。

和 胃 降 逆

此为木横侮土以致胃气上逆的一种治法。叶天士主张：治此类病，“非用辛开苦降，亦非苦寒下夺，以损胃气。不过甘平或甘凉濡润，以养胃阴，则津液来复，使之通降而已。”可是，章氏别有见地，对此病善用苦辛下泄、宽中降浊的汪氏五磨饮和辛苦芳化、理气燥湿的二陈汤。如对纳食而胀，心下痞，脘腹汩汩有声，自觉有攻逐之状，便秘者，则多用五磨饮加减：或合良附丸以温中阳；或合六君子以复脾运；或配入椒目、黑丑、大黄黄芩泻心汤以苦寒导滞；或配杏仁、佛手及瓜蒌薤白半夏汤辛宣胸阳；或伍以蚕砂、灵脂祛瘀泄浊；或配以吴萸、柿蒂辛润相济、和中降逆；或佐入橘皮、云苓、旋复花温化痰浊；或增添谷麦芽、莱菔子、加平散（平胃散加鸡内金、砂仁）以消食滞；或辅用附子、肉桂、来复丹暖脾破结降逆；或襄助当归、莪术、越鞠丸活血调气。至于辛苦芳化燥湿，则多用于朝食暮不消，得呕哕则舒，或受寒则泛酸之症，方用二陈汤合以健脾益气的党参、白术；或增入疏肝调气的金铃子、玄胡；或配伍芳化湿浊的砂、佩、丁香；或添加辛热散寒的附子、干姜。若吐后不痛有痰而责之脾胃虚寒者，常予吴茱萸汤复方并用；对吐酸不止因抑郁致肝气犯胃者，与旋复代赭汤两法兼施。又对时时作呛，颇类胃咳之状者，则用宽中降气祛痰的朴、杏、三子（苏、莱菔、葶苈）共同取效。总观上述诸法，可谓匠心独运，药随症变，恰到好处。

通 肠 泄 浊

胃肠是气机升降的枢纽，一旦清浊相混，中焦受阻，则现默默不欲食，饱更甚，饥不减，得失气则快然等症。章氏对此多遵“胃以降为和”，“阳明以通为用”之说，常选用大黄为主药降逆荡滞；兼见高热、胃脘痛极而拒按者，则合元明粉、枳实和三仁（藜、杏、郁李）润滑肠道、通下开达；如痞闷较甚，多伍用枳、杏、半夏、

莱菔子辛开苦降,流利气机;对胸闷、呕酸由感寒所致者,则配合干姜、附子、吴萸等辛热之品,温通寒结、驱散阴凝;若系进流汁亦胀的消化不良者,则增入归、芍、参、草,共收益气健脾、养血通幽之功。又对胃液枯涸,肠道失润,引起脘膈便秘者,深恐下导损阴,常弃大黄,取知母、地黄,合入杏、柏子、郁李诸仁,甘润缓下,增水行舟。对体质壮实兼有积液之征者,甚至运用药力猛峻的椒目、黑丑、皂角子以及大戟、续随子等,攻邪夺关,一通而解。此非临床经验丰富,具有真知灼见者不能为。

温 中 补 虚

《景岳全书》对胃痛虚实之辨甚详,谓痛而可按者为虚,久痛者多虚,得食稍可者为虚,痛徐而缓莫得其处者多虚,痛在脘胁经络,不与中脘牵连,腰背无胀无滞者多虚。章氏亦遵此旨,对虚症痛有定时,心下空空然,或兼心嘈吐酸者,多用建中法温中补虚,缓急止痛。《胃病门》第32案的按语指出:便难而痛剧者用当归建中汤,气虚用黄芪建中汤,较轻用小建中汤。并说:“以十二指肠球部溃疡属虚寒型者,用建中汤最适应。”这具体阐明了章氏应用三建中治疗胃虚痛的要点,颇合临床实际。而章氏对痞满难忍、纳呆、啰噫腐气、体弱神疲为主症者,又多用党参、白术为主,酌情选配芳化健运的佩兰、厚朴、毕拔、艾叶、附子、干姜、山药、炙草、鸡内金、谷麦芽等灵活施治。上述二法虽同用温中补虚为主,但前者取法仲景,用建中汤辛甘生阳,酸甘化阴,重在滋养强壮、缓急止痛,有避刚用柔之意;后者仿效东垣,君以参、术甘温健脾,配以芳香辛散,则取刚燥化寒湿之法,恢复脾运振奋胃阳。二者同中有异,值得后学者细细玩味。

滋 营 增 液

叶桂云:“太阴阴土,得阳始运;阳明阳土,得阴自安。以脾喜刚燥、胃喜柔润也。”章氏有鉴于此,对胃脘隐痛、嘈杂,得食则

痛嘈均减,口苦便难,舌红苔光剥,或胃脘灼热如焚者,多予魏氏一贯煎,养肝阴滋胃液;或用白芍、知母、麦冬、山药及桑麻丸滋液养营。对急性胃炎有高热者,甚至用白虎汤合玉竹、花粉等直清阳明壮热,速救垂绝之胃津。章氏云:“利用石膏之钙披护胃膜之炎,兼能镇静”,实为经验之谈,并扩大了生石膏的运用范围。古人治胃痛每多偏于香燥行气一面,章氏认为叶氏提出的“忌刚用柔”之说,是治胃的一大突破,并在临床实践中大彰其法。我们应学而验之。

化 瘀 止 血

木失条达,气血郁滞,久而久之,络脉受阻而凝泣成瘀,也是导致胃病的因素之一。章氏对消化道溃疡患者的脐上板硬而痛,呕吐紫黑色物或解黑粪等症,均本肝郁血瘀的病理机制进行辨治。他常用的活血化瘀、通经止血药有当归、桃仁、地榆、血余、马勃、琥珀、煅瓦楞、五灵脂、仙鹤草、百草霜、刺猬皮、阿胶珠、伏龙肝、白残花等。其组方之妙在于,化瘀而不伤新血,止血而不致停瘀。章氏于此等证,多融汇新知,既辨证又辨病,并在实践的基础上提出了不少新的见解,如谓血余和琥珀同用,治溃疡出血极佳;马勃和凤凰衣相伍,可制酸、止血而保护溃疡面;赤石脂具有吸附作用,亦可保护消化道粘膜,止胃肠道出血。这对后学有很大的启示。

体 会

综观章氏治胃病的验案,有两大特点:

1. 以“通”立法:《医学心传》云:“但通之之法,各有不同。调气以和血,调血以和气,通也;上逆者使之下行,中结者使之旁达,亦通也;虚者助之使通,寒者温之使通,无非通之之法也。”章氏在《胃病门》中,因证选用金铃子散、越鞠丸、五磨饮、二陈汤、承气汤、灵丑散、小建中汤等方,意亦在调整胃肠功能,以达到

“通”的目的。再就他善用杏仁治疗胃病而言,剂量常在 24~30 克,最大达 45 克,以“疏利开达”,亦着眼于通。又如用槟、枳、丁香等芳香流气降逆,亦不外通字之义。

2. 顾护胃气:经云:“人无胃气曰逆,逆者死。”故章氏在施治中处处顾及胃气,对于辛散走窜而耗胃气之品,如木香、豆蔻等选用较慎;对于苦寒易于伤胃之药,如连、芩、山栀、胆草等,亦较少选用或用量极轻。纵然偶用辛热之品,用量较轻,乃取其“少火生气”之意。

章氏治胃病的丰富经验,是留给我们的一份宝贵财富,我们应认真加以继承和研讨,使它得以发扬光大。

(马继松。原载于《江苏中医》1982 年第 2 期)

卷三 当代名医精华

一 朱良春对痹证辨治之建树

朱良春老中医乃当代治疗痹证的专家,笔者有幸随师进修,深感其对该病的认识和辨治有诸多独到之处,今将待诊心得结合学习其所著《医学微言》、《用药经验》及《虫类药的应用》三书之体会,简述如下:

一、理论上的突破

1、首创风寒湿痹、顽痹、燥痹、急痹、浊瘀痹等病名

痹证的分类命名,最详莫过于《内经》,共分六大类,命名数十种。其按病因命名有风、寒、湿、热、食等痹;按病位命名有:皮、肌、脉、筋、骨之五体痹和肺、脾、心、肝、肾之五脏痹;按症状命名有行、痛、着等痹;按病之深浅轻重命名有远、大、深、浮等痹;按病程长短命名有暴、留、痼、久等痹;按季节命名则有孟春、仲春、季春……季冬等痹。后世医家又增添历节病、白虎历节病、痛风、风冷、风湿痹、尪痹、贼风等名称。上述这些命名,有的概念欠明确,如浮痹等;有的不切合临床实际,如孟、仲、季三夏之痹等;还有的概念上是互含的,如风痹和行痹等,真正有实用价值的定名却不多。有感于斯,朱老遂参考属于痹证的西医病种,并结合临床,给痹证这一大家族重新分类定名。

(1)他很赞同李士材《医宗必读》提出风寒湿三邪致病虽各有特点,但临床却常“合而为痹”不能截然划分的论点,同时临床常行、痛、着三痹同现,仅各有所侧重,故将其合而为一,命名为风寒湿痹,五版大学教材则采用了这一分类命名法。(2)将慢性风湿性关节炎、类风湿性关节炎及脊柱增生等病程较长、病情顽

缠、久治难愈之痹，命名为顽痹。(3)将痹证伴发全身津液缺乏症状的命名为燥痹，包括西医的干燥综合征。(4)将嗜酒啖肥、致湿浊瘀阻血脉，现趾、指关节肿痛为主的痹证命名为浊瘀痹，包括西医的痛风。(5)将常伴高热、烦躁、皮疹、白细胞增高、舌红脉数等有热入营血症状的痹证命名为急痹，此与中医把病急症重，按热入营血辨治的黄疸定名急黄取意相同。朱师在命名时，突出了这些疾病的病因、病机与症状上的特点，并参考西医相关疾病的分类命名法。不仅有利于记忆掌握，且名正则言顺，为辨治亦提供了极大方便：如一见定命为燥痹的患者，即知会伴有津亏的病机，故对辛温燥烈的治痹药就会慎用了。

2、倡顽痹“久痛多虚、久痛多瘀、久痛入络、久必及肾”之新论

前人治痹喜宗“急则治标”、“通则不痛”之论用药，常致祛邪有过，扶正不及，或虽可取效一时，却难痊愈。朱师指出：“顽痹所涉及的西医病都有关节疼痛、肿胀、拘挛僵直，其病因、病机悉与风、寒、湿、热之邪外袭，气血痰瘀内阻，致脉凝涩闭，气血难通，痰瘀胶结，深入经隧骨骱有关，病情顽缠，绝非一般祛风散寒、燥湿清热、通络止痛之品所能奏效”。故强调“久痛多虚、久痛多瘀、久痛入络、久必及肾，”需在常规辨治基础上，参用益肾蠲痹丸（熟地、仙灵脾、鹿衔草、鸡血藤、当归、苡蓉、蜂房、僵蚕、全蝎、蜈蚣、蕲蛇、炮甲、蜣螂虫、地鳖虫、生草），87年投放市场以来，评价极高。笔者侍诊中也时见其让患者以汤剂送吞此丸，或在用汤剂控制急性症状后，改此丸巩固之，颇值效法。

3、阐“瘀痛”之因、机，定痰瘀同治之法

前人把痹证疼痛的因机，概分为风痛、寒痛、湿痛与热痛四型，而朱师却指出：“凡顽痹久治乏效，关节肿痛，功能障碍，多是病邪与瘀血凝聚经隧，胶结难解，即叶天士所云：‘络瘀作痛’是

也”。在 92 年发表的《从痹病三个主症谈用药经验》一文中,极有识见地提出“瘀痛”一词,并将其与风、寒、湿、热四痛并列,作为痹病第一大主症疼痛的第 5 种类型,主张在透骨搜络同时,尚须配涤痰化瘀,宗“痰、瘀同治”之法投药。他根据朱丹溪“痰在肋下及皮里膜外,非白芥子莫能达”及景岳“白芥子消痰癖瘕痞,除胀满极速”之言,擅用此药与“制后毒减,能燥湿化痰,祛风定惊,消肿散结,专走经络,善止骨痛”的天南星合虫药以定瘀痛。他认为因西医对类风关病理变化的很多阐述,似与痰瘀深结经隧骨骱之机理相吻合,故它如既可化痰,又善活血的桃仁、当归、威灵仙、穿山龙,亦常配用之。

4、析“热痹佐用热药”之理

热者寒之,本为治疗之大法,但痹病除有风、寒、湿、热诸邪侵袭之外因外,还常有阳气先虚,卫外功能下降之内因,故朱师提出“治热痹恒需佐用热药”。认为这样做“在病变早期,有开闭达郁,促使热邪速降之效;中期有燮理阴阳,防止寒凉伤胃之功;后期有激发阳气,引邪外出之用”。对热痹遣用凉药也倡以甘寒为主,指出龙胆、芩、柏古人虽有用治痹证,然毕竟伤阳败胃,投用可暂而不可久。且反对寒凉药迭进,恐“热未去,寒又起,病由急性转为慢性”。

朱师对选用热药治热痹亦极具匠心:如治郁久化热之热痹,他选用川草乌、桂枝配生地、知母、寒水石(咸寒入肾走血,既可解肌肤热,又可清络中热,其认为治痹优于石膏)组成“乌桂知母汤”,较仲师桂芍知母汤精简了 3 味药,效却更佳,堪为师古不泥之典范。另于寒温剂量之比亦十分精究:对关节灼热却喜温者,系寒重热轻,二乌、桂枝均用 15 克,仅用 10 克知母配 45 克土茯苓以清热;若寒热并重,温药量同前,改选地龙 10 克,寒水石 15 克,忍冬藤 30 克,加强清热之力;而对寒轻热重者,二乌、桂枝均

减至6克,除凉药如前外,还加用龙胆草、大黄苦寒直折。曰人矢数道明、藤本健等曾曰:“汉方之秘不告人者,即在药量,”诚然哉!

二、辨治上的拓展

1、善抓主症,先治疼、肿、僵挛

朱师从60载实践中观察到:痹病症状虽繁纷复杂,但却以肢体疼痛、肿胀、僵直拘挛,最为患者所苦,若控制了三大主症,其它伴发症亦可随之缓解。故临证中他对三大症孜孜以求,取得了卓尔不凡之效。

对疼痛他提出应分风、寒、湿、热、瘀五型去辨治,但又强调此五型疼痛只是各有侧重,临床却常混杂出现,难以截然分开,故施治应以一痛为主,兼顾它痛。对肿胀之形成,虽和前贤同样认识到“湿胜则肿”,然又指出:早期可祛湿消肿,而中期由湿生痰,后期痰瘀交阻,祛湿必佐涤痰化瘀,肿始能消,这正是他高人之处。晚期痹病骨节常僵直拘挛,不仅功能严重障碍,痛亦显增。他强调此时应细辨阴阳、气血、寒热、虚实之偏颇,予以整体调治:凡红肿甚,难屈伸,以清热解毒为主,加用豁痰破瘀及虫蚁搜剔之品;如属风湿痹痛而关节拘挛,应重用宽筋藤30—45克。有时还倡海风、清风、忍冬、鸡血数藤并用,以加强舒筋活络之功,缓和僵直拘挛之苦。另还再三告戒:对三大主症的治疗均需参用益肾培本之品,如熟地、苁蓉、仙茅、仙灵脾、鹿衔草、鹿角霜等,标本同治,疗效才可望提高。

2、用药灵变,尤擅用草、虫药

朱师一贯主张“读万卷书,行万里路”,每日必挤时间翻阅下书刑,以求能有一得。外出讲学时,常与各地道友、老药农、土专家等切磋,故其掌握了很多草药治痹的知识。如对《东北药植志》“舒筋活络、治腰腿疼、筋骨麻木”的穿山龙、《广西实用中草

药新选》“行气止痛、活血消肿、壮筋骨”的七叶莲、《本经》“利筋骨皮毛”的石楠叶、《本草拾遗》“治一切血、一切气、一切冷”的扶芳藤、《别录》：“消皮肤毒肿”的鬼箭羽、《别录》“主瘀血”的萆薢等草药，虽未能被五版大学教材收载，但他却常频频用治痹证。另对收入教材的某些中药，又赋予治痹新任：如将以清热解毒为主的土茯苓、山慈菇、虎杖分别用治痛风、消骨肿和降痹证患者之血沉与抗链“0”，用主治跌打损伤的刘寄奴消骨肿等，均极具慧眼匠心。

鉴于朱师于20年前已著《虫类药的应用》，详介了用虫药治痹的经验，后多家报刊也陆续载登了一些读者学用该书治痹的体会，故笔者对其用虫药治痹的经验不再赘言了。

3、结合西医，辨证不忘辨病

朱老乃卫生部首任中医顾问章次公之高足，其时刻不忘章公“发皇古义，融会新知”之遗训，临证常借西医之石来攻中医之玉，以利提高辨治水平。如他认为广义痹证应包括与自身免疫功能密功相关的结缔组织病（类风关、红斑狼疮、皮炎、硬皮病、干燥综合征、结节性多动脉炎等）；与代谢有关的痛风、假性痛风、软骨病等；与感染有关的各种化脓性、病毒性、真菌性关节炎；退行性关节炎（如增生性骨关节炎）；某些神经肌肉疾病（如多发性硬化症、重症肌无力等）；遗传性结缔组织病；内分泌病中的关节病以及各种以关节炎为表现的其它周身性疾病（肿瘤后期的骨肌肉病）等，只有对这些西医病有较深了解，才可有的放矢地治疗。故他对西医的检查十分重视，以利用于确诊和评定疗效。另其还能将西医的科研成果应用于临床中：如硒是人体必需的微量元素之一，在他了解到华东医院采用硒酵母胶囊对老人做延缓衰老的观察时，发现合并有类风关的服用者，症状明显好转，遂将含硒十分丰富的黄芪更大剂量用治痹症，实在是难

能可贵。

朱师向来提倡辨证时勿忘辨病,对痹证尤如此。他指出:“辨证与辨病密切配合,研究疾病和证候的关系,探索临床的诊治规律,必能相得益彰,从而扩大治痹思路”。如类风关、强直性脊柱炎及痛风性(尿酸性)关节炎等多种疾病,虽皆可归入顽痹范畴,但因各病有各病自身病理性特点,即使辨为同一证型的上述各病,由于临床症状不尽相同,方药也很少相似。如类风关多有晨僵,其用药应清解、豁痰、行瘀、通络,常选用生地、知母、虎杖、蛇舌草、虫类药合乌头、桂枝等,以收止痛缓僵之效。而痛风系湿浊瘀滞内阻,每因血尿酸的持续升高,发展成为“痛风性肾炎”而致肾衰,故当急于泄化浊瘀以降血尿酸。他常用土茯苓、萆薢、苡米、灵仙、泽兰、泽泻、秦艽等合虫类药,利尿祛风活血。而以肾督亏损为本的强直性脊柱炎,即使和上两病同样伴有明显血瘀症状,却改用熟地、苁蓉、仙灵脾、骨碎补等合通络活血及虫类药,均取得彰彰之效。若辨证不能和辨病相结合,用药焉能如此贴切。

4、善用“药对”,重视辅以外治

因药对能通过药物的“七情和合”发挥较大疗效,且使处方精炼,故朱师颇喜用之。如痹证初起,每用地黄配当归,既可养血补血,又可制风药之燥性;病久及肾者,则以熟地配仙灵脾峻补肾阳阴精了。他虽喜用虫药治各类痹痛,若背痛剧则合药对葛根、秦艽;腰痛甚则合川断、狗脊;关节僵肿变形,又改合泽兰、白芥子。寒湿盛用虫药配制川乌、苡米;化热者,却又改配萆薢、寒水石了。因其对药性了如指掌,故均能泛应曲当。

他还结合现代医学之理,自拟不少药对:如用大剂土茯苓配萆薢,降低血尿酸;骨碎补合补骨脂,延缓关节软骨退变,抑制新骨增生;对血沉、抗链“O”、粘蛋白增高而辨为寒者,每投川乌与

桂枝;对免疫功能差者,则选用仙灵脾伍蜂房;燥痹咽喉干燥,口腔溃疡者,常投凤凰衣佐木蝴蝶;而红斑狼疮之痹痛严重者,却喜投穿山龙、忍冬藤了。看似信手拈来,皆能恰到好处。

考虑痹证病程偏长,治效较慢,故他常用中药局部电离子导入,或贴自制的“朱氏温经蠲痛膏”,或擦四生搽剂等,每能配合内服药缩短疗程,值得借鉴。

5、剂型多样,以应不同之需

因朱师门诊量极大,平均一上午 50 余号,大多为远道慕名求诊之疑难危重者,且有些患者要当场检查肢体活动功能。为提高诊疗速度,更为了价值较昂之虫药的药效充分发挥,并减少一些虫药对胃肠道的刺激,他将数十载经验拟成协定处方,加工成“蝎蚣胶囊”、“痛宁胶囊”、“痛风冲剂”、“水蛭胶囊”等,或配入汤剂中服用。病人经治症状稳定后,及时改水剂为丸、散、膏、丹,作巩固疗效之用,减轻了病人负担。

结 语

朱师因行医 60 余载,临床以治痹证为专长,故积验之丰,非拙文所能尽述。然他一再教导:治痹虽有一定规律可循,但仍以辨证为关键,症变药亦应变,切不可执一、二方以治所有痹病。兹录一案,足可见其治验关键之所在。

杨:女,39 岁,1999 年 10 月 14 日初诊。

双足跖疼痛伴手臂疼痛,低热已 4 个月,迭治未效。检查 RF $\oplus$,ESR75mm/h,ASO:800U。刻诊:左手食指亦疼,牙龈肿痛,腰及四肢肌肉酸楚,并伴口干欲饮,面部浮肿,难以入寝。苔白腻燥、质衬紫,脉细小弦。此乃肝肾阴虚,痰瘀阻络之燥痹。治以补肝肾、化痰瘀、蠲痹痛:穿山龙 50 克、蜂房、乌蛇、土鳖虫、鹿角霜、当归、知母、苍白术各 10 克,炒桑枝、骨碎补、女贞子、补骨脂各 15 克,生地、青风藤、鸡血藤各 30 克,水蛭 6 克、白豆蔻

3克。10月28日二诊:服药14剂,经来量较多,色紫挟块,疼痛略松。但脘嘈不适,寝仍难安,口亦偏干。恐上方偏燥,改用穿山龙50克,蜂房、乌蛇、土鳖虫、鹿角霜、当归、知母、生草、骨碎补、补骨脂各10克,白薇、地骨皮各15克,生地、鹿衔草各20克,山药、鸡血藤各30克。14剂。11月11日三诊:嘈缓口和,痛续轻减,但仍难寝,并发低热,脉细涩,苔白腻衬紫:上方加夜交藤30克,炒苡米50克。14剂。11月25日四诊:夜卧稍安,低热未退,苔白舌胖。二诊方加玉竹、徐长卿各15克,炒枣仁20克,14剂。12月9日五诊:低热退,夜寝实,但又口干且饱胀,苔薄腻少津,脉细弦:穿山龙50克、蜂房、乌蛇、当归、生草、土鳖虫、鹿角霜、补骨脂各10克,骨碎补、北沙参、徐长卿、生白术各15克,炒枣仁20克,生地30克,藿香6克。14剂。12月23日六诊:低热未作,疼未复起,卧尚安,口干减,惟腹胀暖气,脉舌如前:石斛、绿梅花各10克,太子参、徐长卿、生黄芪、制黄精、甘杞子各15克,炒枣仁、夜交藤各30克,枳壳、生草各5克。14剂。2000年1月6日七诊:诸症基本稳定。检查:RF $\ominus$, ESR19mm/h, ASO:250u,改予丸药缓图也。穿山龙50克,蜂房、乌蛇、当归、甘草、土鳖虫、鹿角霜、鲜藿佩各10克,苍白术、北沙参、徐长卿各15克,生地、枣仁、蒲公英、生赭石各30克,白蔻5克。上方14帖,共末蜜丸,梧子大,每服10克,日3次,空心淡盐水送吞。

按:此案初诊药后胃嘈不适,故去水蛭、白蔻、二术,改山药、白薇、地骨皮。三诊寝仍难,有低热,遂加夜交藤安神,重用炒苡米运脾化湿,且助白薇、地骨皮退热。四诊更加枣仁养心神以助寝,加玉竹滋阴且退热,增徐长卿定痛。五诊因口干饱胀,遂配沙参、藿香、白术。六诊时主症均安,惟腹胀暖气,故舍弃虫药及活化通络药,而改用补益安神和胃收功。为防诸症复萌,又做丸

药巩固之。朱师前5诊均以他自拟的痹痛散(蜂、蛇、归、草、鹿角霜、补骨脂、骨碎补、土鳖虫、鸡血藤)为主方,以定痹痛,但辅助药却随症之不同而灵活变化,故能取得满意疗效。

(马璇卿 叶义远)

二 关幼波治痰经验撮粹

关幼波老中医以善治肝病而名扬遐迩,然其对痰的辨治亦有很多精妙之处,《关幼波临床经验选》中《“怪病责之于痰”的一些启示》一文(以下简称《启示》),实为不可多得的辨治痰证的专著。文中指出:在对痰病的病因病理和证候的分析中,不仅要考虑到相关脏腑的功能失调,而且应当从气分、血分进行辨治,并概括了治疗痰病的四大要点。现就书中部分验案的剖析,简介其治痰四大要点的具体运用。

一、见痰休治痰,辨证求根源

关老将“见痰休治痰,辨证求根源”立为疗痰病的第一要点。《启示》中按此辨治的9则案例多为神经及精神疾患。如耳鸣多年的汪某,近三年加重,被诊为“神经性耳鸣”,每遇精神紧张、情绪波动,甚至小跑均耳鸣不已,头晕脑胀,恍惚目呆。平日纳呆腹胀,大便初硬后溏,洩黄健忘,脉沉弦。关老诊为用脑过度,气阴两虚。气虚血滞则致瘀凝成痰;痰瘀随虚阳上逆而扰于清窍,致耳鸣频作。遂予黄芪、五味子、沙参益气养阴,川芎、香附、首乌藤养血通络,使气充液足,气血畅流,则瘀阻解、凝痰化。佐以赭石、杭菊、旋复花、珍珠母平肝潜阳、镇摄虚风;使以菖蒲开窍行气,并与五味子一开一合,协调气机。虽见痰证却未用化痰

药,却使耳鸣很快终止。

又如周女的癫痫大发作;曹某局限性癫痫;俞女精神分裂症;王、罗二女之瘰病及袁某面神经麻痹,皆为痰蒙清窍或痰阻经络所致,但关老均能通过详察细审,而采用补阴养血,或柔肝熄风,或解郁安神,或祛风通络的相应治疗,略佐治痰之品,远远超过单纯化痰的效果。

二、治痰必治气,气顺则痰消

朱丹溪曾言:“善治痰者,不治痰而治气,气顺则一身津液亦随气顺矣。”关老临证亦强调必须使气机调畅,津液四布,痰浊方可随之消散。

杨某二十年前因患痢疾引起大便异常,钡餐造影诊为大肠粘膜肥厚。近三年加剧,大便细如笔管,每解时需达2~3小时,诊为肠功能紊乱,屡治不效。关老观其舌红、脉沉细,大便外带粘液,认证为气阴两亏,湿滞夹痰内阻,致腑浊难降所致,故重用刀豆子、杷叶、香附、荷梗、桃杏仁调降气机,通浊散瘀;并取加味保和丸化痰消滞;仅少佐黄芪、白芍、石斛益气养阴以助腑气通行。虽未用通便药物,但因气畅浊降,气调血和,一周后大便增粗如手指,每次排便缩短为20分钟,逐渐痊愈。

关老在“气顺则痰消”的治疗法则中,最推崇旋复花与代赭石这组对药,《本经逢原》谓“旋复花升而能降,肺与大肠药也,其功在于开结下气,行水消痰”。张锡纯说:“赭石……其质重坠,善镇逆气,降痰涎”。故合用以治一切痰气交阻之疾的案例有22例之多,占全部案例的十之八、九。此外,还将杏仁、橘红相伍,理气化痰,频投于痰气交阻之病的12则案例中。诚为后学之师法。

三、治痰要活血,血活则痰化

关老认为痰与血同属阴,气旺则津血并行,如“气滞则血瘀

痰结,气虚则血涩少而痰凝”,故善治痰者,必先治气,同时也要治血。他对心、脑血管疾病,脑震荡与脑炎的后遗症,神经性头痛及多种肝病,均经常用此法而取效卓著。如6年前因车祸受伤之外宾伊某,剧烈头痛时常发作,且伴右手疼痛、抽搐,握拳后不能放松,伸直后不能握紧,且左手亦有类似症状。被诊为脑震荡后遗症,手痉症,经治未见显效。关老察其苔薄黄,脉弦滑,睡眠不宁。认证系气血瘀阻,经络不通,瘀滞凝痰,蕴久化热生风。故在用旋赭四物合生石决、石斛、香附、没药活血平肝、行瘀祛痰的基础上,配木瓜、钩藤、寄生、瓜络熄风止痉,服药十剂并配合针灸,症渐好转。由于脑震荡是脑部闭合性创伤后出现的中枢神经系统暂时性功能紊乱,关老经长期摸索,总结出祛瘀通络,调气化痰以恢复功能的基本方(即由旋赭四物汤合首乌、石斛、香附、钩藤、全蝎、蜈蚣组成)及一系列随证加减法,颇利临证使用。

对心血管病的研治,他亦颇多卓识,指出冠心病因多有器质性动脉粥样硬化改变,故属血分病。而因痰浊气结所致的胸痹病,多为气分疾患,基本属功能性病范畴,二者施治不能混同。并对当前多从活血化瘀角度研究此二病,很少从“痰”论治,以致疗效欠佳的现象,深表遗憾。他主张将冠心病心绞痛的病理概括为气虚血滞、血虚失养、心阳闭阻和痰浊阻络四型,对痰浊阻络型,应遵照痰阻血难行,血凝痰难化之理,不但要“治痰必治血,且治血必治痰”,使痰化血易行。宜选用旋复花、赭石、橘红、杏仁合萎薤半夏汤,强调川芎行血通络最强,可重用15~30克,它如丹参、红花、元胡、地龙、王不留、鸡血藤亦常选用,通过痰瘀相关理论,为辨治该病拓开新路。如年半百的王某,已有八年高血压史,两年前查心电图疑为冠状动脉供血不足。诊见胸闷心痛,心前区压痛,右手麻木,血压152/110毫米汞柱,西医诊为冠

状动脉粥样硬化性心脏病、心绞痛。关老认为西医所云：冠心病者因脂肪代谢障碍，以致血脂增高，这与中医所谓的“痰”颇为相似，故予活血化痰为主，结合患者久病，头晕、便溏、苔少等症，而辅以补养气阴，予四物汤，远志、萎仁、贝母、郁金、黄芪、甘草、五味子、首乌、红参等，加減连服三十八剂逐渐正常。

他还将活血化痰法用于多种肝病的辨治中，大大提高了疗效。对急性病毒性黄疸型肝炎、肝脂肪性变、慢性肝炎早期肝硬化的治疗多从活血祛瘀，化痰利湿入手。关老认为水的代谢是“其源在脾，其布在肺，其司在肾。”，故在对肝硬化腹水治疗中，更重视通过活血行气化痰以改善脾肺肾在水液代谢中的作用。在所选8例典型腹水案中，除一例用厚朴、冬瓜子化痰外，余皆取杏仁，五例与橘红同用，三例与厚朴同用，还有两例与麻黄同用化痰；而活血则每用桃、红、归、膝、香附、赤芍、泽兰、茜草、王不留行、水红花子等。有痞块积聚，则常遵“欲软其坚，必先柔其性”之理，予白芍、阿胶、地龙、牡蛎、龟板、鳖甲，反对滥用棱、莪、蛭、虻攻伐，认为妄用反促其凝结硬化，其对活血药与破瘀药的运用是极有分寸的。行气擅用枳实、郁金、腹皮、木香，既合“治水先治气，气行水自制”之旨，更可协助化痰活血。这些宗“痰瘀相关”学说所创的治肝病方法精采纷呈，厥功殊伟。

四、怪病责于痰，施治法多端

考痰为水液代谢的病理性产物，水液输布环流全身，故痰亦随之而变生为病，无处不到，无症不作。正如《寿世保元》云：“一切怪症，皆痰实盛也。”关老有感于斯而指出：“如果辨痰与治痰引起医家重视，不但能够治愈某些疑难怪症，而且也会为中西医结合创立我国独特的新医药学派提供有价值的线索。”如王某26天前眩晕头痛，下肢发软，走路向右偏斜，视物不灵活且有复视，诊为“脑干脱髓鞘病”，经治无效。刻诊，尚见耳鸣、头胀、舌

麻言謇,左眼不能外展,双眼内收也弱,脸面右手发麻、震颤,右腿难立,进食不利,苔白脉沉细。对此怪病,关老审谛覃思,认为系阴虚阳亢,风痰阻络之故。予知柏四物汤合黄芪、钩藤、菊花、全蝎、僵蚕、蜈蚣、丹参、刺蒺藜及蛇胆、陈皮化痰通络,养血平肝。经治半年,终使气盛血充,经络疏通,瘀血凝痰彻底化散而愈。苟不从痰瘀论治,焉望有此奇效?又如李女的贲门痉挛,狄女的肝糖元积累症,刘女的食道良性肿瘤等怪病,关老都从治痰入手,而皆痊愈,足见通过治痰来治疑难怪症,确有着广泛的前途。

总之,痰证在临床中广泛存在,痰病的表现也十分复杂,故关幼波老中医治疗痰症的丰富经验值得我们学习、效法和光大之。

(马继松、吴华强。原载于《中医药研究》1988年第5期)

三 关茂会治慢性肝炎综合疗法之剖析

慢性肝炎,特别是乙型肝炎,丙型肝炎,是世界医学界公认的难治性疾患,我国以乙肝发病率为最高,被人称为“乙肝大国”,由于目前尚未研制出高效、特效的药物,故临床上慢性肝炎——肝硬化——肝癌的衍变方式(也称“乙肝三部曲”),常见于患者的病情进展之中,给病人的身体健康带来极大危害。中国中医研究院研究员关茂会(1925~)主任中医师,深感肝炎给国家和人民造成了严重危害,故对该病进行了不懈的研究,被国家任命为“七五”肝病攻关课题组组长。经过近40载的艰辛劳动,通过治疗数以万计患者的临床经验积累,并认真吸收现代医学

的研究成果,终于形成了他独特而又系统的治疗慢性肝炎的综合疗法。笔者与其同在一科室,有幸跟随关老学习十多年,认为有义务和必要将其对慢性肝炎的治疗经验介绍给更多同道学用,故翻阅了关老近些年在治该病时开出的特有的“大方”,现从四个方面对显示出其完整而细致的治疗脉络的综合疗法分析如下:

一、益气健脾与固肾药协同,调节免疫系统

现代医学认为,乙肝病毒感染人体后,其所引起的肝脏和其他脏器的病变,以至疾病的发生发展,与人体的免疫状态有一定关系。若免疫反应正常,则体内的乙肝病毒易被清除,肝脏病变可得到较好的修复,则病可获痊愈;如免疫反应增强,导致局部出现过敏坏死反应,则会引起重症肝炎;而免疫反应不全者,不能彻底清除体内乙肝病毒,则会使肝病迁延难愈。中医则认为,之所以形成慢性过程,与人体正气之虚密切相关,即“邪之所凑,其气必虚”。因此关老认为,在慢性肝炎的治程中,若适当而又不失时机地扶助正气,调整体内阴阳之平衡,能达到较好的祛邪目的。故他常选用黄芪、党参、白术、茯苓等品以益气健脾(药理研究证实,上述诸药,尤其是黄芪能有效地增强免疫功能和网状内皮细胞的吞噬作用,保护肝细胞);仙茅、仙灵脾、巴戟天、肉苁蓉、菟丝子等味以温阳固肾(现代研究得知这类药能较好地调节发挥免疫系统的作用),益气与补阳药相合,可共收扶正祛邪之伟功。在病情较稳,肝功能变化不大时,前类药每用10—15克,后类药5—10克;当病情波动,肝功明显升高时,两类药均适当减量或减少药味,以利更好地发挥其它类药的祛邪之力。

二、疏肝理气和养阴药配伍,有利保肝降酶

肝脏受病毒侵犯后,由于肝细胞被破坏,血清中各种酶类会升高。若患者看到谷丙酶(ACT)、谷草酶(AST)等客观指标的

较大波动,心理压力必然加大,将给治疗带来极大影响。如能尽快地使肝功能恢复正常,对稳定病人情绪有着积极的作用。慢性肝炎常以胁痛、腹胀、烦躁、寐难、纳谷不馨、女性月经不调、经期乳胀等为主诉,这与病久肝失疏泄,气郁化火,克脾乘胃,扰心耗肾有关,因此疏肝理气配合养阴,亦乃治慢性肝炎的重要治则之一,常可直接收到阴平阳秘的治疗效果。关老颇喜用柴胡、郁金、枳壳、香附、元胡、佛手、川楝子、青陈皮等以条畅足厥阴郁滞之气,而予白芍、枸杞、女贞子、五味子柔养肝阴。药理研究认为:柴胡有抗肝损伤作用,使 ACT 活性降低,促进肝功能及肝组织损害的恢复,还可抑制纤维增生,并能促进纤维吸收,对慢性肝炎的肝脾肿大具有回缩作用,且可利胆。而女贞子所含齐墩果酸等成份有护肝降酶之效,齐墩果酸片已成为肝炎者降酶的常用药。五味子酸敛益阴,又能益气生津,可减轻肝细胞的损伤,达到保肝降酶目的。关老常根据辨证选择药味和决定用量,对湿热内蕴明显者,暂不用或少用酸敛养阴之品,以免恋邪。上述药物的恰当应用,对消除或缓解慢性肝炎病人的临床症状有明显的疗效。

三、清热解毒与利湿药联手,希冀祛邪抗(病)毒

肝炎病毒是慢性肝炎的始动因素,故抗病毒疗法历来为医家所重视。大量的实验研究和临床观察均证实:清热解毒之品具有极强的抗肝炎病毒之力。为尽快解毒祛邪,关老常将清热解毒药与利湿药联手并用,以加强各自的作用而互趋成功。最多用的清热解毒药为金银花、野菊花、紫地丁、蒲公英、白英、紫草、龙葵、虎杖、蛇莓、蚤休、贯仲、山梔、鸡骨草、蛇舌草等,利湿药则为茵陈、苡米、茯苓、泽泻、金钱草、垂盆草等。特别在患者肝功能波动,病毒复制活跃,正气尚足时,上述诸药除梔子外,均可用至 15—30 克。体外药理实验,证实蚤休有较强的抑制乙肝

病毒作用；虎杖、银花、白花蛇舌草有较强抗病毒作用。另茵陈可清除肝脏炎症，减少肠道细菌生长繁殖过程中的代谢产物对肝脏之损害，收到护肝之效。尤值一提的是，肝炎多为湿热所致，若湿邪较甚，每致中脘痞满，前人有“中满忌甘”之论，而关老却未为此说所拘，常反其道而行之，颇爱用甘草。细考其由：一是药理证实该药对肝损害有明显保护作用，能使肝脏的变性与坏死减轻，肝糖元恢复；二是一些药物的抗炎作用是通过甘草所具有的糖皮质激素的作用来实现的；三是可缓和其它药物的毒性（如贯仲、蚤休等均有小毒）；四是不少清热解毒药均为苦寒之性，过用、久用难免伤胃，甘草可矫正苦味，以利服用，且可护胃。通过对甘草作用的分析，可窥见关老师古不泥古，西学为中用的创新精神。

四、活血化瘀佐软（坚）散（结）药，阻抗肝纤维化

中医认为：慢性肝炎日久，常因肝失疏泄，气行不畅而致血运不利，由于气滞血瘀，使肝之脉络阻塞，渐成癥积之征。西医亦认为：随着慢肝病程的迁延及病情的反复波动，同时也伴随有肝纤维的不断增生，终致形成肝硬化。故关老强调：治慢性肝炎定要考虑活血化瘀，提早使用抗肝纤维化之药。他很欣赏桃仁、红花、当归、丹参、川芎、莪术、内金、炮甲、鳖甲、生牡蛎等活化软散之品，组方频率颇高。尤其是丹参，前贤盛赞其“为血中之气药”、“一味丹参，功用四物”、可“养血，去心腹痞疾结气”等，说明该药在活血化瘀同时有一定补益作用，对慢性肝硬化最为合拍。药理研究也证实该药有抗肝纤维化，保护肝细胞结构的完整性，清除毒性自由基，减轻肝脏的免疫损伤，恢复肝功能，回缩肿大之肝脾等作用。对长期慢性肝炎伴脾脏增大，蛋白代谢障碍者，关老均用山甲、鳖甲等，二甲能在抗肝硬化的同时，对增大的脾脏亦能起极为明显的回缩软坚之效。另通过长期实践，他还发

现夏枯草、生山查既能保肝降酶,又可抗肝纤维化,前者还可清泄肝火以降压,后者又能消脂以降压,故对嗜辛酗酒,饮食不节,因肝炎致肝硬化并伴高血压者,常频频入药。鉴于活化软散之品每每有导致出血耗气之弊,故关老提出:在肝功能反复波动的不稳定期,对这类药的选用应持慎重态度。另在对病人的长期观察中发现,当谷丙酶(ACT)、谷草酶(AST)值较高时,当归、红花等辛温活血药应不用或少用,否则会使转氨酶居高不下,加重肝细胞之损害,良言谆谆,值得记取。

以上四项原则是关老治疗慢性肝炎的主题思路,在数以万计的处方中充分得到了体现。一般的处方中用药达二、三十味,服用3—6个月可获显效。但临床中他还十分注重患者的个体差异性,根据其体质、病情、病程、性格、饮食喜恶的不同,结合时令、生活环境等,应用八纲详细辨证,充分体现了他对该病的治疗能将传统的中医辨证论治与保肝、恢复肝功能、抗病毒、抗肝纤维化等现代医学治肝成果予以高度的有效的结合,开拓出中西医结合诊治慢性肝炎的新途。如我们按照他的综合疗法之思路去研究、实践,必将会取得治疗慢性肝炎的重大突破。

(刘燕玲)

四 聂惠民用小柴胡汤治内伤杂证之钩元

聂惠民教授乃著名伤寒学家,博士生导师,临证喜用经方,师古不泥古,尤妙与化裁,擅用小柴胡汤治内伤杂证,今将随师学习所录验案整理数则,以飨同道:

一、偏头痛(高血压)

魏女 53岁 1998年元月15日初诊

右前额头痛伴高血压已七载,迭治时缓时甚。半月前因喝喜酒致病复发,延医诊治未果,转求诊于聂师。初诊右半前额胀痛不已,晨起为甚,耳鸣烦躁,夜卧欠佳,伴中脘嘈杂,时欲呕吐,舌暗红,苔淡黄,脉沉弦略弱,血压150/105mmHg。处方:柴胡6克,黄芩、菊花、丹皮、杜仲、香附、元胡、姜夏各12克,鸡血藤、黄芪、杭芍各15克,生石决明、生龙牡各30克。7剂。复诊时头痛大减,血压正常,惟胃脘偶感不适。前方去黄芩,加当归12克,14剂。诸症大瘥,要求调理,遂以柴胡6克,川芎、天麻、夏枯草、生熟地各10克,元胡、当归、赤白芍、丹皮、黄芩、菊花、杜仲、鸡血藤各12克,生石决明、生龙牡各30克,七剂研末,蜜丸梧子大,每服10克,日三服,数月后随访,未曾复发。

按:偏头痛伴高血压,按常理忌用升提,然聂师认为,因患者伴耳鸣,当责之少阳经气火偏亢,故略用柴胡引经,且疏散郁火,兼以行气,舌暗乃血瘀,遂用黄芪补气以行血。另用大剂石决明、生龙牡潜镇肝火,佐制柴、芪之升散,使气机升降有序,条达舒畅,亢盛之火自熄。丹皮、杭芍、鸡血藤皆有行血之功,血行气畅则偏盛之阳得制,又得菊花疏肝明目、清利脑窍,使诸症除而神志爽。前贤曰:“慢性病当有方有守”,故予丸剂缓图收功。

二、胸痹(冠脉粥样硬化性心脏病)

李女 71岁 1997年4月15日初诊

冠心病近二十载,经治仅轻减于一时。近因乍暖还寒,且家事不顺,又觉心前区阵发性疼痛,并向左肩背放射。伴怔忡闷窒,太息纳少,寒热失和,痰咳不爽,寐难神疲,脉沉细略数,舌暗苔薄白,拟和解补益,化痰通脉。处方:柴胡、黄芩、蒺藜、茯苓、桔梗、大贝各10克,党参、炙芪、菊花各12克,神曲15克,薤白6克,炙草4克,大枣5枚,生姜三片。6剂后,随咯较多白稠痰,

寒热消除,痛减,纳增,心悸略定。但仍胸闷眠差,舌暗紫,脉细涩。用柴、苓、夏、萎各 10 克,茯苓、麦冬、远志、丹、党参各 15 克,炙芪 20 克,薤、芎、五味子各 4 克。又 7 剂,症去七、八,惟心悸未平,纳仍欠馨,改解郁和胃,益气养心,佐以定悸:柴胡、黄芩、陈皮、郁金各 10 克,麦冬、茯苓、丹党参、炒三仙各 12 克,炙芪、生龙牡各 15 克,炒枳壳 8 克,五味子、砂仁(后下)各 4 克。更进 7 剂,诸症若失。

按:胸痹证,医家多责之寒凝痰滞,血脉瘀阻,每用温阳豁痰,活血通络。然聂师虑患者年过七旬,用过活血恐虚体难耐,且附、桂刚烈,难免“壮火食气”。此次病发与心情怫郁有关,《伤寒论》第 96 条明言:“……嘿嘿不欲饮食……或心下悸……身有微热或咳者,小柴胡汤主之”。故用小柴胡汤合薤薤半汤和解通脉(现代药理证明柴、苓有改善脂代谢的作用),配伍桔梗、大贝化痰宽胸,黄芪、茯苓补益心气,菊花疏肝利膈(《日华子本草》曰菊花“利血脉……心烦,胸膈壅闷”),神曲开胃消滞,故效颇佳。转方用丹参、川芎养血和络,复佐远志、麦冬补益心之气阴,则无“虚虚”之咎。三诊予郁、枳解郁,龙牡平悸,终收全功。其考虑周匝,用药贴切,为高年体虚之胸痹患者又立一佳法也。

三、脘胀(浅表性胃炎)

金女 40 岁 1998 年 3 月 10 日初诊

胃脘胀满近百日,西医诊为浅表性胃炎,予吗叮啉及香砂六君丸未效。刻诊脘胀噎逆,时欲太息,纳后尤甚,并牵涉腹胀、腰酸,松解裤带始得缓解。伴口苦饮少,大便欠畅,烦躁寐难,舌红苔白厚,脉弦缓。责之土壅木郁,非解郁和胃则难安:柴胡、枳壳、香附、青陈皮、藿苏梗各 10 克,党参、郁金、白芍、炒卜子各 12 克,黄芩、法夏各 8 克,炒枣仁 15 克,生龙牡各 20 克。7 剂后,随矢气频转,大便畅行,胀满锐减,腰酸亦松,夜卧安然。去

枣仁、青陈皮、易当归、炙远志各 12 克，木香 5 克，更进 10 帖，余恙悉平。

按：前医认为患者单纯胃虚，蠕动无力而胀，遂用吗叮啉及香砂六君剂。聂师由效不佳且脉弦烦躁，悟出系土壅过久，木郁难伸，导致胀满，改投小柴胡和调肝胃，佐入大剂行气消滞。考虑“卧不安”缘于“胃不和”，仅略予枣仁、龙牡安神。腰酸亦系胃胀所涉，故未投壮腰强肾之品，然主症胃胀消除，则寐难、腰酸等亦霍然若脱也。

四、泄泻（慢性结肠炎）

王女 26 岁 1998 年 4 月 28 日初诊

泄泻数载，未能根治，一月前因与男友反目，泻又加重，日 2—4 行，西医诊为慢性肠炎急性发作，予氟派酸、黄连素等，但效果不佳。初诊胃及腹部均胀满不适，噎逆，矢气多，并伴左下腹隐痛，后阴坠胀而欲便，便则痛减，便色黄不成形，时夹不消化物。面眇虚浮，纳少神疲，肢冷畏寒，白带绵下，舌尖偏红，苔白浊，脉沉弦略细。此中土虚于前，木郁随之后，当补疏并行也。处方：陈皮、柴胡、防风、苏梗、山药、扁豆、焦三仙各 10 克，党参、白术各 12 克，苡仁 30 克，黄芩、枳壳各 8 克，炙草 4 克。5 剂泻止纳增，惟带仍多，加生龙牡各 30 克，又 5 剂，一如常人。

按：此证显系木土相争，用小柴胡汤合痛泻要方原无奇特处。但聂师考虑浊阴不降，则清气难升，故反佐 8 克枳壳，以求欲升先略降也，且可协助它药疏畅气机，又能推荡积滞，使阳气和而阴自降，一药功收三用，非精求药理者难为焉！

五、便血（十二指球部溃疡）

刘男 30 岁 1998 年 4 月 28 日初诊

下岗一载，心情失畅，奔波求职，操累较甚，常借酒浇愁。一周前与友共酌而过量，突觉中脘剧痛，嘈杂口苦，大便黯紫如柏

油,门诊查潜血(卅),西医诊为“十二指肠球部溃疡”,其不愿手术,服中西药五天未见好转。刻诊还伴面萎黄,肢清冷,口中苦,时泛噦。舌边红苔薄黄,脉弦弱。此系酒热助张木火,横克中土,致生变端,当标本同治:柴胡、黄芩、焦查、白芨、法夏、香附、丹皮、白术芍各 10 克,党参、炙芪、茯苓、煅瓦楞各 15 克,炒苡仁 30 克,炙草 4 克。5 剂症减,大便转黄,以炙鸡内金 15 克,陈皮 10 克,易焦查、法夏,复进 5 剂,隐血转阴,它症亦痊。

按:患者系木郁化火又饮酒较过而致疾,故聂师以小柴胡汤疏木培中,佐杭芍、丹皮、香附柔肝和血,白术、苓、苡健脾统血,仅用芨、查、瓦楞直接收敛止血,五帖即效,足见治病求于本也。不按常人用建中类或黄土汤治此病,乃恐桂、附辛热,于肝郁嗜酒者难合矣。

结 语

聂师认为:《伤寒论》的六经辨证和理法方药不仅适用于外感热病,且适用于内、外、妇、儿各科,包括心肺、肝胆、脾胃、肾与膀胱等脏腑内伤杂病,因其对内伤杂病在病因、病机、治则、方药等方面,均有全方位的指导作用。正如柯韵伯所言:“夫仲景六经,一为百病立法,不专为伤寒一科”,故全在辨证精确,变通灵活焉。又内伤杂病大多病程较长,反复不已,症常涉及多个脏腑,表现为寒热兼挟,虚实并见之错综复杂状态,故用药当温而勿燥,凉而勿遏,补而勿滞,攻而勿伐,以和为贵也。小柴胡汤为和解剂之祖方,且所主之少阳证候,或因素体虚弱,外邪直犯而发于本经(即《伤寒论》97 条所谓:“血弱气尽,腠理开,邪气因入,与正气相搏,结于胁下”);或由于误治、失治,由他经传入少阳;或因厥阴阳复而转出少阳等,故其所主症状亦常涉及多个脏腑。而小柴胡汤药虽七味,然柴、芩合用,经腑并治,既疏少阳经中邪热,又清少阳胆腑之瘀热,使气郁条达,枢机合畅,表邪外

解,里热清除;半夏、生姜相配,辛开寓降胃之功,且既佐柴、芩祛外邪,又能宣通甘草、大枣之滋腻;参、草、枣可温中培元、补脾胃之气,并能防柴、芩之苦寒。其组方合理、配伍精当,实可调和表与里、上与下、腑与脏、气与血、热与寒、实与虚等诸方面之矛盾,从而收到“阴平阳秘、其病乃治”之目的。内伤杂病患者,只要具有少阳病提纲证或小柴胡汤证四大主症中的某些症状后,皆可用此方化裁投之,若仅将该方作为和解表里之剂,则有悖于仲师制方之本意焉!

(韩刚、刘燕玲,原载《中医杂志》1999年第40卷)

五 聂惠民用经方治慢性 萎缩性胃炎的几个法则

CAG 是临床常见病、多发病,其症状缺乏特异性。中医常把它归属于“胃脘病”、“胃痞”、“胃胀”等范畴。吾师聂惠民教授擅长治 CAG,现将其治疗 CAG 经验总结如下:

一、解郁和胃法

吾师认为本病多因情志不舒,饮食不节所致。因肝主疏泄,调畅气机,在生理情况下可促进脾胃的运化功能,正如唐容川《血证论》所言:“木之性主于疏泄,食气入胃,全赖肝木之气以疏泄之,而水谷乃化。”所以在病理情况下,肝病每易累及脾胃,如长期情志不遂,则常现胃脘痞满胀痛,纳呆,嗳气泛酸等症状。她指出此病关键在于一个“郁”字。郁有广义、狭义之分,广义之郁,如《医经溯洄集·五郁论》所说:“凡病之起也,多由乎郁。郁

者,滞而不通之义。”又如《丹溪心法·六郁》中指出:“气血冲和,万病不生,一有拂郁,诸病生焉,故人身诸病,多生于郁。”可见广义的郁是由于外在致病因素导致了人体阴阳气血不和而产生的病变,其中以气机郁滞为先。气郁日久,由气及血,变证多端,所以病变的表现,可有气郁、湿郁、食郁、痰郁、火郁、血郁等六郁证候。而狭义之郁,专指由于情志不舒,气机郁滞所引起的病证。吾师认为一个“郁”字贯穿于慢性萎缩性胃炎病证的全部发展过程中,故治疗大法当以解郁和胃为主,常用《伤寒论》中的四逆散疏肝解郁,调理气机。根据《伤寒论》128条“小结胸病,正在心下,按之则痛,脉浮滑者,小陷胸汤主之。”之义及慢性萎缩性胃炎多见胃脘部痞塞满闷之症,将其与小陷胸汤合方进行调治。方中柴胡、白芍能疏肝解郁;枳实可消积行滞,更能助柴胡以疏肝下气,协芍药调中定痛;甘草和中,伍白芍能酸甘化阴,缓急止疼。黄连苦寒泄热,半夏辛温化痰,括楼实甘寒滑利,既能助黄连清热降胃,又能助半夏化痰开结。临床她常以炒枳壳代替枳实,因枳壳性缓而枳实性猛,枳壳理脾胃之气而枳实破肝胆之气也;以全栝楼代替括楼实,因全栝楼具有宽胸理气作用而栝楼实偏行大肠有滑利之弊。若病人泛酸烧心加乌贼骨、煅瓦楞;纳呆甚加炒三仙、茯苓、太子参;恶心呕吐加陈皮、竹茹;胃脘痛甚加香附、元胡;胀满甚加藿梗、苏梗;暖气不除,可加旋复花、代赭石,取效颇佳。如崔男,32岁,1997年11月7日就诊,主诉胃脘不适一月,有慢性胃病史。1997年10月30日到协和医院就诊,胃镜提示慢性浅表性胃炎,慢性萎缩性胃炎。西药疗效不佳,故求诊于聂师。细询知其工作压力较大,饮食不规律。观其舌红苔淡黄略腻,切脉沉弦。予解郁和胃,清热涤痰:柴胡、炒枳壳、白芍、法夏、陈皮、元胡、全瓜蒌、藿苏梗各10克,党参12克,酒连3克,炙草4克。7剂。嘱进清淡饮食,忌辛辣油腻及难消

化之物。复诊:症状大减,效不更方,上方稍做加减,继进 14 剂。三诊时诸症已基本消失,嘱其坚持摄生调养,以巩固疗效。

二、寒热并调法

吾师强调本病病程长,病情复杂,多属寒热错杂之证。造成这种情况之因有三:一则脾胃之生理属性,因胃为阳明,多热多实,脾为太阴,多虚多寒;二则因病人体质;三则是医生误下或用过寒凉药克伐脾胃。临床病人常胃脘部以上灼热泛酸,口苦烦躁,渴喜冷饮,但腹部喜温喜按,肠鸣便溏。对此类型患者,当选半夏泻心汤调治:徐女,44 岁,1997 年 10 月 14 日就诊。主诉胃脘部嘈杂不适半月余,平素脾胃功能欠佳。1997 年 10 月 8 日鼓楼医院胃镜检查,提示轻度萎缩性胃炎,服用甲硝唑、阿莫西林、泰胃美后,不但未缓,且日趋严重,故慕名来就诊。病人面色晦黄,形体消瘦,烦躁,口苦,喜冷饮,但食后即觉胃脘不适,疼痛便溏。舌红,苔薄黄,脉沉弱。治以辛开苦降,寒热并调,法夏、枯芩、藿苏梗、焦三仙各 10 克,党参、茯苓各 12 克,酒连、干姜、砂仁(后下)、炙草各 4 克,枣 5 枚。7 剂后复诊,诉症状大减,继服 7 剂。三诊症已消失,又进 7 剂巩固之。

三、醒脾快胃法

吾师从桂枝汤方后注“禁生冷、粘滑、肉面、五辛、酒酪、臭恶等物”及《伤寒论》280 条“太阴之为病,脉弱,其人续自便利,设当行大黄芍药者,宜减之,以其人胃气弱,易动故也。”之义出发,认为治疗脾胃病宜轻补轻调,尤其对于病程较长,症较复杂的慢性萎缩性胃炎更应如此。临证之时务求做到“补中有通,补而勿滞”、“泻中有补,泻不损胃”。她指出慢性萎缩性胃炎多有纳差,脘胀不舒等脾胃之气不振之症状,故常用轻清之品鼓舞脾气,使胃纳渐增。每喜投藿香、苏梗、陈皮、砂仁等醒脾快胃,辅助党参、白术,促使胃纳脾运,希冀收以佳效。并谆谆告诫我们:治疗

此病,切忌一味壅补和攻伐太过,总应以调和为本,欲速则不达也。

四、调气化瘀法

聂师认为慢性萎缩性胃炎,因病程长,疾病由气分渐入血分,由初期的以胃脘胀满为主,过渡到以胃部的疼痛为主。其发展过程即叶天士所谓:“新病气结在经,久病血伤入络”也。为未雨绸缪计,她常把活血化瘀之法贯穿于此病治疗的全过程。强调初期此法可截断疾病的传入,中后期此法可防止邪灼胃络而出血,并通过促进血运加快而助萎缩之腺体恢复(现代医学亦证实,通过运用此法,可使该病胃粘膜明显减少的血流量,逐渐恢复正常)。鉴于此,吾师常用当归、川芎、元胡、香附等活血化瘀之药,辅佐主药以提高疗效。

五、善后调养法

《伤寒论》非常重视病人的善后调养,作为全国著名的伤寒论专家,吾师也十分重视病人的饮食、情志等方面的调养。她常说“三分药物七分养”,强调慢性胃病更宜重视食物的调养。认为食物的调养具有二重意义:其一是饮食有节,勿伤脾胃;其二是通过饮食来调养脾胃。常根据食物的性味,病人的体质和疾病的证型来指导患者选择饮食。如阳虚体质或胃中有寒者,可选生姜、龙眼肉、羊肉等温热食品;阴虚体质有积热者,介绍患者食用山药、莲子、苡米等品;性格急躁易怒者宗甘麦大枣汤义让其用百合、大枣、小麦熬粥。还要求病人饮食宜清淡,少食多餐,忌烟酒及辛辣刺激食物,少饮浓茶,忌糖食。慢性萎缩性胃炎与情志不舒关系十分密切,所以精神调护对本病的预后有重要作用,吾师要求病人远烦戒怒,怡情悦性,指出只有这样,治疗才能彻底。

(张秋霞、刘燕玲、韩刚,原载于《中国医药学报》2000年第5期)

六 聂惠民用“合方”治冠心病之辨义

“合方”一词,始见于林亿等校注《伤寒论》的按语中。“合方”在《伤寒论》中内容十分丰富,有关此方面的论述,可参见聂惠民教授发表于《北京中医药大学学报》1998年第2期10—13页上的一篇文章“论《伤寒论》‘合方’法则的优势”。聂老师认为合方具有两个方剂的综合作用,彼此可扬长避短;两方协同,功效累加;合方相伍,产生新效;经方相合,法为上策等优势。若借鉴前人经验运用之,远比自组方剂更简捷,更速效。因此她常用合方来防治疑难杂病,疗效甚佳。由于冠心病属于本虚标实之证,本虚乃心之气血阴阳不足;标实为痰饮、气滞、瘀血。对此聂师指出合方可发挥更大的优势。现将其用“合方”治冠心病经验总结如下:

一、栝楼薤白半夏汤与生脉饮合方

栝楼薤白半夏汤首见于《金匱要略·胸痹心痛短气病脉证治第九》。主治“胸痹之为病,喘息咳唾,胸背痛,短气,寸口脉沉而迟,关上小紧数。”由于痰饮壅塞胸中,致使胸中气机不畅,而出现胸闷、胸痛、气短等症。方中栝楼开胸涤痰,薤白疏滞散结,半夏逐饮降逆,三药相合,共收通阳散结、豁痰下气之功。现代医学证实该方有扩冠强心、改善微循环、抑制血小板聚集、抗动脉粥样硬化及增强组织耐缺氧能力等作用,实为本方可治胸痹的药理学基础。生脉饮始载于张元素《医学启源》,由人参、麦冬、五味子三药组成。因其具有“气充脉复”之作用,故名生脉饮。方以人参大补元气为君,麦冬养阴生津,清热除烦为臣,五味子

酸收敛肺止汗为佐使,三药相合,一补,一清,一敛,共奏益气养津,敛阴止汗之功。动物实验发现生脉饮具有正性肌力作用,可增强心肌收缩力,加快冠脉流量等。聂老认为生脉饮为治本之法,标本结合,疗效故佳。聂女,50岁,1998年12月29日初诊。主诉胸闷如有物堵塞,善叹息,头晕,乏力,失眠二月余。面色晦黄,精神欠佳,舌尖红,舌质略暗,苔薄白,脉沉细略弱。心电图提示心肌供血不足,冠心病。辨证为心之气阴不足,兼有痰饮内闭胸中,治以宽胸养心。处方:党参、茯苓各15克,麦冬、炒白术、菊花各12克,栝楼皮、法夏各10克,薤白、五味子各4克。7帖。1998年1月12日复诊,诉胸闷大减,睡眠好转,精力转佳,舌暗减轻,脉力增强,效不更方,继进7帖。经过一个月的调理,已无不适感,心电图复查恢复正常。

二、小柴胡汤与生脉饮合方

小柴胡汤源出《伤寒论》,为治少阳病主方。功可和解少阳,扶正祛邪。主治寒热往来,胸胁苦满,嘿嘿不欲饮食,心烦喜呕,口苦咽干,目眩,舌苔薄白,脉弦等症,为“和剂之祖。”本方由柴胡、黄芩、半夏、生姜、人参、甘草、大枣七味药物组成。柴芩相合,经腑同治,清疏并行,使气郁得达,火郁得发,枢机通利,胆腑清和,半表之邪从外而解,半里之邪从内而彻。姜、半为伍,一则调理胃气,降逆止呕;二可佐柴、芩以逐邪;三能防甘、枣泥滞壅中。参、草、枣相配,其用亦有三:一者扶正祛邪;二者杜邪内入;三者中和柴、芩之苦寒,免其戕害脾胃之气。七药相辅相成,寒热并用,攻补兼施。既能疏利少阳枢机,又能调达气机升降,更使内外宣通,气血条畅。从小柴胡汤方义的分析,即可看出小柴胡汤对气滞不通型的冠心病颇适宜。现代药理研究也证实该方能预防动脉粥样硬化,其抗血小板凝集的作用远胜于地塞米松,阿司匹林。聂师运用小柴胡汤合生脉饮治气滞气阴不足型

之冠心病,疗效颇佳。刘女,39岁,1998年12月29日初诊。主诉心慌,胸闷,咳嗽,咳黄痰一个月。素性急躁,此次病起于精神不悦。观舌红,苔淡黄,脉沉弦。心电图示ST段下移,T波低平,提示冠心病。辨证为气滞气阴不足,当理气益气养阴。处以柴胡、黄芩、法夏、白芍各10克,党参、麦冬各15克,炙草、五味子各5克,桔梗、百部各12克。7付。1998年1月12日复诊:心慌,胸闷消失,仍有轻咳,咽干。前方加玄参8克、双花10克,7帖,诸症基本向愈,心电图恢复正常。

三、血府逐瘀汤与生脉饮合方

血府逐瘀汤出自清·王清任《医林改错》,由桃红四物汤合四逆散加桔梗、牛膝而成。桃红四物汤能活血化瘀,四逆散可疏肝理气,加桔梗开胸膈之结气,牛膝导瘀血以下行,合而成方,用以治疗“胸中血府血瘀之证”。聂老师认为血府逐瘀汤与冠心病之血液运行不畅,阻滞胸中气机之病机十分吻合,故常用此方合生脉散治血瘀兼气阴不足之冠心病。药理实验证实该方可扩张血管,增加血流量,抑制血小板聚集,加速纤维蛋白溶解,改善微循环等,为本方治此病作了有力佐证。张女,62岁,1998年9月18日初诊。自诉胸闷,胸部有针刺样疼痛,气短乏力,动则更甚,失眠,病人口唇紫暗,面色黧黑。舌质暗有瘀斑,苔薄白,脉沉略涩。心电图示冠脉供血不足,提示为冠心病。辨证为心血瘀阻,气阴不足,治以活血化瘀兼以养心。处以:生熟地、当归、怀膝、枳壳、麦冬、赤白芍各12克,炒枣仁、党参各15克,桃仁、柴胡、桔梗各10克,五味子5克。7帖。1998年9月25日复诊,喜告症状大减,效不更方,稍事加减,前后三诊,共服药21帖,调理而安。

(张秋霞、刘燕玲、韩刚,原载《北京中医药大学学报》2000年第5期)

七 胡翘武临床经验鳞爪

胡翘武主任医师(1914年—),安徽歙县人。少年从学于新安学派老中医汪泽民,后移居郎溪县,以医道济世,因屡起沉痾而遐迩闻名。曾任安徽省宣城地区中医学会第一副会长,79年在全国集体转全民的中医考试中被优选至安徽中医学院供职。胡老业医五十余载,积累了丰富的临床经验。兹择其鳞爪,以飨同好。

一、对温阳药的灵活运用

胡老以《内经》“壮火食气,少火生气”和张景岳“有形之火不可纵,无形之火不可残”之说,为温热药物应用的理论根据。在运用诸如附子、肉桂、干姜、吴茱萸等温热药中,有独特的见解,妙在灵活变通,配伍精巧。

1、以附、桂引火归原

胡老对于阴损及阳或气阴两伤的病证,常用少量附子、肉桂(2~4克)配入补益气阴药中,以振奋元阳或引火归原。如治李姓女孩,1岁。患口舌糜烂两月,神疲萎倦,四末清冷,形体瘦弱。舌鲜红,脉细。他据症断为虚阳浮越,心火独炎于上。药用生地黄、淡竹叶、车前子各6克,通草3克,酒炒黄连、肉桂各1.2克,辰砂0.6克(冲)。另以吴茱萸、生半夏各9克,共研细末,分四次外敷两涌泉穴,经治2天痊愈。

2、伍附、桂温通排石

胡老认为,尿路结石之证,世俗动辄一味导利,运用大剂清利化石之品,难免有失偏颇。虞搏《医学正传》谓:“故清阳不升,

则浊阴不降，而成淋闭之患矣。”因此，胡老对此证的治疗，善在消化石方中加入适量的附、桂，增强膀胱气化之力，以利排石。曾用此法加木贼草治一男性尿路结石患者，药进2剂后，排出黄豆大结石1粒。

又一男性尿路结石急性发作患者，右侧腰部剧痛，向少腹放射，小溲淋漓，面色惨白，肢冷汗出如珠，舌淡白胖，脉细而弱，急投温经散寒之剂。方用：桂枝12克，附子6克，吴茱萸、当归、白芍各9克，木通、炙甘草各4.5克，细辛3克，生姜4片，红枣3枚。2剂痛止，小溲正常。此案辨证之理，乃宗《医学薪传》所谓：“夫通则不痛，理也。但通之之法，各有不同……，虚者助之使通，寒者温之使通”之意也。虽方用仲师当归四逆加吴茱萸生姜汤，但细究其法，实是李东垣通关丸知、柏与肉桂同用治“下焦湿热”法的发挥。

3、疰夏宜乎温脾

小儿疰夏，时值夏暑，用药一般当远刚近柔，但胡老则别有见解，他认为此证多系夏令伤食，重伤脾气所致，因此非用升阳温脾之法难以奏效。曾治一汪姓患儿，女，5岁。症见纳食不佳，饮水无度，小溲频数清长，大便溏稀日数行，面黄神疲，苔白脉细。脉证合参，辨为脾阳虚馁，不能蒸津上承，以致水液由二便而去。治用党参、白术、茯苓、葛根、鸡内金各9克，山药12克，藿香、干姜、甘草各3克。进药4剂痊愈。观其方乃系钱乙七味白术散加干姜化裁而成，于大队健脾升运药中伍入一味辛热之干姜，颇寓深意。盖脾虚宜补，脾阳不振必佐以温运，包含“太阴湿土，得阳始运”之意。

4、湿温巧用温燥

胡老指出，湿为阴邪，重浊粘腻，与温邪相合后，则缠绵难解。此时若在清化湿热方中，加入一味辛温燥湿之附子，以温运

燥湿,每可缩短湿温病程。而在湿温后期,见有汗出恶风,低热不退等气阳两虚之证时,附子更是不可或缺之品,主方当选黄芪五物汤加附子。

如胡某,男,20岁。1956年7月患湿温3个月,热不退,病渐危,邀胡老会诊。诊见患者面容惨白,午后微寒,旋即发热。自汗出,口不渴,颈下胸腹白痞色枯无华,便溏洩黄,半月不进饮食,全赖输液维持,脉虚浮数,舌淡苔白少津。审视良久,断为湿温早期失治,已由邪实正盛转虚多邪少之候。予附子、桂枝各6克,黄芪15克,白芍9克,佩兰、茯苓各12克,山药24克,炙甘草3克,生姜3片,大枣3枚。外当调和营卫、益气固表,内应温燥化湿、托邪外出。2剂热退大半,诸症遂减。

二、对前贤“名论”的异议

胡老不囿于古见,通过临床实践,认为有些理论还须商榷。

1、对十八反、十九畏的异议

乌头反半夏,为前人遗训,但《金匱要略》赤丸中乌头、半夏同用,每取奇效。胡老受此启示,通过长期实践观察,大胆指出,对阳虚风痰阻络者,非此两药同用难收良效。如曾治一张翁,年过花甲,体态丰腴。忽半身不为已用,舌强语謇,口眼歪斜,痰多纳呆,便艰洩少,脉浮滑大。所幸神识尚清,知邪未入脏腑,急予驱逐经络风痰为法,予制川乌、全蝎各4.5克,枳壳、陈皮各6克,地龙、姜半夏各9克,茯苓、瓜蒌皮、白蒺藜各12克,川连1克,竹茹9克。礞石滚痰丸15克,分3次吞服。上方加减服至20余剂,渐能拄杖蹒跚。胡老还用集圣丸(《冷庐医话》方,内有人参、五灵脂)治小儿疳积30多例,均获良效。对肝郁胃寒致脘痛噎逆者,常将郁金与丁香合用;脾肾虚寒腹泻者,每用肉桂与赤石脂并投;治癭瘤之疾,常将海藻、甘草兼施。胡老谓:“非二药相反之性,则难收相成之效。”

2、对诊脉当“男左女右”的异议

考前贤皆以男为天,女为地;天为阳,地为阴;左为阳,右为阴。故提出诊脉当男以左为主,女以右为要。胡老提出无论男女患病,应根据左右手脉的脏腑分配,结合望、闻、问三诊辨证施治。并认为肝为女子先天而藏血,女子 14~49 岁之间,为肝所主病,临床所谓的妇科病多发生在这一阶段,故诊治妇科病时,尤须重视左关脉。笔者随其侍诊,见其曾治一农妇,往日月汛正常,近突然大下如崩,少腹灼热,口干便艰,烦躁难卧。前医见其舌红脉细数,予以凉血止血;易医见其下血紫块甚多,改投清热化瘀;更医见其面觥心悸,虑出血时久量多,有虚脱之虞,投归脾汤重加煅龙牡,其未敢立服,转请胡老诊治。按脉良久后,询其乳房胀否?答之“胀甚”。遂疏丹栀逍遥散去白术、姜、枣,加生地黄、枳壳、夜明砂、川楝子各 12 克,3 剂血止。余询其理,胡老说:“其左关弦劲,且伴乳胀,故知肝郁化火,损伤阴络,投丹栀逍遥散重用枳壳、川楝子辛散肝郁,寒清肝热也;生地、夜明砂可凉血止血。如以女子当重在右手之脉,见血止血则谬矣。”

3、对芳香药用量宜轻的异议

胡老对本地区一些医家受叶桂“诸香皆泄气”,“香气如烟,先升后降”之说影响,不敢放手用芳香药颇持异议。认为此类药因具辛散之性,入煎剂有效成份极易挥发,若疑难重证用量过轻,难收速效。故桂枝、枳壳、苍术、厚朴常用至 9~15 克,至于药力微薄之佛手、香橼皮、藿香、佩兰、大腹皮、荔枝核及一些花类药,量则更大,甚至 30 克左右。即或砂仁、白豆蔻亦常在 5 克以上。如治周某,女,患慢性胃窦炎,纳呆脘胀已两年,食后痛甚,噎逆,面色苍白,腹痛喜温按,舌淡苔白,脉沉细弱。断为寒湿壅滞中脘,治当温化,投附子、白术各 20 克,干姜、木香、党参、砂仁、青皮、草蔻各 15 克,炙甘草 9 克。服 10 剂后,改服附子理

中丸 5 天。遵此法坚持服药半年而愈。

三、对妇科治疗大法的补充

第二版中医院校妇科教材在治则章中仅提出：“调气血，和脾胃，疏肝气，补肾气”四法。胡老认为仅此四法治疗妇科疑难大证，常有鞭长莫及之叹，故主张参入下列两法。

1、清化湿热，驱痰逐瘀

胡老认为，妇科最多肝郁之证，肝病又易传脾，脾伤不仅痰浊自生，且常为湿热所犯，湿热和肝经郁火相合，疏泄不利，脉络瘀阻。故施治之时，须考虑从清化湿热，祛痰逐瘀入手。曾治万某，27 岁，结婚 5 年未孕，经来超前，量少色淡，每于经前 1 周即感乳房胀痛，两乳外侧可扪及累累如珠之肿块，经后自消，病已 4 年。体偏胖，厌油腻，头晕多梦，苔厚脉滑。前医予养血疏肝之黑逍遥散 10 余剂未效。胡老辨为湿痰阻于胃经，不可泛从肝治，改投姜半夏、浙贝母、橘红、僵蚕、泽兰、白芥子、丝瓜络、路路通各 9 克，竹茹 12 克，茯苓、牡蛎各 15 克。每届经前常服数剂，经治半年，乳核渐消无形。对此类病者，胡老喜用白芥子、路路通，谓前者性温善走，性颇和平，不仅驱皮里膜外之痰，且有较强的开郁作用。《本草正》说：“白芥子消痰癖疔痞，除胀满极速，因其味厚气轻，故开导虽速，而不甚耗气。”后者苦平味涩，虽一般中药学认为其归经入肝胃，但因其一身带刺，可四通八达，走而不守。故《本草纲目拾遗》说：“通行十二经。”《中药志》即言其：“治月经不调，周身痹痛，小便不利，水肿胀满”等证。尤喜其性不峻猛，虚体亦能久用，堪为妇科良药。

2、温宫散寒，通络消瘀

有感于前贤曾说，“寒则气滞血凝，温则消而去之”之理，在治月经病时，胡老极喜加用炮姜温宫散寒，以免冰伏致瘀。对腹中癥积，系寒瘀阻络为祟者，更采用温通之法。即使患者气血俱

虚,甚而因虚发热,他仍根据《本草经疏》所言:“干姜炒黑,能引诸补血药入阴分,血得补则阴生而热退,血不妄行矣。”而在补益药中配入炮姜,此时炮姜还可“温脾燥胃”(王好古言),以防补药之腻膈也。

胡老亦常用虫类药物合散寒温宫之品,治因月经病所引起的症积,多制成丸、散久服,通过通络消瘀,终使痞块缓削渐化。曾治王女,34岁,脐下3寸处隐痛,按之有核桃大硬块一枚,其面晦肢冷,少腹如冰,神疲纳少,舌淡胖,脉沉迟。细询知经期同房,使寒瘀与败精交阻于胞宫及厥阴之络,日久而成症积。予附子、炮甲、乳香各60克,蜚虫15克,共为细末,每服3克,日3次,空腹米酒送服,两料痛止症消。

四、以牡蛎巧夺疑难证

胡老喜用鳞介之品疗治顽难痼疾,而对牡蛎的运用更是独具匠心。《名医别录》说牡蛎可“除留热在关节荣卫,虚热去来不定,烦满,止汗,心痛气结,止渴,除老血,涩大小肠,止大小便,疗泄精,喉痹,心胁下痞热。”《本草纲目》指出牡蛎可“化痰软坚,清热除湿,止心脾气痛,痢下赤白浊,消疝瘕积块,瘰疾结核”。故将其或单用或配伍以治多种疾病,且对用量十分考究,或重达近百克或轻仅用几克。兹录验案三则于下。案一,朱某,女,17岁,1959年8月7日初诊。湿温发热稽留18日不退,皮肤干燥。突然大便洞泄如注,神情更为颓唐,口干喜饮,脉细劲而数,舌嫩红。急宜存阴止泄,稍有孟浪将有亡阴之险。与生牡蛎90克,研碎水煎,分3次服。两天后诸证大减。上方即吴塘之一甲煎,原治温病下后,大便溏泄,脉仍数者。今患者虽未经下,但有脉数便溏之证,故胡老师古不泥,倍用取效。

又治杨某,男,25岁。苦寒热无定期已2年,虽经多次查出疟原虫,但遍服抗疟药无效。现形容憔悴,面色黧黑,两胁胀痛,

肝脾均见肿大,用吴又可三甲散损益,以蜚虫、生牡蛎、木贼、鳖甲、炮山甲、僵蚕、蝉蜕、草果、知母、生姜、红枣组方十剂。药后寒热退,肝脾已无触及,面色红活,后调理而愈。此证颇似《瘟疫论》中之“主客交”,“主”指人身之营血,“客”为疫邪,此为久病正虚,疫邪与营血交结之顽证也。吴又可云:“此证补之则邪火愈炽,泻之则损脾坏胃,滋之则胶邪愈固,散之则经络益虚,疏之则精气愈耗,守之则日削近死。”故胡老用吴氏所制三甲散去龟甲、白芍、当归、甘草,防壅补恋邪,加草果、知母、木贼草驱邪而退寒热,故疗效显著。方中牡蛎为 30 克,系常用之量,取化痰、软坚、清热、止痛之功。

又治谢某,男,62 岁,1970 年 5 月 3 日初诊。舌红干无苔,脉弦滑有力,心下痞,胸痹,咽中痰声嘶鸣,胶结难出,二便不利,既不喜饮,又不纳谷。目下肾阴将涸,热灼津液为痰,阻于胃,逆于肺也,病虽至危,阳尚未脱。姑予标本并治,以观进退:与生牡蛎、葶苈子、清半夏、麦冬各 9 克,玄参 30 克,瓜蒌仁 18 克,阿胶 6 克,胆南星 4.5 克,黄连 3 克,鲜竹茹 15 克。仅 2 剂症即缓解,后出入调治而瘥。此案笔者侍诊目睹,患者患肺结核及肺源性心脏病,反复发作,以这次最剧,西医抢救三日未效,患者系老中药师,坚请胡老诊治。胡老辨证为阴虚痰热结胸,以增液陷胸汤取效。案中牡蛎仅用 9 克,是恐其沉降耗气,虚体难支之故也。

(马继松、胡国珍。原载于《广西中医药》1986 年第 5 期)

八 李传方对尿石病辨证 与辨病相结合的治疗思路

李传方主任中医师,早年曾系统学习西医,59年保送至安徽中医学院中医系深造,65年毕业后一直在皖南医学院附院中医科从事临床及科研并兼任中医教学,临证擅辨证与辨病结合,诊治疑难杂病疗效颇佳。笔者有幸随李教授进修一年,获益匪浅,现将其对尿石病辨证与辨病结合的治疗思想,整理公诸于同道。

李师认为,尿石病既是常见病,又是多发病,且近年有明显增多的趋势。手术疗法损伤性较大,复发率较高(上海华山医院统计10年复发率可达30%),加上一次性所需费用较多,故不能作为依赖性的治疗手段。而使用碎石机因普遍存在“盲区”与“石街”两大难题,且有些患者碎石后却排石不尽,有些病人缘于有并发症不能使用,故中医药仍不失为一种治疗尿石病的重要手段。但传统的治疗方法大多局限于清利、通淋、排石三大套法,疗效不能尽如人意,因此治此病时,极有必要引进一些现代医学的观点,采用中医辨证与西医辨病相结合的新思路,才可望获得理想的结果。

一、西医对尿石病的认识

西医根据尿石的部位将其分为输尿管结石、膀胱结石和肾结石,后者又分肾实质结石(有上极和下极之异)与肾盂结石(又有上盏、中盏及下盏之别)。并根据其性状分为尿酸盐结石、碳酸盐结石、胱氨酸盐结石(多光滑、易排出)及草酸盐结石、磷酸盐结石(多粗糙,甚至成珊瑚状,难排出)。还可检查出其大小,一般认为直径大于1cm的无法排出。另解剖显示男性输尿管

与尿道各有三处狭窄部位,若与女性所患结石在部位、大小、性质相似情况下,排石机率通常小于女性。在对上述西医知识尚未全面了解情况下,就仓猝用中药排石,难免事倍功半。

李师指出:从西医观点,采取保守疗法治尿石病,常有四大要点:一是多饮水,利尿以冲刷结石;二是增加肾盂、输尿管的蠕动波、蠕动频率,以推移结石;三是强化肾脏泌尿功能,增强结石上段正向内压力,以利排挤下压结石;四是由于肾内钙化是尿石形成的主要机理之一,钙盐在尿石形成中起重要作用,故应努力促使尿液酸化,以促进结石崩解、消溶(对少数酸性结石除外)。李师临证常结合此四大要点,并注意病人内分泌情况(实验与临床均证实,雌激素可抑制结石生成,而甲状旁腺功能亢进却会导致血钙升高而形成结石),且参考可能使患者形成结石的其它因素(如反复的泌尿系感染、伴有骨质疏松、久病长期卧床、维生素A或B₆的缺乏、食入过量的钙磷食物及较长期饮用硬水等),进行辨证处方。在辨证处方的基础上,基于上述认识,结合辨病选用药物,常可提高疗效。若尿石横径大于1cm,长径大于2cm,尿路有明显畸形及狭窄,结石与尿路粘膜有严重粘连,患者有肾功能损害,应选择手术治疗。若患侧有十分严重的积水,采用保守治疗的时间过长,亦应考虑手术治疗。

二、中医对尿石病的认识

李师认为中医将本病纳入淋证范畴:如仅见小溲频急,淋沥涩痛、色深黄或浑浊,或伴小腹拘急或腰痛时,则称为热淋;当溺时尿道窘迫或尿中挟有砂石,或摄片、B超等证实有尿石时,则称为石淋;若在证实患石淋的同时又伴血尿,或尿检有红细胞,则为血淋。大多数前贤将尿石形成之因、机责之为下焦湿热,故传统治则不出清利、通淋、排石三途,出血佐凉血止血,病久阴伤伍滋阴之品。随着李师对该病研究的不断深入,他发现传统的

治尿石三法已远不能适应病情之所需,故根据自己近四十载临证经验,并参考近贤一些新认识,初步拟定了治此病的四大治法。

三、主要治法

1、清利通淋排石法

药用:金钱草 50~100 克,瞿麦、川膝、滑石(布包)、冬葵子各 30 克,琥珀粉 6~10 克(分吞)。

主治:尿石形成未久而小,位置偏低,形状规则,近期有下移性绞痛,患者体质较好,或伴尿灼热涩痛,淋漓黄赤,甚或现血尿,口苦烦躁,腰痛便干,舌红苔黄腻,脉濡数等下焦湿热症状。

机理:中医认为过食肥甘、嗜酒无度或下阴不洁者,每致湿热蕴积下焦,煎炼尿液成石。金钱草可酸化尿液而溶石,并可通过利尿而排石;瞿麦可影响肾容积,利尿止血;川膝可直接或间接作用于输尿管平滑肌,使其扩张,加快蠕动而排石;滑石质重下行,利尿滑窍;而冬葵子富含脂肪油,滑利通淋;琥珀主含树脂、挥发油,功能利水通淋止血,后三味药可在保护输尿管内壁前提下,辅助它药排石并防排石过程中的出血。六药合用,可通过利尿冲荡,促使输尿管蠕动和抗炎而获效。

2、行气疏通排石法:

药用:制香附、乌药、川膝各 30 克,三棱、莪术各 15 克,金钱草 50~100 克,琥珀粉 6~10 克(分吞)。

主治:病久尿石较大,位置偏高,形状不规则或粗糙,甚至嵌顿形成积水。少腹或腰胀痛并向前阴放射,尿淋漓不尽或排尿中断或伴明显血尿。舌略红,苔薄黄,脉偏弦。

机理:中医认为形成尿石之因、机虽有多种,但这些因、机在演变过程中,都可发生气滞之病理,近贤即有强调气滞既是尿石之成因,又是形成结石的一种病理变化,即结石内阻→尿泄不畅

→气机阻滞→水道越加壅塞→结石渐沉积增大→复使气滞加重。香附乃行气疏通之佳品,能促使输尿管作节律性蠕动,解除痉挛,并可明显消除炎症,故会有效提高痛阈,减轻内脏或外周疼痛。它还有一定量雌激素之作用,并直接杀菌,防止继发感染。与乌药、棱、莪相伍,可相互激发出极大的行气疏通作用,从而通过增强肾盂正向内压力,促使输尿管蠕动,松弛平滑肌,扩大输尿管腔,促使结石下排。另中医还认为气行则湿自化,而湿去则热必孤,不仅有利于排石,又可防结石再生。有近贤通过比较发现,此法较前法效佳。

3、活(血)化(瘀)软坚排石法:

药用:川芎、川膝各 30 克,皂角刺、留行子各 20 克,炮甲、琥珀(二味研吞)、制乳、没各 10 克,金钱草 50~100 克。

主治:结石较大,形状粗糙不规则,或与器官粘连致石久排不出。局部刺痛或绞痛明显,痛处固定拒按,时有血尿或尿时突被阻断。舌偏紫或有瘀斑、瘀点,舌下静脉紫粗如虬,脉紧涩或弦。

机理:西医认为:结石对周围组织的刺激,必致充血、水肿、粘连。而中医认为固定不移且拒按的绞痛或刺痛即为有瘀,故将结石与症瘕看作同类;尿血乃离经之血,清代王清任早明言:“离经之血即瘀血”;另结石之病发非一日而成,而叶天士却曰:“新病气结在经,久病血伤入络”,加之结石为坚硬之物,故活化软坚法对尿石有较佳疗效。主药川芎乃活血要药,其对中枢神经系统有很强镇静作用(张仲景创酸枣仁汤,即以其配茯苓、枣仁治不寐),还可有助于脏器平滑肌的舒张,并可抗菌;留行子含多种皂甙,可直接溶石;皂刺配炮甲为传统磨硬溃坚的最佳“药对”;琥珀、乳、没均有明显护膜生肌功效,能消减结石下移时对组织的损伤,且琥珀可阻断神经节传导以缓痛,乳、没能直接定

痛。由于本法具有①扩张输尿管,增强其蠕动而排石;②促进炎症吸收,消减炎性组织增生(大量实验表明:炎症反应即为瘀血表现);③解除脏器痉挛;④改善微循环,降低毛细血管通透性,减少出血(有近贤指出:止血的最根本方法即为化瘀);⑤消溶小结石;⑥直接镇痛,尤其是肾绞痛等六大作用,因而受日益增多的医家所青睐。

4、益气补肾(或健脾)排石法:

益气补肾排石法:

药用:黄芪 30~60 克,白芍、川膝、乌药、仙灵脾各 30 克,白术、蛇床子、补骨脂、冬葵子各 15 克、金钱草 50~100 克。

益气健脾排石法:

药用:黄芪、党参各 30~40 克,白术、黄精各 15 克,乌药、瞿麦、冬葵子各 15~30 克,王不留行 30 克,金钱草 50~100 克。

主治:结石较大粗糙,甚至成珊瑚状,位置较高,久用它法却下移缓慢或尿石发生嵌顿、积水、绞痛、刺痛,或放射性疼剧烈。尿血量多,并伴明显肾虚或脾虚症状。

机理:虽中医古有“淋证忌补”之说,乃指实热证而言。李师指出:若素体虚弱或久用清通致气阴双戕,当投以大剂补药,以扶助正气,增加正向内压力,促使输尿管蠕动,有利排石。且益气药还可增加肾盂及输尿管紧张性,纠正低钾(会出现周期性麻痹)及代谢功能的低下,更可通过促进食欲,提高对疼痛或尿血的耐受力。现代药理还证实,温阳药蛇床子含雌激素,可抑制结石形成。由于“壮火食气”,故蛇床子、补骨脂等用量勿过大,并须配大剂白芍以利“阴平阳秘”。另药理证实,白芍含脂肪油、树脂、鞣质等,能较好保护泌尿系脏器的粘膜,其解痉、抗菌作用,不仅有利止痛,且可防尿石外排过程中引起的感染。

李师反复强调:因尿石形成的因机很复杂,形成过程较长,

故上述四法还可视病情的具体情况合而用之,以增进疗效。有时他还将升降气机法(取升麻、桔梗之升合川膝、枳壳之降)、温通行气法(良姜、香附合木香、归尾、青皮等)、提壶揭盖法(以麻黄、浮萍、薄荷、木贼草等宣发肺气)、宣化膀胱法(《内经》曰:“膀胱者,州都之官,津液藏焉,气化则能出矣”,故用乌药、官桂、石菖蒲、小茴香、炒橘核、荔枝核等宣化膀胱之气机,以促进利尿)等,辨证合入上四法中,取效则更佳也。

另在辨证中,见腰腹绞痛(肾、输尿管绞痛),常选加赤芍、延胡索、五灵脂;血尿明显者加小蓟、茅根、炒蒲黄;合并感染(伴寒热、白细胞增多,尿检有脓细胞或白细胞增多),则加银花、连翘、黄芩或黄柏等。

在辨证治疗的基础上,通常配合应用黄体酮 20mg 肌注,日 2 次。有松弛尿路平滑肌,扩张输尿管,缓解肾及输尿管绞痛等作用。还能拮抗醛固酮,产生利尿,均有利于结石排出,与中药同用,相得益彰,且无不良反应。

四、辅助疗法

李师发现,按上述方法排石未效者,若以下列诸法辅之,或可望峰回路转。

1、饮用磁化水

因磁化水常含铜、铁、镁等微量元素,能增加草酸钙的溶解度,而尿石的成份,又以草酸钙为多,故饮磁化水,对有石之人可收溶石、碎石并防新石再生等效,常人饮之亦可防患于未然。

2、酸化尿液法

李老查阅大量文献,发现钙盐形成之石最多,而肾内钙化又是尿石生成的主要机理之一,若能设法酸化尿液,使尿中钙盐溶解,结石遂可消失。故他倡以乌梅、生核桃仁各 25 克或金钱草(50~100 克)泡茶长饮。对体质较好,很少腹泻或经济拮据者,

他劝患者日用3~6克元明粉(主要成分为无水硫酸钠),水溶饮服。

3、局部叩击或电波音频激荡法

在结石局部用手掌叩击拍打,每日2~3次,或用电极板,连接肾俞穴与膀胱俞穴,也可连接肾俞穴与水道穴,采用疏密波型,断续振动法。电流可由弱至强,直到最大耐受程度。日1~2次,每次3~5分钟。另还可使用YC-3型音频治疗仪,选用结石体表部位或绞痛部位的阿是穴,予局部音频治疗,每日1~2次,这对结石较大或嵌顿在输尿管狭窄处,或伴输尿管扩张,肾积水者尤好。因可有利于消除局部粘连和炎症、水肿,故亦有利于结石松动下移。

4、跳跃颠动法(又称运动疗法)

指患者用单腿或双腿上下跳跃,或双腿稍并拢,足尖不离地,人随足跟的提起与落地作上下颠动,此法系通过跳、颠时的惯性和重力作用,促使结石下移。注意跳、颠时足跟定要着地,以增加重力作用,且最好在服药后尽量不解小便的情况下进行,以利用尿液的下行力冲击结石。日做2~3次,每次10~20分钟。

5、体位疗法

适用于肾结石。如患肾下极或下盏结石,取头低臀高位或头下腿上倒立位,并配合拍击结石局部体表,每次30分钟左右(下法时间相同)。中盏结石,取患侧向上侧卧位,并配合局部体表拍击。上盏结石与输尿管结石,取直立位,配合跳跃颠动法。体位疗法通常在服尿路排石剂1小时后进行,日1~2次。

6、总攻疗法

在下焦湿热型、气滞血瘀型中,若体质较强,肾与输尿管上段结石直径在6mm以上,纯用中药排出有困难者,可配合此法。

在腰腹绞痛发生时应用最好,因此时结石有向输尿管下端移动的倾向,正可乘势利导用之。具体操作,举例如下:8:30 饮水 500-600ml 后,口服速尿 60-80mg;8:45 口服尿路排石汤(金钱草 100 克,瞿麦、滑石、川膝、冬葵子各 30 克,浓煎后取汁 200-250ml,送吞 10 克琥珀粉);9:00 再饮水 500ml,9:30 续饮水 500ml 后,肌注 10mg654-2 与 10mg 速尿;9:35 电针双三阴交,调波由弱而强,留针 30 分钟,10:05 起针活动,至此结束。每日一次,连用 4-6 次为一疗程。

五、典型病例

施女,46 岁,无为县农民。1998 年 9 月 7 日初诊。左腰(肾区)绞痛反复发作 10 余年,绞痛呈持续性阵发性加剧,一小时后渐缓。痛时辗转不安,大声呻吟。平素左腰常胀痛不适,伴下肢酸软,神疲纳呆,面少华,尿清长,便偏溏,舌淡暗红,苔白罩黄微腻,六脉沉细。左肾区叩击痛(++),压痛(+),经多次 B 超检示:1、左肾下极见 -6mm 大小强回声光点,左肾下盏见一枚 6×7mm 大小强回声光点,均伴有声影。右肾、两侧输尿管及膀胱未见异常。尿检:蛋白(+ -)、红细胞(+)、白细胞少许,草酸钙结晶(+)。既往治疗多用清热利湿,通淋排石剂,金钱草、海金沙分别曾用至 100 克与 50 克,均未见效。西医动员手术,因恐惧未做。遂断为脾肾两虚,湿热蕴结。予金钱草 70 克,生黄芪 35 克,仙灵脾、炒白芍、川、怀膝各 30 克,补骨脂、冬葵子、乌药各 20 克。日一剂。并嘱日作头低臀高位或倒立位,配左肾区局部拍击,于药后 1 小时进行,日 2 次,每次 20 分钟。服药第 12 天,正值倒立约一刻钟时,突觉左肾剧烈绞痛,并向左小腹放射,欲洩且窘急,溺时有物坠粪池,痛随即消失。又进药 6 剂,B 超示左肾两枚结石影均消失,尿检亦正常。随访至今,未续发作。

钱男 44 岁 工人 1993 年 5 月 27 日初诊。

右上腹引及右腰绞痛伴尿血反复发作3年余,发作时绞痛呈阵发性,需注射度冷丁或654-2方能缓解,镜检尿红细胞满视野,KUB+ iup示右输尿管上段见一大小约1.1cm×1.3cm阴影,右肾积水。B超检示:右输尿管上段见-1.0cm×1.3cm强回声光团伴有声影,右肾中度积水。症见右腹及右上腹胀满不适,溲深黄或赤,口干不欲饮,舌苔薄黄,舌质黯红,脉弦偏数。曾辗转多处医院诊治,用过尿石素、三金片、尿石通及百余剂清利、通淋、排石中药,未见显效。此责之湿热胶结,气滞血瘀。予金钱草100克,川膝、香附、乌药、瞿麦、六一散各30克,冬葵子20克、三棱、莪术各15克,琥珀粉9克(分吞),7剂,药后右上腹痛加剧伴坠胀,疼向右下腹放射,随后痛渐移至右下腹。B超复查示,右输尿管下段结石1.0cm×1.1cm。证明结石已下移,原方加五灵脂12克、白芍40克。同时给予黄体酮20mg肌注,日2次。用药10天,间断排出小结石数枚。服药至26剂时,随右下腹、下腹绞痛后,尿中突下二枚0.4cm×0.6cm不规则小结石。再服药9剂后,复查B超,右肾积水、右输尿管结石均消失。

(马璇卿)

九 朱良春用牛角腮经验发微

牛角腮为黄牛或水牛角中的骨质角髓,其药用记载最早见于《神农本草经》。古人论其功多局限于止下焦出血,用法亦多为烧炭存性。如《药性论》曰:“黄牛角腮灰,能止妇人血崩不止,赤白带下,止冷痢水泻。”《本草拾遗》言其“烧为黑灰,末服,主赤白痢。”《日华子本草》:“烧焦,治肠风泻血,水泻。”《纲目》亦曰:

“牛角腮……烧之则性涩，止血痢，崩中诸症。”诸方书记载亦无出此范围：如《圣惠方》牛角腮散以其烧灰治妇人崩中，下血不止；《塞上方》以其烧灰治鼠痔；《肘后方》用之烧灰疗寒湿痢及蜂螫螫疮；《近效方》用之烧灰治卒下血。

先师祖章次公先生喜用牛角腮，虽仅用于各类血症，然于用法上已有发展。据《章次公学术经验集》记载，其用于叠进止血重剂而血不止的徐女咯血案，将生牛角腮同生血余、化龙骨共研细末吞服，取其生用兼有潜润之功；治朱女鼻出血，洪男胃出血症，均煅炭配以仙鹤草、藕节加强固摄止血之效；疗翟女月经先期及周女漏下案中，均以生品入煎取其兼有化瘀之力，因久漏多瘀也；用于姚女，李女之血崩则用煅炭，取其止血之力宏也；朱女胎漏案用牛角腮，因其能补肝肾而安胎也；汤女产后恶露不尽不宜祛瘀，则用煅炭。

吾师朱良春承袭章公用牛角腮经验，于临床尤多发挥，现阐述如下，以飨同道。

1、牛角腮软坚散 结，止血祛瘀两兼长

牛角腮用于止血，前文之述备矣，然其祛瘀之功未必尽人皆知，《本经》即言其“主下闭血，瘀血疼痛，女人带下血。”《本草经疏》亦曰：“牛角腮乃角中嫩骨也，苦能泄，温能通行，故主妇人带下及闭血，瘀血疼痛也。”朱师认为牛角腮生用或砂炙、醋淬用，确有化瘀之功，对各种有瘀象之出血症，具止血而不留瘀之妙。因砂炙醋淬后有效成份煎出率大为提高，而化瘀止血之力亦明显提高，故于临床喜用炙品。但他告诫我们，须注意要炙到酥黄而不焦为最佳。今贤曹向平教授消风宁络饮用本品治疗过敏性紫癜，即取其化瘀止血之功^[注]，朱师还言：“牛角腮有类似鳖甲的软坚散结之效用，”虽力不及鳖甲，但配合其自拟的复肝丸（炙地鳖虫、太子参各30克，紫河车24克，广姜黄、广郁金、参三七、

鸡内金各 18 克,共末,以虎杖、糯稻根、石见穿各 120 克,煎浓汁泛丸,如绿豆大)用于慢性肝硬化所致出血症,疗效颇佳。牛角腮本非止痛药,《本经》及《本草经疏》言其“止瘀血疼痛”,实际上是瘀血去经络通,而疼痛自止也。

据朱师经验,常用的化瘀止血药如三七、蒲黄、茜草等,生品之化瘀力强于止血,炒制后化瘀与止血之效力大致相等或止血之力更强(视炒制程度而定),而牛角腮炙后性微涩,止血之力强于化瘀,不可不察也。故其用于瘀血较重之症宜配活血药同用,以增强疗效。

2、牛角腮可走奇经,善修冲任之损伤

朱师认为:牛角腮性温,获牛生发之气,生于阳地与鹿角相类而通督脉;又位于牛角壳内,为阳中之阴。且为血肉有情之品,其气腥,与乌贼骨相类而善走冲任,《纲目》言“乃厥阴、少阴之血分药”。不仅如此,且实为交通冲、任、督脉之奇品,尤善修补冲任之伤。朱师常用牛角腮配棕榈炭为对药,治疗更年期叠治不愈的宫血症。朱师常道:宫血久治不愈,补血摄血、固涩收敛之品已早备尝,何以延久不愈,必是虚中夹实,有残瘀逗留,以致瘀血不去,则新血难守,故应以化瘀止血之牛角腮,配以敛涩止血之棕榈炭为主药,则化瘀不峻,行中有止;收敛不滞,止中有行,瘀去血止矣。此症多见经色紫黯有血块,伴有小腹痛而拒按,舌质衬紫或有瘀点,乃其特征。

吴女,36 岁,市轮船公司职员,99 年 10 月 21 日初诊。

分娩后经量多,夹血块,伴腹部胀痛两年不愈,迭治未效。平素畏寒,腰背酸痛,口干欲饮,并有慢性胃炎史,大便时溏时秘,进油易腹泻。舌质红,苔薄白衬紫,脉细小弦。此脾肾阳虚,冲任受损,治宜益脾肾,补冲任。处方:炙牛角腮、淮山药、仙鹤草各 30 克,棕榈炭、煅乌贼骨各 20 克,枸杞子、炒白术、仙灵脾

各 15 克,茜草炭、鹿角霜、川续断各 10 克,甘草 6 克。7 剂。二诊:11 月 6 日,经行血量减少,已无块,腹痛亦缓,惟纳差、寐不安,苔少、舌紫红。上方加炒枣仁 30 克,木香 6 克。14 剂。随访已愈。

3、牛角腮养血益气,疗三系减少有佳效

朱师经验:牛角腮身兼养血与益气之效,能于养血中益气,善从补气中生血。补肝肾之气力似山萸肉而更绵缓,养肝肾之血功同阿胶而不滋腻,效类首乌而有情。《医林纂要》明言其“长筋力。”朱师喜用之为主药,配伍油松节、仙鹤草、鸡血藤、虎杖组成炙牛角腮汤。方中炙牛角腮配强壮止血的仙鹤草,不仅能升高血小板计数,而且能增强血小板的功能,二者相须为君,一则止血之效大增,二则强壮之功加倍。伍固卫生血之油松节,一润一燥,一补血中之气,一祛血中之风,对于血虚兼风湿侵犯者极为合拍;合鸡血藤增强活血通络之功,并暗寓瘀去新生之意,二药共用为臣。佐苦寒解毒、活血祛瘀之虎杖,因其可制前药之温,且虎杖所含蒽醌可明显升高白细胞及血小板数目,对于热毒存留而致血三系减少者尤为必用之品。诸药合用有化瘀止血、益气补血、通络解毒之功,对各种类型的血三系减少症出现的贫血、出血,神疲乏力,易于感染等症,适当配伍加减,有屡试不爽之佳效。今人亦有试用于再障贫血而获效者。

李女,54 岁,工人。1999 年 12 月 1 日初诊。

患血小块减少性紫癜已五年余,迭经中西药物治疗,终未瘥复,血小板常逗留在 $2.5 \text{ 万} \sim 4 \text{ 万}$ 之间, $\text{WBC} 2.0 \times 10^9/\text{L}$, $\text{RBC} 2.5 \times 10^{12}/\text{L}$,牙龈渗血,面色苍白,四肢紫癜,此伏彼起,关节酸痛,头昏肢软,纳谷欠香,怯冷便溏,苔薄质淡,脉细软。新病多属实热,久病则多虚寒,故朱老辨为脾肾阳虚,气不摄血所致,治当培益脾肾,补气摄血。用炙牛角腮、油松节、鸡血藤、仙

鹤草各 30 克,党参、黄芪各 20 克,仙灵脾、炮姜炭、炒白术各 10 克。连服 10 剂,血小板升至 9 万, $RBC 4.2 \times 10^{12}/L$, $WBC 2.65 \times 10^9/L$,精神较振,紫癜逐步减少,已不续透发。嘱续服 8 剂,症情稳定,紫癜全消。乃以复方扶芳藤口服液善后。随访半年,一切正常。

4、牛角腮填精生髓,温补虚性水肿宜

牛角腮乃厥阴、少阴血分药,兼入阳明。《本草经疏》。故其能补肝肾之气血,肝肾气血足则阳明之气血自旺,任督之精血自充,冲脉自盛也。故大凡补肝肾阴血之药(如熟地、杞子、萸肉、制首乌等)均有填精益髓之功用。且牛角腮富含蛋白胶质,性状、质地又与龟板相似,能直入任、督而填精益髓,为血肉有情之品,较之其它填精益髓之品更胜一筹。《纲目》曰:“牛角腮,筋之粹,骨之余,而腮又角之精也,……。”即说明其可作益肾壮督之品。时珍言其“治水肿”,盖其富含蛋白胶质,能增加血中总蛋白的含量,调整血浆胶体渗透压,能治由贫血或丢失蛋白所致的虚性水肿,此皆得之于补养精血之功也。然其获效慢,有别于利水消肿之品,故用于水肿者宜与利水药同用,一消其标,一固其本,方能有远功而兼速效。

王女,43 岁,观音山镇农民。1999 年 6 月 4 日初诊。

肢浮伴腰痛一周,入夜身烘、汗多,夜寐不实,口舌生疮,缠绵不愈,溲热,舌偏红,苔薄腻,脉细弦。查尿蛋白+,白细胞少许,此气血两亏,阴阳失燮,治宜益气血,和阴阳,消水肿。炙牛角腮、夜交藤、浮小麦各 30 克,连皮苓、赤白芍、泽兰泻、生槐角、生地榆、枣柏仁各 15 克,白槿花、杜仲、白薇各 10 克,甘草 4 克。7 剂,并嘱低盐饮食。随访已愈,一年未复发。

5、牛角腮安神定志,心悸、失眠有奇效

朱师指出牛角腮有温养作用,可入少阴,故能养心血而安神

除怔忡；又可祛瘀入厥阴，故能消除心包络之痹阻而定惊悸；性涩入厥阴、少阴，功类龙牡能敛梦安神志；质重能镇、滋阴善潜，不仅能平肝潜阳而安魂神，对精血亏虚之肝阳上亢，与生白芍相须为用亦常奏佳效。朱老经验：用于心气、心血不足，心失所养而致心悸、怔忡、失眠者，宜配伍归脾汤、酸枣仁汤；用于心肾不交之失眠、多梦，宜配伍交泰丸、桂枝龙牡汤；对于肝火，痰热扰心之魂神不定，烦躁易怒，宜伍栀豉汤、黄连温胆汤等。

陈女，33岁，工人。99年3月23日初诊。

失眠8年，多梦易醒，形寒怯冷倍于常人，头昏耳鸣，腰酸带多，舌淡红，苔薄白，脉细弦。此心肾两亏，神志不安，治宜益心肾、安神志。炙牛角腮、柏子仁、酸枣仁、夜交藤各30克，熟地、仙灵脾、露蜂房各15克，炙远志、龙眼肉、茯苓、生白芍、炙甘草各10克。7剂。药后诸症减而未已，带下仍多，舌淡苔薄，能睡唯寐不实，上方加淮山药30克，续服14剂。随防已愈。

朱良春老师从医六十余载，善于发掘前人用药之精髓，结合临床实践而阐发奥义，时有创新之见。近代医家用牛角腮者较少，而朱师处方中却常常见。他取其烧炭后性涩，善收敛止血、止带、止遗、止痢，敛正气而不敛邪气；取其砂炙后善补，养肝肾之血、填肾督之精、补冲任之虚、修管络之损；取其生用性味苦温，化瘀血而不伤新血，出血诸症伴有残瘀者多用之。入散剂擅治水肿诸症。牛角腮一药可以尽其所用矣。

注：《国家级名老中医验方大全》耕耘，李蓉编 1999.3 伊犁人民出版社 ISBN 7-5425-0322-7/R.11

（朱建平、马璇卿、邱志济。原载于《辽宁中医杂志》2000年第8期）

卷四 内、五官科求索

一 寒热错杂证的辨证论治

寒热错杂证临床较为多见,前贤对该证的治疗也颇重视。如《内经》所载十三方中用治此类证的就有三方。《伤寒杂病论》中亦创有十九方,分别治疗多种寒热错杂证。后贤宗仲景意针对此类证也创立了很多名方。如刘河间的防风通圣散,李东垣滋肾通关丸,朱丹溪的左金丸、二妙散,它如陈无择的仓猝散(附子、山栀),薛雪连苏饮(黄连、苏叶)等,以及古方越桃散(干姜、山栀)。笔者对辨治该证也略有心得,特简介于后,供同道参考,谬误之处,指正为感。

一、表证的寒热错杂证治

表证大体有二,风寒、风热是也。但亦多有寒热相兼者,其主证为:发热恶寒,头身困痛,颜面似火烘,口干不欲饮,无汗或少汗,舌偏红,苔黄白,脉浮缓。

王某某 女 42岁 1980年9月25日初诊。

先微恶寒发热,咳痰黄稠,口渴,头、咽疼痛。后因汗出感寒,遂恶寒头痛,痰咳转加,脉浮,舌红,苔白微黄浊。证为先感风热,复受风寒,宜辛凉透泄,祛散风寒:银花12克、连翘9克、荆芥6克、牛子9克、前胡6克、杏仁9克、花粉9克、防风9克、射干6克。三剂即愈。

按:除上感外,麻疹及某些外科感染性疾病初期也可见此类证候。笔者每用银翘散去竹叶、豆豉以凉泄表里,参入辛温宣散之防风、杏仁为基本方。若寒象较甚加桂枝,热象较甚伍黄芩,灵活加减以取效。

二、表里相兼的寒热错杂证治

此等证治《伤寒论》中论述较详。诸如大青龙汤，桂枝二越婢一汤，柴桂干姜汤，桂枝加大黄汤等均为代表方。笔者受仲景启迪，临床多遵其旨而用之。

1、“太少”并病

主证：初起头身疼而寒热，后渐热多寒少，温温欲呕，口苦咽干，渴喜热饮，舌红苔薄黄，脉浮弦。

王某某 男 16岁 1980年10月23日初诊。

先寒热咳嗽，续转先冷后热，热重寒轻，口苦滑腻，太息，泛恶欲呕，两侧头痛，左下肢痛，脉弦滑。此乃太阳之邪，渐入少阳，宜和解枢机，祛邪外出：柴胡6克、枯芩8克、甘草8克、桂枝3克、白芍9克、当归10克、姜夏6克、川芎6克、杏仁10克、萎皮10克、白术10克、鸡血藤20克。三剂病愈。

按：并病乃一经病证未罢，又见另一经症状。太少并病，笔者多用柴桂汤化裁。痰多脘胀者，去参、枣、芍药，防酸甘收敛壅中，加陈皮、茯苓祛湿化痰；心下痞闷者，去芍药合干姜、黄连辛开苦泄；气短、便溏者，去半夏加白术益气健脾。本案因除有《伤寒论》中柴桂汤典型症状外，还兼痰咳腿痛，故用原方去参、枣加杏仁、萎止咳化痰，配归、芎、鸡血藤活血止痛而收效。

2、太阳阳明经证合病证治

主证：微恶风寒，壮热，头痛，汗出，渴喜冷饮，苔黄而干，脉浮洪数。

韦某某 男 40岁 1978年7月15日初诊。

盛夏难耐暑热，露宿受寒以致头痛咳嗽，微恶寒，壮热汗出，渴欲饮冷，纳呆便少，舌红苔黄干，脉洪数。此乃阳热素盛之体，复为风寒外客，法当泻火生津，辅以温开太阳。生石膏45克、知母15克、甘草9克、桂枝3克、白芍10克、粳米10克。三剂诸

症霍然。

按：合病乃起病即现两经或三经症状，在某些急性传染病或非传染性急性热病的初期可以出现。此案系热多寒少的太阳阳明合病，故应重用白虎汤，以甘寒苦寒相合，直清阳明经热，辅以小剂桂枝汤辛解外寒而效。此证无汗者，去白芍；表重里轻者加生姜，酌减石膏；渴饮不止加葛根、芦、芩根。

3、三阳合病证治

主证：先憎寒壮热，渐转寒热往来，头身疼痛，口苦目眩，烦热有汗，舌红苔黄，脉浮弦数。

江某某 女 47岁 1980年11月13日初诊。

因劳后受凉而寒战身疼，继而壮热，口苦目胀，渴欲饮冷，泻下黄白之粘冻及水液，日十余行，腹痛溲热，口苦纳呆，舌红脉弦数。此风寒外邪渐入阳明，化热下迫，旁及少阳，宜解表清里，和解枢机：葛根12克、桔芩9克、黄连4克、甘草9克、柴胡6克、桂枝5克、陈皮4克、苡仁20克、车前子10克。二剂后，病势顿减，但仍目胀，大便作坠。去黄连、苡仁，车前子加当归、升麻、北沙参、白术芍等调理善后。

按：三阳合病，因证有偏重太阳，或阳明，或少阳之异，故临床当以陶节庵柴葛解肌汤为基本方，视何经病重而损益：明显恶寒加桂枝；欲呕加半夏、竹茹；无汗去白芍；内热甚去羌活、白芷。而本案因以阳明湿热为主，外兼太阳表寒，旁及少阳，而改予葛根芩连汤合车前子、生苡仁清化湿热，使邪表里分消；佐以柴胡、桂枝，一疏少阳，一开太阳；少参陈皮理气和胃，以防苦寒伤胃。其法虽从仲景用白虎汤治三阳合病偏重阳明经热悟出，但又有不同。

4、素有虚热，复感外寒证治

主证：时发低热，腰酸盗汗，五心烦热，渴不欲饮，头痛恶寒，

咳嗽痰少,舌嫩红苔白,脉浮细数。

甄某某 女 39岁 1980年6月21日初诊。

平素常发低热,手心灼热,口干喜热饮而不多。因淋雨感寒,头痛恶寒,无汗,骨楚,脉浮紧,舌红苔薄白。拟养阴以充汗源,温散而驱外邪。地骨皮10克、玉竹15克、丹皮9克、生地12克、玄参12克、甘草9克、白术9克、羌活6克、白芷6克,两剂症去七、八。

按:虚中挟实之寒热错杂证,与上述三种表里相兼的寒热错杂证明显不同。笔者对此等证常根据表证或里证的孰轻孰重,或七补三散,或半滋半疏,务使阴津充沛以作汗源,即经云:“阳加于阴谓之汗”之意也。很少取仲景先表后里之法,惟恐过汗劫津,虚其正气。本例患者因长期低热,舌红脉细,故在大剂养阴凉血药中配羌、芷二味解表而止头痛,并根据“阳生阴长”之意,佐白术、甘草健脾益气,阴充气足,祛邪自易。此即俞根初《通俗伤寒论》加减葳蕤汤之变法。

二、里证的寒热错杂证治

里证的寒热错杂证,较表证和表里相兼的寒热错杂证尤为复杂。故临床须根据脏腑辨证立法,抓住主证,将辛热与苦寒两种性味相反之药共投。常视寒热症状之轻重,或重用辛热,少参苦寒;或大剂苦寒,略配辛热,庶使药与证合。兹举数案,以窥斑见豹。

1、胃寒肠热证

陈某某 男 40岁 1981年4月5日初诊。

胃痛有年余,泛酸嗳气,食后尤甚。自感胃中凉,腹中热,心慌乏力,纳少便干,脉弦弱,舌红苔白浊。此固气血虚弱,寒热交阻,气机升降失利。处以:干姜5克、吴萸5克、黄连5克、黄芩6克、当归12克、白芍10克、炙甘草9克、木香8克、陈皮9克、

厚朴 9 克、玄胡 10 克、火麻仁 15 克，三剂便通痛止。

按：胃寒肠热证，属上寒下热范畴。仲景首创大黄附子汤、三物备急丸治疗。后人遵其意，创制温脾汤，用治原有肠热便秘，复感寒致胃痛的患者。笔者也喜用该方，但本患者因泛酸噯逆明显，故以吴萸易附子；又虑脉弱，故将芩、连、火麻仁合用以代大黄；佐以归、芍、炙草养血益气。取木香、陈皮、玄胡、厚朴行气止痛，既赅姜、萸、芩、连奏和胃整肠之功，又助归、芍、炙草收补而不壅之效。

2、脾胃虚寒肝胆郁热证

虞某某 女 40 岁 1978 年 1 月 20 日初诊。

脘痛偏右，喜温喜按，噯气泛恶，漾漾欲呕，胁肋撑胀灼热，如气攻冲，纳少便溏，五心烦热。舌偏红，左脉弦实，右脉弦弱。乃脾虚失运，肝郁化火，土弱木侮，相争为患，宜温中助运，清疏肝胆。木香 5 克、砂仁 5 克、干姜 6 克、白术 10 克、姜夏 9 克、党参 6 克、青皮 9 克、陈皮 9 克、丹皮 9 克、赤芍 10 克、郁金 10 克、炒枯芩 9 克、大贝 10 克，五剂。

1 月 26 日复诊：痛减呕平，纳增便调。原方续进五剂。2 月 1 日三诊：胁胀灼热均解，纳多中脘仍觉满闷。前方减丹皮、大贝、赤芍加焦楂 15 克，继服四剂后，诸证渐平而告愈。

按：胆系感染，肝胆郁热症如有便秘，笔者每宗大柴胡汤化裁施治。本案患者因少食、便溏、欲吐，知脾胃虚寒，气机失运较甚，故改用香砂理中合景岳化肝煎去炙甘草之壅中，易姜夏之降逆；去山栀之动呕滑肠，易黄芩之清胆固涩；泽泻利湿与本案无关，故去之而易入郁金理气疏胆。若平时习用柴胡剂治此等证无效者，不妨改此法试投，或改乌梅丸。如此寒热并用，切合病因、病机，故应手即效哉。

结 语

寒热错杂证在很多病中均可出现,颇值得重视。前人将寒热药并用纳入和法范畴。何梦瑶曾云:“有寒热并用者,因其人寒热之邪夹杂于内,不得不用夹杂之剂,古人每多如此,昧者皆为杂乱,乃无识也。”故临床若纯用寒药或热药施治无效时,当改弦易辙,宗寒热并用投药,庶可望有效。

(谢法巽、马继松、谢祖俭。原载于《皖南医学院学报》1984年第2期)。

二 从肾论治汗证管见

出汗是维持人体正常功能所不可缺少的生理活动,若汗出过多则为病态。汗证的病因病理颇为复杂,本文试从其入手,探讨肾与汗证的关系。

一、肾是汗液生成的源泉

《素问·评热病论》曰:“汗者,精气也”,为心所主,肾阴是化汗之源,但阴根于阳,无阳则阴无以生。《素问·阴阳应象大论》曰:“阳之汗,以天地之雨名之”。又曰:“雨气通于肾”。在正常情况下,心阳下降于肾,以温养肾阳;肾阴上升于心,而涵养心阴。心阳与肾阴相互交通,升降协调。阴津在心肾阳气的温煦推动下,出于肌表化为汗液。即《素问·阴阳别论》篇所谓:“阳加于阴,谓之汗”是也。由此可见,汗液是肾中阴津经心肾阳气的蒸腾变化,外发肌腠,出于玄府而生成的。故《温病条辨·汗论》曰:“盖汗之为物,以阳气为运用,以阴精为材料……阴精不足,多能自出”。当然,阳气与阴精又要不断地得到中焦阳气及所化水谷精微的补益滋充。平时汗液是以津液的形式储存于体内,

当天暑地热或劳动过度时,阳气就鼓动津液外泄为汗。现代医学研究证明,肾阳的功能与内分泌、神经系统、能量合成代谢以及植物神经功能有密切关系。而汗液的主要成份是水、氯化钠、钾、硫以及尿素等,其生成和排泄也是在上述各系统共同协调之下完成的。

二、肾是调节汗液的枢纽

1、肾主水,汗为水液

《素问·逆调论》曰:“肾者,水藏,主津液”。肾对水液的储存、输布与排泄的调节,主要是依赖肾气的开合作用来完成,所谓“肾司开合”也。“开”是指输出水液,包括从毛孔外泄的汗液;“合”是指储存一定量的水液以润养脏腑,并作为补充汗液、唾液等阴液的源泉。肾主“开合”功能,取决于肾阴与肾阳功能的协调平衡。肾阳为先天真火;肾阴则既可为汗液化生的原料,又同时涵养心阳,使心火不亢,以防心火迫津外泄。肾阴肾阳相互的制约调节,通过主水液和司开合的作用,维持着汗液的正常排泄。

2、肾为卫阳之根,司汗液开合

毛窍的开合是由卫气主司的。《灵枢·本藏篇》曰:“卫气者,所以温分肉,充皮肤,肥腠理,司开合者也”。故卫气充足与否,是维持汗液排泄正常的先决条件。清·石寿棠在《医原》中说:“卫气赖下焦阴中真阳,以外出中、上二焦,故卫气出于下焦”。由此可见,卫气的生成必赖于下焦真阳,而卫气的循行又要受肾气的调节。《医宗金鉴》中说:“卫行脉外,故属于阳也,然营卫之所以流行者,皆本乎肾中先天之一气”。这就说明肾是通过卫气而司汗孔开合,从而实现对汗液的调节作用。

三、肾病会导致多种汗证

肾阴肾阳的功能协调,是汗液得以正常排泄的基础。如发

生理理性改变,则会发生多种汗证。正如《丹溪心法附余》曰:“自汗之证未有不由心肾俱虚而得之者”。考之临床汗证的表现虽多,但大多与肾虚有密切关系。兹仅举自汗、盗汗两证略述之。

1、自汗

指人在清醒状态下,不因发散药而汗自出者。《伤寒明理论》曰:“卫为阳……禁固汗液不得妄泄……邪气干于卫气,气不能卫固于外……由是而津液妄泄。漉漉然润,淅淅然出,谓之自汗也”。自汗之证前人多责之阳虚,但并未言何脏何腑之阳虚。然《景岳全书》中云:“人但知热能致汗,而不知寒亦致汗。所谓寒者,非曰外寒,正以阳气内虚,则寒生于中,而阴中无阳,则阴无所主,而汗随气泄。故凡大惊恐惧,皆能令人汗出,是皆阳气顿消,真元失守之兆”。此与《素问·阴阳应象大论》所言:“阴胜则身寒,汗出……能夏不能冬”以及仲景所言“极寒反汗出,身必冷如冰”来看,笔者认为:引起阳虚自汗的主要原因当指肾阳虚。另如《素问·水热穴论》曰:“勇而劳甚,则肾汗出”,是指强力入房或持重远行,因短时间劳累过度,元气受戕,使汗出于肾。此皆由肾阳亏损,不能助卫阳固表之故。至于小儿因先天未充,肾气欠足,腠理疏,藩篱薄,常易汗出,虽李东垣等曰不必治之,但景岳主张对汗出太多者,当以人参一钱以煎服,旨在补其真元。随年龄增长,肾气渐充,卫外固密,汗则自收也。还有一种黄汗病,其主证为汗出色黄如蘘汗,伴有身体肿、发热、口渴,一般也可列入自汗范畴。治法虽有多种,然近贤浙江中医学院原院长何任教授在《金匱要略通俗讲话》中却指出:黄汗和历节是同源异流的病,病因皆为肝肾先虚。故从肾入手治疗黄汗病,亦是其中一重要的治法。

自汗不尽属阳虚,也有阴虚所致。张景岳说:“所以自汗、盗

汗,亦各有阴阳之证,不得谓自汗必属阳虚,盗汗必属阴虚也。然则阴阳有异,何以辨之?……盖火胜而汗出者,以火烁阴,阴虚可知也;无火而汗出者,以表气不固,阳虚可知也”。自汗若同时伴有骨蒸潮热,五心烦热等肾阴虚征象的,就属阴虚自汗了。张景岳所谓“酒色之火起于肾,皆能令人自汗”。《素问·评热病论》亦曰:“阴虚者,阳必凑之,故少气时热而汗出也”,即指肾阴虚会导致自汗。但不论阴虚、阳虚,均和肾亏有千丝万缕的联系,而自汗者仍以阳虚居多。

2、盗汗

《证治要诀》曰:“睡熟而汗出者曰盗汗,又曰寝汗”,此种汗常醒则倏收,前贤多责为阴虚。《临证指南医案》中有“肾之阴虚,不能内营而退藏,则内伤而盗汗”之说。前人对盗汗的施治,虽有养心和益肾两大法,但多不离乎滋阴,即《医宗金鉴·杂病心法要诀》所言的:“盗汗阴虚分心肾”之谓也。然盗汗也有阳虚或阴阳并虚所致者。如《金匱要略·血痹虚劳病脉证并治篇》曰:“男子平人脉虚弱细微,喜盗汗也”,指的即阴阳并虚之盗汗证。《伤寒论》21条云:“太阳病,发汗,遂漏不止,其人恶风,小便难,四肢微急,难以屈伸者,桂枝加附子汤主之”。本条病机显系误治伤阳,但因未明言系寤而汗出,故可认为寐时亦可漏汗。郭子光等在《伤寒论汤证新编》中指出,此条汤证系太阳病通过表里传发展为少阴病的中间证,用桂枝加附子汤旨在调和营卫,温动里阳,使阳生阴长而达到治疗目的。由此可见,盗汗一证与肾阳虚亦有一定的关联,但阴虚盗汗较为常见。

另有一种罕见的红汗证,排出的汗液淡红或鲜红,或呈铁锈色。唐容川曰:“阳乘阴而外泄者,发为皮肤血汗矣”。《灵枢·营卫生会篇》曰:“夺血者无汗”。上海夏荷松氏根据“血汗同源”的理论,采取重用生地、白芍、旱莲草等滋肾补血药,配以黄柏、丹

皮,清肾经伏火,略佐补气药的方法治疗,则取得满意疗效。可见红汗证与肾阴虚的关系极大。

至于脱汗、绝汗、阴汗(外生殖器及会阴部的汗)等汗证与肾的关系则更大,兹不一一细述。

四、从肾入手辨治汗证常获显效

叶天士曰:“故阳虚自汗,治宜补气以卫外;阴虚盗汗,治当补阴以营内”。即盗汗证的治疗,当以补肾阴为主;自汗证的补气,亦寓有补肾气之意。吴鞠通亦提出,对汗自出者,当“用甘凉滋润入肾,培养其阴精为材料,以为正汗之地”。故汗虽为心之液,但前贤治汗证却常从治肾入手。《景岳全书》汗证共列方二十八首,其中有二十方均以治肾虚为主。至于前贤从肾入手治汗证的验案,则更比比皆是。笔者曾用后颇效,故特附病案两则简介之:

周女 19岁 学生 1989年3月17日初诊。

形体颇丰,但却神疲乏力,畏寒肢清,易生冻疮。近两载常汗出溱溱,尤苦于两手心更多,滑腻难以捉笔。虽已3月中旬,两手仍抚之若冰,时伴腰酸、便干、眩晕、健忘。舌淡胖嫩,有齿印,苔白腻,脉沉细滑。告已服过玉屏风散、牡蛎散等未见显效。此乃阳虚故,当以仲师方扩充:熟附子(先煎)、桂枝、熟地、生白术、炒白芍、麻黄根各15克,五味子、当归身各10克,生黄芪、煅龙牡、制料豆、浮小麦各30克,防风、炙草各5克,姜3片,枣5枚。3帖汗收近半,它症亦减,去当归,加鸡血藤30克,又3帖而痊。

按:此症显系卫阳、肾阳皆虚,故前医仅予益气固卫阳而少效。改用桂枝加附子汤合龙牡玉屏风散并加熟地、料豆、五味子等从温补肾阳入手,6剂即痊,可见治病求本之重要。另患女便干,乃津液随汗外泄,肠道少液濡润之故,不可过用峻下通腑,只

需敛汗,待汗收则可肠润便调也。临证常见汗家伴便秘,为医用通剂,虽或可取效一时,但若汗不止,必致复秘且体更馁矣,不可不慎!

杨男 28岁 司机 1987年3月4日初诊。

元旦后即胸闷咳嗽,未及时治疗,2月1日被某市中医院诊为右侧结核性胸膜炎伴右侧胸腔积液收住入院,2月12日与15日分别抽胸水1200cc和860cc,又给予抗痨、抗炎、补液等综合处理,病情基本稳定。但仍伴阵发性咳,咯痰欠畅,色黄,右胸微胀痛,消瘦便干,尤苦于交睫则汗,衣被尽湿,故求诊于中医。察舌偏红,苔薄黄,脉细滑。知悬饮尚未尽消,气阴早显不足,当兼顾:银花、糯稻根各30克,南沙参、鱼腥草各20克,生白术、焙百部、功劳叶、炙桑皮、地骨皮、葶苈子各15克,桔梗、胡黄连、瓜蒌皮、白芥子各10克。12剂。3月15日复诊,咳痰颇爽,胸痛续减,它症如前,且增纳呆泛恶,厌食油腻,右肋隐痛,腰酸沉坠,小溲黄少,排解欠畅。疑为服利福平致肝、肾损害,嘱停服该药,并做检查。3月18日三诊:告肝肾功能轻度受损,遂改投银花、山药、制料豆、糯稻根、生麦芽、垂盆草各30克,生白芍、功劳叶、鱼腥草、北沙参、大生地、怀牛膝、地骨皮、香元皮各15克,萸肉、生草、姜竹茹各10克,胡黄连、五味子各7克。又10剂,腰肋痛止,恶平纳馨,尤喜汗收过半,惟感神疲力乏。诊察舌红渐退,脉滑已缓,前方去竹茹、鱼腥草、胡黄连,加制黄精、白薇、玉竹各15克,以10剂量,加炼蜜2公斤熬膏,药未服尽,即驾车操旧业矣。

按:患者显系阴虚盗汗,投养肺阴、杀痨虫、配清热解毒,应有显效,然却未尽如人意,盖忽略了利福平对肝肾之损害。故复诊改地黄、山药、萸肉、怀牛膝、五味子、马料豆(甘凉色黑,外形似肾,《纲目拾遗》曰:“壮筋骨,止盗汗,补肾活血……解乌、附

毒”)峻补肝肾,以地骨皮(王好古曰:“泻肾火,降肺中伏火”)、胡黄连(《本草经疏》言:“理腰肾,去阴汗”)及大剂入肺肝肾的糯稻根(《药材资料汇编》“止盗汗”)直接止汗,随盗汗好转,阴液得以渐复,诸症日趋向愈。后又加入可“入肾治阴虚多汗燥咳”之玉竹(《广西中药志》),入肺胃肾治“肺结核,骨蒸潮热盗汗”之白薇(《现代实用中药》)和“补肾润肺、益气养阴”的黄精(《四川中药志》)熬膏,遂很快收全功。故临证遇药证相符,应有效却未效之患者,必需认真查询原因,及时改弦易辙,方可获柳暗花明之转归。

(马继松、彭绍荣、承忠委。原载于《北京中医学院学报》1990年4期)

三 辨治老年人咳嗽之浅见

呼吸道疾病是老年人最易发生的一组疾病,常见的有感冒、急(慢)性气管炎或支气管炎、肺炎、哮喘、肺气肿、肺结核、肺原性心脏病等,这些病大多伴咳嗽,相当部分人又因咳加重了原发病,如何及早与有效地控制咳嗽,对治疗有十分重要的意义。人进入老年后,由于脊柱后弯,呼吸肌萎缩及胸肺弹性减弱等,均导致阻塞性通气障碍和血氧分压降低,严重削弱了呼吸功能;老年人又易患多种全身性退行性疾病,使呼吸系统化学感受器和神经感受器敏感性降低,对体内种种刺激的反应较迟钝,组织对缺氧或酸碱平衡的调节能力远不如青年;且免疫功能下降,呼吸道屏障作用削弱,气管粘膜纤毛功能和保护性咳嗽反射减退,呼吸道分泌物排出困难,均使老人易患呼吸道疾病但恢复却不

易。故临床应针对老年人呼吸系统的上述变化与发病特点,用药当遵“攻而勿伐”、“补而勿滞”、“凉而勿遏”、“温而勿燥”之理,宁可再剂,不可过剂,方能取得较好疗效。

治外感咳,多以止嗽散化裁

止嗽散系我省清代徽州名医程钟龄所拟,方取荆芥辛温轻疏风邪,桔梗、白前,一升一降,调畅肺气,紫菀、百部温润止咳,陈皮化湿运脾,甘草和调诸药,七药相伍,颇合“肺为娇脏”,性喜辛润之旨。故程氏在《医学心悟》中云:“本方温润和平,不寒不热,既无攻击过当之虞,大有启门驱贼之势”。清末名医唐容川亦盛赞此方可使“肺气安宁”,加减变化后能治“诸般咳嗽”。对老人不论何种外邪犯肺致咳,均可以该方损益。如风寒偏盛,恶寒无汗,痰咯稀白,苔白脉浮,加炙麻黄、杏仁;伴肺脾气虚,再佐党参、白术。若风热较显,咳嗽气粗声嘎,痰黄稠厚,有汗咽痛,舌偏红,苔薄黄,脉浮滑或感温燥,咳呛连声,痰粘少难出,时挟血丝,唇焦口渴者,均弃荆、陈,恐温燥助热灼津,前者易桑叶、前胡、大贝、牛子、黄芩,后者以杷叶、兜铃替代牛、芩。对二证渴甚者,均配沙参、知母或花粉。热、燥若从火化而出血,复入茅根、玉竹各 30 克。咳久气阴两伤致喘者,重用北沙参、紫金牛(又名平地木、矮脚茶、苦平,可镇咳平喘,祛痰止血,《现代实用中药》谓其“为强壮剂”)、生白芍(王好古曰:“白芍可疗肺胀喘咳”)至 30g。凉燥又称“次寒”,虽仍具“燥胜则干”的特征,但热又不显反伴表寒症,若投止嗽散加杏仁、苏子、冬花遂安。

对嗜烟酒、喜辛辣,肺热内郁复感外寒之老人的咳嗽,马师认为虽方书倡用麻杏石甘汤,且体壮者确效,但虚体则恐麻黄辛燥耗津,石膏寒坠伤脾,故改予止嗽散合现代名医岳美中的润肺汤(沙参、山药、桔梗、枳壳、牛子、兜铃),加桑皮以代石膏(《药品化义》曰:“桑皮散热,主治喘满咳嗽,热痰唾血,皆由实邪郁遏,

肺窍不得通畅,借此渗之散之以利肺气,诸证自愈。故云泻肺之有余,非桑皮不可”),麻黄根以代麻黄(《本草正义》谓其与麻黄:“同是一本,则轻扬走表之性犹在,所以能从表分而收其散越,敛其轻浮,以还归于里”,现代名医蒲辅周在用麻杏石甘汤治体弱小儿肺炎时,每以其根代麻黄),加银花清解,防其感染。对不慎摄生,反复感风寒致卫阳过虚,痰咳难已之老人,可以止嗽散去荆芥合桂枝玉屏风散,增益气固表之力,制成膏、丸,调理月余,多可获效。对感寒久咳致喘者,再加鹅管石(性味甘温,有栝珊瑚的石灰质骨骼与钟乳石两种。《本草求原》曰其“暖肺纳气,治肺寒气逆,喘咳痰清”)、核桃仁,以温补肺阳,纳气归肾。虽李中梓《医宗必读》曰:“大抵治表者,药不宜静,静则留中不解,变生它病。”但老人因免疫力低下,用药亦不宜过动,恐表散疏泄太过,更易为外邪乘袭而难痊,故五味子、炒白芍、制诃子等酸收静药,在痰不多时,亦可酌情参入,收动静结合之效。

二、治内伤咳,重在调理脏腑关系

老人内伤咳实少虚多,或虚实夹杂,常涉及多个脏腑。初期多肺脾同病,而肺脾气虚挟湿者尤为常见(老慢支多属此型)。每感寒即咳,晨起较剧,痰白粘腻,或稀或稠,咯后渐缓。伴反复感冒,自汗气短,脘闷纳呆,舌偏胖有齿印,苔白腻,脉濡滑。考虑脾为生痰之源,肺为贮痰之器,且为母子关系,故当根据五行相生之理,投参苓白术散补脾气以实肺气,取姜夏、苏子、益智仁易扁豆、莲子、砂仁;若痰多,合三子养亲汤遂可获安。然病久“五脏所伤,穷必及肾”,症状复杂,施治亦难。辨证时应分为肺脾气虚致肾气虚,肺脾阳虚致肾阳虚,及肺脾阴虚致肾阴虚三型,前两型多见于较重的老慢支、肺气肿、哮喘;后型主要为肺结核。对这些不同的疾病,临床可遵异病同治之理,概以张景岳治“肺肾阴虚,水泛成痰,见咳嗽呕恶,喘逆痰多,痰常咸味”的金水

六君煎(熟地、当归、姜夏、陈皮、茯苓、甘草)化裁:对肺脾气虚致肾气虚者,因咳而兼喘,稍动则喘甚汗出,加党参、黄肉、沉香、冬花、五味子、鹅管石,或配蛤蚧粉吞服;对肺脾阳虚致肾阳虚,现咳痰清稀灰咸,畏寒腰酸,腿肿脉沉,舌淡胖嫩,苔白滑或灰黑腻者,该方佐附子、干姜、白术、人参、怀膝、补骨脂;对脾肺阴虚致肾阴虚,现咳痰难出或带血,潮热盗汗,体瘦烦躁,舌红苔少,脉细数者,即减二陈之量并合百合固金汤。上述三型还均可加紫苑、百部、桑皮等以助止咳。

若内伤咳嗽由肺脾肾发展至心,出现稍咳则喘,端坐难卧,躁烦心悸,汗多紫绀,溲少浮肿,四肢逆冷,或伴痰鸣难出,舌淡紫胖嫩,苔白滑或灰滑,舌下静脉如蚓,脉浮大无根或有歇止,每见于肺心病后期。马师喜用《冯氏锦囊秘录》全真一气汤(人参、熟地、附子、麦冬、白术、怀膝、五味子,冯楚瞻自云其方治“元气日困,津液耗竭,虚火妄升,气勿藏源,上迫喘促……”),强心益肾,补肺运脾以固本,加葶苈子(《本草正义》言其:“苦降辛散,而性寒凉,故能破滞开结,定逆除喘,利水消肿”,动物实验证实其可使心脏收缩加强,心率减慢,……对衰竭心脏可增加输出量,降低静脉压)、桃仁(《别录》言其“止咳逆上气”)、参三七、桑皮、茯苓等,活血利尿,止咳化痰以治标。有可能者,加蛤蚧粉研末吞服,随证抢救,亦有化险为夷,带病延年者。

对内伤咳偏虚之老者,马师倡用“培土生金”、“金水相生”、“扶火益土”等法,调理脏腑关系,以冀母子并补。若虚中挟实,土不克水,饮邪困脾凌肺,致咳嗽喘满,痰涎清稀,溲少肿胀者,每采用现代名医秦伯未敦土利水法,予胃苓汤去猪苓,加党参、桑皮、杏仁、冬瓜子,通过泻膀胱之水湿来恢复肺脾功能,收止咳之效;另有因肾阴亏馁,水难涵木,使木火逆上,反侮肺金,致咳嗽呛急,时作时辍,其声不扬,痰粘难咯,甚则夹血,胁痛口苦,烦

躁面赤，盗汗潮热，目胀耳鸣，脉弦细散，舌红苔薄黄者，他在养肾阴同时，根据五脏生克制化之理，配以佐金平木法，投一贯煎去杞子，合化肝煎，加杷叶、桑皮、马兜铃。由于老人脏气多衰，纯由肝火犯肺致咳嗽的实证，临床少见，姑不赘论。

李杲曾曰：“内伤脾胃，百病由生”，故在调理脏腑关系时，马师尤多顾及脾胃。病至后期，多脏亏损时，更强调：“上下交损，宜治其中”，不仅习用六君子汤奠安中州，化痰止咳，且极少用于过于滋腻苦寒碍纳之品，恐胃气消索生机难复也。

徐女 65岁 1988年3月7日初诊。

慢性胆囊炎伴泥砂状结石十余载，长期茹素嗜辛，性烦躁急，体虚易感。一周前去九华山参加佛事，汗后受风，致寒热咳嗽，街道诊所诊为急支，抗炎输液三天，症稍缓。前晚浴后诸症复萌，且咳甚则呕，心悸气急，卧床难起，输液未效，故邀马师诊治。见其半倚于床，咳呛气急，声嘎咽痛，痰黄白稠难咯，微寒鼻塞，汗多渴饮，脘闷纳钝，溲热黄少，二日未更衣。舌偏红，苔白黄，脉浮细滑，扁桃体略大，T37.8℃。此显系内热久郁，暴受外寒，“客寒包火”致咳：麻黄根、杏仁、桔梗、牛子、大贝、白前、紫菀、百部、枳壳、银花各10g，炙桑皮、山药各15克，南沙参25克，荆芥、生草各7克，4剂诸症大缓，复诊略予更张，又4剂而安。

朱女 73岁 1990年2月11日初诊。

胃溃疡近三十载，哮喘亦十多年，长期纳少，营养缺乏，春节前10天因吐血色紫量多，作胃次全切除术。拆线时感寒，遂咳剧哮喘大发，限于经济而出院。因与马师为近邻，恳邀以决生死之诊。患者端坐于床，咳频气短，吸少呼多，痰白稀却无力咯出，味略咸。形瘦神馁，面浮灰滞，脚肿腰酸，四末如冰。咳甚溲失禁，数日一更衣。日仅食稀饭两许，听诊哮喘音满布，心率108

次/分,舌淡紫胖有齿印,舌下静脉如虬。苔灰白浊厚,脉沉细滑。虽家人着手为其准备后事,考虑其无汗不烦,脉亦未乱,若急于温肺纳肾,健脾化痰,或许可望转机:熟地、当归、姜夏、陈皮、杏仁、紫菀、款冬花、益智仁各 10 克,白术、鹅管石各 15 克,党参、茯苓各 20 克,炙麻黄、干姜、炙草各 7 克。2 剂即见微汗,痰咳较爽,喘稍平,纳略增。将麻、姜、草各减至 5 克,以五味子 5 克易益智仁,又 3 剂,咳喘颇定,痰白不咸,哮鸣音减少,心率 102 次/分。去麻、姜,改附子 7 克(先下)、细辛 3 克,4 剂症续减,心率 90 次/分。以熟地、当归、姜夏、陈皮、怀膝、麦冬、紫菀、杏仁、鹅管石各 10 克,白术、茯苓各 20 克,附子、五味子、红参各 7 克。5 剂后,诸症大平。因畏服药,加山药 20 克以 7 剂量熬膏,至今尚健在!

(马继松主治,赵庆元整理。原载于《安徽省第二次老年医学学术年会暨继续医学教育学习班论文汇编》1999 年 5 月)。

四 100 例肝硬化相关因素分析

肝硬化是临床上常见的慢性肝脏疾病,是由于多种有害因素长期、反复损害肝脏的结果。我们对近 5 年门诊治疗的 100 例肝硬化病例进行了相关因素统计,现分析如下。

一、临床资料

1、一般情况

全部病例均符合中西医结合学会制定的《肝硬化临床诊断、中医辨证和疗效评定标准》(1993 年 11 月在洛阳)^[1]。男 78 例,女 22 例。年龄最大 79 岁,最小 29 岁,平均 51.42 岁,其中

31~50岁 39例,51~60岁 38例,60岁以上 18例。病程5个月~21年,平均4.95年,由病毒性肝炎发展为肝硬化最短时间为体检发现11例,最长时间22年,其中1~10年转变为肝硬化的61例。

2、病因资料

本组91例由病毒性肝炎发展而来,其中乙肝后肝硬化84例,包括HBsAg阳性、HBeAg阳性、抗-HBc阳性(即“大三阳”)30例,HBsAg阳性,抗-HBe阳性、抗-HBc阳性(即“小三阳”)或HBsAg阳性、抗-HBc阳性(即“二阳”)54例,丙肝后肝硬化6例,乙丙肝混合感染后肝硬化1例,酒精性肝硬化5例,其他原因(如血吸虫、药物性等)4例。

3、临床表现

全部病例的主要症状为:腹胀66%,乏力64%,两胁疼痛47%,大便溏薄39%,鼻、齿衄31%,下肢浮肿29%,尿少尿黄21%。舌脉象情况:舌质暗者58例,淡者28例,红者14例;舌苔薄白65例,白腻21例,黄腻14例;脉弦细51例,沉细24例,弦者14例,弦滑11例。另外有40%以上的病人面色暗黑,有蜘蛛痣及肝掌。并发腹水28例,合并上消化道出血6例,糖尿病8例,脾功能亢进10例,肝性脑病6例,癌变4例。

4、实验室检查

ALT正常($<30\text{u/L}$)26例,30~50u/L34例,50~100u/L23例,100~180u/L17例,其中AST $>$ ALT占66%。血清Bil升高25例,A/G倒置25例, γ 球蛋白升高69例。血小板 $<100 \times 10^9/\text{L}$ 占80%,BUN升高22例。

5、辨证分型与用药

全部病例均采用中医药治疗。依据洛阳会议中医辨证标准分为6型:脾虚湿盛型30例,用参苓白术散、防己黄芪汤、五苓

散加减;血瘀型 21 例,用血府逐瘀汤、大黄蛰虫丸加减;湿热内蕴型 15 例,用黄连解毒汤、茵陈蒿汤加减;肝肾阴虚型 15 例,用六味地黄汤、一贯煎加减;肝郁气滞型 14 例,用柴胡疏肝散、四逆散加减;脾肾阳虚型 5 例,用四君子汤、二仙汤及真武汤加减。

6、疗效

显效 18 例,好转 30 例,稳定 34 例,恶化 10 例,死亡 8 例。

二、讨论

1、肝硬化多发于中年以上,其中一部分人在体检时首次发现,提示我们要警惕隐匿感染者,加强对中年人的体检工作,特别是要定期复查有家庭史者,以便及时诊断,及时治疗。

2、本组肝硬化由乙肝发展而来的占 84%,与北京市统计资料 85.7% 相符^[2]。说明乙肝病毒的感染与肝硬化密切相关。本组 84 例乙肝后肝硬化中“大三阳”者只 30 例,“二阳”者 54 例,说明了乙肝病毒复制的强弱不一定与肝硬化的发生率呈正相关。有文献指出体内乙肝病毒在复制时,肝病症状不一定加重;但也有不少专家认为,乙肝病毒在体内持续复制的急性肝炎易转变为慢性肝炎,肝病变损害的程度与病毒复制相关^[3]。随着丙型肝炎诊断技术的完善,对丙肝的预后日趋明确。本文 6 例丙肝后肝硬化全部有输血史,其肝硬化时间为 6 个月~6 年,其中 5 例均在 1 年左右就转变为肝硬化。临床观察:ALT 持续波动并有血清 Bil 升高者,其硬化趋向大;年龄越大,硬化比率就越高,与乙肝相比更易导致肝硬化。有文献已报道:抗-HCV 阳性的病人更易发展为慢性肝炎,其肝硬化率也会相对增高,这一点不容忽视^[4]。

3、从实验室指标看,除丙肝外 ALT 波动的幅度似乎不与病情的轻重成正比,而血清 Bil 持续增高,则预示病情加重。在死亡的 8 例中,有 6 例 ALT 轻度升高($<50\text{u/L}$),2 例波动在 100

~180u/L,而8例都有不同程度的血清Bil升高。另外,老年患者BUN升高居多,说明老年肝硬化患者多合并有肾脏损害,这与中医理论认为人的生、长、壮、老、已与肾气的盛衰、精气的溢泻变化息息相关。

4、肝硬化的主要症状为腹胀、乏力、两胁疼痛、大便溏薄、鼻齿衄、尿少尿黄、双下肢及踝部浮肿、舌质暗或淡、脉弦弱或沉细,反映了肝硬化患者以气血亏虚、气滞血瘀、水湿内阻三个病理环节为主。中医治疗肝硬化,辨证与用药是一个关键性的问题。所以了解肝硬化的病因病机,摸索治疗肝硬化的有效途径,是非常必要的。在100例肝硬化治疗中,我们发现有效病例大部分集中于脾虚湿盛型(18例)、气滞血瘀型(14例)、肝郁气滞型(9例)三个证型,这与肝硬化三个主要病理环节即气血亏虚,气滞血瘀,水湿内阻相合,临床上包括了大部分早期肝硬化及部分肝硬化腹水的病例。在中医文献中此病证多隶属于鼓胀、肝着、胁痛、症瘕、积聚等门类,其病理机制比较复杂。当代治肝名医关幼波认为:多是湿热困脾,运化失职,转输无权,脾气虚亏,正气不行,浊气不化,湿浊顽痰凝聚胶结;另则热注血分,伤阴耗血,气虚血滞,以致瘀血滞留,着而不去,凝血与痰湿蕴结成痞块,进而凝缩坚硬而为肝硬化^[5]。腹水的出现也与其三个病理环节密切相关。如气血两虚,行水运水无力,水液必滞而为邪;气滞血瘀又可以导致水液代谢异常,引起水湿内停。故其治则为益气健脾利水、活血软坚解毒。经统计,下列一些药物在处方中出现频率较多。益气健脾类:生黄芪、茯苓、白术、山药;利水渗湿类:泽泻、猪苓、车前子;疏肝行气类:柴胡、青皮、陈皮、大腹皮、枳实;活血化瘀类:丹参、桃仁、当归、生地、川芎、赤芍、益母草、泽兰叶;软坚化结类:炙鳖甲、鸡内金、生牡蛎、土鳖虫;清热解毒类:茵陈、金银花、蚤休、白花蛇舌草。在治疗过程中,我

们首先将益气健脾与软坚化结类药贯穿始终,但在各阶段其侧重面不同,如肝硬化腹水期,软坚化结类药要少用,以免耗伤正气,而加重健脾利水之品,有利于祛除水患。其次,在早期肝硬化阶段除了辨证用药外,及早地使用活血化瘀药和解毒类药是很有必要的。一方面活血化瘀药如丹参、当归、赤芍等有活跃肝内微循环、增加疏通胆管、降低门脉压、抑制纤维增生的作用^[6],另一方面解毒类药如金银花、蚤休等,实验证明对乙肝病毒有抑制作用,此可减少致病因子,减轻肝脏负担。再者,肝硬化腹水期在注意攻补并用的同时,也要适当配合活血养血之品,如益母草、泽兰叶等,使血行气畅,以助水湿排泄,必要时配合少量的西药利尿剂,以提高疗效。

参考文献

- [1]张育轩,等·肝硬化临床诊断、中医辨证和疗效评定标准(试行方案)·中国中西医结合杂志,1994;14(4):237
- [2]高寿征·病毒性肝炎防治研究·北京出版社,1993:322
- [3]邱德贵·肝炎防治指南·成都:四川科学技术出版社,1993:46
- [4]陈立华·丙型肝炎的特点及中医治法·中医杂志,1994;35(10):621
- [5]若 秋·中医药治疗肝硬化验案回溯·光明中医,1988;(5):12
- [6]杨运高·中医药抗肝纤维化实验研究述评·国医论坛,1994;(2):42
- [7]余亚新·大剂量丹参治疗肝纤维化的临床观察·上海中医药杂志,1994;(2):8
- (刘燕玲、陈立华。原载于《山东中医杂志》1995年第9期)。

五 浅谈脂肪肝的中医药治疗

随着饮食结构的变化,各型肝炎患者的增多,以及临床检测水平的提高,脂肪肝患者的人数亦相应增加,如何发挥中医药优势,使脂肪肝得到有效的治疗,显得日益迫切。笔者根据收集的有关资料及临床观察,对本病进行了初步的探讨分析,供同道参考。

一、中医对脂肪肝病因病机的认识

脂肪肝是西医病名,中医古文献未见记载。但根据其发病特点和大量的中医药临床实践,本病的发病机理与中医理论中的痰、湿、瘀、积等密切相关。如蒋森、赵洪涛认为,该病系因过食肥甘厚腻,恣意饮酒,导致湿热蕴结肝经,瘀血阻滞^[1]。宋福印认为,虽本病病位在肝,但其发生原因较为广泛,总结为气血湿食瘀滞^[2]。黄沪燕、杨环等则指出,湿热久羁,熬炼成痰,痰浊阻络,痰瘀胶着为主要病机^[3]。

总之,大部分学者认为脂肪肝的产生主要责之于肝脾两脏,其病机可概括为:肝失疏泄,肝血瘀滞;脾失健运,湿邪不化,痰浊内生。因此,活血化痰、清热疏肝解郁、健脾化湿祛痰可作为治疗本病的基本大法。

关于肾在本病发生发展中的作用,文献中较少论及。但根据肾为先天之本,内居元阴、元阳,肾为痰之根,脾为痰之源等中医理论,结合临床观察来看,笔者认为,肾的作用是举足轻重的。《素问·生气通天论》曰:“阳气者,若天与日”,“阳不胜其阴,则五脏争气,九窍不通”。肝之藏疏,脾之运化,无不依赖阳气之鼓动,若肾气不足,肾阳虚弱,则气化不及,加重痰湿和瘀滞。因此,温补肾元以疏肝健脾,能进一步提高治疗脂肪肝的疗效。

二、脂肪肝治法方药分析

笔者将近年来报道的治疗脂肪肝的有效治法、方药进行了初步的统计与分析,发现:

处方立法主要有活血化瘀法、健脾消导法、清热解郁法、利水渗湿法、养阴疏肝法、益气助阳法、通下法等。其中活血化瘀、健脾消导、清热解郁 3 法使用频率最高。

从处方使用的药物及其性味上看,所用药物品种有泽泻、丹参、生山楂、虎杖、制首乌、柴胡、草决明、白芍、当归、茯苓、枸杞子、茵陈、焦槟榔、法夏、女贞子、荷叶、白芥子、郁金、白术、甘草、杏仁、莪术、浙贝、明矾等 54 味,其中使用频率最高的依次为:生山楂、丹参、泽泻、草决明、柴胡、制首乌、虎杖、茵陈、白术、当归等 10 味。在 54 味药中,大部分属苦燥、辛香、咸降、酸涩、淡渗之品,小部分为甘润之物^[1~4]。

通过上述分析证实了活血化瘀、化痰祛湿、清热解郁等治法是行之有效的方法。其辛香苦燥正宜消除瘀滞,清利痰浊,清热解郁;而甘润柔阴之品可柔养肝体,恢复肝用。

此外,根据肾的生理病理特点,笔者认为固肾助阳法在脂肪肝的治疗上也应受到重视。我们在临床实践中观察到,许多脂肪肝患者常见倦怠乏力,腰背酸软,大便溏泻,舌淡体胖,脉沉细等肾气虚弱、阳气不足之象,治疗上酌加助阳补肾之品,如参苓白术散加何首乌、桑寄生、仙灵脾、仙茅等药,达到补益肝肾、振奋阳气、健脾化湿的目的,常常获得较好的疗效。

三、现代药理学研究

现代药理学对中药抗脂肪肝的研究已做了大量的工作,主要包括单味中药和复方研究两个方面。

1、单味中药。日本学者小林忠之的研究发现,泽泻的有效成分 T 提取物对各种原因所致的动物脂肪均有良好效应,指出泽泻可减轻肝内脂肪量,改善肝功能。国内学者也发现在实验

性高脂血症动物模型中,泽泻组内的 TC、CE、TG 总脂均显著低于对照组。实验证实山楂对豚鼠肝细胞微粒体及小肠粘膜匀浆 HMGR 酶的活力有明显的抑制作用,达到降低胆固醇及去脂的目的。丹参水煎剂对动脉粥样硬化的大鼠及家兔有降低肝脂(特别是 TG)的作用,其机理可能是丹参促进了脂肪在肝中的氧化,从而降低了肝脂含量。虽然本文统计的方药中未曾使用过人参,但实验证实人参有明显的降低肝胆固醇、甘油三酯和显著升高肝内磷脂含量的作用。组织学结果说明,高胆固醇饮食所致大鼠肝脏脂肪浸润因同服人参可大为减轻。实验还证明仙灵脾能减少肝脏过氧化脂的形成^[5],何首乌所含卵磷脂能阻止胆固醇在肝内沉积,阻止类脂质在血清中滞留,与之同类的女贞子、枸杞子等也都具有明显降脂和保肝作用。清解药如虎杖,其所含白黎芦醇甙,有降血清甘油三酯之功效,茵陈也有类似作用^[3]。

一般看来,淡渗利湿类药(如泽泻)可以消除过高的血脂;滋养甘润类药(如首乌)可通过保肝润养来消除肝脂;清解类药(如虎杖)又以清泄来消脂去浊;仙灵脾、人参等助阳益气之品及丹参等活血药,则往往通过促进脂肪的氧化或降解等“主动”的机制来消除肝脂。这些因不同性味而能通过不同的途径起到降脂抗脂肪肝的作用,为脂肪肝的中医药辨证论治提供了理论和临床运用的根据。

2、复方研究。日本学者通过不同的分组进行动物实验的结果表明,小柴胡汤、大柴胡汤、五苓散、柴苓汤等汉方对肝脂肪有明显的抑制作用,同时抑制血清中性脂肪、磷脂、过氧化脂质的增加,对血中甘油三酯的降低作用最为显著。日本学者推断上述汉方并不是作用于靶器官,而是作用于全身。国内学者马伯良等研究六味地黄丸的实验提示,该方有抑制肝内脂肪沉积的

作用。李传富等对自拟方血脂平(何首乌、蒲黄等药组成)的实验研究表明,该方能有效地降低高脂血症大鼠和家兔的肝胆固醇和甘油三酯的水平。

综上所述,脂肪肝的中医药治疗在辨证施治的基础上,借助于现代药理学研究结果,针对病因病理选择有效药物和复方,将有助于疗效的提高。

小 结

关于脂肪肝的中医研究,根据相关的中医理论和临床实践可以认为:痰、湿、瘀、积等病理产物是脂肪肝形成的条件;各种外来因素(病毒、酒精、不合理膳食等)所致的肝脏损害则是脂肪肝形成的基础。因此,活血化瘀、健脾消导、清热解郁、化痰祛湿等法是中医药治疗脂肪肝的基本治法。同时还应充分注意到肾在治疗脂肪肝中的重要作用,临床对脂肪肝发病年龄统计的资料表明,40岁以上者占70%,《素问·上古天真论》曰:“五八而肾气衰”,肾中阳气随年龄增长而有减弱之势。因此依据病情酌加补肾助阳之品,鼓动肝脾的疏运之功,将有助于提高疗效。

参考文献

- [1]蒋森,降脂益肝汤治疗脂肪肝 100 例疗效观察. 黑龙江中医药, 1992,(1):13
- [2]宋福印,李禾花.疏肝健脾和胃软坚法治疗脂肪肝 45 例观察. 黑龙江中医药,1991,(4):37
- [3]黄沪燕,曾宗明.利胆益肝汤治疗慢肝并高脂血症 21 例疗效观察. 新中医,1992,(10):27
- [4]李书奎.降脂复肝汤治疗脂肪肝 35 例. 陕西中医,1990,(5):208
- [5]李仪奎,姜名瑛. 中药药理学. 北京:中国中医药出版社,1992. 193~194)

(刘燕玲、陈立华.原载于《北京中医药大学学报》1995 年

第5期)。

六 前列腺炎勿忘治肝

前列腺炎属于中医学淋证、癃闭范畴,古今医家多从肾治。芜湖中医学校马继松老师,认为前列腺和少腹,正处于足厥阴肝经循行所过之区,该病主症洩黄淋涩,少腹坠胀等,与肝经湿热下注、肝气郁滞又密切相关,且肝肾同源,精血同源(本病常有瘀阻症状,而瘀血皆出于肝),故临证每肝肾并治,对从肾治效欠佳者,则改治肝为主,常收显效,现简介验案四则。

一、清泄肝经湿热案

高某,34岁,工人。1991年6月27日初诊。

结婚四载离异,遂借酒消愁,渐烦躁目胀,颜面生火,洩赤涩痛,偶夹丝状白物,会阴睾丸坠胀掣痛,半月前淋雨,症益甚。某院诊为急性前列腺炎,用青霉素、前列康未效,改八正散略缓,遂转马师诊治。刻下:时欲太息,便艰寐难,寒热胁胀。舌偏红,苔黄腻满布,舌下静脉紫粗如蚓,脉弦。证属肝经郁火与湿热瘀血搏结为患。药用:柴胡、枯黄芩、焦栀子、炒枳实、木通、龙胆草各10克,泽泻、当归、丹皮、车前子各15克,玄参、朱茯神、六一散(布包)各30克,石菖蒲、苍术各7克。5剂症减,去胆草、木通。加瞿麦、生蒲黄各15g。又5剂,仅睾丸、会阴痛坠未除,弃苦寒利水药,加金铃子、延胡索、橘核、赤芍,继服十剂痛止,检查腺体、腺液均已正常。

按:患者初用抗生素、八正散等,但效不显,故改投清泄肝经湿热首选之剂龙胆泻肝汤。《医学启源》曰:玄参“治懊恼烦不得

眠……血滯小便不利，”故取其易生地，加菖、苍、枳实芳化湿浊，且防苦寒药败胃也。

二、疏泄乙木气机案

王某，55岁，工人。1991年10月7日初诊。

因急怒不已，小溲突闭，胀满益加。虽导尿排出，却又复难解，数次导尿后，尿如浓茶，淋漓涩痛，尿后滴白粘液，且腰骶酸胀，少腹下坠，牵及阴囊会阴。肛检前列腺饱满触痛，中等硬度，前列腺液化验：脓细胞散在成小堆，卵磷脂小体消失。诊为前列腺炎予抗生素、前列康等而未效，改求马师。刻诊：伴喑呃纳呆，烦躁胁胀，舌红苔薄黄，脉弦。证属肝气失畅，且化火上逆。予自拟复方四逆散疏肝调气，宣肺运脾。药用：柴胡、枳壳、郁金、当归、川楝子、旋覆梗各10克，茯苓、丹皮、赤芍、香附各15克，焦栀、白术、薄荷、石菖蒲各7克。5剂它症皆减，但溲仍不畅，去旋、丹、栀、薄，加炒知柏各7克，萆薢15克，肉桂3克（研冲）。又5剂溲涩痛显减而辜坠复甚，去郁金、赤芍、川楝子，加山药、玄参、荔枝核各30克。5剂后诸症大瘳。上方出入十剂而渐奏康泰。

按：此例颇似“气淋”，教材多倡用五磨饮子，然沉香价昂，槟榔峻破，故改投丹栀逍遥散合自拟复方四逆散（四逆散加郁金、白术、香附、当归、延胡索），加楝、旋、石菖蒲共奏疏肝化浊、利尿定痛之效。柴、薄相合又可宣肺以“提壶揭盖。”但药后溲仍欠畅，遂仿余听鸿用疏肝理气药浓煎送服通关丸治愈李妇郁怒伤肝癰闭案，加入知、柏、肉桂（通关丸）、萆薢而效。荔枝核最擅理厥阴滞气，故用其佐柴胡及诸补益药消除了会阴睾丸之坠胀。

三、温化厥阴寒瘀案

胡某，45岁，干部。1994年1月31日初诊。5年来饮酒过量，渐感神疲口苦，腹坠溲黄，淋涩欠畅，尿后偶带白物。检前列

腺液:卵磷脂小体(+),红、白细胞各(++),诊为前列腺炎。马师据舌红苔黄、酗酒史等,投大剂清解化湿药合通关丸,5剂后,坠胀益甚,气短懒言,脉沉弱,舌下静脉紫粗如蚓,细询知去岁冬天去东北感寒太过后发剧。故改投生黄芪、山药、葛根、薏苡仁各30克,王不留行、熟地、怀牛膝、当归身各15克,柴胡、延胡索、炒知柏、桃仁各10克,肉桂5克(研冲)。5剂后如石投水,其又转赴某院激光治疗尚安。寒露后暴冷病复剧,10月13日再次请马师治疗,告日暮症重,腰骶酸冷,热敷稍舒,少腹似有石下压,溲微涩痛,但不灼热,舌淡紫舌下静脉如前,脉沉缓。此显系寒湿夹瘀客于厥阴。改予附子(先煎)、生黄芪、当归、白芍、延胡索、莪术各15克,鹿角片、炮穿山甲、乌药、柴胡、杜仲各10g,山药、荔枝核各30克,肉桂(研冲)7克。服5剂颇安,遂以该方损益,曾用细辛、干姜、巴戟天、淫羊藿等辛热温壮之品,冬至后又加红参10克,服药14周,每周5剂,诸恙悉平。

按:此案初诊用过清化,复诊虽加温化之品,但仍用了知柏、怀牛膝,故又罔效。三诊放胆用附、桂合鹿片(《本草经疏》云其“咸能入血软坚,温能通行散邪,……,咸温能入肾补肝,故主腰脊痛”)、炮甲(张锡纯谓其:“味淡性平,气腥而窜…凡血凝血聚之病,皆能开之”)及大剂温化厥阴寒凝之品,冬至后连投红参以益气化瘀,顽疾方渐臻坦途。此案服附子近千克,红参150克,鹿片、炮甲各700克,可见慢性病当有方有守,切忌频频更张改弦。

四、壮水以制阳光案

吴某,63岁,干部。1993年3月27日初诊。1年前排尿淋涩,腹隐痛坠,偶有血精,阳萎亦甚,B超示前列腺I°肿大,前列腺液红、白细胞各(++),卵磷脂小体(+),诊为慢性前列腺炎伴肥大。迭用中西药时缓时剧。马师诊察舌淡紫、苔少黄干,脉

细数。证属肝肾阴血不足,虚阳挟湿瘀上越下泄为害。宜“壮水之主,以制阳光,”佐利尿凉血。药用:北沙参、生地、白茅根各 30 克,朱茯神、麦冬、丹皮、茜草各 15 克,枸杞子、当归、泽泻、川楝子各 10 克,焦栀子、青皮、生甘草梢各 7 克。5 剂症减,又 5 剂颇安,惟少腹胀坠如旧。去生地、麦冬、泽泻、枸杞、栀子、青皮,加生白芍、山药、玄参各 30 克,柴胡、黄芩、香附各 10 克。服十剂大愈。去白茅根、茜草,加炮穿山甲、琥珀各 10 克。十剂量为末,以鲜益母草 250 克,浓煎,泛丸,空心淡盐汤送下,1 日 4 次,每次 10 克。丸尽复查,前列腺液正常,腺体亦平伏。

按:“壮水之主,以制阳光。”原为治肾阴亏损,龙火上亢的大法。但因“精血同源,乙癸同源,肝肾同源,”故清·魏玉璜创一贯煎,专治“肝肾阴虚,阴液枯涸,血燥气滞,变生诸证者,”故实可看作是对“壮水以制阳光”一法的变用。马师以此方合六味地黄丸中三泻之品,清泄肝肾之火且利尿,合栀子、茜草、白茅根、甘草清利凉血;青皮合川楝子疏肝而渐瘥。末诊以益母草煎浓汁泛丸,以使药力直达下焦而不过峻也。

(马继松主治,李开屏、郎晓闽整理。原载于《辽宁中医杂志》1999 年第 3 期)。

七 刍议泌尿系结石

泌尿系结石,相当于中医淋证中的“石淋”,但两者又不完全相同。

在病理上,中医认为是下焦湿热蕴积煎熬尿液,尿中杂质结构成砂石。西医认为是体内代谢失衡,尿中晶体凝结;或尿中排

钙过多,钙盐沉淀;或尿路病变,病理产物凝结成结石核心,再由水中钙盐晶体附着而形成结石。

在诊断上,中医自仲景以下一直均以尿中夹有砂石作为“石淋”的确诊依据。以小便艰涩或排尿中断,尿道窘迫疼痛,或腰腹酸痛难忍,少腹拘急,甚至向生殖器和睾丸牵拉放射,或尿中带血等为常见伴随症状。中医主要以症状作为诊断和辨证论治的基础和依据,如无症状,其诊断便难以成立,治疗也就无从下手。重症状,轻检查,是中医诊查之局限和不足。西医除了以症状作为诊断依据外,更重视利用现代检查手段来帮助明确诊断。如用X线显象来进行静脉肾盂造影,逆行肾盂造影,膀胱空气造影及用B超进行结石诊断,用膀胱镜直观检查以助诊断等。这些手段可在无症状的情况下准确地判断出结石的部位、多少、形状、大小,有无活动,嵌顿,梗阻及导致积水等诸多情况,还可通过化验来判断有无感染,出血和肾功能损害及其程度等。既重症状,更重检查,这是西医诊断的优势和长处。

作为现代中医,理应衷中参西,取长补短,即使没有症状,只要检查发现结石,也应该确诊为“石淋”。

笔者根据多年的临床体会,认为对结石辨证应分活动期和静止期,针对这两期的一些具体情况,定出相应的治则和治法。兹不揣浅陋,简介如下。

一、活动期 急则治标—以对症治疗为主

疼痛 临床上结石病人以疼痛为主诉就诊者最多,当结石大到一定程度时,因某种原因产生活动,刺激相应的部位,并使之产生剧烈的收缩,蠕动和痉挛,便产生疼痛。其疼痛多为腰腹部阵发性剧烈酸痛,或少腹拘急,并向生殖器放射或牵拉,尿道窘迫,痛甚时可伴有呕吐。查体时可有一侧或双侧肾区叩击痛,沿输尿管方向有压痛,中医认为是气机阻滞,不通则痛。治宜疏

通气机,缓急止痛,方用金铃子散加味,药用金铃子、醋玄胡、罂粟壳、炒枳壳、青皮、陈皮、乌药等。

血尿 当结石活动的刺激使局部受到损伤时,常出现肉眼血尿或在显微镜下发现血尿。中医认为是湿热灼伤血络,治宜凉血止血,方用小蓟饮子合四生丸加减,药用大、小蓟,白茅根、生侧柏叶和琥珀屑等。

感染 当泌尿系的局部受到结石的损伤后,抵抗力下降,很易受细菌感染,出现小溲频急、热痛,甚至有发热恶寒,尿常规可见RBC、WBC,甚至有脓球,血象也可能升高。中医认为是湿热下注所致,治宜清热利湿通淋,可予八正散化裁,选生地、木通、车前子、竹叶、焦栀、黄柏、篇蓄、瞿麦、虎杖、银花、六一散等。

梗阻积水 肾盂结石过大可导致肾积水;当结石在输尿管嵌顿造成输尿管梗阻,亦会导致输导管和肾的积水。表现为排尿突然中断,或小便艰涩,淋漓不畅,甚则腰部及沿输尿管胀痛不适,当急予排除结石,解除梗阻,可投以桃核承气汤攻逐之,药用归尾、桃仁、大黄、芒硝、肉桂、川膝、红花、琥珀、三七、留行子、金钱草等。

在结石活动期,对症治其标固为首要原则,若同时抓住结石活动的有利时机,因势利导,及时将结石排降,常可收标本兼治之佳效。

二、静止期 缓则治其本—辨证论治

阳虚 结石静止时,很少有明显症状,若表现为腰部胀刺不适并伴畏寒肢冷等阳虚症时,可用温阳法,以右归饮损益,药用杜仲、川断、寄生、怀膝、补骨脂、仙茅、仙灵脾、熟地、菟丝子等。

阴虚 若患者素体阴虚,或久服利尿排石剂,伤津耗阴,现阴虚表现时,可用滋阴法。方用知柏地黄丸出入,药用生地、山药、知母、黄柏、何首乌、玉竹等。

当检查发现部位较高的肾盂或肾结合系统有结石,暂时很难排出而患者毫无感觉时,可用消除法促使结石慢慢溶化,方用治石淋方增损,药用冬葵子、滑石、牛膝、鱼脑石、石韦、海金砂、金钱草、鸡内金等。

根据结石性质而用相应之药。当患者结石较多,并已有结石排出时,可对结石进行化验,如系草酸钙、磷酸钙等碱性结石占大多数,可加用乌梅、山楂、莢肉等酸性药;如系较强酸形成的盐类结石,可加用生牡蛎、生海蛤壳、珍珠母等碱性药,这样将有利于结石尽快消溶。

对结石的治疗,最主要的是排除之,对如何排除它,当代中医学家常仁智互见,治疗佳法灿若繁星,笔者结合临症体会,以四法简括之:

利尿排石法:利尿可增尿量,加强尿液对结石的冲击力和推动力,促使结石排出,并可降低尿液的浓度,提高尿液对结石的溶解能力,促使结石溶化或变小。方用四苓散进退,药用茯苓、泽泻、车前子、木通、赤小豆等。

行气排石法:当结石运动时发生嵌顿或顺狭窄部位被夹卡难行时,常疼痛剧烈,中医责之为气机阻滞不通,行气可促使泌尿系器官加速运动,有利于排石。现代药理实验已证实很多行气药都具有松弛和扩张平滑肌或增强平滑肌张力,增强平滑肌蠕动的作用。输尿管平滑肌松弛扩张了,狭窄处就会变得宽松,此时因平滑肌蠕动亦加强,故结石亦可尽快下行。方可取四磨饮子加减,选沉香、枳壳、厚朴、青陈皮、槟榔、乌药等。

活血排石法:结石嵌顿日久,受损局部充血水肿,产生淤血,运用活血药可使瘀消症缓。另中医还认为血为气母,血行气亦行,故活血有利于气机通达,促使排石。现代药理实验也证实,有些活血药可兴奋平滑肌,促进其蠕动,达到排石目的。以抵当

丸出入,加川牛膝、留行子、丹参、生地、当归、赤芍、穿山甲等。’

攻下排石法:金元四大家之一的张子和曾云:“逐水、破络、泄气,凡下行者,皆下也。”从临床研究来看,攻大便的药既可大大加强肠道平滑肌的蠕动,同时也增强了泌尿系平滑肌蠕动,因此攻下有利排石亦为日益增多的医家所重视。方用大承气汤扩充,其中生大黄还可活血,芒硝可软坚,枳实、厚朴并具降气作用,因该方有多种功效,余对体壮便艰的结石者喜首选之。

由于泌尿系结石非朝夕所能形成,且活动期的症状常又很急重,故治此病如中医疗效欠佳或欲尽快根治时,亦可中西两法同时采用,即在服用中药的同时,积极配合西医解痉止痛,麻醉止痛,封闭止痛,止血,抗感染等保守疗法。还可利用现代体外碎石机,待结石震碎后,再用中药排石,必要时请西医行手术摘除。

总之,该病颇为复杂,临床上常是多种类型混杂出现,在实际运用中应灵活掌握,切勿为一方一法所拘。有时需多种方法综合运用,融汇贯通,随机应变。另对服中药后效果明显者(如结石经西医检查证实消溶较快,或下移较多,有排出之可能),应遵“治慢性病当有方有守”之卓见,劝患者耐心服用中药,惟其如此,才能取得良好的疗效。

(王世峰、田爱华。原载于《亚洲医药》1998年第10期)。

八 大黄在中医五官科疾病中的应用

大黄不仅是应用最早,也是应用最广的中药之一,早在《神农本草经》中即详述了其功效,最早的临证专著《伤寒杂病

论》中,选用该药组方竟达 40 余首,几乎占全书方剂的八分之一,不少名方一直沿用至今。清代杨璠在《伤寒温疫条辩》中以四钱生大黄与二钱僵蚕、一钱蝉蜕、三分姜黄相伍组成“统治一切温病”的升降散。除内、儿科外,各代名贤还将其广泛用治外科、妇科、伤骨科疾患,张景岳更将其与附子、人参、熟地并列为药中之四维,盛赞其拯危救急之功。然鉴于今贤对大黄在五官科疾病中的应用有鳞爪之嫌,故余不揣浅陋,结合近三十载临证体验,将有关内容简介于下。

一、泻火解毒

前贤曰:“目不因火则不病”;胆经“从耳后入耳中,出走耳前”,胆热常挟肝火循经上逆致耳病;《奇效良方》则曰:“鼻之为病,不过风热而已”;《巢氏病源》云:“脾胃有热,气上冲,则咽喉肿痛”。诸家所言,虽欠全面,然亦可知,五官科之病,热证过半矣!其中六淫中的风、暑、燥、火及胃肠中宿食变生燥火致疾尤多。诸如天行赤眼、凝脂翳、瞳神紧小、暴盲、绿风内障、鸪眼凝睛;耳疔、脓耳、耳根毒;鼻疔、鼻疳、急性鼻渊;乳蛾、喉风、喉痹、疫喉等。此类因火热所致的疾患,常来势猛、发病快、变化多,若辨治略有迟误,每可危及生命。由于患者常伴有大便干结,故可投苦寒沉降、有推墙倒壁之功的大黄,直达下焦,釜底抽薪。不仅能收泻火解毒之伟功,且可获“里通则表自解”(丁甘仁语)之奇效,张锡纯赞大黄:“性虽趋下,又善清在上之热”,即此谓也。此法用于喉科尤验,盖《尤氏喉科·治法》云:“凡喉症初起,大便秘结,宜大黄、玄明粉下之,则火降而易痊”;并强调:“如大便闭结,不可轻许其愈”。历代用大黄组成的泻火解毒名方,不胜枚举,而治五官科疾患,却以清咽利膈汤为最佳。虽该方出自《喉科紫珍集》,但银、翘;连、芩;硝、黄三组对药合用,能分清上、中、下三焦之邪热,泻火解毒甚强;玄参、生草、山栀滋阴解毒;薄、

蒴、防、桔辛凉轻疏头面邪热。略予损益,亦可治疗因火毒所致的眼、耳、鼻、口之疾。它如承气汤类方、《局方》凉膈散、《卫生宝鉴》既济解毒汤(升、柴、翘、桔、连、芩、草、归、大黄),均不失为要方。另《银海精微》、《秘传眼科龙术论》等书中,有数十首以大黄与芒硝或芩、连合用的泻肝汤、泻肝散等,皆可辩证试投。

陆幼 7岁 初诊日期:1985年4月3日

发热咽痛一天,予抗菌素治疗两天,未见显效。现 T38.7℃,咽痛仍剧,汤水难进,口干口臭,腹部膨胀,壹周末更衣,舌红苔黄腻,脉滑数。检查:咽充血,扁桃体Ⅱ°肿大,左侧有脓点。此系风热乳蛾,予清咽利膈汤增损,以泻火通腑,疏解化痰:生大黄(后下)、炒枯芩、焦山栀各7克,连翘、玄参、僵蚕、生草、炒牛子、炒枳壳、玄胡粉(冲)各10克,银花15克,芦根30克。两剂。当晚排坚硬如栗之黑便少许,翌日下午又排恶臭溏便甚多,咽痛减,腹胀松, T37.8℃,可稍进糜粥。去元明粉、生军、焦山栀,加知母10克、熟大黄5克,接服二剂痊愈。

按:此案内有宿食化火攻咽,外又触受春温时邪,故用表里双解而效。因取大黄峻下通便,故生用后下。然幼儿质小体稚,只仅用7克,服硝、黄已得溏便,为防久服伤中,复诊遂予改弦。

二、清利湿热

六淫中湿热之邪,可直接侵犯七窍致病,若其它诸因引动肝胆或脾胃素蕴之湿热,每多化火炎上,亦致头面诸窍生病:如睑弦糜烂湿痒、黑睛生翳溃陷、云雾移睛、白睛微红涩胀;耳部湿烂、黄水淋漓、甚至耳内流脓;鼻多黄浊脓涕、鼻渊;咽喉疼痛、声音嘶哑、梅核气等。因大黄为“泻……湿热胶痰滞于中、下二焦之要药”(《本草经疏》),故每与清热利湿之品相合,用治此类疾患。代表方为《原机启微》的竹叶泻经汤,该方取连、芩、栀、升苦寒燥湿清热;泽泻、竹叶、茯苓、车前子淡渗利尿,引湿从小便出;

大黄、柴胡(章次公认为柴胡有通便之功)[注]、决明子清泄肝胆,引湿热由大便出;赤芍、生草凉血解毒;独用一味辛温燥湿之羌活,既可将沉降药之药力引达头面,又可在大队苦寒药中为反佐。虽原为治漏睛证专方,由于配伍谨严,故可通过驱使肝胆脾胃湿热下行,而达到疗眼、耳、鼻、喉疾患之目的。它如刘河间之当归龙荟丸、钱乙泻青丸、《银海精微》猪苓散(猪苓、苍术、山栀、木通、篇蓄、大黄、狗脊、茯苓、车前子、草决明),均可随证选用。

段男 18岁 学生 初诊日期:1988年5月14日

右耳患慢性化脓性中耳炎已年余。常有稠黄脓液积于耳内,耳鸣、耳胀且闭塞不聪,近壹周尤甚,不仅右耳闭不闻声,且左侧亦鸣响,无法听课,十分焦躁。以致夜不能寐,头目胀痛,时感寒热,溲黄便干,舌红苔黄腻,脉滑数。检查:右耳道红肿变狭,有黄稠脓液堵塞,直至外耳道口,耳壳亦略红肿。此系胆经湿浊为外感风热引动而化火循经上炎,当予竹叶泻经汤进退,以清利湿热,排脓通窍:柴胡、白芷各6克,黄芩、焦栀、泽泻、生草、赤芍、僵蚕、石菖蒲、皂角刺、酒大黄各10克,茯苓、银花各20克,鲜连心竹叶一小把(约15克)洗净,煎汤代水煎药;另以生大黄、黄柏、白芷各6克,煎水先洗后滴耳道。三天后寒热退,红肿消,脓液减,但耳鸣、耳闭依然。去黄芩、竹叶,加制香附、白蒺藜各10克,五剂,外洗方三剂。随二便之畅解,耳鸣耳闭渐复正常,脓液干净而痊愈。

按:患者系外感风热诱动肝胆湿火,因已化脓,故可用竹叶泻经汤加白芷、皂角刺以排脓;大黄可清泄胆火,导热下行,加强药效。因耳窍较深,故大黄酒炒同煎,取其降中有升,而达耳窍之中;外用生大黄可活血解毒,排脓消肿,内外兼治,获痊愈速。

三、活血化淤

前贤认为:“七窍之灵,无非血之用。”故血贵流通而忌淤滞。

王清任更明言：“血受寒凝结成块，血受热则煎熬成块”。故阳气衰微或外感温邪时毒、过食辛辣、五志过极化火，皆能致淤。另外伤络损血出，亦可成淤。因此，青盲、暴盲、白睛溢血、血灌瞳神、胬肉攀睛；外伤性耳聋、耳外伤、耳闭；鼻痔、鼻菌、鼻塞、酒渣鼻；喉痛、喉菌、久喉暗、梅核气等疾患中的部分证型，均可投活血化淤一法。而眼疾运用尤多。《本经》言大黄：“下淤血，血闭，寒热，破瘕瘕积聚”，故可配入方中用之。代表方可选《审视瑶函》归芍红花散，方取当归、赤芍、红花、大黄活血化淤；白芷、连翘、防风轻扬上浮，辛香透窍（张锡纯云：连翘可“流通气血，治十二经血凝气聚，……凡头痛、目痛、齿痛、鼻渊，……皆能主之”）；梔、芩、生地泄头面火热以畅血运，甘草和胃调中。虽原为治目疾专方，但若略予损益，亦可治上述耳、鼻、喉之疾患。它如张子和玉烛散（四物汤与调胃承气汤相合）、吴塘桃仁承气汤（桃、归、硝、黄、丹皮、芍药）、《银海精微》破血红花散（芷、升、蒲、翹、连、梔、芎、归、枳、芪、赤芍、苏叶、红花、大黄）等，亦可随症选用。若淤滞与热毒相合，蕴久化脓，可选《金鉴》神授卫生汤（银、翹、羌、防、归、芷、生草、花粉、石膏、沉香、乳香、炮甲、皂刺、红花、大黄）化淤排脓；如系外伤致淤导致五官诸疾，《医学发明》复元活血汤（柴、归、桃、红、花粉、生草、炮甲、大黄）又具显效了。

王女 42岁 工人 初诊日期：1987年6月20日

壹月前因公致左眼穿孔伤，虹膜脱出，急于手术，出院时诊为左眼穿孔伤，玻璃体积血，外伤性虹膜炎，左眼视力0.09，右眼视力1.2，继续注射安络血，但因注射处硬结疼痛，遂延余诊治。刻诊：左眼球突出，眼睑微肿，眼眶周围色黯，瞳孔药物性散大，近6、7、8点处虹膜缺损，球结膜偏鼻下方充血，指测眼压比右眼偏高，自觉左眼胀痛，牵及眼眶，畏光，眼前有一长条大片黑影，边缘色鲜红，内热口干，夜不能寐，心悸烦躁，便干溲黄，舌红

有瘀斑，苔薄黄，脉弦滑。此乃外伤损目，引动肝火，急予活血散瘀，平肝明目，归芍红花散出入：归尾、红花、焦栀各 7 克，茜草、僵蚕、钩藤、郁金、连翘、赤白芍、酒大黄各 10 克，生地、仙鹤草、茺蔚子、石决明各 15 克，煎汁送服参三七粉 3 克。连服二十余剂，玻璃体积血全部吸收，但稍有混浊，黄斑反光有而较弱，原方出入续服近一月，复查，左眼视力 0.6。

按：患者外伤大出血，虽经西医止住，但仍有小量出血，停积致瘀，故在用大黄等活血散瘀方药治本的同时，参以清镇平肝，防继续出血，伍少量凉血养血药，以助收“瘀去则新生”之功效。若纯用炭剂或收敛止血，必有寒湿太过，血虽止而瘀不化之害。《本草切要》曰：“至若跌扑损伤，血有所瘀……加酒炒大黄”，且患者体壮发病急，故用酒制大黄 10 克同煎，终获佳效。

四、凉血止血

若温热时邪或脏腑之内热过甚，常灼伤阳络，迫血上溢，引起目、耳、鼻的衄血，部分喉菌（喉癌）晚期，亦可因嗜酒或过食炙烤辛辣之物出血，另骨类异物梗于咽喉导致的外伤，也可出血。它如急性会厌炎、急性喉炎、溃疡性喉炎、喉结核，有时见少量出血或痰中带血。对血上溢之症，仲景早在《金匱》泻心汤中，即创大黄与连、芩相合，用治心阴不足，心阳独亢的吐、衄血。近贤唐容川强调，此方“得力大黄一味，逆折而下，兼破瘀逐陈，使之不留患。此味今人多不敢用，不知气逆血升，得此猛烈之药，以损阳和阴，真圣药也”。[注 2]张锡纯亦云“其性能降胃热，并能引胃气下行，故善止吐衄”，他将大黄炒与赭石、肉桂相配，创秘红丹用于肝旺吐衄。故古今名贤将其配入凉血止血方中的颇多。然五官科所用含大黄的凉血止血方，以元代葛可久十灰散为最常用，该方由一派凉血止血药组成，且价廉易得，并有成药应世。方中之大黄不仅可以直接凉血，且可引热下行，加强它药止血效

果。如火热出血甚者,可用清瘟败毒饮加大黄。

刘男 20岁 学生 初诊日期:1987年9月7日

每年秋季,即经常鼻衄,已二、三载,曾被认为鼻前庭糜烂。昨日中午起突然左鼻出血,量多如涌,某院急予鼻后孔填塞,且口服及注射止血剂,但血虽减却未止,并从后鼻道流入口腔,遂来我处求治。刻诊:面部潮红,发热($T38.3^{\circ}\text{C}$),眩晕,口干欲饮,纳少溲黄,四日未更衣,舌红苔黄,脉滑数。鼻检见左鼻塞之纱布被血染透,右鼻腔粘膜充血,有黄脓涕潴留。此显系肺胃之火循经上犯,急予十灰散加减,以清热泻火,宁络凉血:茜草炭、炒丹皮、焦栀、侧柏炭、大黄炭(后下)各10克,生石膏、金银花各20克,煅赭石、鲜茅根、仙鹤草各30克。另以生大黄、青黛、马勃各5克煎水,待冷,浸药棉塞鼻,稍干即换,勿使粘于鼻内。药仅二帖,大便通,血渐止, $T37.5^{\circ}\text{C}$ 。续服两帖,遂血止热清。但鼻腔干燥,且出热气,去栀、茜、大黄、侧柏、赭石,加玄参、花粉、生草、白芍、枳壳各10克,三剂以善后。

按:本证乃秋燥引动肺胃积热,今贤任应秋赞大黄:“为凉血之神品”[注3],故用大黄炒炭,收凉血止血之功。但惟恐药力之不逮,更用大黄等煎汁湿敷创面,直接作用于局部,以有助于血凝,内外合治,数天即痊也。考大黄外用之法颇多,除外洗、湿敷(浸)外,还可研擦局部(如《金鉴》颠倒散以大黄、硫磺等分擦酒渣鼻),亦可含化(如《喉科秘集》八仙散:以大黄与石膏、玄参、黄芩、僵蚕、西瓜霜、轻粉、玄明粉、人中白研末,蜜锭,舌津化下)。它如作外撒粉剂、滴剂、吹药,或作膏药外敷,以直接作用于局部,而收速效,全在医家匠心活用也。

注1:缪正来《章次公的学术经验及其医案》(《新中医》(4) 13. 1981)

注2:转引自江苏中医学校编著的《金匱释义》,191页,江苏

人民出版社,1958年5月第一版

注3:任应秋编著《中医各家学说》(大学教材),388页,上海科技出版社,1980年8月第一版。

(田爱华、马继松。首届国际大黄学术研讨会学术论文)。

九 健脾益气法治五官科病拾零

李东垣在《脾胃论·脾胃虚则九窍不通论》中云:“脾胃既为阴火所乘,即清气不升,九窍为之不利。”欲使九窍得利,当予升清,而升清必赖脾健。故在五官科疾病治疗中,健脾益气法有着广泛的应用价值。现将笔者临床运用该法的点滴体会报导如下。

一、视瞻昏渺(中心性视网膜脉络膜炎)

董某某,男,40岁,司机,1983年11月3日初诊。

近因情怀抑郁,初感左目干涩,视物模糊,易疲劳。渐感左眼前方中央似有黑云遮住,视人视物变小,中间欠清。头晕,行走似踩棉团。经某院诊为中心性视网膜脉络膜炎。曾用维生素B₁、维生素B₁₂、地塞米松,六味地黄汤治疗,月余未愈。初诊还伴胸闷、口粘、腹胀、梦多,苔白,脉弦滑。眼检:视力右1.2,左0.6,右眼眼底无明显病变,左眼底黄斑部水肿,中心窝反射消失,并见黄白色渗出物。辨为肝郁气滞,目失所荣,治拟养肝解郁明目:生地15克、防己10克、川芎7克、生白芍10克、白蒺藜12克、当归10克、朱茯苓15克、羌蔚子12克、葛根7克、杞子10克、黄芩10克、石决明15克、柴胡5克。柴帖。

复诊:腹胀加甚,便溏日2-3行,纳呆,时欲咯痰,苔转白腻

水滑。前药无效,经重新审证,断为木郁土虚挟痰浊为害,改拟健脾升清,疏肝化痰法:炙黄芪 15 克、党参 15 克、肉桂 5 克、柴胡 3 克、茯苓 25 克、白术芍各 10 克、白蒺藜 15 克、川芎 6 克、羌蔚子 15 克、密蒙花 10 克、杞子 10 克、陈皮 10 克、葛根 7 克。连服十五帖,左眼中心黑影消失,视物大小渐和右眼相等。检查:中心反射渐现但较弱,渗出物基本吸收。

按:本患者初诊投养肝解郁,非但无效,反致便溏,显系药不对症。考《丹溪心法》云:“头眩,痰挟气虚并火,治痰为主,挟补气药及降火药。”程钟龄在《医学心悟》中亦曰:“有气虚挟痰者,书曰清阳不升,浊阴不降,则上重下轻也,六君子汤主之。”复诊宗此立法,以黄芪合五味异功散益气健脾化湿,柴、芍、芎、羌舒肝通络明目,葛根合柴、芎升腾脾胃清阳之气,独用一味辛热之肉桂,温养鼓动血脉以濡目窍,诸药相合,使脾健清升,阴凝散,浊气降,目自明矣!

二、耳鸣(慢性化脓性中耳炎)

王某某,男,46 岁,技术员,1982 年 4 月 25 日初诊。

四年前右耳曾患急性中耳炎,因治不及时,转为慢性化脓性中耳炎,耳内常潮湿,多方寻治未效,听力渐降。近半年来,右耳日夜响鸣,日甚一日,且右侧头面微麻,头晕恶心,烦躁多梦,苔白,脉弦细。检查:鼓膜混浊,耳内有淡黄水。此久病脾肾并虚,气血不足,拟健脾补肾,益气升清:党参 15 克、苍术 7 克、生白芍 12 克、茯神 20 克、泽泻 15 克、白芷 10 克、升麻 7 克、黄芪 20 克、黄柏 10 克、山药 30 克、京菖蒲 7 克、熟地 25 克、磁石 30 克、葛根 12 克、蔓荆子 10 克。柒帖。

复诊:诸证渐缓,去苍术加细辛 3 克,又连服二十帖,耳鸣消失。

按:耳鸣一症,有虚有实,实证多责之为肝胆气火上逆,如

《素问·六元正纪大论》曰：“木郁之发，甚则耳鸣旋转。”然气虚精伤者，临证亦不罕见。正如《灵枢·口问篇》云：“上气不足，脑为之不满，耳为之苦鸣，头为之苦倾，目为之眩。”《医学纲目》更云：“脾胃一虚，耳目九窍皆病。”本例据症辨为脾之精气失升，不能奉养耳窍，故予东垣益气聪明汤加苍术健脾升清，合验方耳聋左慈丸填精补肾以顾本，佐以白芷、菖蒲、细辛等芳香辛通以启耳窍，并引诸药直达病所（《药性赋》言菖蒲可“治耳鸣”；李杲曰白芷：“其气芳香，能通九窍”；《纲目》论细辛：“辛能润燥，故通少阴及耳窍”），故取效颇捷。

三、鼻鼽（过敏性鼻炎）

陈某某，女，19岁，服务员，1982年4月初诊。

自前年冬季起即经常感冒，鼻塞且痒，清涕不断，时轻时重，难辨香臭，纳呆头昏。其工作地点系人防工事所设旅馆，冬季温暖湿润，下班来地面即鼻塞喷嚏，流清涕。西医诊为过敏性鼻炎，用一般滴鼻剂及抗过敏药疗效不佳。观其面黄消瘦，舌淡苔白，脉细弱。检查鼻粘膜淡红水肿，鼻腔内有清涕潴留。此乃肺脾气虚，拟益气健脾，温肺散寒：党参15克、黄芪20克、生白芍10克、细辛3克、辛夷花12克、苍耳子15克、藿香10克、白芷10克、升麻7克、川芎10克、桔梗10克。伍帖。

复诊：药后诸症皆减，因煎剂不便，故以七帖药量加鱼脑石75克共研末，蜜丸缓图，两年多来，未见大发。

按：过敏性鼻炎，祖国医学称为鼻鼽。《素问玄机原病式》曰：“鼽者，鼻出清涕也。”考其病因，叶桂云：“……其有精气不足，脑髓不固，淋下无腥秽之涕者，此劳怯根萌，以天真丸主之。”然天真丸旨在以羊肉、苁蓉、当归、山药、天冬填补肾精，药偏滋腻，更碍食欲。故守补法而易入补气之方，取芪、术、参峻补脾肺之气以治本，合济生辛夷散（辛夷、细辛、升麻、川芎、白芷、羌活、

防风、藁本、木通、炙草)损益,升清通窍以顾标,使脾之清阳之气上达奉肺,而终获“肺和则鼻能知香臭矣”之效。

四、喉痹(慢性咽炎)

李某某,男,24岁,学生,1984年元月6日初诊。

经常咽喉不适,如有物堵,吞咽时稍有疼痛,冬季尤甚。痰多清稀,肢冷神疲,便溏日2-3行,舌淡胖,苔白。检查:咽喉呈慢性充血,后壁有少许滤泡。此乃脾虚失运,湿痰留于喉间而成喉痹,拟健脾升清,化痰利咽:黄芪15克、党参15克、肉桂5克、酒连3克、半夏10克、云苓15克、白术10克、陈皮10克、桔梗10克、粉草10克、柴胡3克、黄精10克、僵蚕10克。伍帖。

复诊:药后咽痛觉堵减轻,原方续进五帖而愈。

按:喉痹与现代医学的咽炎颇类似,责其病因,有实有虚。然虚证多偏于阴虚,而言阳气虚者甚少,惟近贤湖南治喉名家言庚孚在其《医疗经验集》中云:“平素体虚,多言伤气,肺气津液两伤,咽喉失于滋润,故咽喉干燥不适”。倡用四君子汤加黄芪、山药、黄精、石斛、玉竹等补气生津药,治此类气虚喉痹。而对肾阳素馁或过服寒凉,戕损肾阳之阳虚喉痹,主用肾气丸。该患者显系脾之气阳双虚,故遵言老之论,用六君合黄精、肉桂以健脾益气升阳;参入桔梗、柴胡载药上浮以达病所。稍用黄连,一可消炎以治慢性充血;更可反佐,以监肉桂温燥之性,赆助诸药,共收其效。

结 语

五官科疾病因于脾肺气虚所致者,临床并不罕见,但施治时必须在补气的时候,配以柴胡、升麻、葛根等升清之品,清升则浊降,邪自祛矣!另一定要辨证与辨病相结合,即在用补益升清大法治其本的同时,当根据病位的不同,参与治局部症状的引经之品,诸如本文中眼病用茺蔚子、密蒙花;耳病之用磁石、菖蒲;鼻

病之用辛夷、白芷；喉病之用桔梗、僵蚕等以顾其标，才能收较满意之效。一得之见，仅供酌参。

（田爱华、马继松。原载于《皖南医学院学报》1986年第6期）。

十 “上病下取”治则在眼科的应用心得

“上病下取”是指病症的表现、部位偏于上，而却用药物、针灸等从主症所在部位以下的脏腑或体表去进行治疗的方法，此系基于中医整体观而确立的一种治疗法则。眼科前贤根据《灵枢·大惑论》：“目者，五脏六腑之精也，营卫魂魄之所常营也，神气之所生也。”之理，创五轮学说，将目之五轮分属五脏，认为“轮为标，脏为本”，轮之有病，实由脏之不平所致。部分目病之发生，与相应的下焦脏腑的病变有极大的关系。因此，位于人体上部的目疾，常用通过治理与之内应的下焦脏腑而获良效。今结合自己临证心得，将该法则在眼科临床上的应用，分述如下：

一、釜底抽薪法

前贤曰：“目不因火则不病”，故多种眼科专著均创立了较多的清热泻火剂，然火有肝火、肺火、心火、肠胃火的不同，故治法各异。若肠胃之热与食滞、痰瘀等相结合而成肠中燥实之证，运用泻下之剂通腑导滞，使食滞、痰瘀所化的火邪热毒下行而不逆上犯目，则可收“上病下取”之效。这种“釜底抽薪”法在眼科运用极广，可主治热盛毒深之角膜溃疡、角膜炎、巩膜炎、急性结膜炎、急性泪囊炎、麦粒肿、前房积脓、急性传染病之双目失明、因血热上冲引起的眼内外出血等多种目疾同时又伴大便燥结，苔

厚脉滑实者。常用方剂多为苦寒、咸寒组成的三承气汤之类,若系寒实结滞,亦可予温下法。

案例:王某,男,65岁,干部。1985年2月初诊。双目患病毒性角膜炎、慢性结膜炎已年余。虽经滴可的松、利福平等眼药水,亦常复发。有习惯性便秘史。此次发病已3日,双目红赤、磨痛、怕光,泪多且粘,视物模糊,口干心烦,四、五日未更衣,舌红苔根黄腻,脉弦滑。检查:双眼睑微红肿,球结膜充血(++),角膜呈弥漫性点状着色。证属肠胃腑热素盛,予通腑泄热。处方:生大黄(后下)、黑山栀、炒枳实、丹皮、连翘各10克,生地、决明子、苦杏仁各15克,银花20克。服药仅1剂,红赤磨痛即随大便畅解而减轻。续服2剂,眼目红赤基本消退,诸症皆缓。前方改用熟大黄5克,合入菊花、白芍、白蒺藜各10克,以7剂量研末蜜丸,服完遂愈。随访3年,未见大发。

二、疏利水道法

若湿热蕴结,使气化失常,则水液潴留,可致湿浊上泛于目。举凡急慢性结膜炎、白睛溢血、眼睑湿疹、睑缘炎、早期青光眼、早期视网膜震荡(视网膜有水肿者)、眼睑下垂、湿浊上泛之中心性浆液性视网膜病变黄斑区水肿期等目疾,若伴有头重目黄、足胫浮肿、小溲淋浊等全身症状时,用疏利水道法最为贴切。常用药方为五苓散、四苓散、三仁汤、八正散、甘露消毒丹等,还可略辅轻扬升散、宣化外湿之品,如羌活、防风等。

案例:陈某,男,51岁,工人。1985年1月初诊。右眼视力下降已3个多月,初起眼胀痛,渐模糊,视力减退,饮食尚可,夜寐困难。西医予VB₁、VB₁₂、VC、强的松、肌苷、TTFD等鲜效。市一院检查:视力右0.2,左1.0。双眼球结膜充血(++),角膜(-),屈光(-)。右眼黄斑部水肿约(1D),可见水肿渗出,中央及其周围可见点状渗出,深层有陈旧性出血,中心反射(-)。舌

淡、苔白膩水滑。证系脾虚失运，水浊上泛。予五苓散化裁：苍术 7 克、葛根、泽泻、菊花、白芍、木贼草各 10 克，石决明（先煎）、山药、白蒺藜、茯苓、黄芪各 15 克，肉桂 3 克，连服 10 剂。眼目红赤渐退，中心黑影缩小。然纳谷欠馨，原方去石决明、白蒺藜，加姜半夏、路路通各 10 克，川芎、砂仁各 5 克，续服 10 剂，中心黑影渐淡，苔膩渐化，纳谷复常，但视物仍模糊。原方再续服 10 剂，双眼视力均达 1.0。

三、清泄肝胆法

《内经》曰：“肝开窍于目”，而胆与肝互为表里，眼的神膏，神光均与胆有关，故眼病与肝胆之关系较其它脏腑尤为密切。肝胆火炽或湿热内蕴上犯清窍，均可导致实证目疾，发生角膜溃疡、虹膜睫状体炎、急性充血性青光眼、眼睑湿疹、急性视神经炎等病。临床多见有目胀头痛、白睛红赤、眉棱骨痛、黑睛生翳、瞳神散大、眼内出血等症状。此类病由于发病快、来势猛、变化多，故历代名贤喜以龙胆泻肝汤苦寒直折，引肝胆湿火由二便而去，无使其上犯清窍。另刘河间当归龙荟丸、钱仲阳泻青丸亦可选用。只是此类方过于苦寒，故中病即止，防伤中败胃。明代傅仁宇所创四顺清凉饮子（龙胆草、黄连、黄芩、熟大黄、车前子、炙桑皮、枳壳、生地、赤芍、归身、川芎、柴胡、羌活、防风、木贼草、炙甘草），将清泄肝胆湿热与养血柔肝、明目理气之品相合，临证尤有实用价值，故余以该方损益，治此类病证每获佳效。

案例：陶某，男，33 岁，工人。左眼患青光眼，曾因急性发作而行两次手术，近又复胀痛。检查左眼角膜 10-1 点处有一斑翳，瞳孔呈梨状，眼压 28，因不愿再行手术，故改服中药。考虑其左眼磨胀疼痛怕光，痰多便燥，舌红苔灰黑，故诊为肝胆湿热挟痰火上扰清窍。拟四顺清凉饮子加减：柴胡、黑山栀、龙胆草、川芎各 6 克，黄芩、密蒙花、木贼草、炙桑皮、天竺黄各 10 克，石

决明、赤白芍各 15 克,生地 20 克。5 剂药后,大便稍稀,痰仍多,午后目胀,苔黄腻,脉弦滑。原方加车前子、泽泻各 10 克,续服 10 剂,目胀痰多皆减,以原方 7 剂量为蜜丸,以巩固之。

四、降逆通经法

妇女行经之际,因肝气怫郁,血热内蕴,常使经血不循常道,反逆上犯目,致发生经行目痛,满目赤涩,或血灌瞳神,称为“逆经赤肿”,亦名“女子逆经赤涩”,分血热气滞和瘀阻气滞两型。前者多见目珠肿痛,重坠干涩,不耐久视,甚则视物昏朦,胞睑浮肿,白睛赤涩,或有溢血如胭脂色,重者则血灌瞳神及眼底出血。治宜清热活血,引血下行,可用《银海精微》调经散(由四物汤合黄连、黄芩、大黄、山栀、羌活、薄荷、甘草、香附、红花、苏木、木贼草组成)。笔者则尤喜用近贤陆南山《眼科临证录》中的清热凉血祛瘀汤(丹参、丹皮、赤芍、生地、焦山栀、连翘、黄芩、蒲公英、决明子)加枳壳、降香;而瘀阻气滞型因伴有明显的经行腹痛,故宜行气逐瘀,可用王清任血府逐瘀汤去桔梗施治。另《银海精微》载顺经汤(归尾、川芎、赤芍、玄胡、红花、肉桂、香附、枳壳、小茴、杏仁、柴胡、青陈皮),言该方“通经行血止痛,治女子逆经,上注于目,灌于睛外,满眼赤涩,或乌睛上起如胬肉”,故亦可参用之。

案例:陈某,女,36 岁,工人。月经常两月一行,量少色黑。此次又停经达 70 日,腰酸少腹胀,两目红赤干涩,视物模糊,晨起眼眵干结,口干,便难,舌淡紫,苔白,脉细弦涩。西医诊为慢性结膜炎,祖国医学则责之血热内结,瘀火循肝经逆上犯目。予清热凉血祛瘀汤加减:生地 20 克,赤白芍、决明子、菊花各 15 克,当归、丹皮、丹参、枳壳、焦山栀各 10 克,桃仁、降香各 7 克,桂枝 3 克。服药 3 剂,经通,然量少色黑,两目红赤稍退,似觉干涩不舒,眼眵仍多,苔薄白,脉细。去桂枝、桃仁,加五灵脂、香附

各10g。又3剂,经行较畅,双眼红赤退,干涩除。后以归芍地黄汤去山药、泽泻,配入丹参、焦山栀、菊花、枳壳、决明子、白蒺藜等,连服10剂而痊愈。

五、补益肾元法

肾藏精,精生髓,脑为髓海,肾主水轮,目系上属于脑。肾精充沛,髓海丰满,则目光敏锐,而“肾虚则目眈眈无所见矣”,故对慢性内障眼病虚证之治疗,历代名贤均以补益肾元为要。然肾乃水火之脏,对肾元的补益则又有温补肾阳与滋补肾阴之别。肾阳虚者,由于火不生土,往往兼有脾之气阳不足,可见冷泪长流,目力渐昏,视物变形、变色,瞳神变白,或眼前有闪光幻觉,自觉有黑幕从某方向遮隔等症,而导致上睑下垂、远视、泪溢、白内障、视网膜剥离、视网膜色素变性、中心性视网膜炎等病,主以温扶命门之阳,参以益土,以肾气丸、右归丸损益。

案例:汪某,女,48岁,教员。右眼白内障手术后已3个月,虽配戴眼镜,但仍感视物模糊,易于疲劳。检查:右外眼(-),视力0.1;左外眼(-),视力0.6,小瞳下晶体可见混浊。患者素有胃病,受寒则痛,呕吐清水,面浮眇白,畏寒腰酸,便溏,带下清稀,舌淡苔白,脉沉细。证属阳虚不能蒸化精血上奉眼目。处方:干姜、桂心各5克,熟附片7克,杜仲、枸杞子、菟丝子、葫芦巴、白术、芡实各10克,怀牛膝、党参各15克,茯苓、苡米各30克。服药5剂后,腰酸、呕吐渐缓,白带、大便亦趋正常,惟视物仍不清楚,舌脉依旧,原方续进10剂。三诊时视物稍清,因病属慢性,故改丸缓图。原方10剂,水泛丸。服近两月,右眼视力0.3,左眼0.7。

由于精血同源,故肾阴虚者,常伴肝血不足,可见近视,远视,眼目干涩,视物昏花;或入暮无所见;或黑睛生星点翳障,隐伏不显;或白睛赤脉稀疏而淡;或瞳神渐渐缩小,甚则干缺;或眼

外观尚好,但自感眼前有蚊蝇飞舞;或有云雾样黑影飘移,以致视力缓慢下降终至目盲。以上诸症,可分见于病毒性角膜炎、慢性结膜炎、虹膜睫状体炎、白内障、慢性视神经炎、视神经萎缩、玻璃体混浊等病中。临证多予杞菊地黄丸、一贯煎等以双补肝肾精血。若阴虚火炎者,又当以龟板、知母、黄柏等潜阳泻火。

案例:孙某,男,10岁,1985年5月初诊。患者有双眼先天性晶体半脱位,近视病史。后因眼部受轻度外伤致右眼视网膜剥离,经手术治疗仍视力极差,复查为继发性视神经萎缩。右眼视力0.01,左眼0.1。神疲纳呆,舌淡红苔薄,脉细弱。良由先天不足,阴血双戕,拟补益肝肾。处方:生地、山萸肉、枸杞子、女贞子、密蒙花、丹皮、丹参、制首乌各10克,当归、山药、熟苡仁各15克,夜明砂7克,服药15剂后,未觉不良反应,加菊花7克,以15剂量,研末制蜜丸,服药近一年,复查右眼视力0.2,左眼0.3。

在一些慢性内障眼病中,还可见到阴阳并虚者,余临证每喜以《冯氏锦囊秘录》的全真一气汤化裁。该方以麦冬、附子、人参、熟地分别滋阴、扶阳、补气、益血,用白术奠安中州,五味子补气酸收以敛真元,取类比象而专益瞳仁,牛膝引诸药下行入肝肾,共收“上病下取”之效,为内障慢性眼病之要剂。

(田爱华。原载于《中国医药学报》1989年第4期)。

十一 理气法在眼科的应用举隅

理气法亦为眼科常用治法之一,在已故著名眼科专家韦文贵的《眼科临床经验选》中,自拟经验方57首,45首用了理气

药,笔者受其启迪,治眼病亦喜用辛散流动之品。具体应用简介如下:

一、清热理气

张子和说:“目不因火则不病,”故目疾热证居多,如胞睑疔肿、巩膜炎、角膜炎、角膜溃疡、青光眼、眼内外各部出血、急性虹膜睫状体炎等,多因火热毒邪壅遏脉络,使气血运行失畅而致病。虽均需清热解毒以治本,然若配以适量理气药,以助清解之品疏散郁火,推动血运气行,可更好地发挥药效。亦可防清解药寒凉太过,戕伤脾胃,且能促进疮肿的消散吸收。笔者常宗韦老之旨,选川芎、防风等配入方中,

黄男,50岁,1988年4月16日初诊。

二十余日前患面瘫,针灸治疗十日,继发左头额部带状疱疹,经治已结痂,然四天前左眼复患病毒性角膜炎,西医于球结膜下注射干扰素,但仍感眼胀,且视力急剧下降,故来我科。检查:左眼角膜中央混浊,Fe+,睫状充血(+),怕光,视力左眼仅眼前指数。舌红苔黄薄,脉弦滑。BP:160/100mmHg。询其口干欲饮冷,烦躁寐难,便干溲黄,头额胀跳时痛。乃知系肝火为风热诱导而上犯作乱也,急予清热理气平肝:银花30克,石决明20克(打、先煎),赤白芍、大青各15克,黄芩、焦栀、郁金、川楝子、青箱子各10克,川芎、防风、蝉蜕、龙胆草各7克。药服5剂,眼胀颇减,它症亦缓,但视力未明显提高,眼前黑点飘浮。上方去蝉蜕,加白蒺藜15克,又5剂,视力稍增。BP:145/95-mmHg。在二诊方基础上出入又复诊四次,共服药30帖,视力渐至正常,仅留黄豆大云翳。

二、降气导滞

胃肠中的实热积滞,可影响气机升降而致目疾,因热积于下,火炎于上,而发生角膜炎、角膜溃疡、巩膜炎、急性结膜炎、麦

粒肿等病。可用导滞通下之品,将胃肠中的痰、食、瘀、浊等邪驱出,冀收“上病下取”之效。然欲达通导之目的,必赖气之推行,故当参入行气、降气,甚至破气之品,方可收殊功。有时亦可参入少量升提气机之味,如加用防风、桔梗、白蒺藜等,既可引领诸药直达病所,又起到“欲降先升”之效。笔者临证喜用承气汤,若体虚者,常以桃仁、杏仁、路路通、莱菔子易硝、黄以理气缓下。若为寒实积滞,多取五磨饮子消积降逆,然槟榔须重用 15~30 克,并伍以等量的杏仁,方见显效。

邹男,48 岁,1986 年 10 月 4 日初诊。

三天前不慎在电焊时将铁屑溅入左眼,觉畏光、流泪、疼痛。遂自点眼膏,症却未减,始去医院,被施以角膜异物剔除法,除去嵌于黑睛浅层之铁屑,畏光流泪遂稍缓,但仍眼痛难睁,故求我诊治。检查:左眼睫状充血(++),角膜近 7 点钟处有一 2×3mm 圆形溃疡,周围呈灰白色浸润,表面有少许黄白色分泌物。患者嗜酒能啖,甘肥迭进,口中干苦,脘腹满胀,便少不畅,舌偏红,苔黄白浊厚,脉弦滑。遂断为黑睛外伤后复感风热毒邪与肠胃食滞纠结作祟,不通则痛矣。予降气导滞佐疏风活血,三化汤扩充:银花 20 克,生地、赤芍各 15 克,生军(后下)、枳实、焦栀、黄芩、谷精珠各 10 克,羌活、厚朴、生草、龙胆草各 7 克。3 剂后随矢气频转,二便畅行,疼乃大定,畏光流泪显减,但溃疡未愈合。去生军、厚朴、枳实、胆草,易入生白芍、白芨各 15 克,槟榔、杏仁、香附各 10 克,蝉蜕、蛇蜕各 5 克,又 5 剂溃疡渐敛。略予增损,则基本复旧而停药。

三、理气化湿

湿邪重浊粘滞,可寒化亦可热化,可聚为饮或凝为痰,致成多种眼疾,如中心性浆液性视网膜脉络膜黄斑区水肿、渗出,早期青光眼、眼眶湿疹、眼睑浮肿或下垂等。李用粹说:“湿乃津液

之属,随气化而出者也,”故当理气与化湿双管齐下。若发病短暂,可予藿香正气或三仁汤以芳香理气化湿;若病久脾虚,当予香砂六君健脾理气化湿;若偏寒湿甚应投实脾饮温阳理气化湿;若湿热偏甚,用四苓散合桑白皮、大腹皮、泽兰、木香、郁金、川楝子、路路通等;若痒甚者皆兼风邪,常选白芷、荆芥、白蒺藜祛风理气合化湿药共投。

金女,40岁,1988年1月19日初诊。

陈旧性中心性视网膜炎近又复发,中心暗影出现,眼前淡灰色变色,且有水汪汪感觉。左眼胀连及眼眶,神疲纳呆,白带绵绵,瘦少腿肿,舌略胖大有齿印,苔白黄腻,脉弦滑。检查:左眼外眼(一),瞳孔比右侧略大,反应稍迟钝,指测眼压T+1。小瞳眼底:黄斑部水肿渗出,伴有少许出血点。远视力测定:左眼0.2,右眼0.8。此显系脾虚木旺,湿浊弥漫三焦也。投运脾平肝,理气化湿:茯苓、苡米各30克,石决明(打先下)、白蒺藜、泽兰泻、香附、丹参、葛根、钩藤、大腹皮、党参各15克,路路通、白芷、白术芍各10克。10帖后诸症皆减,效方出入月余,基本痊愈。

四、行气祛瘀

因各种原因造成的眼脉络瘀滞,若停留时间较久,不但消散不易,且严重影响视力,故应速祛为要。然气为血帅,气行则血行,故行气与祛瘀必并投之。诸凡各种出血性眼病的静止期或尚有小出血,及眼底血管发生阻塞、痉挛、充血或视网膜发生渗出、水肿等病理性改变时,可予王清任通窍活血汤或血府逐瘀汤。此时选用的理气药必须辛香走窜,使其与活血药相伍,能扩张脉络,开塞导闭,促进瘀血的消散吸收,以细辛、白芷、羌活、防风为好,至于川芎、当归、郁金、香附、活血行气,功擅两职,尤为大妙。

梁女,53岁,1987年5月9日初诊。

壹月前跌仆致头右侧现鸡蛋大小血肿,自用酒精按摩后肿痛稍消,复感牙龈、咽喉疼痛,自服黄连上清片而除。但十天前右眼又红赤磨痛,畏光难睁,视物模糊,连及眼眶、头额亦胀痛。在他院注射青霉素一周未见显效,转来我处。检查:右眼球结膜高度充血,畏光,眼睑痉挛,视力0.1,舌红苔薄黄,脉细滑。此乃外伤脉络运行欠畅而瘀滞使然,拟理气活血明目:赤白芍、茜草各20克,白蒺藜、香附各15克,当归、僵蚕、菊花、焦栀各10克,荆芥、川芎、柴胡、龙胆草各7克,茅根30克。5月14日复诊:右眼红赤渐退,已能睁开,磨痛及头痛均减,但右颈部肿痛,视物仍糊,原方加郁金10克。5月26日三诊:眼红赤全消,它症递减,惟视力未明显进步,去荆芥、胆草,加杞子10克,生地20克。5帖后视力渐佳,又10帖蜜丸收功。

五、补益理气

气虚之人所患眼病,若单纯补气,既有中壅之弊,且使气虚所伴生的痰、瘀更难速化,故当配入适量理气药。然叶天士曾云:“诸香皆泄气。”故虚证眼病用理气药时,量不宜大,且忌久服,并当慎用气雄味烈、辛散太过的白芷、羌活、细辛等品,以香元皮、佛手柑、枳壳、诸花为妥。

卢男,19岁,1988年8月29日初诊。

右眼视网膜脱离已手术,现视力仍为光感,经电生理测定,视N传导功能障碍,视网膜功能极差。左眼视N传导功能正常,而视网膜功能也差。舌红苔薄黄。虽无明显其它虚象,但仍宜峻补气血,配以行气通络,以修复营养视网膜,改善其功能:生黄芪、制首乌各30克,熟地、党参各20克,当归、杞子、赤白芍、丹参、葛根、香元皮各15克,密蒙花、川芎各10克,柴胡、三七各7克。上方出入近百剂,并熬药膏两料,左眼视力由0.4升为0.

6,而右眼已失明矣,现仍在继续治疗中。

(田爱华。原载于《中医杂志》1990年第6期)

十二 益肾健脾治外障

凡发生在胞睑、两眦、白睛、黑睛之眼疾,概属中医外障眼疾范畴,病发多由六淫及外伤所致,治以驱除外邪为主。然亦有因脏腑不和、气血失调等内因致疾而属虚证的,临证当知常达变,而采用补法。

考外障眼疾之虚证,虽以肝肾两虚最多,但脾肾两虚也不少见。盖因肾藏精,为先天之本,十二经脉之根,眼又称“精明”,成于先天之精,称为“真精”。肾精属阴,对眼起着濡润滋养作用。此精虚损,眼的各种功能活动和抗病能力将明显下降,遂产生一系列精微物质缺损的眼病,如眼球的干涩昏花,酸沉疲乏等。另真精化生的肾气称“真气,”对眼起温煦作用,若不足亦导致陷翳、冷泪不已等眼疾。由此可知肾虽主水轮之眼疾(即内障眼病),但外障眼病和肾亦密切相关,故益肾诚为治外障一大法则。

脾胃为后天之本,生化之源,共司升清降浊。若脾气虚馁,脾阳不运,则难以化水谷为气血濡养眼目,且反聚湿生痰,阻滞于眼络,产生因气血匮乏所致的外障眼疾,如胞睑生疮、生核、下垂不举、白睛污而不清,黑睛翳陷不退。故《脾胃论》云:“五脏六腑之精气皆禀受于脾,上贯于目。……故脾虚则五脏六腑之精气皆失所司,不能归明于目矣。”另若胃之气阴不足,亦使糟粕不能下行肠道而外泄,反化浊气逆上攻目致外障眼疾生焉!

人是一整体,脏腑通过生克制化发生千丝万缕的的联系,对

疾病产生巨大影响,眼病亦不能例外。如肾精化生的肾气可温煦脾胃(即火能生土),则使脾运强健,精血得生;若肾之气阴亏损,则因脾运失职,精血难生,目失所荣而眼疾发矣。另土可克水,故一些因脾阳不振,无力克水,致水浊逆上而致胞睑肿胀、湿疮等眼病,可运用温肾健脾、利水燥湿法,标本兼疗。故对外障眼疾按常法施治鲜效者,若能改从肾脾两脏入手,每可收柳暗花明之效。

对素禀不足,或因劳伤、老迈致脾肾皆亏,或因它病累及脾肾致亏者,在患外障眼病时,亦需益肾健脾同举。它有初虽患实热眼病,而延久热灼液耗,渐致脾肾阴虚转成各种虚性眼疾,其中亦不乏外障眼疾;还有初患实热外障眼病,因过用苦寒戕伐了脾肾阳气,转成虚寒性外障目病,则当滋养脾肾阴精或温扶脾肾阳气。

案1:王男,37岁,军人,疱疹性结膜炎。81年10月24日初诊。

主诉:眼结膜生小泡20多日未消退。

病史:双眼先后患疱疹性结膜炎,稍劳则发已年余。常用氯霉素眼水,可的松眼水,内服维C、B之类即退,然未久又发。这次右眼发作20日,未点激素眼水,改服清热活血中药,十剂却未消。且周围充血伴干涩微疼不舒,眩晕腰痛,口干纳呆,多梦疲乏,舌可,脉濡细。此显系脾肾气阴为苦寒药伤残,遂成两虚之症。予山药30克,党参20克,首乌、丹皮、杞子、楮实子、朱茯神各15克,生地、泽泻、麦冬、白术、白芍、怀膝、夏枯草各10克,炙草7克。5帖症减,但寐仍欠酣,口干纳钝,去泽、麦、首乌、加天冬10克,茅根、夜交藤各30克。又进5帖,并配维C口服,每次100mg,日3次。三诊诸恙悉平,惟脉较弱,以5克桂枝易茅根接服5帖善后。1年后随访未见复发。

按:本病多发于体弱者,故易反复。西医予维生素合激素类眼水治疗,可暂愈而难根治。若在用西药控制临床急性症状的同时,结合中医辨证论治,每可减少或控制复发。王某初服凉血消瘀药而未效,说明非纯实之疾患。笔者辨为脾肾气阴两虚致白睛血络瘀滞难消,故重用“健脾补虚,益精固肾”的山药(《本草正》)为君,配以杞子、首乌、麦冬、怀膝、楮实子助长肾之气阴以明目(《本草汇言》曰楮实子可“健脾养肾,补虚劳,明目”),又加入白芍益脾,“能于土中泻木”(《纲目》),该药合丹皮、怀膝还可消散白睛血络之瘀滞。然诸药皆入中下二焦,故独取一味“清上补下,去眼膜,止痛”(《生草药性备要》),“微辛而甘,于散结中兼有和阳之功”(《重庆堂随笔》),且轻清上浮的夏枯草载药上行,合维生素C以增强对感染的抵抗力,故获效较佳。

案2:季男,48岁,干部,病毒性角膜炎,1988年3月10日初诊。

主诉:双眼磨痛怕光,不能睁五个多月。

病史:双眼病毒性角膜炎五月余,曾注射聚肌胞、干扰素、丙球,点氯霉素、利福平、病毒唑及卡那霉素等眼水,但红赤虽消却未清,双目磨痛畏光,时轻时重。若遇感冒上症则加剧,且视物模糊。尤苦于5个月来双眼睑痉挛难睁。前日感冒,致双眼用力始睁开,看物欠清,伴口干苦,身困神疲,故求治于余。

检查:远视力左0.6,右0.7,双眼睫状充血(+). 荧光素染色阳性,双眼沙眼Ⅱ++。苔薄黄,脉濡滑。

辨证为外感风邪挟内里湿热共扰空窍。予祛风清热化湿:石决明(先煎)、板蓝根、银花、苡仁各20克,决明子、车前子、白蒺藜各15克,黄芩、丹皮、钩藤(后下)、木贼草各10克,柴胡、蝉衣各7克。10帖后双目红赤减,磨痛畏光亦轻,但视力欠清,目仍难睁,口淡乏味,纳呆体倦,且便溏日3行,舌淡胖苔白浊,脉

濡滑。系湿遏脾阳，清气不升故。改补中益气汤原方加茯苓、白芍、葛根、姜夏、白蔻、川芎、密蒙花、木贼草，配林厚省气功仪局部治疗。10帖后身轻便，双眼磨痛畏光大减，视力均提高至1.0，惟眼仍难睁。患者自行停药转他院推拿科治疗半月，症如前又便溏磨痛，且腰背酸楚，夜尿频多。综观症虽杂乱，总以肾之气阳欠振，不能助脾运化为要。改山药30克，党参、黄芪、茯苓、葛根各15克，白术、白芍、萸肉、怀牛膝、煨益智、菟丝子、木贼草各10克，密蒙花、川芎、升麻、苍术各7克，又10帖证渐瘥。以上方7帖研末，水泛丸，绿豆大，每服10克，日3次，痊愈。后观察两年，未见因感冒而诱发。

按：病毒性角膜炎多因外感风热，肝胆火炽而起，后期因灼耗肝肾阴精，使虚火上炎致黑睛翳障难退。初诊囿于湿热，忽略其病久脾肾阳虚而过用清利，反增泄泻。改用补中益气虽好转，但因未加温肾药，故仍难根治。三诊增“少火生气”之萸肉、益智、菟丝子，而获大效。然病已半载，遂遵“治慢性病当有方有守”之旨，改丸剂缓图，终收全功。

案3：陈男，10岁，浅层点状角膜炎，1995年10月3日初诊。

家人代述双眼频频眨动已年余，父母初以为顽皮而未介意，后其自诉双眼干涩不舒，视物模糊，视力下降。检查为近视伴浅层点状角膜炎。配镜矫正略提高，但仍眨眼不已，且午后视糊尤甚。幼时曾患慢肾，经治基本痊愈，却身材矮小，面黄消瘦，便艰纳呆，口干挑食，偏嗜香甜，上课注意力不集中，舌红苔薄微黄，脉细弦。诊为脾肾阴虚，无以上奉下渗。当滋调脾肾气阴，稍佐柔肝祛风。山药30克，太子参、决明子、楮实子各15克，生白术、白芍、生熟地、神曲、杏仁、青箱子各10克，枳壳，木贼草各7克。另以生黄连5克，加水20ml，蒸至10ml放冰箱，每取1ml

与鸭蛋清少许混匀,与氯霉素眼水交替点眼,日两次。5天后症渐缓,白睛仍干涩、眨动,去熟地,木贼草,加杞子、菊花、僵蚕各7克,续点前药水。又5帖症显减,与复诊方出入,10帖而痊。

按:患儿幼患肾病,肾虚于眼病之先,加之后天失调,脾阴复受戕,遂使虚阳亢,内风起,眼时眨矣!初诊仅顾护脾肾阴液,配消食平肝之品,症虽改善,而眼眨之主症未愈,故复诊参入养肝血、息内风的杞子、菊花以及最平和的虫类祛风佳品白僵蚕,效果显现。可知临证对一些仅从本治效欠佳者,如适当参入治标药,常获良效焉。

(田爱华、马璇卿。原载于《临床治疗学研究与应用集成》,胡剑北主编,中国中医药出版社,1996年9月版)

十三 从角膜炎外治引起反复试析冰片非寒

李某某,男,38岁,教师,1982年6月26日初诊。

主诉:右眼充血、涩痛、怕光、流泪、视物模糊已六个月。

病史:当年2月份起右眼开始充血,涩痛、畏光、流泪、视力急骤下降至0.03,经该地区医院诊为“右眼病毒性角膜炎,”住院后予碘酊烧灼,结膜下注射强的松,滴用环胞苷、泡疹净,散瞳,肌注胎盘球蛋白、干扰素等,并服滋肾养肝明目中药四十余剂,视力提高至0.06。然白睛红赤、疼痛、畏光依旧,且伴心悸纳呆,寐难神疲,故复来我处求治。

检查:视力左眼1.0,右眼0.06,瞳孔大,右眼角膜瞳孔上方有灰白色呈地图形的浸润区,直径约6毫米,深达实质层,荧光素染色阳性,睫状充血(+).舌淡红、苔薄黄腻,脉细弱无力。

诊断:右眼花翳白陷。辩证为气阴两虚,肝脾湿热郁蒸,上攻目窍。

治则:平肝健脾、养血明目:石决明 15 克(先下)、蝉衣 7 克、焦苍术 7 克、丹皮 10 克、焦栀 10 克、当归 10 克、杞子 10 克、山药 15 克、苡仁 30 克、川芎 6 克、桑椹子 15 克、菊花 10 克、黄芩 10 克、赤石脂 10 克(包煎)。7 帖。

二诊:服药 7 帖,纳谷渐馨,寐安神振,苔腻已化,脉仍细弱,右眼视力提高至 0.2,续步原意出入:减栀、芩、苡仁、山药、桑椹,加泽兰、生白芍各 10 克、黄芪 15 克、桂枝 5 克。考虑其在外地工作,故付药 20 帖。

三诊:药后睫状充血已减,视力上升到 0.6,荧光素染色阴性,稍有畏光,角膜实质遗有云雾状白翳,视物略模糊。因患者急望早日退翳,恢复原有视力,故除内服原方外,配用北京中医研究院韦文贵经验方犀黄散点眼。詎料第三天患眼又疼痛,白睛红赤、视物模糊、视力下降到 0.2。遂自行停用点药,仍服二诊原方 30 余付,视力又恢复至 0.6,追访三年,未有复发。

讨论:“病毒性角膜炎”属中医“聚星障”、“花翳白陷”,为外障眼病。对外障眼病,医家历来主张辅以外治,正如傅仁宇在《审视瑶函·点眼之药各有不同问答论》篇中所说:“……若内有病不服药而愈者,吾未之信也。至于外若有翳,不点不去。古云,物秽当洗,镜暗须磨,膏脂之釜,不经涤洗,焉能洁净……,至于外证有翳,单服药不点,如病初起,浮嫩不定之翳,服药亦或可退,若翳已结成,服药虽不发不长,但恐不点,翳必难除,必须内外兼治,两尽其妙,庶病可愈矣”。

犀黄散系韦氏经验方,由西月石 60 克、冰片 10 克、麝香 1 克、牛黄 1 克共研组成,有清热解毒、退赤消肿、退翳明目作用,可治砂眼、急慢性结膜炎、巩膜炎、角膜炎、角膜溃疡等。韦老主

张治角膜炎,在内服药同时配此方点眼,多收效迅速,并无禁忌和不良反应。笔者曾用于其他 3 例角膜炎患者,也未发生不良反应。考硼砂甘咸凉,《本草汇言》曰其:“去肿翳障之药也。此剂淡渗清化,”有良好的清解防腐作用,没有局部刺激。牛黄因甘苦凉,可清心化痰,故适用热毒较重之星点翳障,眼科医师常将两药与麝香(《别录》云去“目中肤翳”)配成点眼剂,虽麝香辛香走窜,然量极少不会酿成危害。故患者病情之反复,窃以为恐与冰片有关。

冰片历来为眼科外用要药,《秘传眼科龙木论》云其:“味辛苦微寒,一云温苦微毒,主明目,去目赤肤”:《海药本草》言其“主内外障眼”。在《中医眼科历代方剂汇编》中的 236 个点眼剂中,用冰片的有 92 个,为群药之冠;《全国中药成药处方集》中的 76 个眼科外用方中,73 方配冰片。然该药在眼科外治方中运用虽然极广泛,但前贤对其具体运用又有三种不同看法:如《秘传眼科龙木论》、《原机启微》、《目经大成》等书主张多用;而东垣、丹溪主张不用,《异授眼科》曰:“治眼之法,用药最难,大热则发,大寒则凝,所以冰片禁用,黄连少用。外点之药,须以消熔敛光为主”。此两说未免过偏,故明代眼科大家傅仁宇指出应限制使用,他在《审视瑶函·用片脑得效后宜少用勿用论》中云:“夫片脑寒热兼有,阴中之阳,味凉而性热,实眼科之劫药也,……故凡用片脑劫病,既退之后再复多用,则膏汁凝,而目光华弱矣。必减片脑用之方妙”。另《本草衍义补遗》亦云:“龙脑属火,世知其寒而通利,然未达其暖而轻浮飞扬。……,人身阳易于动,阴易于亏,幸思之”;《本草经疏》更明言:“眼目昏暗属肝肾虚者,不宜入点药,”皆是倡慎用冰片的代表。对冰片之药性亦颇多争议,虽云其“凉”、“微寒”者较多,但《海药本草》曰:“微温”,《本经逢源》云:“温,有毒”,而张元素直呼性“热”。故该患者用冰片或许不

符合辩证精神。

另此患者在两年前,因左眼病毒性角膜炎,经西医治疗,在临床愈合情况下,注射干扰素,曾亦有引起反复的病史。据现代眼科研究:“不赞成一切对单疱病毒性角膜炎临床愈合后强烈的退翳疗法,因为局部的刺激是一种明显的复发诱因”(见《中国眼科杂志》1982年2期《单疱病毒性角膜炎的临床病理探讨》);高校《中药学》教材亦言,冰片如“运用于局部对感觉神经的刺激很轻,而有某些止痛及温和的防腐作用”。但其对局部毕竟有轻微的刺激,此患者用冰片出现反复,是否与现代医学所说的机理有关,有待进一步探讨。总之对冰片在眼科外用中的适应症还有待进一步明确,故临床外用须在辩证的前提下审慎对待。(田爱华、马继松。原载于《贵阳中医学院学报》1988年第3期)

十四 喉暗治验四则

一、暴暗(急性咽喉炎)

例一 高某,女,44岁,1985年5月22日初诊。

素喜饮酒,1周前因饮酒较多,遂觉燥热,开电扇纳凉,翌晨咽喉疼痛难忍,口干欲饮,不易下咽。寒热咳嗽,喉间似有痰阻,但咯之不出,尤苦胸闷音嘶,经服磺胺,麦迪霉素,维生素C及六神丸等,咽痛音哑未减,遂延予治。刻诊寒热虽退而未清,声音低而嘶哑,胸中如有物堵,咳痰黄稠难出。检查:咽部充血肿胀,扁桃体红肿Ⅰ°,声带充血,舌红苔黄腻,脉滑数。此乃患者素喜辛燥甘肥致内积痰热,今猝为风寒外遏,遂郁闭肺卫,气机不利,成“金实不鸣”之证。治宜祛风宣肺,清化痰热而利咽。方

用麻杏石甘汤加味：麻黄 5 克，生石膏 20 克（先煎），板蓝根 15 克，杏仁、生甘草、浙贝母、郁金、僵蚕、蝉蜕各 10 克，木蝴蝶、荆芥、生大黄各 5 克。2 剂。

复诊：寒热清，痰咳较爽，胸闷略舒，音声渐扬，苔腻前半已化，脉转缓滑。再予原方 2 剂，诸证若失。

按：《张氏医通》曰：“盖暴暗总是寒包热邪，或本内热而后受寒”，此案亦是如此。若单清热痰则风寒难散，纯祛风寒则痰热不解。此类患者虽病之初起往往热象较重，使所感受的风寒之邪易从热化，但如用过咽喉丸，炎得平等苦寒药，又反使热伏寒凝或化燥伤阴，甚则转成久暗致延绵难愈，医者投药极宜慎之。笔者受前贤用麻杏石甘汤治疗寒包火型咳喘的启迪，用该方加浙贝母、郁金、僵蚕清化痰热，合蝉蜕、荆芥辛散外寒，治愈此型喉暗颇多。此案更取板蓝根、木蝴蝶领药入咽，佐大黄引痰火下泄，终收表里双解，音响如初之效。

例二 曾某，男 56 岁，1984 年 7 月 8 日初诊。

素有气管炎及肠炎病史。五天前被暴雨所淋，遂发寒热，服扑热息痛片，热退寒未已，穿夹衣仍不出汗。咳痰清稀，欲喜热饮，咽痒微痛，如有物堵，声哑，纳少便溏。曾服银翘散 3 剂，音哑更甚，且增泛恶头晕。诊见舌淡胖有齿印，苔白滑，脉沉细。咽后壁粘膜淡红水肿。此乃内积之寒痰与外入之湿邪互结于咽之故，治宜宣肺散寒，化饮开音。方用小青龙汤加减：细辛、干姜各 3 克，炙麻黄、桂枝各 5 克，白术、姜半夏、炙远志、杏仁、桔梗、甘草各 10 克，潞党参 15 克，茯苓 20 克。3 剂。

复诊：恶寒悉解，胸闷亦舒，口干咽痛大减，惟咳痰仍多，咳甚欲呕，音声似不扬，苔白脉细滑，仍从温化开音。原方加陈皮 10 克，木蝴蝶 5 克，续进 4 剂。

三诊：药后吐粘痰甚多，咳呕尽平，音声已扬，惟胃纳欠馨。

改香砂六君子丸善后。

按:患者素有气管炎及肠炎病史,其脾肾之阳虚已早于未病之先,内积之冷饮与暴受之寒湿相干,壅遏于声音出入之门,遂致致闭而暗也。《杂病广要·暗》曰“若暴暗声不出,咽痛异常,卒然而起,或欲咳而不能咳,或无痰,或清痰上溢,脉多弦紧,或数疾无伦,此大寒犯肾也,麻黄附子细辛汤温之,并以蜜制附子含之,慎不可轻用寒凉之剂。”笔者师其法,却改予小青龙汤,考该方原为治外寒内饮证的首选方剂,今舍白芍、五味子之敛邪助饮,益以四君子汤以健脾助阳,佐桔梗、杏仁、远志宣肺豁痰。二诊更合陈皮、木蝴蝶化痰、利气、开音,故6剂而效。

二、久暗(慢性咽喉炎)

例三 陈某,男,43岁,1983年5月7日初诊。

近因言语过多,使反复发作的暗哑又发,午后甚至完全失音。口粘,咽喉部觉有物阻,痰多胸闷,渴不欲饮,神疲汗多,舌淡红,苔白腻,脉濡滑。间接喉镜检查:会厌、喉及声带充血,会厌卷曲,声带水肿。初诊时囿于声带充血明显,而投银翘散合蝉蜕、桔梗、木蝴蝶等开音药,非但无效,反致便溏纳少。细思此证,乃因劳倦思虑伤脾,久言更耗中气,使饮食不化精微,反变生痰浊,无力排出,遂阻于咽喉,故音哑难出声也。改拟健脾益气,略佐宣肺化痰,活血利湿治之。方用补中益气汤合三仁汤加减:黄芪15克,薏苡仁、党参各30克,白术、白芍、桃仁、杏仁、姜半夏、陈皮、僵蚕各10克,厚朴、白豆蔻、升麻、牡丹皮各5克。5剂。

复诊:胸次随痰咳渐爽而渐开,口粘减,大便正常,惟声仍未出。去桃仁、牡丹皮加桔梗10克,木蝴蝶7克。连服30剂,声音恢复如未病前。虑其病久,以此方5倍量研末蜜丸,日3次,每次10克,以巩固疗效。

按：张景岳云：“音哑之病，当知虚实。实者，其病在标，因窍闭而暗也；虚者，其病在本，因内夺而暗也。”此患者病发于劳倦伤脾，多言伤气之后，初诊却反予清散，焉能有效。予补中益气汤化裁，健脾益气升清以治本。因肺主气，司声音，肺气为痰所阻，失于宣通亦致音哑，故复诊参入三仁汤宣通肺气，和胃畅中，廓清内里痰浊而顾标。然痰瘀又常互结为患，又配桃仁、僵蚕、牡丹皮散瘀化痰通络。复诊易入开音之药，并予丸药缓图，终收全功。

例四 王某，女 37 岁，1983 年 3 月 5 日初诊。

多梦失眠，头晕神疲 2 年余，近又添阵阵烦热，手足心热，汗出咽干，言语吃力，非用力提气则声难出。头发渐枯黄脱落，顶额部明显稀疏。去冬因连咳 2 月余，尔后即不能高声讲话，偶发高声则声哑，甚则失音，午后尤甚，喉间常觉闷阻，便燥，三四日一行，舌淡红，苔薄黄，脉细弱。此乃肺气不足，肾阴亏损，故当益肺气，滋肾阴，利咽喉。方用增液汤加减：北沙参、玄参、生地、黄各 30 克，麦冬 15 克，生白芍、牡丹皮、川贝母、郁金、焦栀子、当归各 10 克，五味子、黄连各 5 克。7 剂。

复诊：诸恙悉减，惟仍神疲音嘶，原方加生黄芪 15 克，木蝴蝶 5 克。10 剂。

三诊：已能较长时间讲谈，大便润，寐难，舌尖红，参入宁心安神之品：百合 30 克，朱茯神 15 克。续服 10 剂而愈。改予滋补肺肾气阴之品以善后。

按：此例显系久病肺气肾阴双馁，虚火炎上灼肺而致金破不鸣之证。《仁斋直指方》曰：“心为声音之主，肺为声音之门，肾为声音之根”，故虚证喉暗不仅责之肺气不足，且和心肾阴液之亏虚亦有极大关系。笔者宗益水清金之法，予大剂增液汤合北沙参、白芍以养肺、肾、心之阴液；五味子收敛补益肺气，合甘药而

收酸甘化阴之效。更以黄连、焦栀子、牡丹皮清心肾之火,当归养血润肠,大便通畅,则虚火随之下泄不灼肺金也。复诊加入黄芪益肺气、木蝴蝶开声音。经此治疗,久喑获愈。

结 语

喉喑可分为暴喑和久喑。暴喑多为卒受风寒、风热之邪所致,多为实证。暴喑治之失时或治不得法,可转成久喑;另高声谈唱,耗伤气阴,亦可导致久喑,此多为虚证。临床当详加诊察,根据虚实之孰轻孰重,投以扶正或祛邪为主之剂。虽前贤认为“咽喉病皆属于火”,然笔者体会,治此病不宜过投苦寒,尤其是久喑,否则必将损脾败胃或反化火伤阴。对西医诊为声带炎性水肿或声带小结所引起的喉喑,一般疗效较好,而声带肥厚所导致的喉喑,其效较差。

(田爱华。原载于《广西中医药》1987年第4期)

卷五 古今方剂应用

一 桂枝芍药知母汤运用体会

桂枝芍药知母汤出自《金匱要略·中风历节病脉证并治第五》篇中,由桂枝、芍药、知母、麻黄、白术、附子、防风、生姜、甘草组成。原方用于治“诸肢节疼痛,身体尪羸,脚肿如脱,头眩短气,温温欲吐”等证。后世医家多崇仲景之意,将其加减治疗各类痹症:如唐·孙思邈《千金方·诸风门》中偏治风痹的小续命汤;清·林佩琴《类证治裁》中偏治湿痹的薏苡仁汤;清·徐大椿《兰台轨范》中通治各类痹症的大活络丹等。另因该方有表里兼治作用,亦有将其化裁为解表温里要方,如《局方》五积散。许叔微却在《普济本事方》中将其化裁为排风汤治中风;而王旭高氏在《医书六种》中又将其化裁出桂枝黄芪鳖甲汤用治久疟;傅仁宇又在《审视瑶函》中将其化裁为补阳汤和升阳泄阴汤用治眼科视正反斜证;常用成药狗皮膏亦是用该方去生姜,以官桂易桂枝并配入76味中药熬炼制成的。由于尤在泾进一步阐述本方:“诸肢节疼痛即历节也;身体尪羸,脚肿如脱,形气不足而湿热下甚也;目眩短气,温温欲吐,湿热从下上冲矣,与脚气冲心之候颇同。……为湿热外伤肢节而复上冲心胃之治法也。”故近代中医名家曹颖甫又用本方改熟附子为生附子,治愈戴姓妇子死腹中,用药大下后,感腹中有块跳动,四肢剧疼,不可屈伸,两足如脱,腋下黄汗为时已二年的疑难杂症;^[注1]易华堂用本方治愈一青年男子远行汗出,跌入水中久之成鹤膝风(类似西医膝关节结核)。^[注2]由此可见该方临床应用颇广。现根据异病同治法将个人运用该方的治疗体会小结于后。

1、麻疹并发肺炎

朴××,男,3岁。1979年1月7日初诊。

出生后一直人工喂养,故体质瘦弱。三天前发热、咳嗽、鼻塞喷嚏,前天在大队卫生所注射青、链霉素,并给服退热片。昨日遍体大汗,热稍退,但烦躁,复去求医,遭大雨遂归。今晨小儿面色苍白,咳呛不畅,神萎气急,腹泻肢冷,身上有黯淡不红之疹点,疑为麻疹,故急来我科。察舌淡嫩、苔白干,指纹淡紫,已过命关,抚之肌肤津润而冷。化验白细胞 11800,中性 77%。听诊心音低钝,140次/分,两肺细湿罗音颇多。透视见两肺有多量云絮状阴影,知已成麻疹并发肺炎。除输液并用链霉素外,予炙麻黄 2 克,桂枝、知母、附片、五味子各 3 克,赤芍、前胡、炙草,麦冬各 5 克,云苓、山药、潞党各 10 克,姜三片。1 剂,连煎两次,灌暖瓶内,代茶频饮,留院观察。翌日咳呛渐减,肢暖汗收,疹点色转红艳,仍用西药,续与原方 1 剂。三诊:神情大振,咳泻均止,已思纳谷,听诊基本正常,减知母、附片、前胡、赤芍,加白术、白芍各 5 克,香谷芽、地骨皮各 10 克。携方 3 剂,欣喜返家。

按:患儿素体较差,复因大汗时突受雨淋,以致疹毒内陷,并发肺炎。《麻疹活人书》云:“麻疹之色,最喜通红,……故麻鲜红者,毒得尽发而去也;若麻色淡白者,乃心血不足也。”肺炎虽多为阳、热、实证,但因疹色淡白内隐,故予附、桂补心阳,配赤芍以畅血行。麻黄宣肺平喘,前胡、知母、云苓、山药、炙草止咳润肺生津。生脉散不仅可加强附、桂之作用,且正可通过大补气阴而托邪外出,且五味子又可防止麻、桂等的过散发散,故获效较快。

2、气 管 炎

马××,女,48岁,农民。1977年12月28日初诊。

患慢性支气管炎已近十年,每届冬寒必发。昨日因外出冒

风,晚间又食肥甘较多,入夜遂感咳闷不已,甚则喉间漉漉有声。观其形体胖壮,痰白稠而易出,颇畏风寒,厌饮便溏,舌淡胖,苔白腻,脉濡滑。听诊两肺湿罗音甚多,知肥人多湿多痰,故宗“病痰饮者,当以温药和之”立法:炙麻黄、附子、炙甘草各 5 克,白术、白芍、桂枝、厚朴、杏仁、姜夏、苏子、白芥子、炒卜子各 10 克,知母 3 克。5 帖症遂安,改胃苓二陈汤调理。

按:本方和仲景另一治咳喘名方小青龙汤相比,虽化痰涤饮,敛肺止咳之功稍逊,而健脾强心作用却大得多,且有扶正祛邪兼顾,开不伤气,补不滞气,正治更兼活法,颇能收动静平衡之佳效。但对辨证属肾虚痰多味咸者须合景岳金水六君煎,肾阳虚咳而兼喘者,可配鹅管石、紫石英、沉香以纳气归肾。

3、肺心病伴心衰

陈××,男,39岁,工人,1978年4月3日初诊。

七岁时因麻疹后过多游泳遂致咳喘,后每年冬春和霉雨季必发,并日益加重。半年前因气急浮肿,伴心电图改变等入院,按肺心病调治半月余缓解出院,此次因过劳复发。检查:颜面浮肿,口唇紫绀,颈静脉充盈明显,杵状指,桶状胸,呼吸 30 次/分,心率 100 次/分,心尖区和三尖瓣区均有 II 级收缩期吹风样杂音,心尖搏动在第五肋间隙乳线外侧,两下肺可闻水泡音。腹部中度膨隆,腹壁静脉怒张,肝肋下 4 指,剑下 3 指,质中,肝颈返流(+),两下肢中度凹陷性水肿。x 线透视见心影增大,心尖圆钝,肺动脉隆鼓,右上陈旧性结核。心电图检查:肺心 P 波(右房肥大),电轴右偏,重度顺钟向转位,右心室肥大伴劳损。诊为慢性肺原性心脏病而收住院,由于患者要求服中药,故请我诊治。刻诊面灰虚浮,纳呆胸闷,腹膨尿少,便溏腿肿,咳吐白泡沫痰,舌淡紫,苔白浊腻,脉沉涩,时歇止。诊为脾肾阳虚,水湿内盛,犯肺凌心。予生麻黄 7 克,附片、桂枝、赤芍、知母、炙草各

10克,生白术、防已、大腹皮各15克,生黄芪、葶苈子各15克,生姜皮3克。3剂咳喘较平,瘦畅肿减。复予3剂,痰吐渐少,便调纳增,惟腹水退而未尽。加桑皮、五加皮各20克,陈皮10克,又7剂腹水腿肿全消,改济生肾气丸出院缓调。一月后能从事理发等较轻工作,但肝脏未见明显软缩,心电图改善也欠理想。7月淋暴雨,诸症复萌,自服出院时中药方配少量氨茶碱,十天后又渐趋稳定。

按:患者反复发病已二十余载,邪势益猖,正气日馁,虚实交错,治难措手。刻诊因见明显脾肾阳虚,寒饮犯肺凌心,故投本方去防风(恐虚其表)温化寒饮,强心化痰(用赤芍乃旨在活血也),合以仲师治“皮水为病,四肢肿,水气在皮肤中”的防已茯苓汤,并佐入大剂量的葶苈子、大腹皮,益气行水、本标兼顾,使纳增瘦畅,喘缓肿减。接方合入五皮饮,更加强肃肺(桑皮)、强心(五加皮)、利尿化痰作用,证遂趋好转。济生肾气丸乃南宋严用和所创补肾温阳、利尿消肿之名方,且峻药缓用,有助于调理。但由于患者经济拮据,难以长服中药,故肝大与心电图短期未能恢复。

4、慢性肠炎

李××,女,50岁,工人,1977年6月28日初诊。

素来畏寒,常泄溏便。霉雨季节冒雨劳作后又食不净之物,遂感发热无汗,身疼纳少,太息脘闷,泛泛欲恶,腹中漉漉,日排完谷不化挟痰沫状大便五、六次,舌淡胖,苔白厚浊,脉沉缓。此因脾阳素弱之体,又复为寒湿所伤,以致痰浊内生,下注肠道而成泻。予桂芍知母汤去知母,加姜夏、潞党、葛根、云苓、厚朴。3帖后汗出热退,纳增泻止,改健脾丸缓收全功。

按:明代李士材在《医宗必读》中曾立治泻九法,笔者用桂芍知母汤加减后,已含淡渗(茯苓)、升提(麻黄、葛根)、疏利(厚

朴)、甘缓(党参、甘草)、酸收(白芍)、燥湿(半夏、白术)、温肾(附子、桂枝)七法,故对脾虚复感寒湿致泻者,获效彰彰。因无热象且未至滑脱不尽,故弃清凉与固涩二法。

5、深部组织炎

袁××,女,38岁,工人。1981年2月11日初诊。

素体肥壮,喜食甘肥。一周前感右腿弯部酸痛木胀,恃体强未予诊治。五日后局部漫肿,皮色如常,按之痛甚,微觉寒热。西医诊为深部组织炎,予抗菌素治疗两日,寒热虽退,它症如前,故转我求治。刻诊舌淡紫,苔白浊腻,脉滑。询其身懒肢沉,漾漾欲呕,经色紫黯,白带如涕。显系湿瘀与寒痰互阻客于经络,蕴久致酿脓之变。当急予温通消散:生麻黄、知母各7克,桂枝、花粉、防风、姜夏、白芥子各10克,当归、赤芍、白术各15克,银花、茯苓各20克,连服5剂,诸证霍然。

按:此证属中医“流注”,病因不外暑湿、湿痰、余毒、瘀血等数种,总由外邪侵入而发。但多数因病发较急,正气尚未过衰,使邪内未能深入脏腑,外不得越于皮毛,而停于营卫之间,阻于肌肤之内,故施治当以温通消散为宜,不可为西医的“炎”字所拘,浪投大剂清热解毒,恐反致正虚而邪恋不去也,总以辨证立法为要。如确系寒湿挟痰瘀为患,投本方加活血化痰,佐适量清解,则可使气血流通,痰消瘀化,肿块炎症即荡然无存矣。

6、慢性荨麻疹

张××,男,47岁,农民,1978年5月16日初诊。

慢性荨麻疹反复发作已六、七年,每逢春夏之交乍暖还寒之时,则日夜搔痒无度。伴见胸闷纳钝,腹痛洩少,便溏日数行,畏寒颇甚,面觥神疲,舌淡苔白厚腻,唇边齿印较多,脉沉迟涩。服西药及凉血祛风之中药,鲜见效机。遂断为脾虚难化之寒湿为外风诱发而达表致病。予生麻黄、附子、蝉衣各7克,防风、苍白

术、桂枝、赤芍、厚朴各 10 克，蛇床子、地肤子、朱茯神各 15 克，炙草 5 克。3 帖，诂料服药未尽两帖，皮疹骤增，且色较红艳，搔痒更甚。家属慌来告，欲停药。细询胸闷已减，尿多而便次渐少，乃悟因体内寒湿为温药所趋而外出，嘱原方照服，药尽疹收，它症悉平，改养血祛风 3 帖善后。

按：荨麻疹为现代医学病名，中医称“风疹”（春秋战国）、“瘾疹”（汉代）、“风隐疹”（唐代）、“时疫疙瘩”（元代）、“逸风”（明代）或“风疹块”（清代）等，^{〔注3〕} 西医认为其病因复杂，尤其是慢性荨麻疹不易找到病因，除和各种致敏原有关外，还和个人的敏感性素质及遗传因素等也有关系。中医则强调系禀赋不耐、外淫侵袭、饮食不当、情志所伤、素质虚弱所导致^{〔注3〕}。张某因连续多年在乍暖还寒时节发作，并伴明显寒湿困脾症状，故可用本方祛风散寒健脾，加蝉衣、蛇床子、地肤子、朱茯神等消疹止痒。服后疹增，色红，痒甚，非药不对症，乃正气驱邪外出的“瞑眩”反应现象，为医者切莫心慌而随意改弦更张。另此方治该病的药理作用，和山东医学院附院用麻桂各半汤治此症^{〔注4〕} 颇有相似之处。

体 会

本方属散寒祛湿剂，是以桂枝汤去大枣加麻黄、附子、白术、防风、知母组成。取麻、桂、防风气雄辛散，通阳驱风，走表以疏畅血行；用附、术、生姜辛温燥湿，以逐水、散寒、镇痛；芍、草酸甘化阴，补益气血，既缓上述诸药燥烈之性，又可缓中治挛急。尤妙在独用一味苦寒之知母为反佐。九药相合，则全方虽温而不嫌过燥，祛邪兼可扶正，共收温阳散寒、祛风解表、活血行水、清热镇痛之效。凡偏阳虚之体，又复感风、寒、湿为患，现痹痛（参见《新制八白汤应用掇英》一文）、咳喘、呕泻、浮肿、风疹等症状的各类病变，均可加减投治，而对风、寒、湿邪未尽且蕴久有化热之势的关节疼痛，尤为首选之方。然由于本方药性较偏温燥，故

临床应严格掌握适应指征,若不见畏寒色眦、神疲气怯、身困肢沉,太息泛恶、舌体淡胖、苔白浊滑、脉沉弦紧等症时,不要贸然轻投,对附子最好从小量试投并先煎。

注1:江苏省中医学校《金匱释义》53页,江苏省人民出版社58年5月第1版,或见叶橘泉《古方临床之应用》22页,上海卫生出版社56年6月第1版。

注2:何廉臣《重印全国名医验案类编》66页,上海科技出版社59年12月新1版。

注3:徐宜厚编著《中医皮肤科诊疗学》248页,86年3月第1版。

注4:天津市南开医院皮肤科《中西医结合治疗常见皮肤病》93页,天津人民出版社79年1版。

(马继松。原载于《陕西中医》1982年第3期)

二 温脾汤应用心得

温脾汤出自初唐名医孙思邈《千金要方》,由大黄四两、附子大者一枚、干姜二两、人参二两、甘草二两组成。主治脾胃虚寒、积滞内阻而导致的冷积便秘或久痢赤白不止,腹痛,四肢不温,脉沉弦者。本方可看作是《金匱》大黄附子汤去细辛加干姜、人参、甘草而成,亦可看作是四逆汤加人参、大黄,故属温下之剂。本方温补而不壅,攻下而不猛,确系扶正祛邪之良剂,故为后世名医所喜用。章次公即将本方作为治虚寒痢疾的代表方;王旭高不仅用本方治多种消化道疾病,还将其用治高年感暑致呃逆神昏、便泄溏臭和痼癖等大证。近贤有将其用治因脾肾阳虚,寒湿积滞而见腹痛便秘的肝硬化腹水、消化不良及蛔虫等症。也有用本方加元明粉、枳实、半夏、藿香、砂仁、竹茹、当归治

愈幽门梗阻伴有胃扩张。更有人从现代医学观点提出:慢性肾炎后期,如因氮质滞留而见消瘦、面色萎黄、腰酸、泛恶等症者,亦可用本方酌加温肾利水药施治。笔者受其启迪,也喜用本方,现将运用中的一点不成熟经验介绍于下。

1、休息痢

范××,男,56岁,农民,1980年3月9日初诊。

反复排紫酱色大便已八个月,日数次,入圉难尽,后阴坠胀,脘腹阵痛,温熨略舒,移时复作。纳虽健而面无华,头晕身重,肢麻难眠。由于粪检和钡透不支持阿米巴痢和消化道溃疡,一直按慢性菌痢治疗,时辍时甚。近因春节时进油腻较多,诸证复萌。察舌淡紫,苔白浊微黄,脉濡软。粪检有白细胞和钩虫卵,潜血强阳性。血色素5.5克,红细胞230万/mm³,此系脾阳因寒湿久羁而馁顿,已失统血之权,药用:附片5克,炮姜5克,潞党15克,木香10克,熟军3克,槟榔10克,葛根15克,炙甘草10克,白术、白芍各10克,仙鹤草15克,罂粟壳10克。2帖。十日后复诊,云药后症减,又自配方5帖,刻下便较畅而色紫黑转淡,腹痛大松。惟脘嘈乏力,粪检白细胞钩虫卵仍有少许,潜血弱阳性,原方去罂粟壳、葛根,加当归、山药、乌梅各10克,5帖后,自觉已无明显苦楚,神振脉起,但仍面黄气怯。粪检:钩虫卵少许,潜血转阴;血检:血色素8克、红细胞310万/mm³。要求根治。以首乌15克、炙芪20克、雷丸10克易炮姜、熟军、乌梅,取10帖量共末蜜丸,日服三次,每次10克,并配西药人造补血药500毫升,嘱其适当进食鸡蛋,瘦肉等营养。三月后复查,大便已无虫卵,血色素9.8克,红血球375万/mm³。

按:周慎斋曰:“下痢血色如猪肝色,如紫草,如苋菜汁者,非炮姜不治。”前贤曰:“痢无止法”。故笔者以炮姜配制军,参入调气和血之品,使后重自除,便脓得愈。

2、阴 黄

承××,男,61岁,农民,1978年6月23日初诊。

面黄如烟熏,肤黄如土色,溲黄如柏汁。纳不开,右胁胀,漾漾泛恶,噎逆便艰已近半月。经当地医生用板兰根针剂,肝泰乐等未好转。诊脉濡缓,舌淡紫苔白浊。化验黄疸指数41单位,谷丙转氨酶146单位,胆红质弱阳性,诊为肝炎。此明系湿困脾阳,热结肠腑之证。因年高体弱,《千金》温脾汤小其制以治:附片3克,干姜3克,潞党10克,生军3克,茵陈15克,焦栀10克,苡米15克,枳壳10克,生麦芽15克,六一散(另包)18克,板蓝根10克,厚朴花10克。药尽5帖,纳较香、便转易,惟脘闷太息,苔厚淡黄,减六一散,加苍术10克。复进7帖,诸症继减,但便溏软,腹微痛,以熟军、木香易生军、枳壳。又进7帖后,肤渐转华,腑行亦正,噎逆胁痛全平。惟溲仍黄短,舌仍淡紫。前法参以活血:干姜3克,制军3克,茵陈10克,焦栀10克,苡米30克,香附10克,当归10克,丹参10克,苍术10克,六一散(另包)18克,米炒北沙参10克。10剂后复查:黄疸指数13单位,转氨酶58单位,胆红质阴性。原方加山药15克,复与5帖善后。

按:阴黄即阳虚黄疸,《临证指南》蒋式玉明指:“脾阳不能化湿,胆液为湿所阻,渍于脾,浸淫肌肉,溢于肌肤,色如熏黄。阴主晦,治在脾。”笔者认为只要断为阴黄,均可以姜附茵陈蒿汤主治,一以振奋脾阳,一以分消湿热,若少参清解芳化,则效更捷。

三、胃 痛

陈××,女,41岁,茶农,1980年5月28日初诊。

素有胃痛、便秘、腹膨史,今春冒雨采茶,脘痛遂无休时,腹膨如孕五月,呕吐便结,纳不进,形日瘦,疑为食道癌而急住我院。经钡透未发现器质性病变,但服药即吐,故拟诊为胃神经官

能症,改转中医诊治。观面晦黄,脸浮脸肿,舌淡胖有齿印,苔白滑满布。询其身懒肢困,白带如涕,切脉滞涩,腹虽膨软,但重按则痛,知系脾阳不足,食滞难运,又复感寒湿所致。予平胃旋复代赭汤合枳实、当归、良姜。进药一时许,倾囊吐出,脘痛更甚,困顿难支。细忖因腑气不通,浊阴不得下泄反上窜之故,不可以形瘦而不投大黄,当攻补并进。改潞党 15 克,白术 10 克,山药 15 克,扁豆 15 克,生军 10 克,附子 5 克,干姜 5 克,枳实 10 克,赭石 20 克,云苓 15 克,苏梗 10 克,炒兼菴子 10 克。2 剂,嘱煎后当茶饮。药后痛渐下趋,腹中喧鸣如雷,满腹胀痛,几不欲生,注射镇静剂稍缓。至暮排出先硬后溏便甚多,臭秽不堪,痛略松。2 帖大黄减半服之,又续排溏便不少,苔渐化,呕亦平,但神气极馁,去大黄、干姜、赭石易半夏、苍术各 10 克,5 帖。并予清宁丸一两,每次用药汁送服一钱,诸恙悉平。后常用生姜、番泻叶各 3 克泡茶,送服香砂养胃丸以保持大便畅通,胃痛遂年余未发。

按:本案因系素体脾虚,又兼寒湿挟滞,阻于肠胃,初诊仅健脾芳化,降逆止呕,故难效。复诊改用温脾法,使宿滞畅行,胃气得降,则呕平痛止。由此可知,《内经》所谓“必伏其所主,而先其所因,”确为至理名言。

四、便 血

洪××,女,26 岁,居民,住院号 463,1981 年 3 月 7 日会诊。

十天前中午,感胃中嘈杂,恶心,呕血约 200 毫升,晚饭后又呕紫血块约 200 毫升,遂急诊入院。西医按胃溃疡处理,略有好转,但五天后又大量呕血,经两次输血,呕血虽止,但大便却如柏油状,始邀中医会诊。观其面萎黄,脸微肿,自汗心悸,耳鸣头眩,脘痞纳少,神疲气怯,舌淡胖有齿痕,苔白滑,脉细滑疾,不耐

重按。知气阴随血出过多而有亡散之虞，当急予健脾温摄，不可囿于口渴便干，而浪投滋腻养阴或苦寒炭剂。处方：附片 5 克，炮姜 4 克，潞党 10 克，白术、白芍各 10 克，白芨 10 克，玉竹 10 克，枳壳 7 克，仙鹤草 15 克，熟军 3 克，藕节 15 克，炙草 7 克，乌贼骨 15 克。服两帖药后解黄色溏便数次，因腹痛又改请他医投左金归芪建中加佛手花、茜草炭、藕节炭，殊知便又转黑。因无钱继续输血，又复请予诊。仍宗七日方，用当归炭易枳壳。连进 4 帖，潜血阴转，惟面眇乏力，续与原方去乌贼、白芨、藕节、玉竹加山药、扁豆、栀子、木香调理出院。

按：血属阴主静，赖阳气以运行。阳虚气滞，则不能导血归经，血因停蓄，致络损血溢。对阳虚失统的出血者，在用附子理中振奋中阳的同时，稍予熟军炭为反佐，能收意外之效。近贤姜春华等常用一味生大黄研吞治上消化道出血；朱步先用生地配熟军炭治多种血证。均证实大黄有很强的止血作用。

五、崩 漏

孙××，女，21 岁，农民，1979 年 6 月 13 日初诊。

室女，半年前经期淋雨涉水，遂致一日即止。后每月仅来点滴，少腹渐胀满，人渐消瘦。上月被游医诊为干血癆，投二冬二地等滋阴养血杂以大剂桃、红、棱、莪，致血出如崩，自急以陈棕炭止住，近几日即血出紫晦，时夹小块，淋漓难尽，已二十余日。询知其少腹阵痛即下血，痛缓即止，腹部满胀较前尤甚。初抚觉适，抚久反觉灼热不舒，似有包块，常觉洒寒微热，腕闷泛恶，便溏硬不定，舌淡紫苔白浊，脉细不扬。此系寒湿凝瘀，郁久化热。不攻瘀则邪不去，徒攻瘀则正益伤，予温脾汤损益，使瘀去新生，不止血而血自止。处方：炮姜 7 克，生军 7 克，玄参 15 克，赤白芍各 10 克，当归 10 克，桂枝 7 克，丹皮 10 克，地鳖虫 10 克，川芎 10 克。药尽 3 帖，下紫黑血块甚多，腹渐松软，炮姜、生军各

改为5克,又3帖证去七八,以八珍益母丸巩固。

按:前贤曰:“暴崩宜温补,久漏宜清通。”然证之临床,亦须活看。此证先因感寒致经行闭止而停瘀,郁久化热,但寒象并未尽除。若纯用寒凉,凝结之包块终难化散也。故以炮姜配生军,温散清通双管齐下;元参易党参,既扶正,又凉血;桂枝易附子,其配芍药外可调和营卫、内能燮理阴阳。此即温脾之变法也。叶桂曰:“久病血伤入络”,故加地鳖虫深搜细剔而共奏其功。

体 会

本方药虽有五味,主药乃大黄和干姜。其治疗作用即是通过大黄泻下将体内的食滞、痰积、瘀血、诸虫排出体外来实现的。而这些病理性产物却正是在中焦脾阳不运情况下产生的。干姜为振奋脾运的首选药,在参、附、甘草的配合下,可以鼓舞正气,兴奋全身机能,既能减少病理产物的产生,又可助大黄使病理产物排出。使本方补不碍通,通可助补,寓泻于补,相得益彰。实为治全身机能衰退,胃肠功能低下的各类消化道疾病的良方。有些同道视大黄为泻下峻剂,不敢轻用,对血证尤多顾忌。据笔者近二十年的临床体会,具体应用时,要根据主治的不同而易其炮制和服法:通便祛瘀,清热解毒时,应生用后煎,量宜大;健胃和止痢,应制用,小量同时煎;而用来止血和止泻,则最好用炭剂,亦同时煎;治血分病时,干姜须炮用,取其守而不走也。本方药仍偏猛,对辨证不确或病重体弱者,从小量试投为宜。

(马继松。原载于《江西中医药》1985年第1期)

三 全真一气汤应用述要

全真一气汤出自《冯氏锦囊秘录》，系明末清初名医冯兆张（字楚瞻）所拟。由熟附子、人参、麦冬、五味子、熟地、白术、怀牛膝组成。冯氏认为患久病重病，必脏腑牵连受困，而以脾、肾为最吃紧。曰：“脾肾阴阳两虚，上焦火多，下焦火少，脾阴不足，肾阴虚损。盖少阴脏中，重在真阳，阳不回则邪不去；厥阴脏中，脏司藏血，血不养则脉不起。故用此方以使火降，水土健运正常，精气一复，百邪外御，俾火生土，土生金，一气化源，全此一点真阴真阳，镇纳丹田，以为保生之计而已，即名之曰全真一气汤。”他指出该方：“阴阳俱备，燥润合宜，驱邪扶正，达经通络，药虽七味，五脏均滋，保护森严，外邪难入，功专不泛，补速宜臻，滋阴而不滞，补脾而不燥，清肺而不寒，壮火而不热，火降而心宁，养荣而肝润，”颇宜于五脏均损的大病久病。笔者学用其经验，以此方化裁，治多种疑、杂、重、危之证，获效尚佳，兹简介验案数则，望道友指正。

1、麻疹并发肺炎误治衰竭案

茆小六，男，3岁，1972年3月7日初诊。

患儿为双亲40余岁所生之老来子，因母无乳，全系人工喂养，喜食香燥，质弱病多。春节后感染麻疹病毒，初发尚顺，但出疹时外出嬉戏而冒寒，致一夜疹全收没，壮热吵闹，咳痰难出，胸满喘急。某集镇医院诊为麻疹并发肺炎，注射青、链霉素后，热喘略平，未再续治。两日后壮热喘咳复起，复用前药未效，急至一专治痘疹的老中医处，断为疹未透发，予银翘散合升麻葛根汤两帖，遂疹出遍体，冷汗淋漓，咳喘颇甚，腹泻神萎。体温降至36℃，又急去输液，连治5日，虽疹渐退，汗略收，但它症如前，且瘦少腹膨，拒纳水谷，因过瘦难觅静脉，西医不愿续治。其长兄与我颇熟，于出院三天后邀我以决生死。刻诊：患儿肉削骨突，面色黄晦，目睛转动迟缓，呼吸微弱，哭声嘶哑，肌肤不温，腹较

膨,小溲少,日排溲便2~3行,色淡黄,量不多。时发喘急呛咳,痰粘不出,两肺呼吸音低,挟较多痰鸣音,心率170次/分,心音低。舌淡白,边偏红,前无苔而根微黄腻,脉细滑数。知虚体感麻毒失表,反冒寒邪陷,又过用凉散伤阳,后输液多排出少,加重心肾负担,一误再误,确感棘手。所幸停输液后的三天,日尚能纳稀饭两许,故予全真一气汤勉治之:潞党、茯苓、山药各15克,炒熟地、地骨皮、炙桑皮、炒白术各10克,麦冬、木香各7克,熟附片、五味子(杵)各3克。2帖。双亲不信能救,仅购药1帖,服后无不适,又续购2帖。药尽3剂,小便显增,咳喘略平,肌肤回温,3天排便4次,仍未成形,量比前稍多,腹渐软,纳颇馨,目睛转动已灵,哭声较响。加生炒谷芽各15克,又3帖,咳喘大平,纳增便正,舌边红退,脉数亦减。呼吸音和心音均较清晰,心率135次/分。去泻白散,加白芍、玉竹各10克,5帖,诸症渐愈。

按:患儿因失治、误治,使虚体一伤再伤,而以脾肾阴阳俱虚为尤甚,故用全真一气汤阴阳并补,因便溲遂去牛膝(《药品化义》)曰:“若泻痢脾虚……不宜用”。因舌边红苔根黄,咳喘痰难咯,脉滑,平时喜食香燥,知痰热壅郁于肺,故佐泻白散。重用山药、茯苓,濡脾阴、利水道、化痰浊、实大便。7克木香,助参、术补脾健运而不致辛燥灼阴,且防地、麦之腻。熟附仅用3克,欲“少火生气”也。方中未用一味苦寒药,缘抗生素已久用无效,且一线残阳再为苦寒所伤,则断无生还之望矣!二诊加谷芽,复后天之本也。三诊痰热渐清,故去泻白散,加玉竹、白芍润肺定喘(王好古曰白芍:“可疗肺急胀逆喘咳”)、泽肤生肌,终使化险为夷。

2、肺心阳虚垂危案

柳男,69岁,1988年10月28日初诊。

年青时嗜烟太过,且从事地质工作,常感风寒,反复咳嗽二十余载,85年冬因咳喘肿胀住院,诊为肺心,经治半月缓解始戒烟。但因整日打牌,懒于活动,致咳频稍动则喘,晨面浮,暮腿肿,小溲少,纳不馨,畏寒神疲,心悸唇紫。尤苦于气候转寒,则必输氧,否则喘急难宁。未四年,住院近十次。平时常用氨茶碱、咳喘平。鉴于西医难根治,故转请予治。刻诊:形瘦色晦,面容苍老,步态蹒跚,天未大寒,已着棉服,目睛下肿,语低气促,咳呛痰难咯。桶状胸,肋间隔增宽,两下肺湿罗音多,腹较膨隆。舌淡紫胖,有齿印,苔灰白滑腻。询之:“尿少腿轻浮,腕胀纳钝,渴不多饮,腰膝酸软,便少不畅”,两脉细滑而沉。此肺心重症,肾阳衰微,寒水凌心也:附子(先下)、麦冬、炒熟地、葶苈子、防己、怀膝各10克,焦白术、生黄芪、补骨脂、鹅管石(打)各15克,茯苓、党参各30克,五味子(杵)、炙麻黄、落水沉(劈、后下)各5克。服尽3帖,尚适。葶苈子、白术各加5克,又5剂,随小溲转畅,喘肿稍平,痰咯稀白较爽,去沉、已,加厚朴7克、炒卜子10克。5帖。四诊随多量白痰排出而喘咳大松,二便颇畅,喘减纳增,恶寒减,步履健,唇紫及白滑苔渐退,脉略扬起:去麻黄加桂枝10克。7帖。症续好转,脱棉就夹,以姜半夏、陈皮各10克易厚朴、卜子。六诊:诸症基本稳定,日能纳谷半斤,改丸剂缓图:上方加当归、地龙、三七各10克。以10剂量,共未蜜丸,日服3次,每次10克,空心下。

按:此患者显系肺心日久,病及脾肾,多脏损亏,且阳虚为甚,故用全真一气汤峻补肾脾、养心益肺,合《金匱》防己黄芪汤益气消肿。麻黄散外寒,助血运,解除气管痉挛以平喘;补骨脂、五味子、沉香、鹅管石温肾纳气以敛喘;葶苈子强心利尿。合用可改善脏腑功能,促进气血运行,使尿增肿消,纳旺神振。然毕竟年过七旬,病已三十载,只能带病延年。90年、91年、92年冬

寒时仍发病,按上方调治皆缓,三年仅住院四次。93年冬大寒,红参、附子各加至20克,尿仍少,水肿甚,虽无内热之象,但鼻腔、牙龈轻微渗血,致未敢再增参、附之量,终致阴霾太甚,元阳消残而亡。

3、肺炎寒凉较过致变案

凤女,75岁,1998年11月6日初诊。

曾患高血压、冠心、肺心、慢性肾炎,半年前又因乙肝住院近两月,十天前不慎又罹肺炎,住院一周。经用抗生素等,热虽退却未清,口干欲饮,溲少便艰,烦躁寐难,痰咳欠畅,且稍动则喘,纳少畏寒,舌偏紫黯,苔黄厚,舌下静脉如虬,脉软滑。高年气阴两虚之体,痰热久恋不去,当在补益气阴,清化痰火同时,佐消导和胃:姜夏、杏仁、知贝母、萎陈皮、郁内金、生白术各10克,潞党、炒麦芽、紫金牛、北条参各15克,桂枝5克,茯苓30克。11月11日二诊:药尽4帖,随便畅,矢气频转而脘胀渐松,苔厚稍化,神情略振,但仍口干烦躁,畏寒有痰。口淡甜腻,脉细软滑。上方参以纳气,缘喘发较甚:去桂、陈加佩兰、条参各10克,沉香3克(劈小块、后下)。5帖。11月14日三诊:仅服3帖,感寒从内发,清涎如涌,困顿难支,苔转白滑,脉渐转沉。此痰热未清,阳衰复甚也。为其检出近半大贝、萎皮、条参、紫金牛,加附子、桂枝各10克,让其将余药服完。11月17日四诊:寒象稍减,但背脊仍出凉气,脉舌皆现寒象,清涎仍多,纳钝便难,且晨起面浮,日暮腿肿。改全真一气汤:熟附(先下)、炒熟地、桂枝、陈皮、姜夏、酒怀膝、炒卜子各10克,归身、白术各15克,茯苓、潞党各20克,干姜、麦冬各7克,五味子(杵)、沉香各3克。3帖。11月27日五诊:首帖药当天煎三次服后,感腹胀、腹泻、溲多、神疲。遂自将另2帖药,每帖作三天服,每天仅煎服一次,二便即正常,痰涌渐平,肿略消,寒稍减,脉较扬起,日能食煮极烂面条

二两。舌下静脉由紫转红。虽气血有流通之兆,但心悸寐难:潞党、枣仁、白术、炒麦芽各 15 克,(炒)熟地、黄芪、桂枝、麦冬、川芎、香橼皮、炒归身、酒怀膝各 10 克,熟附 7 克,干姜、沉香、五味子(杵)各 5 克。3 帖。12 月 20 日六诊:仍 1 帖药服 3 天,诸证渐次松减,加之寒流适至,又将前药自购 5 帖服下。现日能纳谷近半斤,二便基本正常,卧较安,肿大退。但稍劳仍气喘力乏。天寒就诊不便,要求改成药调理:上方加鹅管石、葶苈子各 10 克,三七、莼肉各 7 克,10 帖。加蜜 2 公斤熬膏,日 3 次,每服一汤匙。现症情尚稳,仍在治疗中。

按:风邪因五脏几乎皆有病变,体质极差,深秋感燥较甚,咳剧而得肺炎。初服补益气阴,清化痰火颇适,但因对药过敏感,且素体阳虚,笔者忽略了叶天士“清凉到十分之六七,即不可过于寒凉”之论,复诊方药仍偏凉,以致热去寒起,变证丛生。遂急于全真一气汤,大补脾肾阴阳,加归、桂活血强心,二陈、干姜、卜子化痰消饮,沉香纳气与怀膝共引诸药达肾敛喘。然因药力稍峻,日服三煎,体力不胜药力,改 3 日一剂则安然,可见服药之法大有考究焉!

4、血痹虚劳案

谭女,61 岁,1998 年 4 月 4 日初诊。患者双腿发麻,腰背酸胀已半年,曾服中、西药,未见显效。刻诊尚伴双目模糊,两耳蝉鸣,眩晕失眠,胸闷纳呆,口干饮少,大便稀溏。舌红,苔黄腻,脉左沉缓,右结代(血压、血脂正常,但心电图诊为心肌供血不足)。此心脾两虚,气血难运,先拟健脾宁心通络:丹党参各 15 克,白术芍、萎陈皮、炙远志、石菖蒲、炒黄芩、姜夏、郁金、神曲各 10 克,薤白、五味子(打)各 7 克,茯神、鸡血藤各 30 克。5 帖。二诊:胸闷、背胀、眩晕、失眠略好转,但仍纳呆、腿麻、便溏日数行,且增颜面晨浮,日暮腿肿,脉舌如前,去芩、姜、远、夏加川膝 15

克、苡米 30 克、砂仁 5 克。5 帖。三诊:未见显效,脉仍沉缓,时现歇止。细询其常下水田劳作,且年事偏高,脾、肾、心之阴、阳皆 馁,非峻补难效:附子、五味子(打)各 7 克,红参、薤白、麦冬、木香、川芎、酒怀膝、石菖蒲、煨益智各 10 克,炒熟地、炒白术芍各 15 克,炒山药、鸡血藤各 30 克。4 月 23 日四诊:小溲颇畅,大便渐正,纳增肿减,背酸亦松,腿麻大减,要求原方续进五帖。4 月 30 日:肿消纳旺,腿已不麻,脉歇止极少,惟舌仍偏红,耳鸣目糊未大瘥。去红参、木香、川芎,加党参 30 克,杞子、骨碎补各 15 克,8 帖研粉,每服 10 克,空心淡盐汤下,日 3 次。随访近年,一切尚安,心电图示心肌供血亦有好转。

按:谭女因高年正虚,复为寒湿阻于经络而致腿腰麻酸,浮肿便溏,前两诊由于问诊未详,且考虑舌红,故未敢用附子,效不佳。三诊其告多年来舌质一直偏红,故舍舌从脉,改投全真一气汤加薤、芎、菖、芍、山药、鸡血藤,峻补阴阳,活脉通络;合木香、益智温运脾阳,使气血运行得畅,寒湿自能外泄,故能尿畅肿退,纳旺麻瘥。因已用麦、味、参、术,故熟地、白芍,山药均炒用,且未用黄芪,否则恐将壅中矣!怀膝若不酒制,亦恐致腹泻也!本案和《金匱》血痹病因虽不尽同,但病机均和因虚致血运行不畅有关,故姑以血痹虚劳名之。

5、肾虚阳痿案

黄男,44 岁,1993 年 11 月 20 日初诊。

17 岁下放 5 年,劳力较甚,工作后常感神疲,体虽偏瘦,但无明显大疾。31 岁结婚,翌年得子,性生活基本正常,但前年始渐觉行房时阳竖不坚,右睾丸常冷痛,未予治疗。今年疾益甚,且右睾渐萎缩,尿频急难忍,解时淋漓难尽,伴腰酸畏寒,四末如冰,性欲几无,寐难安宁(11 时前极少有欲寐之感),纳少腹坠,眩晕神疲,脉细软滑,舌偏红苔白浊。显系肾阴元阳早 馁:予附

片(先煎)、麦冬、酒怀膝、仙灵脾、煨益智、炒乌药各 10 克,茯神、黄芪、白术、川断、合欢皮各 15 克,党参、熟地、山药各 20 克,五味子(打)7 克。5 帖。复诊小溲渐正常,纳增晕减,苔稍化,卧略安。续进 5 帖,小溲已能自控,卧已安,畏寒减。去合欢皮、乌药、益智、加杞子、菟丝子各 15 克,巴戟肉 10 克。又 10 帖,腰酸大缓,性欲渐复,但仍竖而不坚,舌苔渐正,脉亦扬起。去茯神、怀膝,加山药、熟地、蜂房各 10 克,制黄精 15 克。10 帖。五诊:右掣渐复正常,同房时间延长,肢温神振,要求成药缓图。上方加鹿角霜 10 克,10 帖,加蜜两公斤,熬膏,日服三次,每次一汤匙,连服药膏 3 料,阳痿未见续发。

按:阳痿病因虽多,但以肾亏为最。患者因显系劳力伤肾,故全真一气汤效佳。初诊配缩泉丸,乃为固涩小便也。三诊溲正常后,加杞、菟、巴戟,益补肾之阴阳也。四诊加蜂房,为壮阳起痿也(《唐本草》曰蜂房“主阳痿”)。若湿热、肝郁致痿,此方不可浪用。另患者毕竟刚过不惑之年,若耳顺以上,恐难如此速效。

结 语

冯氏创立全真一气汤,实际是对赵养葵、薛立斋、张景岳诸大家“阴阳互根,水火同源,肾脾为先后天之本”这一理论的创造性应用。他纵观治虚方剂,“水不足者有六味,火不足者有八味,气不足者有四君,血不足者有四物,心脾不足者有补中、归脾”,然“独脾肾不足,心肺之火宜抑,而肝肾之阳宜温,实无其药”,故立此方。因此近贤有用此方进退,灵活施治慢性肠炎、肝硬化腹水、慢性肾炎、慢性肾盂炎、肾病综合征、慢性肾功能不全、甲状腺功能减退、糖尿病、前列腺肥大、中风后遗症、晚期肿瘤等。首任卫生部中医顾问章次公,还用此方治登革热、脾不统血之出血及抢救温病之心衰,全在其匠心之独运。但该方终究以温药为

主,有明显热象者选用宜慎。另附子还是从小量试用渐加并先煎,五味子杵碎入药为好。

(马继松主治,白鹤鸣、马璇卿整理)

四 复方四逆散运用撷拾

四逆散出自《伤寒论·少阴病篇》,原主治:“少阴病,四逆,其人或咳,或悸,或小便不利,或腹中痛,或泄利下重者。”虽仅有柴胡、芍药、枳实、甘草四药,药性不寒不热,中庸平和,但却可行气和血、疏肝调脾、祛邪扶正、解表通里,颇合“和方之制,和其不和者也”之旨,故被后贤列为和剂之祖方。吾师马继松认为该方毕竟药性略偏于凉,气分药多于血分药,扶正药不足于祛邪药,故他临床常配入郁金、香附、延胡、当归、白术,组成复方四逆散,用治多种消化道疾患及一些内伤杂证,取效颇佳,今整理其验案数则,供同道参考。

1、慢性胃炎伴胆囊多发性息肉案

程男,43岁,乡村民办教师,1997年3月22日初诊。

慢性胃炎伴胆囊多发性息肉已3载,曾断续服中西药未效。一周前复做B超提示胆囊息肉增大,最大为10mm,西医为防恶变,建议手术,其颇感畏惧。因16年前胃出血经我治愈,故由芜湖县来求诊。刻诊:胃脘胀痛,嗳气嘈杂,胆区亦胀满不适,口苦纳呆,便溏日2—3行,形瘦面晦,稍劳则力乏汗出。舌红边有瘀点,苔根黄腻,脉弦细弱。此显系脾虚气滞,胆胃失和,痰瘀壅凝为息肉。予苡米30克,白术芍、郁内金、金钱草、八月札、党参、银花、香附各15克,炒归身、元胡、酒芩各10克,枳壳、生草

各7克。6帖。3月29日：嘈杂止，苔腻化，舌边瘀点渐淡，胃仍疼且坠，去党参、黄芩、枳壳，加生黄芪20克，石斛10克，柴胡7克。12帖。4月12日：诸症显缓，去石斛、甘草，加山药30克，藤梨根15克。12帖。5月10日：告因限于经济，自将每剂煎4次，作两天服。现脘胁痛均大减，面色渐华，舌正脉扬，体重增近3斤。尤喜前日B超复查，息肉缩小，最大为8mm，要求成药调理。予苡米、山药各30克，白术芍、金钱草、郁内金、生黄芪、藤梨根、八月札各20克，银花、当归、香附各15克，白芨、元胡各10克，柴胡、生草各7克。7剂量共末，每用10克，米饮送下，日4次，空心下。6月26日：3天前药服完，复查息肉尚有2枚，大者5mm，无其它明显不适，要求续作药粉一料。10月7日：其陪乡邻求诊告，国庆复查仅剩一枚3mm大息肉内，胃痛因未大作，未作胃镜复查。体重又增2公斤，因供子上大学，遂停药。嘱：每日以苡米50克煮粥长服。

按：程某平素劳累过甚，致脾气亏馁，兼较长期饮酒，致湿热食滞壅阻变痰，与行缓之血凝聚成息肉。病在胆胃，故马师以本方去柴胡（防过升加重暖气），加银、芩、党参、金钱草运脾利胆疏滞，配苡、内、八月札（功主疏肝理气散结，原多用治胁胃痛，近年常用治消化道肿瘤）直接消磨息肉。复诊因胃坠甚，故以芨、斛、柴易党、枳、芩。三诊重用山药，气阴双补，以代斛、草，因体质渐好转，加藤梨根清热解毒，化湿活血（现亦常用其治消化道肿瘤），以加速消磨息肉。考虑膏剂甘壅太过且滑肠，丸剂过硬有碍胃消化，故用粉剂缓图矣。后考虑患者之经济，改用食疗方，希冀能收全功。今人有用苡仁配生香附、木贼草煎浓汁，外用擦洗扁平疣，足见该药有较强的消磨增生组织之功。

2、慢性胃炎伴肠上皮化生案

倪男，59岁，农民，1996年3月27日初诊。

老伴过世八载,又无子女,致饥饱无定,借酒浇愁。近3年胃胀,饭后尤甚,伴噎逆纳呆,便干消瘦。春节后食硬物常梗噎不顺,遂去县医院检查。胃镜报告:慢性胃炎伴①活动及糜烂②轻—中度肠化③修复性腺体轻度不典型增生,胃体部淋巴组织亦慢性增生。经乡邻介绍马师诊治。刻诊尚有咳嗽,吐白稠痰,稍动则喘(日吸劣质烟包余)。舌偏黯红,舌下静脉紫粗如蚓,苔白腻根黄;脉弦滑,不耐重按。此脾运乏力,胃降失权,痰瘀纠结,随肝气之逆上而作祟。投茯苓、生白术、仙鹤草各30克,赤芍、当归、枳壳、大贝、郁金、生赭石、八月札、蒲公英各15克,姜夏、杏仁、香附各10克,醋柴胡、生草各7克。6帖。4月3日:随大便较畅,矢气频转,咯痰渐爽,而噎逆梗塞似减,苔黄亦稍化,去茯苓、赭石,加苡米30克,旋复梗10克。6帖。4月10日:吞咽渐畅,纳较馨,脘胀松,神稍振。舌黯及舌下静脉转淡,脉弦缓。去香附、柴胡,加北沙参、藤梨根各15克。12帖。4月24日:自觉症减过半,要求改服成药。生白术、仙鹤草、苡米、山药各30克,赤白芍、八月札、蒲公英、藤梨根各15克,郁内金、石见穿、党参、大贝、当归、枳壳、姜夏、香附各10克,九香虫、柴胡、生草各7克。7帖。与炼蜜2公斤熬膏,日服3次,每次一汤匙,饭前服。6月20日:药膏服完,已无明显大苦,胃镜提示:慢性胃炎伴轻度肠化。限于经济,未再续治。

按:患者年近花甲,气阴本已欠丰,况又心绪特差,饮食无规律,常以辣酱、炒花生下酒,致生胃疾。马师投本方疏肝和胃,活血通络,重用苓、术奠安中州且化痰,配旋、赭、夏、杏、八月札等降逆消滞,大贝、公英清热解毒,并合大剂仙鹤草修复糜烂(该草又称脱力草,有一定强壮补益之功,今贤根据《伪药条辨》曰其“治療癆”之言,还以其治肿瘤等增生性疾病)。故诸药相伍,尚合病机。复诊以苡仁易茯苓,增其软坚消肿之功。后二诊又加

藤梨根、石见穿、九香虫，乃防疾患恶变也（朱良春《虫类药的应用》载：上海市徐汇区天平路地段医院曾用此三药合龙葵、卫矛等治胃癌），故药后颇效。然终因停药过早，且复嗜辛酗酒，一年后复发，被诊为食道贲门癌，难耐疼痛，服农药自戕，诚可叹也！

3、慢性胆囊炎伴痛经案

张女，28岁，工人，1998年3月20日初诊。

右胁胀满疼痛，厌油纳呆已半月余，经皖医附院B超提示：胆59×35mm，壁厚边毛，囊内胆汁透声欠佳，但未探及增强光团及声影，确诊为慢性胆囊炎。因对一些西药曾有过敏，故请马师诊治。刻诊近三年尚伴有月经愆期，量少色紫挟块，淋漓难尽，常近旬始净。经前腹痛颇甚，乳胀，太息，右乳外上方可触及一质软光滑能移动小包块，约大蚕豆大，经后遂消。经前后带白频下，平时入暮下肢常肿。虽纳谷渐减，但形体却反丰。舌胖有齿印，苔白腻，脉弦滑。此显系痰瘀水乘脾虚木郁而互结为患。现离下次经期尚有十日，先予苡米、金钱草各30克，白术、郁金、赤白芍各20克，香附、元胡、当归、内金、橘核、焦查各15克，枳壳、柴胡、生草各10克。7帖。3月27日：胆区胀痛稍减，纳谷渐增，已可略食油腥。去赤芍、枳壳，加丹参20克、青皮10克。7帖。4月3日：前日经至，量多于前，疼痛显减，乳胀松，包块缩小，但胆区仍时隐痛，腿仍暮肿。去丹参加银花20克、路路通15克。7帖。4月10日：月经5日即净，胆区痛与腿肿亦基本平伏，胃纳馨，不太厌油，但大便溏，日2—3行，腻苔化过半，脉力仍欠足。去当归、减金钱草为20克，加米炒山药30克。7帖。4月17日：神旺脉起，已无明显大苦，因表姐约其去珠海打工，嘱予改成药久服。以初诊方去枳壳、赤芍加青皮10克，银花、丹参各20克，山药30克。7剂共末，以100克路路通煎浓汁泛丸，绿豆大，每服10克，日4服。国庆期间其表姐返芜告：

患者如过食油腻或辛辣物,右胁略痛胀,它症皆除,且渐苗条。所憾未续作B超,不知胆囊后来情况。

按:患女慢性胆囊炎,伴痛经且经期乳房出现包块,病似乎较复杂,但据症细析因、机,与其下岗有关。《素问·阴阳别论》曰:“二阳之病发心脾,有不得隐曲,女子不月”,故肝气失畅,致月经与乳房病起,月经稀发使瘀难泄反化为痰,形体因痰阻湿壅而渐丰,终复使胆囊患病。初诊正值经前十天,故予本方伍入橘核、内金、山楂,加重行气活血,且有利胆汁排泄;金钱草、苡米虽以利胆去湿为主,但均有一定活血之力,故诸药合力,使瘀泄痰化而共臻成功。路路通苦辛平,《纲目拾遗》言可通行十二经,马师对经少乳胀伴腕疼痛者喜用之,轻度水肿与关节疼亦可投。

4、慢性阑尾炎伴慢性前列腺炎案

王男,44岁,干部,1996年11月4日初诊。

素无酒力,近两月因公事连续赴宴多次,饮酒较过,遂觉阑尾处常隐约疼痛。西医诊为慢性阑尾炎,予氟派酸、阿莫西林等,虽可暂缓痛于一时,但感大便欠畅,日欲登厕数次,有时极难排尽,肛门坠胀,牵及阴囊,小溲亦频急淋漓,转请马师诊治。刻诊:右腹胀痛,入暮犹剧,不喜抚摸。口干苦,不欲饮,神疲太息,偶发阳痿。脉细滑弱,舌淡胖有齿印,苔白略滑。WBC:10600,N78%。此乃湿热乘气阳之虚,羁于下焦不去。当标本兼顾,参以疏肝开郁,缘性格较内向也。苡米、红藤、冬瓜子各30克,生黄芪、生白术芍、败酱草、元胡各20克,郁金、香附、枳壳、桃仁各15克,柴胡、丹皮、生草各10克。7剂。11月11日:便畅夹有粘液,日仅2次,右下腹痛胀显减,但会阴仍坠胀,溲淋沥未尽除,腰亦时疼痛。减枳壳5克,加黄芪10克,柴胡5克。7剂。11月18日:阑尾已三日未痛,会阴与小便症状略减,经泌尿科诊为慢性前列腺炎,上法参以益肾:苡米、银花、山药、黄芪

各 30 克,怀膝、红藤、荔枝核、白术芍、菟丝子各 15 克,郁金、元胡、当归各 10 克,柴胡、生草各 7 克。7 剂。11 月 25 日:药后颇适,后以此方进退,断续调治两月而大缓。

按:患者年幼多病、气阳夙虚,复因饮酒过量,酒性助湿生热,与甘肥之物相合而羁于下体不去,遂致病发。故初诊在用本方调气活血的同时,马师复参入仲师治肠痈要方大黄牡丹汤与薏附败酱散,但却既未因便难而投硝、黄,也未因苔白而投附子,深恐药峻而虚体不受也,改用银、芪,加强清热解毒、补益气阳之力。肠痈症平后,改方加菟、膝、荔核、山药,增益肾之功。患者在坚持服药同时,坚决戒酒忌辛,以清淡菜蔬为主,故病痊较速。

5、胃肠神经官能症

陆女,46 岁,农民,1992 年 10 月 17 日初诊。

15 年前因前置胎盘大出血,抢救虽生还,但五心常发热,全身时恶寒,中西药迭治未效。6 年前又患颈椎病,阴天痛剧。近年余胃脘及右胁胀满,胃纳极钝,脘嘈得食可缓,夜平卧或右侧卧胃皆不舒。一月前市某院胃镜提示:胃体轻度充血,胃窦亦轻度充血,水肿,拟诊为浅表性胃炎,但服西药乏效。B 超查肝、胆、脾、胰一切正常,遂按胃神经官能症,予谷维素、新 V_B 等,服后尚适。詎料未一周又胀满如前,续服前药一周,效不显,故转请马师诊治。刻诊见其消瘦躁急(自云近三载体重减轻 20 余斤,而以今年为尤甚,现身高 164Cm,体重 52Kg),汗多寐难,小溲日少夜频,淋漓不尽。月汛两旬即至或三月四潮,色黯红夹小块,少腹隐约胀痛。喜食凉物甘肥,却极少腹泻。脉弦弱,舌可苔白浊。马师细忖良久,悟为亡血后肝失滋涵,气逆难敛而横逆犯中,致土衰食减,虚气散逆,则益增肿胀满。当健脾柔肝,佐和血导滞,缘月经将至。予生麦芽 20 克,党参、郁内金、生白术芍各 15 克,当归、枳实、桃仁、香附、元胡、金铃子、八月札各 10 克,

柴胡、绿梅花各 7 克。6 帖。10 月 24 日：告服至第 4 剂，眠食均随矢气频转而改善，但梦仍多，胀尚甚，今日经至，色尚可，腹稍不适。以焦查、香元皮、丹参各 15 克易元胡、金铃子、八月札。6 帖。10 月 31 日：诸症均缓，但夜尿仍多，颈椎欠适，舌脉已可。以生芪 20 克、五味子 7 克易党参、桃仁。6 帖。11 月 14 日：药后胀满复甚，加之三天前母自杀，操办后事，烦劳较过，又感寐难，纳呆，神疲，烦热，舌转红苔少，脉细滑。初诊方去党参、枳实、元胡、金铃子，加百合、白薇各 15 克，香元皮、枳壳各 10 克。6 帖。诸症遂安。后以上方出入调治至冬至，以生麦芽、夜交藤、合欢皮各 20 克，党参、郁金、百合、生白术芍各 15 克，当归、丹参、枳壳、香附、八月札、香元皮各 10 克，柴胡、甘松、绿梅花各 5 克，10 帖共末蜜丸以收功。

按：本证与中医之郁证颇似，故马师从始至终均遵叶天士治郁“每以苦辛凉润宣通，不投燥热敛涩呆补”之旨用药，故获效尚可。三诊时改用芪、味代党、桃，以利颈椎，固夜尿，非但未效，反又胀满，足见叶桂治郁之论的正确。故丸剂也仅在效方基础上加夜交藤、合欢皮、甘松等养血调气，解郁安神等平和之味，因患者之“卧不安”，实与“胃不和”有关，无庸浪投重镇、滋养。由于郁证常易反复，马师认为不宜同时杂用过多治它病之药，因而四诊时劝其采用推拿治颈椎病，后颇缓解。随夜卧渐佳，夜尿之频亦减矣。

6. 胸骨下段疼痛案

邓女，20 岁，商贩，1991 年 1 月 10 日初诊。

新产刚弥月，近一周若猛由平卧起坐或挺胸或换位乳婴时，胸骨下段均有明显牵拉疼痛感，贴活血膏 4 日未效，遂求治于马师。观局部皮色如常，触摸胸骨下段右侧略漫肿，软而不疼。除大便偏干，胸闷时欲太息外，无明显它苦。望诊形丰面红，舌淡

紫胖有齿印,苔白黄浊,脉沉细滑。细询之,患女因生男孩合家欢欣,整日甘肥迭进,睡多动少,马师告吾其系安逸太过,气滞血凝,致饮食不化精微反复生痰浊,随体位之改变,影响气机之升降而疼痛发矣。予赤芍、当归、香附、郁金、元胡、皂刺、白芥子、丝瓜络各 10 克,生白术、生山查、炒枳实、萎皮根各 15 克,柴胡、土鳖虫各 7 克。未尽 5 剂,随畅排数次粘液性大便,肿消痛失矣。

按:患者胸透(一),知非器质性病变;而外贴活血膏乏效,且皮色未变,亦知非外伤。细询始知嗜食甘肥,安逸太过,内生之痰浊与运缓之气血相合而病作,故投本方行气活血,佐以皂、芥、萎皮根祛痰通络,更增查、鳖活血消脂,使痰浊从便中畅泄,气血运行复常,遂肿消痛失。前贤曰:“白芥子驱皮里膜外之痰”,马师对体表部位形色不变的漫肿或包块,投用常效。另花粉在宋代《校注妇人良方》的仙方活命饮中,即将其作为消痈排脓主药,现代医学证实,其有极好的抗肿瘤作用。如中国十大杰出青年、国际抗癌药物专家王振国新研制的治多种癌肿的天仙胶囊,主药即花粉,马师对急慢性炎症或非炎症性包块(如颈部淋巴结肿大、乳腺增生等),常配入该药,收效颇佳。

7、不明原因低热

朱女,61 岁,1989 年 11 月 30 初诊。

低热近半月,日晡后甚,右胁胀痛却喜按,得矢气或噎逆则松,口干苦渴,饮却不多。B 超排除肝胆胰病,西医按发热待查收住院五天未果。女婿略懂中医,与马师颇熟,让其出院,求治于马师。诊见除上述症外,时发太息,喜以手抚胸,但却说不清所苦。另纳减寐难,便少偏干,常独坐发呆,记忆显退。其婿告其原无大疾,常去他人家打牌,二十天前打牌后,遂再不打牌,家人原以为是好事,谁知未多久即病。西医诊治未效后,他去其牌

友处细询,方知那次她输钱较多,估计与心情不畅有关,遂和家人劝说,也未好转,岳母平时言语不多,是否为肝郁化火而发热?马师认为有理。再细诊其脉,果弦细而滑,舌偏紫黯,苔薄黄腻。遂投:柴胡、郁金、香附、枳壳、甘松、大贝、当归、白术芍、八月札、川楝子各 10 克,百合、朱茯神各 20 克,生麦芽、合欢皮各 30 克。药尽 4 剂,随矢气频转,便畅咯痰,遂热退胀缓,眠安纳增。迭进 4 剂,诸症若失。

按:此病西医诊治未效,乃未知病因也,幸其婿懂中医,故马师遵嘱按肝郁发热,投本方加贝、楝、八月札、生麦芽,清疏厥阴郁火,配甘松、百合、茯神、合欢,养心宁志安神,故获效较好。《日华子本草》言甘松“治心腹胀,下气”,王好古曰:“理元气,去气郁”。药理证实:其有较好的中枢镇静作用,故《现代实用中药》明言“治精神忧郁证”。百合本经言“主邪气腹胀”,张仲景在金匱百合病篇中,将其作为君药,组方 6 首,均用治精神志疾病及其伴发症状。因甘松甘辛温散,百合甘苦凉润,故马师治较轻的精神神志疾患(如郁证、癡证等),每喜将两药组成“对药”投之。一得之愚,仅供酌参。

结 语

盖四逆散乃和法要方,而复方四逆散不仅可作和解剂,亦可作消法之要方(邱德文等在《中医治法十论》书中,将消之一法,衍化为活血化瘀、祛痰、祛湿三法,而本方中的当归、郁金、元胡、香附均有活血化瘀之功;当归、郁金、白术又可祛痰;且《日华子本草》明言白术:“消痰,治水气,利小便。”),故本方较好地扩大了四逆散的运用范畴。马师用本方配合五金汤(金钱草、海金沙、郁内金、金铃子)加减治胆囊炎、胆石症;配伍苦辛通降法(诸如半夏泻心汤,旋复代赭汤、黄连温胆汤、保和丸、化肝煎、左金丸之类)治各类胃病均上百例,获效皆尚满意。另多种妇科疾

患,如痛经、经期前后不定、血瘀崩漏、气滞血瘀闭经、盆腔炎、良性肿瘤、血走脾经所致肥胖、经绝期综合证及部分乳腺病,辨证投用亦好。然马师指出:该方毕竟药性平和,故症情危急的大实证,大虚证,勿轻试用,以免延误病情,错失抢救良机。

(马继松主治,孙秋生整理)

五 新制八白汤应用掇英

自拟新制八白汤(白附子、白芥子、白僵蚕、白蒺藜、白芷、白术、白芍、白茯苓),系根据清代名医赵学敏《串雅外编》八白散去白丁香、白牵牛、白芨,合入《仁斋直指方》三白汤而成,笔者以该方损益,辨证施治于多种疑难杂证获效满意,现择数案,以广其用,并对该方的配伍特点、作用机理作简要探讨。

1、术后误补失语案

肖××,男,13岁,学生,1985年6月8日初诊。

素体壮健,十天前行右下颌骨含牙囊肿摘除术,术后尚正常,但父母却煮肥母鸡一只,并请医生输复方氨基酸补“虚”,使患儿反觉胸咽堵胀,烦躁眩晕,困顿懒动,表情淡漠,渴欲冷饮,纳呆便坚,时有怪僻行动,且翌日难于发音,只能用笔代言。西医给服镇静剂、维生素与营养神经药,但第三天仍不能说话。又治5天未见显效。因其母曾患精神分裂证经余治愈,故急领其来求治。察其体偏丰盛,喜食肥腥,太息痰多,舌尖红略胖有齿印,苔白浊腻,脉滑数。因时入长夏,遂诊为脾困失运,痰浊逆上,阻于会厌致音声难出。投白附子3克,白芥子7克,白僵蚕、白术、白芍、大贝、郁金、炙远志、生山栀、石菖蒲各10克,瓜蒌

仁、白蒺藜、炒卜子各 15 克，朱茯苓 30 克。药进 1 帖，咯吐出一些白稠粘痰，咽堵稍松，已能微言；两帖后音声渐扬；药尽三帖，随吐出大量浊痰及排出很多带粘液之溏便，发音则如常人，而余症亦渐随解矣。

按：《医宗金鉴·四诊心法要诀》曰：“凡万物中空有窍者，皆能鸣焉，故肺象之而主声也。凡发声必由喉出，故为声音之路也。”前贤将失音分为：“金实不鸣”与“金破不鸣”两大类，病机要旨皆与肺、喉相关。而《古今医统·声音候》更明言：“有内热痰郁，壅塞肺气，而声哑及不出者。”肖孩误补猝发失音，由脉症相参，显系脾困失运致痰浊逆上壅肺阻喉所致，故予八白汤运脾豁痰。因病已 10 日，已现痰浊郁久化火之象，故予梔、贝、蒺仁，通幽而引痰火下泄；远志、郁金、石菖蒲三药，乃豁痰开音最常用之药组；炒卜子既可运脾消食滞，又能理气化痰涎，故诸药相合，终获佳效。

2、风寒湿型痹证案

陈××，男，43 岁，农民，1978 年 3 月 8 日初诊。

一月前下水捕鱼，后感右趾麻木不能久立，近数日感环跳穴处剧疼如刀割而被抬来就诊。根据直腿高抬试验(+)，环跳穴明显压痛并向下肢放射，西医诊为坐骨神经痛转入我科。患者呻吟不已，右腿屈曲不能伸，胸闷纳少，咳吐白痰，便溏日数行，中挟痰沫状物，舌淡有瘀点，苔白浊中裂，脉紧滑。平素体健，此为风寒湿三邪夹痰瘀阻于络道，气血流行不通，而致痹痛。予八白汤合仲师桂芍知母汤：白附子、白芥子、白僵蚕、白芷、生白术、白芍、生麻黄、桂枝、知母、乳香、生草各 10 克，白云苓、白蒺藜各 15 克。药服 3 剂，家属云其右腿膝发痒，起红色丘疹甚多，而疼大减，已能伸直。续方 3 帖，家属云其已能扶物缓行片刻。又续方 3 帖，患者独自步行八里来医院求治(途中仅歇一次)。喜告

腿痛全止,诊其丘疹消退,大便正常,脉势转缓,直腿抬高(一)。患者要求加大剂量作最后治疗,遂将麻黄、桂枝、白附子各加 5 克,复予三帖以善后。一月后追访,已能参加田间劳动,直至 82 年未见复发。

按:本患者因感受寒湿,致右腿由麻木发展成剧痛,虽可列入风寒湿型痹证范畴,然因、机和治疗与以疼痛为主的单纯风寒痹证却有别。《类证治裁·麻木》指出:“麻……只气虚而风痰凑之……木则肌肉顽痹,湿痰挟败血,阻滞阳气,不能遍运,为病较甚,俱分久暂治之”。故笔者用八白汤驱风痰、通经络,合入仲师桂芍知母汤散寒祛湿,活血止痛。麻、桂与白芥子同用,乃取王洪绪阳和汤将三药相合驱皮里膜外及经络中痰凝瘀滞之法也。由于药能与证相应,加之患者素往体健,故四诊十余剂药即告痊愈。

3、外伤顽固头痛案

朱××,女 48 岁,工人,1983 年 11 月 27 日初诊。

30 年前因车祸致头枕部受伤,经西医治疗,剧烈之头痛暂缓而出院,后遗留痼疾,每至天气突变或劳累气恼则头痛发作,由枕部移至偏右为甚,伴右侧肢体麻木十余载。近二、三年又增添习惯性便秘,此次因猝受风寒致痛又甚。询知平时性急烦躁,鼻干口苦,纳少寐难,一身困重。舌淡紫苔白浊滑,脉濡滑。认证为肝郁化火伴瘀血作祟,投丹栀逍遥散合生军、石决明、苦丁茶等,虽便较畅,但更感脘闷泛恶,身沉头如裹,肢软乏力。细询方知其纳虽少,却喜嗜甘肥,且经停 6 年,形体渐丰,痰多瘦少,入暮下肢肿胀,始悟乃痰瘀水相合为病也。改投八白汤:白附子 5 克,白芷、白芥子各 7 克,生白术、白僵蚕、明天麻各 10 克,白菊花、生白芍、丹皮、川牛膝、当归、葶苈子各 15 克,石决明 20 克,郁李仁、朱茯神各 30 克。药尽 3 帖,诸恙随二便畅行,咯出

白稠之痰而渐松。以白蒺藜 15 克易天麻、白附子,以珍珠母 20 克易石决明,又进 5 帖,头痛续减,浮肿亦消,身体颇感轻松,惟胃纳仍不馨。去葶苈子、郁李仁,加焦楂 15 克、枳壳 10 克,珍珠母减为 15 克,出入调治 10 帖,头痛平息,胃纳日增,后偶因情志不畅或感冒风邪,致头痛复发,以上方损益,一般不出 10 剂头痛和伴发诸症均可安然焉。

按:外伤头痛当以活血化瘀为要,然对朱女投丹栀逍遥散加大黄却未效,是笔者忘却“肥人头痛,是湿痰”(《丹溪心法》)之训,且药偏寒凉,反致助湿凝痰。复诊时考虑患女瘦少肿胀,遵痰瘀水相关学说,投八白汤合归、膝、丹皮活血化瘀,葶苈子、郁李仁引痰浊瘀水由二便下泄(清、陈士铎《辨证论》散偏汤,即取郁李仁与芎、柴、芷、草、白芥子、生白芍相合,治偏头痛),天麻、菊花、石决明可祛风平肝而直接止痛,故能奏功较快。

4、肉瘦急剧肿胀案

黄×,女,24 岁,农民,1989 年 8 月 15 日初诊。

甲状腺轻度肿大已两载,半月前因“双抢”劳累太过,且为暑热所伤,初觉咽痛,干燥不适,继而甲状腺呈明显进行性肿大,胀痛颇甚。其父挖草药外敷 3 日未效。因基础代谢率正常,且无典型的甲亢症状,某县医院按甲状腺肿瘤予药服用,瘤体虽未急剧增长,但颈部憋闷胀痛仍甚,因疑为癌肿,焦虑万分,随父远途求治于余。望诊双侧甲状腺肿大如鸡蛋,难以移动,质地偏硬,但表面光滑,咽喉部阻塞颇甚,致呼吸纳食障碍,心悸烦躁,口干欲饮,便坚溲黄,因哺乳而经停五月。舌淡红,苔白黄浊,脉滑数。拟清热消肿,软坚散结,予八白汤痰瘀并治,合入程钟龄消瘰丸:白芥子、白僵蚕、生白术、黄药子、生大黄、大贝、姜夏、青皮、蚤休各 10 克,白芍、白蒺藜、香附、昆布、生牡蛎各 15 克,元参、朱茯苓各 30 克。药服 5 帖,肿块渐软而缩小,口干减,大便

润,纳略馨,憋闷感轻减,但仍心躁烦,舌红中干,脉细滑数,上方去生军易熟军,并加生牡蛎各 10 克。药尽 6 剂,肿块继续软缩,心悸渐安,大便溏薄,日 3~4 行,去大黄加丹皮 15 克。又服 6 剂,而肿块消散近半,惟纳增不显,渴饮气粗,舌红中剥,脉细滑数,去生牡蛎、大贝、蚤休加麦冬、丹参、柏子仁、炒卜子各 10 克。五诊时,肿块已小如连壳花生果,纳谷较馨,原方加枣仁 15 克,7 剂量共研末,以夏枯草 70 克煎水泛丸,如梧子大,饭后每日服三次,每次 10 克。春节其父喜告,肿块消尽,无甚不适,它症亦基本痊愈,随访至今,未见反复。

按:二版教材《中医外科学》认为:瘰多发生于颈部,漫肿或结块,皮色多不变,不痛,且不破溃,为外科中缠绵难消的阴证。又(细)分为气瘰、肉瘰、石瘰三型,黄女之证与肉瘰颇似,即类同于西医甲状腺良性肿瘤。但因劳累兼受暑热,致血脉因灼热而凝瘀,增生胀痛,且又诱发一派阴虚征象。故予八白汤舍辛温燥烈之白附子、白芷,合入养阴软坚化痰之消瘰丸,加入姜夏、青皮、昆布、香附、蚤休、黄药子,更增行气化痰,清热散结之力。尤妙者,以“除痰实……诸老血留结”之生大黄清解热毒,随大便畅解,痰瘀外泄,诸症明显轻缓。后加入养心凉血之品,标本并举。待肿块缩小大半后,复遵“治慢性病要有方有守”之旨,改丸药缓图,终收全功。

5、经闭浮肿肥胖案

盛××,女 34 岁,会计,1990 年 3 月 16 日初诊。

乳腺小叶增生手术已八载,三年前春天,月经渐稀发,形体渐丰,经市某医院予人工疗法好转约 8 个月,而年底月经又愆期,量仅点滴,色淡无血色。左乳外上方仍有包块如核桃大,质中等,可推移,微胀痛,且躯体、脸面日见丰满,臀、腹部脂肪明显堆积,稍动则气喘吁吁,便艰溲少,白带频下,腰酸力乏,下肢凹

陷性浮肿。西医诊为特发性水肿,予利尿剂,肿虽随小便增多而略退,但它症依旧,尤苦于月经闭止而腹胀渐加,遂来求治。切其脉沉滑,察舌淡紫,苔黄,知系脾虚痰瘀水交阻之证。遂投桃红四妙散合启宫丸,参入桂枝以化气利尿。药服3剂,言便秘不行,腹胀反加,五心烦热,气急更甚。恐系桂枝、苍术、姜夏、川芎过于辛雄燥烈而与证不合,遂改投八白汤:白芷、白芥子、生大黄各7克,白术、白芍、白僵蚕、木通、泽兰各10克,泽泻、川膝、丹参、白蒺藜各15克,连皮苓、连皮槟各50克,3帖。药后呕吐痰涎颇甚,并排先硬后夹粘液样大便两次,脘腹渐觉松快,但两腿酸软无力,行走如踏棉中。遂以防己、熟军易木通、生军,续服5帖。每日均能更衣一、二行,小溲显增,大腿肌肉渐松弛,脚面肿胀消退,气急稍平,但月汛仍闭止不潮。去连皮槟、熟军、丹参,加桃仁、莪术各15克,以益母草50克煎汤代水。药尽5帖乳胀较甚,腰腹坠痛,脉转滑数,似有行经之兆。去莪术,加水蛭10克,续进5帖。3帖后,开始行经,量少色紫黑挟小块,5帖服完,经行又止。去水蛭加丹参20克,以此方辨证损益。15剂后,去泽泻加水蛭,又服10帖,月经二次来潮,量较上次为多,但仍紫黯挟块,延至4天始净。此后平时以八白汤去白附子,加入利水活血药,经前十天佐入破瘀之水蛭,连服三个月经周期后,体重由125斤减至112斤(身高156cm),臃肿之躯而渐臻苗条,月经正常,并能负米35斤而登六楼矣。

按:盛女月经稀发,形体渐丰,颇似现代妇科名家朱南山所言“血走脾经”之证。笔者诊为脾虚痰水瘀交阻,虽为对证,然初诊用药却忽略了便艰苔黄症状,药偏温燥,致变症迭生。复诊投八白汤,去白附子,加大黄、木通、丹参、川膝、泽泻等寒凉通降之品,合泽兰、连皮槟,使痰瘀水随二便畅排而外泄,诸症渐次松懈,惟月汛仍闭止不行,故加用“最喜食人之血,而性又迟缓善

人,迟缓则新血不伤,善人则坚积易破”;“咸入血走血,苦泄结,咸苦并行,故治妇人恶血、瘀血、月闭、血瘕积聚”(参见《本草经百种录》和《本草经疏》)之水蛭,终使月经复潮。若畏惧水蛭“大毒”,而不敢放手用之,则难获佳效。然《内经》曰:“大毒治病,十去其六……勿使过之,伤其正也,”故结合中医时间医学理论,对该病采取了每月前连用十天的“迎病截治”法。

6、更年期综合征

孙××,女,54岁,干部,1989年2月27日初诊。

两年前月经将绝未绝之时,常感眩晕心悸失眠,时欲悲哭,喜怒无常,稍动则汗出如洗,神疲乏力,甚则昏厥。尤苦于神志恍惚,语无伦次,经市某院西医诊为严重的更年期综合征。曾多次住院,然效果不显,故转请中医治疗。问诊除上述诸症仍存在外,尚有头痛如刺,当风尤剧,交睫则恶梦纷纭,耳鸣如蝉,腰酸膝软,纳呆溲黄,大便干溏不定。舌红边有瘀斑,舌下青筋怒张,苔薄白腻,脉濡涩。素有高血压史,服复方降压片,血压维持在20/12.5KPa左右,然肢端麻木,左半身活动欠利,感觉异常。诸证虽杂乱,但病机不外正气不足,痰瘀互结,予八白汤合补阳还五汤复方图之:白附子3克,白芷、白芥子各7克,杏仁、红花、当归、川芎、赤芍各10克,白术、地龙、白僵蚕、白蒺藜各15克,白茯苓30克,生黄芪60克。上方略损益,连服33剂,随咯吐甚多白稠粘痰及经常排出夹粘冻之溏便,自觉头痛缓,肢麻轻,汗收神宁,纳增寐安。但仍感腰膝酸软,脚跟痛,难久立,时有冷气自长强穴直上巅顶,生活虽能自理,却仍艰于外出,去杏仁、红花、赤芍、地龙,加木瓜、鹿胶各10克,龟板、怀膝各15克。又经四诊,上方稍予加减服21剂,遂渐复原如常人焉,除料理较重家务(如洗衣、做饭等)外,且能外出进行体育锻炼(打拳、爬山)。

按:西医认为更年期综合征系由卵巢功能减退,引起内分泌

失调,新陈代谢障碍,心血管系统、植物神经功能紊乱所致。中医大多责之肾气衰退,精血不足,阴阳失调,脏腑功能失常。自上海中医学院创二仙汤(仙茅、仙灵脾、当归、巴戟天、知母、黄柏)燮理阴阳,填任固冲,用治此证,从者如云;对纯属肾衰精亏者,堪称的对良方,而对因痰瘀交阻引起的此证,不可轻投。故对孙女予八白汤痰瘀并治,合补阳还五汤益气通络,使肢麻减轻,活动渐利。黄芪据药理与临床证实,小量能升压,而大量反降压,且患者每日均服降压片,故用 60 克而无碍。继而以远、郁、枣、菖易活血药,使汗收寐安,神志正常。然踵痛膝软,沿督脉经有冷气上窜,终属任督虚馁,故又合入鹿、龟、瓜、膝,使痼疾得以根治。

结 语

考赵学敏所制八白散,原作为金国宫女洗面之方,乃是皮肤科外用之美容剂。然方中的白附子有燥湿化痰、祛风止痉、散结解毒之功,现代药理认为可镇静、镇痛;白芥子温肺利气,性温善走,不仅为驱皮里膜外之痰的要药,且有较强的开郁作用,《本草正》言其“消痰癖痞痞,除胀满极速,因其味厚气轻,故开导虽速,却不甚耗气”。白芷为解表祛风,活血止痛佳品,《本草汇言》云其“上行头目,下抵肠胃,中达肢体,遍通肌肤以至毛窍,而利泄邪气”,药理研究证实有较强而广泛的抗菌作用;白僵蚕咸辛性平,入肝、心、脾、肺四经,可散风泄热、化痰消坚、解毒镇痉、活络通经,含脂肪及蛋白质,白僵蚕还含甾体 II a-羟基化酶系,用于合成类皮质激素,对增强机体防御能力和调节功能,可能有较好作用(朱良春《虫类药的应用》);而白蒺藜却一身带刺,四通八达,走而不守,为“下气去风,行水消瘰之药”(《本草汇言》),又能“凉血养血,亦善补阴……解毒”(《本草正》),张璐取其明目,叶桂用之解郁,《本草再新》更言其可“镇肝风,泻肝火,益气化痰,

散湿破血，消痈疽，散疮毒”，药理证实能明显降压利尿，印度民间则作为利尿要药，且苦辛性平，实为临床应用极广之良药。故笔者认为此五药相合，可广泛用治多种“痰、瘀、水相关”的内伤杂证。但虑五药皆重在祛邪，而内伤杂证大多病程久长，正气偏虚，故合以可气血双补，又能利水化痰的《仁斋直指方》三白散（舍去甘草、大枣、生姜），组成新制八白汤，用治具有形体较丰，或伴浮肿，舌质淡紫胖大，苔白浊，脉偏沉滑等指征的多种疑难病证，邪正兼顾，颇为两全。如能妙于化裁，还可用于治面瘫、癫痫（加天麻、南星等）、耳鸣、眩晕（以白菊花易白附子，辅天麻、钩藤等）、支饮、咳嗽（以白前、白苏子易白附子、白芷，配杏仁、炙麻黄等）、呃逆、痞、闷（以白蔻、白扁豆易白附子、白僵蚕，加姜半夏、炒卜子等）、癰疽、痘痕（以白毛夏枯草、白花蛇舌草易白附子、白芷，伍昆布、牡蛎等）、流痰、流注（以白薇易白附子，赤芍易白芍，参入贝、防、芪、归等）、白带稠粘（以白果、白扁豆易白附子、白芥子，佐乌贼骨、牡蛎等）、体肥不孕（以本方合启宫丸）。然全方药性仍偏温燥，故形瘦烦热，汗、渴、便艰，舌红苔少，脉象细数，出现一派明显热证或气阴双虚之证者，切不可轻易投之。

（马继松、田爱华、陶夏平。原载于《全国首届中西医结合诊治疑难杂症学术论文集》）

六 清化活血汤应用琐言

自董汉良提出痰淤相关学说（见《中医杂志》1980年9期）后，笔者颇受启迪，故宗痰淤并治之旨，并结合五官科疾病热证偏多之理，将化痰活血药与清热药共治一炉，自拟清化活血汤治

部分五官科之热性疾病,获效尚可,简介于后。

方剂组成:银花 15 克,连翘、丹皮、大贝母、苦杏仁、白僵蚕、广郁金各 10 克,白芷、粉甘草各 7 克。痰热较甚,口渴便秘加天花粉、大黄各 10 克;风热表证明显者加薄荷 6 克、菊花 10 克;血热之象明显加紫草、地鳖虫各 10 克;热毒较甚加黄芩 10 克、蒲公英 15 克;久病或有阴伤之象加北沙参、天花粉各 15 克;眼、耳、鼻、喉之病,各可酌加引经药,即眼病加菊花、青箱子;耳病加柴胡、石菖蒲;鼻病加辛夷花、白蒺藜;喉病加桔梗、板兰根。

方中银花、连翘辛甘凉,清解上部风热;大贝母苦寒与杏仁辛温相合,对热痰或偏寒之痰皆可用之;丹皮辛酸苦寒,清热活血;僵蚕、郁金皆可清热、化痰、祛瘀,僵蚕系蠕虫走动之品,又可通窍;郁金具芳香理气之性还能开胃。独取一味辛温之白芷,量少可作反佐,一可防诸药寒凉伤中,又可祛风消肿、止痛排脓;三可借其芳香走窜之性,引领它药共入清窍,而“治阳明一切头面之疾”(黄元御语),粉草清热化痰调和诸药。诸药合用,寒而不凝,温而不燥,且芳散轻扬,善入孔窍,颇合吴鞠通:“治上焦如羽,非轻莫举”之意。大黄苦寒荡涤,既可清热逐瘀,又能化痰,使上焦之痰热瘀血由大便畅下,此即“上病下取”之理,故对体实较壮者常佐用之。素体阴虚或病久呈阴伤之象者,适当配滋阴药,因“水足则火易清,正旺则邪自达”。兹举病案四则以证之。

1、慢性鼻炎伴脂溢性皮炎案。

陈某,男,23 岁,1984 年 11 月 15 日初诊。

三年前曾练气功,数日后,因感面部阵阵烘热潮红而中止。一次感冒后觉鼻塞,浓涕不多,两鼻翼开始发红不退,且渐渐肥厚,表面光滑,微有木感,鼻内觉热,西医诊为慢性鼻炎,脂溢性皮炎,配药外洗内服无效。转请中医外科诊治,服大剂清热解毒,十余剂效亦不显,遂来我处求治。诉其鼻塞时轻时重,鼻出

热气，口干便结，观其颜面潮红，两鼻翼微红肥厚，舌红苔黄腻，脉滑数。知系肺脾积热挟痰淤阻于络间，故拟清热化痰，祛淤软坚：银花 15 克，连翘、焦栀、紫草、丹皮、僵蚕、大贝母、海藻、北沙参、地鳖虫各 10 克，白芷、白芥子各 7 克。7 剂。

复诊 鼻塞、出热气均减，鼻翼红赤稍退，大便仍干，苔前半渐化，根仍黄腻，脉弦滑，前方加生军 7 克（后下），7 剂。

三诊 鼻翼红赤肥厚大减，便润苔化，惟面部仍有烘热感，脉弦弱，痰热随便通而外泄，原方去生军加杏仁、怀牛膝各 15 克，续服 5 剂。

四诊 诸症悉平，再进 5 剂以巩固之。

按：气功乃一种保健祛病之体育运动，然练不得法，反使气血失调，导致疾病，该患者恐系此因。考鼻为肺之外窍，两鼻翼属胃，《素问·刺热论》曰：“脾热病者，鼻先赤”，若脾肺之气失调，痰热淤滞循经上逆而互结，遂成斯症。故以银、翘清泄肺热；焦栀泻脾胃伏火；辅以丹皮、紫草凉血活血；僵蚕、大贝清化痰热；更用海藻、地鳖虫咸寒软坚，通络祛淤，二药和白芥子相伍，对鼻翼之肥厚消散极妙。方用白芷，取其引经通窍；略参北沙参，乃病久当兼顾肺胃之阴也，故初诊即获效机。复诊、三诊更参以生军、怀牛膝，使肺热、血淤随大便畅通而下泄。使三年之顽疾，四诊即完全平复。

2、慢性中耳炎案。

肖某，女，21 岁，1986 年 2 月 24 日初诊。

自幼耳内即经常流水，时轻时重，西医诊为慢性中耳炎。近一周，两耳内又感针刺样疼，且轰鸣不已。检查：两耳鼓膜充血、混浊，右外耳道肿胀，有脓性分泌物，西医诊为慢性中耳炎急性发作，予抗菌素、磺胺片、滴耳油，效不显，故转予诊治。因见内热口干，便秘溲黄，胸闷白带多，舌红苔薄黄腻，脉细滑，故予清

热化痰，活血通窍：①朱茯苓 20 克，银花、连翘、杏仁、僵蚕、郁金、甘草、丹皮、白蒺藜各 10 克，黄芩、黄柏、京菖蒲各 7 克。3 帖。②紫花地丁 10 克，黄柏、白芷、枯矾各 5 克。外洗。3 帖。

复诊：耳内干爽而疼减，左耳仍响鸣，且失眠多梦，舌红苔黄腻，脉细弱，去黄柏，朱茯苓改为 30 克，加柏子仁 20 克，生白芍 10 克。外洗药去枯矾。均续用 3 帖。

三诊：耳鸣渐微，睡卧亦安，大便转软，去黄芩，续进 3 帖收功。追访至今未复发。

按：《明医杂著》曰：“痰火上升，郁于耳中而鸣，郁甚则壅闭矣。”患者喜食辛辣，故予清化为主。因鼓膜充血混浊，复稍参活血之品。内服方中未用白芷等芳香燥湿药，虑其辛散助火，更加重便秘也，将其配入解毒燥湿之外洗剂中，以协助收脓。内外合治，获效得以较速。

3、麦粒肿反复案

翟某，男，3 岁。1985 年 10 月 10 日初诊。

两眼常红赤发痒，反复起麦粒肿，四个月前左下眼睑麦粒肿成熟，术后脓虽排尽，但红肿不消。刻诊两眼红赤发痒，左眼麦粒肿创口局部红肿，且周围硬结，左眼上睑又发一小针眼，但尚未成脓。近三天感冒，鼻流清涕，喉中痰鸣，大便干，舌红苔薄黄。此因热痰与余毒瘀结于眼络，故拟清热解毒，化痰祛瘀：银花、板兰根各 15 克，连翘、丹皮、郁金、僵蚕、大贝、粉草、青箱子各 10 克，桃仁、杏仁、白芷各 7 克。2 剂。

复诊：咳嗽、痰鸣、流涕均减，两眼红赤渐退，左上睑麦粒肿略消，苔黄薄，脉滑，仍从效方出入，再加炒枯芩 7 克。2 帖。

三诊：术后之硬结及麦粒肿均消退，大便转软，其母为防复发，又续服二诊方 3 帖收功。

按：麦粒肿系眼科常见病，此患儿因初患麦粒肿后，热毒未

能及时涤清,故致经常复发,热、痰、瘀互结滞留于眼睑络间,致术后硬结久久不消。方取银、翘、板兰根清余毒,僵蚕、杏仁、郁金、大贝、甘草化痰通络,丹皮、桃仁凉血化瘀,白芷祛风消肿,更加青箱子清肝明目,引领诸药达经归目窍,而获效较好。

4、扁桃体周围脓肿案

胡某,女,28岁,1981年6月12日初诊。

寒热头痛已五天(39.4℃),咽喉亦痛,虽用西药而未减,且咽痛更剧,妨碍吞咽,自觉咽阻痰多,咯之不出,口不能张,言语不清,当地医院诊为扁桃体周围脓肿。但脓未成熟,不便手术,因其对青霉素过敏,改服中药试治。查咽充血鲜红,两扁桃体Ⅱ°肿大,且右侧周围红肿高突,此实即祖国医学之喉关痈也。虑其热毒痰瘀纠结颇甚,当急予清热化痰,凉血祛瘀:蒲公英、银花各30克,薄荷(后下)、丹皮、大贝母、杏仁、僵蚕、白芷、粉草、桔梗、皂刺、炮甲各10克,乳香7克。2帖。

复诊:体温降至38.5℃,然咽痛觉阻未减,口干欲饮,粘痰仍多,大便四日未解,舌红苔黄,脉滑数。原方去薄荷、公英、乳香,加板兰根30克、郁金15克、生军10克(后下)。2帖。

三诊:药后随畅解臭秽黑便而热退口张,粘痰大减,然口干、神疲、汗多,虑其阴液为邪热所灼耗,故去生军加花粉20克。3帖。

四诊:药后诸证悉平,去炮甲、皂刺、板兰根,加玄参20克,3帖以善后。

按:喉关痈乃咽喉病中急重之症。《灵枢·痈疽篇》曰:“痈发于咽中,名曰猛疽,猛疽不治,化为脓,脓不泻,塞咽半日死。”该患者从其声音重浊,言语不清,且自感喉间痰多,知其脓尚未成,此系肺胃积热与痰瘀互结颇盛,乃速投大剂清解,化痰活血之品。然因拘于表热不可早用泻剂,恐引邪内陷之说,未能速投大

黄,以致取效不显。复诊加用大黄,使痰瘀由大便畅解,而热势顿挫,转危为安。由此观之,治喉痹若早用通腑,常可缩短疗程。如恐邪陷,可与辛凉疏解并用,表里同治而取效。一得之愚,仅供酌参。

(田爱华主治、马继松整理。原载于《山东中医杂志》1987年第4期)

七 附马芪鹿二藤汤治痹证之发挥

痹证乃常见多发病也。吾师马继松早年因在江南基层医院工作,鉴于病者感寒、湿二邪偏甚,且多从事体力劳动,体质相对较好,故治此病喜用仲师桂枝芍药知母汤。八十年代中期后因调入城市,见求治的痹证患者,与农村患者病机有较大差异,故不断探求对该病的同病异治方药。87年其在南通市参加全国首届中青年中医痹证学习班,对朱良春名老中医所提“痹证当重治肾”之理十分服膺,并遵照焦树德教授所倡“疏风勿燥血,温散勿助火,化湿勿劫阴”的治痹三要诀,结合皖南医学院李济仁教授重用鸡血藤、活血藤组成“对药”治痹,以及我省名老中医胡翹武用马料豆治痹等宝贵经验,自拟附马芪鹿二藤汤,用治风、寒、湿三气无明显偏颇,或体力劳动较少、或伴糖尿病、高血压等慢性病,或年迈体弱或症状较轻者,获效尚可,现简介如下:

一、方剂组成

附子7-15克(先煎半小时),当归、徐长卿各10克,鹿衔草、活血藤各15克,生黄芪、马料豆、鸡血藤各30克。

二、方义析要

《本草备要》言附子：“补肾命火，逐风寒湿”，《本草汇言》云其为：“通关节之猛药”，故以其合“助气壮筋骨，长肉补血”（《日华子本草》）、又“补肾脏元气”之黄芪为君；马料豆学名野料豆，甘凉，《本经逢原》曰：“入肾经血分”，《纲目拾遗》言：“壮筋骨，……，补肾活血，……，煮汁服，解乌、附毒，”《本草再新》云其：“健脾除风，利湿消肿”；鹿衔草甘苦温，入肝肾，《中药大辞典》云：“祛风、除湿、活血”，《植物名实图考》言：“强筋健骨，补腰肾”，四川、陕西多家地方中草药书均明言其治“筋骨酸软，风湿关节疼，类风湿性关节炎”等，故以二药相辅为臣，以助附、芪补肾益气祛邪之功。当归、鸡血藤均擅补血通络，祛风散寒，为治痹最常用之品；徐长卿辛温，《本经》云：“祛邪恶气”，后世多将其作为止痛要药，如广州部队《常用中草药手册》言其：“祛风止痛，……，温经通络，治风湿骨痛”；《简易草药》曰：“治……筋骨疼痛”。而活血藤学名大血藤，又称大活血，为木通科植物大血藤的茎，性味苦平，《简易草药》云：“治筋骨疼痛，追风，健腰膝”，《中药志》更明言其可“祛风通经络，……治风湿痹痛”，故以此四药为佐使。

三、加减应用

1、上肢酸痛明显者，加防风、片姜黄、羌活、桑桂枝等，加重祛风散寒之力。

2、下肢肿胀麻木或肿者，加防己、五加皮、独活、炒蚕沙、川牛膝等，以祛湿通络为要。

3、指、腕、趾、踝等较小关节疼痛麻胀、屈伸不利，加伸筋草、寻骨风、白僵蚕、桑桂枝等，以助活血通络。

4、肩背痛多由太阳经受寒引起，加羌活、川芎、麻黄（或桂枝）、藁本、防风等。

5、脊背一线冷痛酸软，甚至腰亦不舒，乃督脉虚寒，加熟地、

狗脊、鹿角胶(或鹿角霜)、独活、桂枝等。

6、颈部酸疼、俯仰不利,气血运行不畅为多,加葛根、桂枝、芍药、僵蚕(或全蝎)、川芎等。

7、腰酸软痛,肾虚为多,加熟地、杜仲、川断、狗脊、酒怀膝等。

8、膝痛多为筋病(因膝为筋之府),系因寒湿侵袭而致,常能屈难伸,加酒怀膝、木瓜、苡蓉、天麻(上四药合附子、虎骨为虎骨四斤丸,功能补虚除湿,强壮筋骨,专治肝肾虚弱,致膝不能屈伸,足不能踏地等症)、油松节等。

9、足跟痛或牵及足心痛,不红肿、难任地,乃肝肾阴虚,加龟板、杞子、熟地、酒怀膝、菟丝子等。

10、若病在冬令,或感寒症剧,且体质较好者,以制川乌易附子,但需从小量渐加并先下或久煎,若有舌麻、眩晕、心悸等中毒反应则停用。

上述加味法,系马师遵卫生部首届中医顾问秦伯未的经验结合自己心得所拟。另他还根据 30 多年的临证体会指出:对游走性酸疼,必加乌梢蛇(蕲蛇效更好,但价昂毒性较大);全身性疼或局部疼剧,醋元胡、威灵仙效好(可用 15—30 克);若胃纳可,左秦艽、制乳香、或制没药亦能用;局部灼热红肿,银花藤(30 克)、络石藤、豨莶草、地龙可配入;顽固性酸疼肿胀或关节畸形,用三七研末吞服,瘀象甚者配地鳖虫,挟痰者合白芥子;若摄片见骨质增生,加骨碎补(15—30 克)、补骨脂或千年健,同时加重鹿衔草、鸡血藤用量;如确诊为类风湿性关节炎,定佐雷公藤,其它病致关节顽固性肿胀或畸形,屈伸不利者,亦可选用;痹证用它法效不显时,酌情略参此药(10 克以内),有时可较快缓解;对少数因痹致痿,或同时患痿致肌肉萎缩,肌张力明显降低者,则用制马钱子研末,每次用药汁送吞 0.2—0.3 克,日 2 次,能有一

定疗效。

另他还指出,痹症若配外治,每能缩短疗程。外治法中,最喜用外洗法,风寒湿痹用生川乌或生草乌、猪牙皂各 10 克,南红花、刘寄奴、寻骨风、伸筋草各 20 克,桂枝、艾叶、透骨草各 30 克煎水热洗;而风湿热痹则取蚌埠医学院附院朱希亨主任医师(乃他大学实习时的带教老师)的三草二叶汤(透骨草、老鹳草、伸筋草、桑叶、艾叶各 30 克)煎水后微温而洗。

四、典型病例

1、许女,61 岁,1995 年 5 月 3 日初诊。

糖尿病四载,茹素信佛,20 天前去九华山、峨眉山朝圣参佛,劳累较甚,下山时又被窃,只好坐大轮 5 等舱返回,致感寒湿太过,至回芜湖双脚已呈凹陷性水肿。伴灼热疼痛,按之疼甚,热熨稍舒,步履艰难,瘦短赤热,大便不畅,纳呆汗多,烦躁神疲,舌暗红,苔白浊,舌下静脉如蚓,脉缓滑。此乃内燥阴虚之体,复感寒湿且劳累,遂蕴而化热:制附子 7 克(先煎),当归、徐长卿各 10 克,防己、川膝、黄芪、鹿衔草、活血藤、生白术芍各 15 克,苡米、马料豆、鸡血藤、银花藤、金石斛各 30 克,5 帖。药后溲增便畅,脚肿灼痛均减,烦躁略平,胃纳较增,但虽能在室内移步缓行,若稍多行仍疼痛汗出也,且口渴加甚。上方去苡米、忍冬藤、加醋元胡 20 克,炒蚕沙(布色)30 克,石斛改为 50 克。又 5 帖。痛、渴大减,行走室内已无大碍,它症亦基本平伏,惟多行及日暮后腿脚仍略红肿。去徐长卿、蚕沙,改苡米 20 克,僵蚕 10 克。5 帖。加用朱氏三草二叶汤(各 30 克)5 剂外洗。四诊因诸症悉平,仅脚力较弱,自觉洗脚后较适,加千年健 20 克,5 剂外洗。后随访半年,未见复发。

按:患者因患消渴数载,故素体阴虚燥热可知也,加上旅途被窃,焦虑忧思亦致化火,使大轮上所感寒湿很快随之热变,而

产生较典型的风湿热痹症候。根据朱良春老中医“治热痹恒需用热药”之理,马师投用附马芪鹿二藤汤全方,逐邪止痛,温阳通络,佐已、膝、苡、银加强清化湿热之功,生白芍凉血养血,益营止痛;《本经》言石斛“主伤中,除痹”,《别录》云其治“脚膝疼痛弱,”故重用之以清热除痹,且与白芍相配,甘酸化阴,还可愈消渴也。《本经》言:“白术主风寒湿痹”,且能补脾益气,可防苦寒活血药之伤中。由于药与症情颇合,因而获效较好。二诊洩畅遂去苡米,且消渴过渗利恐耗阴;热减去银花藤,虑过凉有碍气血之下达。加元胡、蚕沙,以增通络止痛之力。三诊用僵蚕,乃因该药不仅能祛风通络且善治消渴矣。因组方作用较全面,痹症缓解的同时,未见血糖明显反复。

2、林女,46岁,宣州市人。1989年11月29日初诊。

类风湿性关节炎已四载,手指梭形肿大伴晨僵一年,未进行过系统连续性治疗,仅于疼剧时服用保泰松、消炎痛、炎痛喜康及祛风除湿止痛之中药,未见显效。近因天冷疼痛加甚,致脚难任地,手难持物,始由亲戚架扶至我处求治。刻诊尚伴腕槽纳少,口干汗多,腰酸便秘,经多色紫。观其形瘦色晦,膝及足趾关节亦灼热肿胀,舌偏紫黯,苔薄微黄,BP120/80mmHg。结合弦细滑之脉与嗜食辛辣史,断为风寒湿邪乘肾阴之虚而久羁不去,且蕴久化火,灼络伤骨,当急予补肾化湿,祛风通络:熟附子7克(先煎半小时)、徐长卿、雷公藤、地鳖虫、三七(研吞)、粉草各10克,黄芪、当归、防己、酒怀膝、鹿衔草、炒熟地、威灵仙各15克,炒桑枝、鸡血藤、马料豆各30克。5帖,并告戒辛辣发物,嘱去西医院作抗“O”、血沉及类风湿因子等相关检查。12月5日复诊,关节肿胀酸稍减,但疼痛依旧,时觉抽掣,余症同前。ASO:800u,ESR:70mm/h,RF(+)。去桑枝、灵仙,加制乳香10克、银花藤30克、附子3克、炒熟地10克。14帖。12月22日三诊:

双手小关节肿消近半,屈伸较利,全身游走性疼痛亦减,但仍酸胀,且腿膝日暮抽掣颇甚,伴面浮纳呆,泛恶晨僵,舌稍红,脉渐扬:熟附子(先煎)、木瓜、三七、防风、乌蛇、雷公藤各 10 克,黄芪、当归、怀膝、活血藤、神曲、生白术芍各 15 克,鹿衔草、马料豆各 20 克,鸡血藤 30 克,粉草 7 克。14 帖。1 月 9 日四诊:因天过寒冷,由其爱人代其转方,告手肿痛及全身疼均显缓,便、纳可,渴、汗大减。但左膝关节肿胀伴腿偶抽掣,泛恶晨僵尚有余症。元旦时行经,两日即止,量亦显减。自觉效果颇好,要求方勿大改:去防风,加钩藤。年关在即,恳购 30 帖。5 月 1 日五诊:限因经济,两日服药 1 帖,诸症基本控制,故协助其夫贩卖蔬菜,下水颇多,晨起又早,近一旬晨僵复现,屈伸欠利,足软腰酸,汗多口渴,纳少便干,月经渐停,舌稍红,脉滑细:附子 7 克(先煎)、乌蛇、当归、粉草、麻黄根、雷公藤各 10 克,当归、石斛、怀膝、神曲、生白术芍、鹿衔草各 15 克,黄芪、活血藤各 20 克,马料豆、鸡血藤各 30 克,14 帖。6 月 2 日六诊:诸症又趋平伏,因天渐热,两日服药 1 帖恐药变质,要求改丸药缓图,遂续予水药 7 帖,又取 10 帖,加三七 50 克,共末为小蜜丸。待汤剂服完,接服丸剂,日 4 次,每次 7 克。另以朱氏三草二叶汤加生川乌、猪牙皂各 10 克,桂枝 20 克,长期煎洗。后通过其亲戚追访年余,虽手指畸形未见明显改观,但它症未再大发,能从事较轻家务,且形体较前为丰。月经完全闭绝。91 年春节,曾让其亲戚劝其化验:RF 为弱阳性。ASO:330u,ESR27mm/h。

按:患者因类风关四载,且断续服对胃肠道刺激较大的西药,致长期纳差消瘦,体质颇虚,故马师始终用附马芪鹿二藤汤出入治疗。初诊因肿痛灼热较显,故附子仅用 7 克,并加地鳖虫、雷公藤、防己、桑枝清热通络,灵仙、三七活血定痛,熟地、怀膝益肾扶虚。复诊因症略缓,胃纳未减,故加重熟地,更佐乳香

以增定痛之力,以大剂银花藤代桑枝,意在去苦寒易甘寒,以求对胃无伤也。然地、乳毕竟腻膈太过,虽疼缓却致纳呆泛恶。因而三诊舍地、乳、已、鳖、银花藤、改神曲、木瓜、防风、白术芍、乌蛇等和胃柔肝,濡络熄风;徐长卿价昂,易以活血藤。此方因效颇好,四诊仅以钩藤易防风增止痉之力,并连服 30 剂,症状得以控制。后因劳累复发,且天渐热口渴汗多,配用石斛、麻黄根(甘苦平,止汗且能通络祛风),症又大减。因该病被戏称为“不死的癌症”,故改丸剂并辅以外洗缓图。马师遵朱良春名老中医之理法,将扶正(以补肾为主)祛邪贯穿于治疗的始终,标本兼顾,因而获效较佳。然检验却未全部正常,乃停药过早,亦足见此病治疗之难。

考雷公藤又名断肠草,系卫矛科植物雷公藤的根(因根皮毒性较大,多数地区如沪、闽、苏、皖、北京等地用去皮根的木质部分入药,而湖北、广东习用全根,量则应减少。芽、叶、花、茎毒较大,多不入药)。上海秦万章最早用其治红斑狼疮及多种皮肤病,根据病情观察及化验结果的改变,认为性味苦寒,有清热解毒、活血化瘀作用。1969 年福建三明地区二院报道用其治类风湿性关节炎,各地仿用颇多,至 1997 年积累例案数千,有效率 87.74%~98.4%,被公认为近二十年来治该病颇有效的新药之一,也有医家将其引伸用治它病所伴痹证症状,多数获效亦可。

据对该药研究达 25 年的南京军区总医院于德勇主任医师认为:本品可解毒清热,祛风除湿,活血通络,消肿止痛,能治风湿痹痛、历节风、疔疮痈疖、皮肤痒疹及跌打损伤,杀虫毒鱼等。其化学成份很复杂(实为一帖相当大的复方),主要有生物碱、二萜及三萜类化合物等三大类,它们具有抗炎、免疫抑制、抗肿瘤、抗菌杀虫等主要药理作用,另对心血管亦有较好作用。其治结缔组织疾病,收效最满意,特别是与其它抗炎药或少量激素合

用,不仅可提高疗效且能减激素用量,同时大大减少了激素的副作用,有替代激素的作用且又无激素的副作用。但长期用药者用时有效,停药症又加剧,再用又效,产生依赖性;且长期用后,虽副作用可减少,而疗效亦减弱,增量也无明显提高,必须加抗炎药以助增效。另该药对消退炎症,改善关节功能较快,但存在着进行性的缓慢的骨质损害,对胃肠道亦有一定刺激,致口干、呕恶、腹泻、便秘及食道烧灼感等。但继续服药均可逐渐减轻并完全消失。对皮肤粘膜亦有反应,少数人会出现白细胞一过性减低。其最为突出的副作用是对生殖系统的影响,女性会月经紊乱、量少、周期延长乃至闭经(马师说也遇多例药后闭经者,但停药3个月后会逐渐恢复,45岁以上者闭经快而又难复潮,提前出现绝经),男性服药三个月以上现精子减少或消失,停药可恢复。故必需先详告患者上述副作用,以免引起不必要的医疗纠纷。

于主任还指出:随着该药在临床广泛应用,中毒报告亦不少,至1987年全国有190例,多系服药过量引起。急性中毒表现为全身多系统的严重损害,如服药量过大且抢救不及时可致死亡。轻症中毒除上述消化道症状外,尚可见腹痛、胁痛、黄疸、便血,用榆槐脏连丸清养止血,以配合西医对症抢救;重症还可见心血管、泌尿、神经系统的较多症状,出现心源性休克、肾衰或中毒性脑病,以西医治疗为主,中医可根据症状按闭证、脱证予以辨治:属阳闭者,投安宫牛黄丸等三宝以清解开窍;属脱证,当予参附汤或生脉散急救之。民间抢救急性中毒时,用新鲜羊、鸭血顿服;鲜连钱草捣汁服;鲜凤尾草或杨梅等煎水或捣汁服;亦有用甘草绿豆汤饮服。马师用该药达数百次,指出如量不超过10克(体强者不超15克),并加入生甘草(10克内),一般不会发生中毒(女性会现月经量少或闭止),强调掌握剂量是用好该药

的首要前提。另勿用芽、叶、花、茎,则无大碍也。由于该药抗炎效果良好,已引起国外研制抗风湿药物学家的关注(如1982年在北京举行的中英风湿病学术交流会上,英国药物学家及临床学家对雷公藤多甙很重视,尤其是毒性最小的三萜类多甙,被认为是抗风湿最有希望的成份),我们如因其有一些毒性就舍弃不用,未免太可惜了。

(马继松主治,赵庆元、贺建军整理)

参考资料:

1、秦伯末著《谦斋医学讲稿》。上海科技出版社,1978年1月新1版,168页。

2、中华全国中医学会南通市分会等主编:《痹证专题学习班资料》1987年11月。

八 昆蛎桔半汤治疗梅核气

我省名老中医胡翘武,经过长期摸索,采用自制“昆蛎桔半汤”内服,配吴萸外敷涌泉穴,治疗“梅核气”取效满意。现简介如下,以资参考:

方剂组成及加减:

洗昆布10克,生牡蛎30克,桔梗6克,射干10克,清半夏10克(最好用竹沥夏),杷叶10克,紫菀15克,茯苓24克。

痰多难咯者加白芥子6克、杏仁10克;暖气频作者加旋复花10克、刀豆子10克;肝郁湿热尤甚者加川贝10克、夏枯草10克;脉细舌红阴虚较盛者则酌加麦冬、元参而减半夏之量;痰湿偏盛者,去牡蛎、射干,加厚朴15克、陈皮10克。

外用吴萸研末以醋调敷两侧涌泉穴,布包紧,日一换,以愈

为度。

病例介绍：

1、王××，男，42岁，农民。患者咽中如有絮状物堵塞已一周，吞不下，咯不出，且觉咽喉外肌肉有如火灼，痰白稠多而难咯出，两脉浮滑有力，舌偏红，苔淡黄，饮食二便如常，西医检查未见异常。患者素嗜甘肥烟酒，而病发于怒争之后，显系肝火挟痰热上攻所致。用清肝开郁，上利下导之法：昆蛭桔半汤加白芥子5克、杏仁10克、川贝10克。外用吴萸研末以醋调敷涌泉。先后诊治三次，方药略有增减，共服12剂，外敷四次全愈。

2、张××，女，26岁，农民。患者脉细数而滑，舌红苔黄略干，自觉咽中如有物堵，梦多寐难，脘膈便艰，口苦纳少。显系肝郁化火，痰凝气滞，昆蛭桔半汤去茯苓加朱茯神15克、桑叶10克、胆星6克、麦冬12克。4剂，外敷如上。以初诊方增损诊治四次，服药14剂而愈。

3、张××，女，46岁，独居多年，情怀素郁不畅，近忽停经三月，倍加虑忧。从此咽中感觉有物阻塞不利，吞不下，咯不出。被西医诊为慢性咽炎，经服消炎药和含喉片未效。诊见面黑形削，目眶下青，少腹隐痛，时有低热，而脉沉细而疾，舌红苔少微黄。予生牡蛎30克、昆布12克、桔梗6克、竹沥半夏6克、杷叶10克、射干10克、桑叶10克、川贝10克、夏枯草10克、当归10克、丹皮10克、郁金10克。吴萸外敷如上。上方服6剂后经通，咽阻塞如失。

按：本方以昆布、牡蛎为主药。昆布咸寒具滑利之性，《别录》谓其“主癭瘤聚结气”；《便读》谓：“功用相同海藻，”即“咸寒润下之品，可软坚行水，疗一切癭瘤癭瘤顽痰胶结之症”。上述梅核气乃系肝郁化热，痰瘀交阻致气机升降失畅所致，故昆布最为对症。牡蛎咸平微寒，潜阳软坚。《本经》曰：“主惊恚怒气”；

李时珍谓：“可化痰软坚……消疝瘕积块，瘵疾结核”；张璐在《本经逢原》中更云其“可散内结之热”。其与昆布配伍，可咸寒相合，滑涩互济，共收清郁火，化痰热之效。桔梗、紫菀性浮，升肺气达咽而豁痰，半夏、杷叶性沉，降肺气于胃而坠痰，四药为辅，大可调畅气机，气顺则郁开痰消。本病虽有热象，但仅用一味苦寒之射干，不欲直折其火势，而取其引经报使，且射干最能引肺热至大肠，故本方服后，常得微泻，使痰热由大便而外泄也。但因上七味皆祛邪之品，故胡老独予较大剂量茯苓莫安中州，以杜生痰之源；益气健脾，和调它药之性。药仅八味，却能做到当升者升，当降者降，配伍极其严谨，祛邪却不伤正。恰如《临证指南》郁证门华岫云按：“郁则气滞，气滞久必化热，热郁则津液耗而不流，升降之机失度，初伤气分，久延血分，延及郁劳沉痾。故先生用药大旨每以苦辛凉润宣通，不投燥热敛涩呆补，此治疗之大法也”。故用治因肝郁化热，痰瘀交阻型之梅核气能有良效。

《纲目》云：“咽喉口舌生疮者，以吴茱萸末醋调，贴两足心，移夜便愈。其性虽热，而能引热下行，亦从治之义也”。故胡老遵用此法，以配合汤药使疗效更速。

（胡翹武主治，马继松整理，原载于《吉林中医药》1982年第4期）

九 清肺益肾汤治小儿遗尿

遗尿一证，多见于儿童，成人亦偶有患之。历代医家认为系肾与膀胱虚冷为患，每用补肾壮阳固涩剂，从肾与膀胱论治，

有效者，亦有不效者。马师指出成人患遗尿，大多系儿时患此疾失治、误治迁延而成，病程较久，虚象亦多，故投补肾固涩，确为正治之法。儿童遗尿，若伴明显体衰，或先天秉赋不足，或小便清长者，可予补肾。不效者，可遵《内经》“饮入于胃……上归于肺，通调水道，下输膀胱”之论，应用清肺热，益肺气合固涩之法，治疗白天小便频数短涩且喝水较多患儿，获效尤彰。盖水饮在进入人体后的化生和输布过程中，与肺主治节所起的“宣发”、“肃降”的生理特点密切相关，“宣发”即开发上焦，使肺主一身之气的作用得到保证；“肃降”可“通调水道”，以便协助膀胱发挥“气化”的功能，这正是张景岳强调的“小水虽利于肾而肾上连肺，若肺气无权则肾水终不调摄，故治水者必须治气，治肾者必须治肺”观点的具体体现。

马师临证每用生石膏配生山药组成的对药为君，合入李东垣用知母、黄柏、油桂配制的滋肾通关丸为臣，佐入乌药、益智，使药多用五味子。一般均以此八味组成基本方，若神疲面觥，加生黄芪；口渴较甚，加北沙参；遗尿次数较多，加煅牡蛎。辨证转方，灵活机变，较纯用补肾固涩，疗效明显提高。

曾治一七岁女孩王某，系市铜网厂子弟。初诊 1988 年 6 月 8 日。遗尿已近三载，每夜约 7~8 次，量少色黄，白日亦尿频量少，平素喜嗜辛辣，性急喜闹，形体欠丰，西医检查未发现明显器质性病变，叠服中西药疗效不显，家长甚为苦恼。马师诊其舌质光红，苔白，脉弦数，其常干咳，嗜凉，结合前述脉证，断为系肺热下迫膀胱，膀胱气化受阻，而致肾气封藏失固发为斯证。处方：生石膏（先下）15 克，山药 20 克，南沙参 12 克，桔梗 7 克，乌药 5 克，油桂（后下）2 克，炒知柏各 7 克，生牡蛎 20 克，生黄芪 15 克，益智仁 7 克，五味子 5 克，3 帖，并嘱勿食辛辣。6 月 12 日二诊：药后一夜仅尿两次，喝水亦减，唯咳嗽咽痛痰少，前方加大力

子 12 克,粉草 6 克,改桔梗 10 克,继服 3 帖。6 月 19 日三诊:夜尿已能自觉,咳嗽咽痛亦除,予首诊方去桔梗,加桑螵蛸 5 克,改南沙参为北沙参 15 克,肉桂 3 克,乌药 7 克,再服三帖以善其后。随访一年,仅晚间喝水过多或兴奋太过,偶有小发,但按三诊方服药一帖即可止,且形体渐丰,神情较前安定。

(马继松主治、陶夏平整理。原载于《新疆中医药》1992 年第 4 期)

卷六 奇难医话医案

一 药得奇效话“瞑眩”

“瞑眩”原指昏糊眩晕之意，语出《尚书·说命》“药不瞑眩，厥疾弗瘳”，其意是指病人服药后，若不产生昏糊眩晕的反应，则药物对顽症痼疾就很难奏效，现在即泛指服药后没有一定的药物反应，治疗效果则欠满意。

历代医家对“瞑眩”现象均较重视，如东汉张仲景在《伤寒论》、《金匱要略》中对此记载颇多，如《伤寒论》46条曰：“太阳病，脉浮紧，无汗，发热，身疼痛，八九日不解，表症仍在，此当发其汗，服药已微除，其人发烦目瞑，剧者必衄，衄乃解，所以然者，阳气重故也”，此处之发烦，目瞑，正是“瞑眩”之表现。在《金匱要略》白术附子汤方后云：“一服觉身痹，半日许再服，三服都尽，其人如冒状，勿怪，即是术附并走皮中，逐水气得除故也”。乌头桂枝汤方后亦有“其知者，如醉状，得吐者，为中病”的记载，此处之“如冒状”、“如醉状”即是“瞑眩”。再如《伤寒论》154条、104条服柴胡剂后“必蒸蒸而振，则发热汗出而解”之“身振”，可看作眩晕，身颤动致行走不稳，至于“发热汗出而解”，乃指机体得到药力帮助后，“上焦得通，津液得下，胃气因和”的抗邪结果，此种“身振”、“发热汗出”并非病态，而是用药奏效之佳兆，即广义“瞑眩”反应。另《金匱要略》防己黄芪汤方后言：“服后当如虫行皮中……差”，而在桂枝去芍药加麻黄细辛附子汤方后更明指：“当汗出，如虫行皮中即愈”，都是药力奏效，推动阳气运行，驱逐湿邪的广义的药后“瞑眩”现象。

“瞑眩”产生之因颇复杂，清·莫文泉认为是“病被药攻，拒

之使然”，(《研经言》)，周慎斋称作“邪寻出路”所致(转引周学海《读医随笔》)。仲师也有“阳气重故也”和“术、附并走皮中，逐水气未得除”之论述。笔者结合临证体会，认为“瞑眩”现象是药与证符、剂量恰到好处，且机体正气未衰，有足够的抗邪能力，机体对药物又十分敏感等多种因素而造成的，如没有这种药与证相互作用后机体产生的积极反应，那么药物治疗(尤其是顽证痼疾)的效果，一般则较有“瞑眩”者为差。不仅仲师常用“即解”、“即愈”、“差”等，来强调有“瞑眩”现象患音，药治疗效的卓越，不少名贤还通过各自验案证实了这点。如北宋许叔微治李信道伏阳肢冷，与破阴丹，不半时烦躁狂越，许曰：“此换阳也”。逾时，果汗出而定。清代赵晴初治某伤寒失下，与四物承气加减，片晌，腹中剧痛欲死，口噤目瞪，不省人事，至天明下黑粪累累而解(周学海《读医随笔》)。现代名医岳美中在总结前贤和自己大量的临证经验后，颇有见解地指出：“深痼之疾，服药中病即瞑眩，瞑眩越剧，奏效越宏”(转引自《安徽中医学院学报》1986年2期45页)，并作诗赞曰：“瞑眩力能瘳厥疾，催锋陷阵仗雄师”(《岳美中医活集》)。为进一步论证岳美中等的言之有据，特摘录一例验案以佐之：

娄女 34岁 1988年4月29日初诊

少时家贫，常下水田劳作，22岁婚后，和夫摆鸭摊为生。因长期低头制鸭，并操刀卖鸭，渐感颈部酸胀，肩背不适，上肢时麻木沉重，被诊为神经根型颈椎病，牵引推拿后略缓，但无暇坚持，故转清余治。刻诊除上述症状外，尤苦于头部昏蒙似裹，如有物压，双眼上睑重坠，沉困难睁，几乎无法持刀、镊卖鸭、制鸭。伴现形体较丰，脘闷纳少，太息泛恶，便溏恶寒。脉偏沉缓，舌淡紫胖，齿印颇显，苔白黄腻。认证为中气不足，湿瘀交困，予补中益气汤合活血通络，加苍术、厚朴，迭进十剂未效。细思其长期与水打交

道，冬日亦常下冷水，恐非大剂辛温燥湿配升运脾阳佐活血通络而难效，遂仿李杲升阳举经汤意，投白苍术、葛根、党参各 15 克，羌活、藁本、川芎、防风、干姜、桂枝、白附子、白僵蚕各 10 克，细辛 5 克，生黄芪、鸡血藤各 30 克。3 帖。甫服一帖，即觉有股气自胸阵阵上腾，颜面先热后痒，头反昏沉加甚，小憩片刻即舒。二帖药后，面痒加甚，并出红疹，但头昏沉转轻，头部如物压之感渐减。三帖后，随红疹转多，搔抓出淡黄血水，不仅头更轻松，眼睑亦可上抬。后用上方略损益，曾用生麻黄易细辛，白芷代防风，全蝎换僵蚕等，但大法不变，每次药后，均随气之升腾而面出红疹，出后即感脘畅神振，头昏沉、眼难睁遂减，颈、肩、上肢亦颇舒适。但因无法不下冷水，且日日低头操刀，月余后诸症始趋稳定。后改制药丸两公斤，症方大缓。

综上看之，“瞑眩”虽为一种正气抗邪，有利愈病的积极反应，但因广义的“瞑眩”能有多种表现，除前所述的“发烦”、“目瞑”、“衄”、“如冒状”、“如醉状”、“呕吐”、“蒸蒸而振”、“发热汗出”、“如虫行皮中”、“烦躁狂越”、“口噤目瞪、不省人事”等，秦德平、胡剑北还指出：在用半夏泻心汤合旋覆代赭汤治行胃次全切除术后发生剧吐患者时，发生“胸脘似有大量气体下压，肠鸣音亢进”，及用软散消瘿，疏肝理气法治一甲状腺腺瘤时，发生“肿块局部似有虫钻样疼痛”等广义“瞑眩”现象。有些“瞑眩”现象似和药物中毒现象难以截然区别，特别是有些药物本身有一定毒性，服后中毒反应和“瞑眩”更易混同。如附子、乌头均含有毒的乌头碱、次乌头硷等多种生物硷，用量稍不当或未能久煎，常致患者有舌麻、头晕的中毒反应，故近贤金寿山认为在服白术附子汤或乌头桂枝汤时，若发生“如冒状”、“如醉状、呕吐”已是药物中毒现象，不可拘于属“瞑眩”中病。连非常重视“瞑眩”现象的岳美中，也在其医话集《用药当知毒药的利害》一文中指出：“附子

用小量则兴奋,大量则麻醉。伤寒论方中,附子最大量用至三枚,也不过一两,如桂枝附子汤,去桂加白术汤等,但方后注谓:“三服都尽,其人如冒状,说明已有昏晕反应,正是治疗限制,所以临床使用附子一般以不超过一两为妥”。故临证对药后反应,须严密观察,除了把它和心理反应相区别外,更重要的是要把它和药物的毒副反应相区别。

笔者根据近三十年的观察,认为“瞑眩”与药物的毒副反应之区别有如下数点:一是服无毒药物发生的反应,虽较剧,亦可看作为“瞑眩”;而服用药书上注明有毒的药,虽反应较轻,亦应视为中毒。二是药后原来的症状减轻或消失,虽有反应,多为“瞑眩”;若原症不减,甚至反加重,应考虑中毒。三是“瞑眩”反应即使剧烈,但较少有四大生命体征(血压、呼吸、脉搏、体温)同时发生改变的;而中毒反应常会发生四大生命体征同时改变的严重情况。四是若二者难以当即明辨,可暂停药观察,服药反应很快消失的为“瞑眩”;若反应消失较慢,或不消失甚至持续加重则为中毒,应立即抢救。

1978年10月,某县四名小学教师为庆祝被摘右派帽,相约欢聚饮酒,将饮,一人说岳丈处有三七酒,饮当有益健康,遂取共酌。后三人相继昏倒,口吐涎沫,呼吸困难,另一仅饮不足一钱者急电告县医院。医急至其家,饮最多者已死,将另三人与酒瓶急送医院。经中药师鉴定,酒瓶中三枚浸泡已很大的棕黑色圆锥形药,非三七乃草乌也(后据死者岳丈告,他每至冬天,筋骨疼痛,隔日饮此酒钱许,以驱寒定痛,药已泡近月),遂按乌头碱急性中毒用大剂阿托品抢救。所憾,一人也因中毒较重,翌日发生阿—斯综合征而亡;一人虽脱险,住院二旬始愈。故临床在用毒药治病时,应学习仲师应用毒药的配伍经验及煎、服药方法(张仲景用乌头或附子等毒药时,常根据中药配伍七情和合中的相畏、相

杀理论,将其与可制约或杀其毒性的蜂蜜、熟地、生姜、甘草等相合;或是将药久煎;或是“不差,明日更服,不可一日再服”),这样,则既可达到“瞑眩”目的,亦可避免产生中毒的不良后果。

(马继松、彭绍荣、承忠委。原载于《江西中医药》1990年第3期)

二 癫狂医话四则

1、细询病因,巧配开导,疏肝活化愈病

1983年底,我市一单位陈女因其小妹患精分症,在沪断续服西药,时缓时甚,终未痊愈,经罗女(见后四)介绍,求询于余。告其乃7弟妹中最小者,因聪丽活泼,极受家人喜爱,父尤娇宠倍加,致其个性偏强。10岁入选沪少年游泳队,12岁被选拔将出国参赛,恰文革开始,查其父有“历史问题”未让出国,急怒之下,遂烦躁失眠。三年后下放崇明农场,又受数小青年恐吓,遂表情淡漠,少与人往来,常对墙独坐流泪,甚至无目的在场内乱跑,自言:“游泳”、“得金牌”、“历史问题”等。被诊为青春型精神分裂症而遣返。住院治疗稍缓,出院后长期服抗精神失常药,仍少语喜卧,懒散懈怠,食饮须家人敦促再三,方进少许。一见其父,则怒斥不已,盛夏令年过半百之父在烈日下跑步,迨汗出如雨,气喘吁吁,几欲昏仆时,在多人劝阻下始让停止。有时独自大笑“我得冠军了”,并常反复从床、桌上以游泳入水姿势往下跳,如违其意,即吵嚷欲自尽,家人终日防范极严,深受其扰而又忧恐难言,欲送住院但拒去,只好以西药长期叮嘱服之。余请将其妹带来芜游,84年春节后,患者在其姐与姐夫强制下暂移居我市,余应邀而往诊。见其面色晦滞,口时流涎,动作迟钝,表情冷漠。勉诊其

脉，弦细而滑，察舌淡紫，苔白黄浊。百问只说无病，并怀敌意说：“医生都是骗子，没有一个人好人，你走我不吃药”。余知若不了解详尽病情，则难对症用药。故向其姐细询其兴趣爱好。其姐告：“除游泳外，其最爱看小说，尤其是童话”。翌日我复去其家，不言其病，却和其姐大谈起白雪公主，卖火柴的小女孩，皇帝的新装等安徒生的童话，她十分注意地聆听，并不时插话：“白雪公主是好人”，“卖火柴的小女孩真可怜”，并大笑“那个皇帝是个大傻子”。于是我顺势开导她：“您也是个象白雪公主那样的大好人”，她十分高兴地点着头。我又说：“您生这个病，真象卖火柴的小女孩一样可怜”。她大叫：“我是被陈××(指其父)害的，否则我可在国外得金牌，为国争光”，接着便伤心地大哭。我和其姐劝慰说：“您刚 30 出头，如愿吃中药，将病治好，可去少年宫当游泳教练。若能结婚有了孩子，今后可培养当游泳运动员”。她立即止住哭，连说：“我吃药，我吃药”。我询其月经常三月两行，或五旬一至，量少色紫。经期乳胀颇甚，平时极喜太息，且纳饮虽少，形体却尚丰。知其情怀失畅过久，血运迟缓凝瘀，加之少动嗜卧，气滞脾虚，瘀遂化痰，痰瘀互阻包络，扰乱心神而病作矣。投逍遥散合自拟新制八白汤损益。服药颇适，后始终以疏肝、活血、化痰为法，辨证参以健脾、养心、利湿、祛暑等药，时用汤剂，时用粉散，时用丸药，半年后一切渐趋正常，返沪上，年内与上海电影制片厂一职工完婚，并经该厂照顾，安排做房产登记等较轻工作。86 年举一女，合家幸福。95 年因下岗，病方复萌矣。

2、耐心观察，结合季节，芳化淡渗收功

郎溪县毕桥镇 18 岁陈小蛮子，其下放时住大队会计家，相处甚恰。1970 年春，该会计被疑为组织反革命集团被捕，其也被

带至队部，勒令其交代“罪行”并让检举房东，否则必逮捕严惩。当晚受吓外逃，天明家人在镇边一户人家杂物房内找到昏睡的他，让他回家，他却高叫：“我无罪，不要逮我！”一会又喊：“我有罪，坦白交代！”力逾平时数倍，挣扎又逃远处，数壮汉协助绑其而归。路上仍叫“无罪”“有罪”等，且不知自己名姓及其它极简单之物、事。其父急延我治，余见其起病突然且脉症皆实，予程钟龄生铁落饮，3剂却如石投水；继进龙胆泻肝汤合大承气，虽解溇便数行，但烦躁稍平复甚；虑苦寒迭进化燥伤阴，易天王补心汤，反太息痰多；转用十味温胆，痰涎略少神志却仍异常；最后又改投柴胡龙牡汤，亦无效。家人见近月而病依旧，遂采用跳大神、收吓等，仍终日喃喃自语，神志时昧时清，成天卧床懒起，无法自理生活。甚至见其时而目闭，时而凝视，面无表情，推之不动，呼之不应，对一切刺激反应极少，遂筹款赴宁。被南京精神病院诊为紧张型精神分裂症，予电针强刺激疗法，月余渐缓，却因针刺部位搔痒抓破感染，改换它法效又不显，且经济紧张而返回。因医院离其家很近，故有暇我即至其家，经多日观察，发觉其隔数分钟即小溲，量少欠畅，色偏黄，并长吁短叹，以手抚胸，伴腿脸轻浮，舌胖大有齿痕，苔白水滑。时正值梅雨季，江南农村淫雨连绵，其所居平房，湿气极甚，故认定此期之病与暑湿有关。遂开大豆黄卷、冬瓜子、苡米、茯苓、六一散各30克，佩兰、泽泻、生白术各15克，郁金、法夏、大贝、杏仁、厚朴花、石菖蒲各10克，白蔻（后下）、苍术各7克。3帖。家人欲秋凉后仍赴宁，原不想购药，却被我精神所感，且药价极廉，遂配3帖，强制其服下。未料病情就此出现转机，家人喜不自胜，敦促转方。后以此方进退，曾用过藿香、甘松、香元、木香、陈皮、蒺藜、百合等药，药尽50帖，除完全自理外，且能参加较轻农事矣。

3、“成竹”横梗，误虚为实，苦寒迭进症剧

1994年9月，我在皖南医学院一门诊部坐诊，有章小马者，男17岁，患精分症两载，其姐偕其求治。告其饭量惊人，日食2斤许，喜食肥肉、辛辣，常1人外出，捡食他人弃物，家人无奈，索锁于屋，若供食稍慢，则大声吵闹。视其形丰色晦，表情痴呆，目转欠灵，退缩不愿多言，舌胖苔白厚，脉沉滑，二便均少。因见其求医购药者不断向自己投来异样目光，小马遂拽姐衣角，催其离去。我却自认为胸中已有成竹，肯定系阳明腑实之症：燥屎不去，必火化上逆，胃中热甚，焉能不消谷善饥？故不复详询，遂书大承气汤加赭石、胆星、大贝、竹黄、黄连等。詎知服药一帖，腹泻数行，翌日进二帖，竟倾囊吐出，不再吵扰进食，反畏缩墙角，四肢发凉，气弱力乏，颤抖难立。其姐速告我，自知药不对症，乃细询病因。其姐告：因家境较贫，小马自幼病多，智力亦受影响，成绩差，小学留级两次，自卑较甚。6年级时，因怕考不取中学，弃学离家，找回被长其10岁之兄猛打一顿，后遂不愿和人接触，胆小畏缩，生活懒散，感情淡漠，思维贫乏，一年后益甚，且食欲亢进，食后即睡，形体虚肥，除外出觅食，从不上街。另畏寒亦剧，未届深秋，即欲穿棉。被西医诊为单纯性精神分裂症，但服西药未见显效。余结合初诊舌、脉，知非大实证，乃心、脾、肾虚也。前贤“中虚求食”之论，与此颇合。故改用上海周康主任所拟壮阳汤进退，予附片、干姜各7克，仙茅、仙灵脾、陈皮、巴戟天各10克，党参、黄芪、白术芍各15克，熟地、茯苓、制首乌各20克。药尽3帖，吐泻止，四肢温，能站立行走，后去仙茅、巴戟，易姜南星、白芥子各10克，又5帖，神情渐振，食欲颇减，不畏熟人，并能交谈数句，回答不过于离奇。限于经济，未再治疗。

4、过于“夺食”，医嘱欠详，狂证衰竭而亡

罗女，58岁，1982年患精分证，经予治愈。1998年10月，其夫回远地原籍探亲，因病未按时而归，其焦虑太过，常难安眠。复因与其小女婿呕气，急怒伤肝，病又大发。终日喋喋不休，骂詈不已，甚则外跑，彻夜少眠。其子女邀我往诊，见其目光灼灼，唇如涂朱，两颧红赤，舌瘦紫，苔黄少津，按脉弦滑而劲。子女言其大便干少，但纳谷颇旺，力气逾常数倍。故认证为肝火引动胃火，逆上扰心。遂予大承气汤加金礞石、煅磁石、青龙齿、柏枣仁、北沙参、夜交藤等，并按《内经》“夺其食则已”之言，嘱子女适当控制饮食，尤勿进辛辣之品。3日后复去其家，子女高兴告：药后腹泻数行，加之控制饮食，并配服安定2[”]，每日能睡七、八小时，现正睡着，我未敢打扰而返。谁知又过四日，其邻居告我，其夫昨日返回，见其昏睡沉沉，呼之少应，表情淡漠，冷汗阵出，疑病有变，即送医院抢救。后终因低血糖过久，衰竭不治。其夫告曰：“其子女听您说应控制饮食，遂不主动予食，加之被其久扰，多日亦未安卧，劳困不堪，见其神疲嗜睡，误认病已好转，他们亦稍事休息，忽略经常询视，致酿此祸端。”我闻之，亦深感愧疚，如当时医嘱能详尽一些，预告遇嗜睡应防休克，想不会遭如此惨变！为医者一言一行，均与患者性命攸关，能不慎乎！

(马继松)

三 医难为医话十四则

1、湿温未尽愈，违医嘱，“食复”骤变

1978年秋，余调芜湖县医院未久，有熟人之子孙火保，26

岁，体颇壮实，从事搬运，患肠伤寒，因对西药过敏，故求治于余，时中医科开设4张病床，遂收住院。经半月诊治，服三仁汤等，并严格控制饮食，进流质、半流质，症已日轻，中秋节前一日，化验亦转正常。遂告可进软食，5日内若无反复，则可出院。

未料翌日夜半，有人急促敲门，惊醒余全家，询知乃火保妻，开门后她扑通跪下，哭：“火保危险！”余即随往。路上她告：今晚中秋节，家父邀火保共饮。因其半月未进荤，又自认病已愈，故忘掉您‘近阶段不要进油炙煎烤、大荤辛辣之物’的嘱咐，吃得较多，1小时前腹痛较剧，大便中挟有紫黯之血，人感烦躁难宁，半小时前又便血1次，遂昏沉难支，汗出身冷，面容惨白”至病房，悉如其言，量血压60/40mmHg，诊脉细数，察舌淡白津少，知为肠出血，即中医所谓“食复”导致的“漏底伤寒”也。此病虽危险颇大，但患者未发热，且大便后腹痛渐缓，加之体质好，故我即叫醒药房小王，秤红参片10克，口中含嚥一刻钟后，待烂缓咽。另取红参、地榆炭、炙甘草各10克，白芨、白术、白芍各15克，银花、焦查各20克，仙鹤草30克，炮姜7克，急煎服。并请外科会诊，医生查后言不会立即生变，同意服中药观察，如继续便血，即送手术室。药后半小时，汗渐收，肤稍暖，血压未再下降，嘱安卧。过2小时，欲进2煎药时，量血压已为70/45mmHg，余心稍定。但未敢合眼，和其爱人一直守护至天明，量血压为80/55mmHg，且喜未再便血，又购原方一帖，转危为安矣。

（马继松）

2、已孕衄经至，投活化，误使胎坠

1969年初夏，余至毕桥未半载，有小两口争吵，女方言被男方张木匠打伤，而至医院治疗。余见女方四肢有数块青乌斑块，面部亦有青肿，即欲用活血药，但又恐其怀孕。医院一兼搞化验

的妇科医生去上海探亲,只好询其月经情况。告此次经行刚数天,并无任何妊娠反应(两年前曾生一女,因故夭折),且言因和其夫感情极差,已数月未同房矣。我信其言,而投王清任身痛逐瘀汤,除用桃、红、芎、膝、没药、灵脂等外,更以10克地鳖虫易地龙,并言服后疼痛肯定减轻。詎料傍晚时分,来了一些人,说张木匠老婆的胎被马医生打掉了,现出血不止,要西医赶紧急救,西医与一护士去其家,进行了止血处理。因其23岁,体质颇好,故未酿大变。事后未至一月,女方坚持离婚,双方离异。离异后该女私告我院一与她关系颇好者:“我当时停经已近两月,谎告马医生未孕,否则他绝不开打血药,若胎不掉,生了孩子,就无法和木匠离婚了”。吁!天下竟有拿自己生命作儿戏者,农妇无知,既害自己,又险害医生,为医之难,信不诬焉!

(马继松)

3、处方潦草,乳香过量致呕

1980年9月,某卫校毕业班学生至芜湖县医院实习,有一姚姓小青年随我待诊抄方。一妇女痛经数月,每次经前用血腑逐瘀汤加减均可暂效,故我亦用该方去桔梗、地黄,加香附、乳香。谁知翌日患女来告,药后即呕,并言煎药时的气味比前几次难闻得多。我思忖方药均为其曾多次服用过的,且是一般剂量,是否为药发错了?即让其取药来辨。将剩余的两包药中之一包倒报纸上,发现有不少乳香。又查另包药,乳香亦不少,均远远超过病历上所开7克之量。遂去药房查看处方,见小姚写的字带点“美术体”,将7写成7,药师遂误发17克。考乳香又名熏陆香,含树脂60~70%,树胶27~35%,入煎剂汤液混浊,其味本已甚苦,况又多用醋制,胃弱者极易动呕,常人若超10克量,胃亦感不适,此女误服17克,呕则难免焉。忆及芜湖市某大医院,一名望

颇高之老医生,在带教实习生时,由于一时疏忽,对学生因马虎而写错的剂量未能察觉,导致医疗事故,从此一蹶难振之事,面对患女与药师,余脸红、心悸、汗出矣。

(马继松)

4、药物霉变,大黄下咽即吐

1990年底至1999年春,余受聘于皖南医学院一门诊部,每周日上专家门诊。92年6月底,一近40岁吴男患肝炎求治。因从事房屋开发,常和人共餐于火锅城,致湿热从阳而化,现热耗阳明胃肠津液之证。常数日一更衣,便结如羊粪,于是用茵陈蒿汤加味,开生大黄10克。考虑方内山栀、虎杖等均可泻下,患者体质不算太好,遂将生大黄与它药同煎,防泻下太过也。他携方去一定点可报销之医院购药。第2天其气势汹汹来门诊部告负责人,我开之药服后即吐,大便仍未通,定看错病了。我被电话喊去,将其带的一包药倒出和方对照,药均相符,量亦相差无几,惟大黄由于连日阴雨,霉变颇甚。余思山栀、虎杖等虽可致呕,但和大黄同服,若得泄泻,胃气下行,则极少会呕。今大黄因霉变已失泻下作用,反更促使较多苦寒药碍胃故吐作,遂正告其吐与大黄霉变有关。他不信,我遂与其同去药房,自费购原药一帖,让其带回煎服。下周日其复诊时告:“药后大便畅行甚舒,并未再吐;我错怪您了”,且归还我为其购药之款。噫!中药之质量乃保证疗效的关键,因质量之差致影响疗效之事,时有发生,若效不理想或发生反应便怪罪医生,医生岂不冤哉!

(马继松)

5.5 帖附子一剂服，病人腹泻难起

1973年4月至76年底，我被芜湖中医学校借用，授课之余，参加校门诊临床。

73年深秋，有半百之盲人邵某，咳喘来诊。其在砂制品厂二十余载，患肺结核多年，经治去年钙化。现因凉燥致咳，痰多黄稠难咯，咳甚则气急胸闷，纳少便秘，形瘦骨立，舌黯红苔黄浊，脉细滑，按其胸略痛，似为一派痰热结胸之象，遂投小陷胸汤合三子养亲汤加葶、杏、茯、贝、白术、条参等，5帖如石投水，大便不仅未行，且咳更无力，纳谷亦减，咳甚洩失禁，伴畏寒腰酸，苔转白滑，脉偶停搏。余悟前方偏寒，若无阳药之助，药效难以发挥，当参入温阳强心之品，此类药以附子为首选，虑其原有结核，故仅用5克，并注明先煎半小时，它药未作大动。一周后未见其复诊，余心惴惴难安。又过一周，患者前告：“上次那包先煎之药，服后胸中火烧，口干难已，其它药未敢再服，却喝了一碗热稀饭，未一小时，觉腹中有气下行，腹胀颇甚，又半小时肛坠，未及入厕，在室内痰盂中排先干后溏恶臭粪极多，家人倒时有粘液不少，后又连泻两次，胸脘顿畅，但人亦疲惫，后痰咳颇减，饮食渐增，在家休息十多日，体力渐复方能前来。”听后始知，当时发药的吴姓青年，因未交代清楚，仅告附子先煎，使其误将原应分成5剂用的附子，误作1剂单煎先服（按理为先煎后倒入它药中同煎后再服），附子辛热，力峻善行，催动了前服的葶、苕、贝、杏等清化痰热之药力长驱直下，使痰浊得以廓清，病情因而好转，但实侥幸耳！万一25克附子致肺络灼伤，咳血不止，……我不敢再想下去。故医者与司药者，应详细向患者（特别是老幼、弱智、文化较低及目盲、聋哑等残疾人）交代服药（尤其是峻猛有毒之品）方法，才能避免发生医疗事故。

(马继松)

6、6 帖乌头分未均，患者鼻衄如注

1987 年深秋，芜湖县化肥厂一工人因夏天卧水泥地近月，致全身酸麻疼痛。诊得舌淡苔白，脉亦较沉，遂投桂枝芍药知母汤，考虑汗多故以秦艽易麻黄；因体质尚可，仅 40 余岁，故用川乌代附子，并嘱另包先煎半小时兑入浸泡于冷水中的其它药共煎，服药 3 剂颇适。复诊时其要求予原方 6 帖，以求彻底治愈。但第 3 天上午来院告余，言：“首剂服后效不显，但亦无反应。昨服 2 剂后，腕嘈烦躁，口干舌麻，临睡前鼻出血甚多，刚才早饭后仍有些出血。”余问：“药渣倒否？”答曰：“因怕药发错了，未敢倒”。该厂离院很近，我和另一名医生随其视药，见乌头颇多，似不止 7 克，又逐一检视剩余 4 包药。有 3 个小纸包中仅 2—3 片乌头，另 1 小包中却 7—8 片，始悟鼻衄乃乌头分未均也。至药房询之，乃一刚毕业不久的上海张姓女司药所为，因其想调回老家，且对我处方中先煎、后下较多有反感，配药速度很快却时欠认真，故致出错。幸病人反馈及时，否则将酿变端。故司药之不慎，对医生治病之疗效，常会带来较大影响。

(马继松)

7、广地龙未洗净，忘炮制，欲降压反升

1971 年夏，我在芜湖县清水镇回纺厂任厂医，一近五旬之洪女，高血压已多年，常在 150~180/100~130mmHg，因体壮纳旺，余用天麻钩藤饮合镇肝熄风汤出入尚适。但又告四肢时有抽掣，又增酒制广地龙 10 克。翌日上午告：“昨晚煎药时腥臭扑鼻，同室另三女工躲避外出，所煎药液混浊如泥浆，勉强服下，如食生黄豆油，心中泛泛欲呕，急以糖水送服半个面包，方未吐出。

但一夜腕中嘈杂，烦躁难眠，现耳鸣眩晕反甚”，一量血压，较昨天收缩压与舒张压均分别高 10 和 5mmHg。我随其至宿舍查看所剩之药，它药之量、质尚可，惟地龙未酒制，腥臭无比，且都是未切断的整长条，头尾各有 2~4cm 均未剖开，内中全是泥土。故与其将地龙头尾用小剪刀剖开，洗净泥沙，在烈日下曝晒，午后嘱其收回，剪成约 3cm 长小段，用少许黄酒浸泡，待酒将被地龙吸尽，入锅小火翻炒，至表面呈棕色时取出凉透。当晚用此地龙入药，则一切安然也。第三天我去医院找药房负责人汪老药师言及此事，他告地龙进货未久，一年青药工以为药斗有存货，忘了及时加工，前天自己生病未上班，青工即付了未炮制的地龙，言罢长叹不已！考地龙咸寒而腥，前贤为防其伤胃致呕，极重视炮制。《丹溪心法》即曰：“酒浸去土”，“酒炒”，《外科大成》更言：“敲去腹内泥，黄酒洗，文火焙干”，还有清炒，滑石粉炒、甘草水制等法，均不及酒制适用。当代虫药大家朱良春主张：“酒洗后炙至呈兰色，并放出一种奇臭时离火”，此时地龙之腥臭消失殆尽，不会有副作用了。

(马继松)

8、马钱子没写“制”，付生品，治痿证生疑

1973 年春，淮南矿务局电工郑忠凯，29 岁，工作中不慎跌落，致胸 10 椎以下截瘫年余，因听说芜湖市某医院有两位女医生，去北京积水潭医院学习用马钱子治截瘫经验，遂专程由妻陪同来芜求治。但由于一些原因，两位女医生并未用马钱子，也未能收其住院，郑于是住正大旅馆 51 号房间，每日去门诊。在针灸时恰遇余一也患截瘫之表兄，让其将所购积水潭医院治截瘫经验之书借我细阅，嘱我用马钱子为其治病。余虽对其深表同情，但对用马钱子却毫无经验，故除详阅郑之书外，又查找了一些资

料。知此药在砂烫炒或香油炸过后去毛研末可入丸、散剂中使用，但每次量勿超过 0.6 克，日 1 服，或每次 0.3 克，日 2 服。因苦寒有大毒，所含番木鳖硷（又名土的宁）和马钱子硷，对脊髓有高度选择性的兴奋性。若剂量稍大，会现头昏头痛，烦躁不安，全身发紧，两手握拳，甚至角弓反张，牙关紧闭，面呈痉笑，直至昏迷而产生抑制，使循环衰竭而死。对其中毒抢救则以控制惊厥为首要步骤。将上述资料给郑看后，让他写了份“在日服马钱子粉不超 0.5 克时，发生中毒与马医生无关”的保证书后，我即为其求购此药。当时全市仅南正街药店（为省医药公司的先进门市部）有货，但不单售，只在制作丸、散的加工方中配用。我问一药师：“该药您们生用还是制用？”告：“一律制用”。于是我即开丸药一料，处方中马钱子前未写“制”。一周后取丸，询及耿姓女药师：“马钱子是砂炒还是油炸的？”她竟说：“你处方未写‘制’，我们就用生的了”。闻言我大吃一惊：万一服之中毒，如何是好！若弃而不用，又实在可惜，因方中还有虎骨、鹿茸、巴戟天、辽细辛等不少名贵药，价格不菲。只得自己先试服。遂浓煎 1000ml 甘草水，告爱人若现中毒症状，急以此水灌服，再送医院（离家仅 5 分钟）抢救。当晚服丸药 6 克（含马钱子约 0.3 克），一夜尚安，但晨起觉咽干舌燥，牙龈出血，想系方中辛热壮阳之品过多所致。为防引动阳亢，嘱郑服药若感燥热可暂停或以生甘草煎汤送服。1 公斤丸药服尽，其能弃杖借助假肢站立，后用制马钱子合补肾壮阳、养血通络之品为丸 2 公斤，每服 5 克，日 2 次。药尽能弃杖借助假肢以踉跄摇摆之状行走约 30 米。又作丸一料，喜返淮南。由于制马钱子极难购得，余至今仅用此药 11 次，治疗跌仆伤损，风湿痹痛，肌肉萎缩等病，取效颇捷。在严格掌握剂量前提下，仅两例发生轻度中毒反应。

（马继松）

9、忽视旋复花降气速，治呃逆却气坠欲脱

1995年冬，近6旬之徐男患萎缩性胃炎，中西医迭治时缓时甚，求治于余。当时除嘈杂、口干、纳钝、烦躁外，尤苦于频发呃逆。余见其身修形瘦，且舌红少津苔剥，脉细数，断为胃阴欠丰，虚火内炽，致胃气逆上而呃。遂用仲师麦门冬汤合吴塘沙参麦冬汤，佐香元、枳壳、白术芍等。考虑半夏温燥较过，易以10克旋复花，自认为方药与症颇合，胜券稳操，告其曰：“3帖呃逆可愈”。但仅服药1帖，即感有气自胸直趋下压，矢气不已，大便似难控制。虽呃减少，却神疲欲倒，气难上接，难受非常。余思方内降逆药惟枳壳、旋复花，徐曾数次服枳壳而无碍，故反应与旋复花殆有关？又思花类药大多平和，焉有如此破气作用？故试以柿蒂代之。4天后复诊告，诸症显减，服旋复花时的反应荡然无存，要求原方续进。又书5帖，持方欣然离去。

（马继松）

10、未料苦桔梗升散猛，疗咽疼致耳胀流脓

1998年3月，10岁男孩张申因发热咳嗽，口干咽疼，痰黄稠，咯不爽等就诊于余，检视两侧扁桃体肿大颇甚，嚥饮均不适，颌下淋巴结亦累累似豆如珠。舌偏红，苔薄黄，脉浮滑。视其形瘦色晦，询之平素盗汗殊甚，便干烦躁。显系阴虚之体，又触风热，遂拟银花、条参各20克，玄参、牛子、生牡蛎各15克，连翘、桔梗、大贝、僵蚕、生草各10克，黄芩、麦冬、猫爪草各7克。3帖后各症均减，但感左耳较胀。其母言，前年因游泳，左耳得中耳炎。遂问其母：“喜食辛辣香燥否？”答：“极喜，且服药时还以花生米过口”。故自以为耳胀与食香燥有关，即让停食五辛与烘炒油炸之品。仍与原方，仅以丹皮10克易连翘，又开5帖。但未尽3

帖，左耳胀痛颇剧，且流淡黄脓液。并自告药后感有气上行，且伴暖气欲呕。其母怕药发有误，将所剩药带余，检视无误，量质亦可。思忖恐与桔梗过于升散有关。遂找出桔梗，令其续服，并嘱用滴耳液，后诸症渐安。我临证颇喜用桔梗，盖其微苦性平且价廉效速，30年内未见有所副作用，但却忽略了朱丹溪曾言，该药对“下虚及怒气上升者不宜”之告戒。此小儿肾阴虚肝阳亢，对此药故特敏感，加之桔梗原有一定排脓作用，故而出现上述情况，若为医者能预告该药有可能导致的副作用，则可避免病人的一场虚惊了。

(马继松)

11、不知茯苓会过敏，重用其安神，反心烦意乱

1992年，余受芜湖县清水镇刘姓医生之聘，每周去其诊所坐诊一天。将近年关，有王女30余岁，素患失眠，睡前服2片安定，亦仅眠3—4小时，伴眩晕头痛，烦躁焦虑，形瘦纳少，西医诊为严重的神经衰弱症。一周前，其做较大生意的爱人在返乡途中因车祸丧生，致失眠更甚，虽加服1片安定，亦仅近鸡鸣时始交睫1~2小时，且诸症转加。遂请当地一老中医开方5帖，但未效反更烦躁，刘医生遂荐我治。余认为原已心血不足，虚阳上扰，复又郁忧伤肝，遂投朱砂安神丸加生龙牡、夜交藤、灵磁石、柏枣仁、合欢花、百合、甘松、郁金、麦冬等，5帖后能睡5小时，颇喜，又复加茯神30克。一周后刘告：“王女服药当夜1时，就前来敲门，诉心烦意乱，莫名所苦，几不欲生，服安定4片无效，疑药开有错，劝慰良久，并略配镇静药输液，天明稍安。”余极奇怪：仅加30克茯神，为何病变如此？恰王氏至，并带来未服用的4帖药与病历，我又细阅前医之方：乃知柏地黄加柏枣仁、夜交藤等安神药，按理与病亦合，为何也现烦躁，是否与用了30克茯苓有关？

余初诊未用茯神却获佳效,想其对茯苓(神)特别敏感也!当即捞出此药,明告烦乱系此药之咎,嘱其放心续服,后睡眠渐安。盖茯苓、茯神均为最常用之品,乃中药中的大路货,余行医至今,从未见此药有副作用,查阅不少书刊,也未找到服此药发生反应的案例,故存录于此,供道友鉴戒也。

(马继松)

12、畏于蜈蚣过峻烈,坚辞不服用,使顽痹难痊

1998年长夏,老病友吴某之母患行痹,年60余,形瘦色萎,汗多烦躁,且血压常140~160/90~100mmHg,服降压药虽可暂降至正常,但稍停数日则升高如旧。观其关节局部略红肿,舌偏红,苔薄黄,脉细弦数。虽未患过器质性大病,却因一直从事会计工作,活动极少,纳亦不多,常易外感,体质颇差,且年初被诊出骨质疏松。刻诊全身关节游走性痛,四肢与腰尤甚,时感晨僵,但抗“O”,血沉略增高,RF $\ominus$,西医未确诊,仅疑为“类风关”。去年秋腰腿疼,由于血压未高,汗不多,余用独活寄生汤出入,服药半月而愈。目前该方中的独、细、防风不可再用,遂以四物汤加鸡、活血藤、骨碎补、片姜黄、秦艽、防己、怀膝、杜仲、地龙、乳香、赤白芍等,却无反应。余思虫药乃治痹证圣品,地龙少应,遂改乌蛇,药后关节部位觉有气窜动,疼稍减,续用则效又不显。余告之,若以蜈蚣代乌蛇,定会有效,只是此药有小毒,力较猛,服时当注意反应。她听后坚辞不肯用,其子劝之亦不从,碍于情面,只好弃用,后因效不佳,改去市中医院。仅诊两次,服药6剂,疼即大瘥,我颇感奇。吴某窃语于余曰:“您上次不应当家母面说蜈蚣有毒,这次我找了一熟医生,要他勿告家母在方中配入蜈蚣,我为其取药并煎好,她连服12条蜈蚣,果然起效了”。这真是:告其实话,拒不服药;隐瞒真情,病反获瘳。足见患者的心理状态,为

医者亦不可不知也。

(马继松)

13、误认药有效求再服，肿虽消却致母婴亡

1964年9月，我与两同学赴我省某医学院附院实习。带教的中医科主任年近花甲，由苏南某市高薪聘至，该老对中医经典与各家学说均烂熟于心，诊疾果断，用药大胆，收效颇速。10月下旬，有26岁李女患肾炎且怀孕，西医劝其人流，因去年为肾病已人流一胎，且爱人为独子，双方父母盼孙极殷，故请该老设法保胎，主任答应尽力为之。开始两月尚效，元旦后胎儿长至5个月，中医多种消肿法均欠佳，肿胀遂甚，难以平卧，终日斜倚于病床床栏上，俄顷觉累，又转靠爱人或母亲身上，因溲少腹胀，呻吟不止。肌肤皤白绷急，按之没指，稍用力则有水液外流，虽知饥欲饮，却苦于腹胀而不敢。多进食饮或略动则喘急不已，惶惶不可终日。在该市它院实习的一同学恰至病房，见状甚悯之。问：“主任用十枣汤否？”告：“考虑毒大且怀孕而未用，”那同学说：“《内经》曰‘有故无殒，亦无殒也’，我和你们同劝其用之。”经我们再三恳求劝说，加之妇科因中期妊娠，人流风险过大而婉拒转科，主任终于同意试用，但反复叮嘱：“量勿过5分，小溲略增则停服”。我们立马去药房称出甘遂、大戟、芫花各10克，又至炮制室碾末，虽三药刺激性极大，我们不时地流泪，咳嗽、打喷嚏，但为抢救病人生命，很快将药过筛装胶囊。又选30枚大红枣，煎浓汁，9时许将枣汤与4粒胶囊（约5分重）送至病房，令其服下。1小时后腹中鸣响颇甚，不到2小时，排大小便半便盆，腹胀略减。午后又排二便不少，腹颇宽松，欲进食，嘱服稀粥半碗，尚适。将晚其夫找我们，告其腹胀又剧，自认为上午之药比前两个多月所服水药效好得多，恳求再予胶囊数粒。我们告药有毒不能多用，

他却说：“服后未见任何反应，再服4粒无妨”。此时主任已返家，我们拗不过其夫，且欲观察十枣汤之效，故又与4粒，让其用红枣四两煎浓汁送服。翌日上午查房，小李喜告：“昨晚与夜间又排二便数次，现腹胀大松，仅感微痛”。诿料10时许，其夫急至门诊，告其腹痛加剧且下坠，阴道出血。主任立即赶回病房，请妇科会诊，诊为不完全流产，并转该科，后终因继发感染而不救。

(马继松)

14、患眼疾失治视力降，服偏方加速双目盲

赵某，男 46岁，1998年9月27日初诊。

素嗜烟酒，喜进辛辣，性情躁急。经商数载，盈余颇丰，遂投资股票，未料连连下跌，损失颇重，心焦意乱，更借酒浇愁，致原患之肺结核复发咳血，且鼻腔又生疮肉，四处奔波求治，复受暑热。加之不遵医嘱而将抗结核及止血西药杂乱服之，并作疮肉手术，未久双眼疼痛，流泪畏光，微现红肿，自以为红眼病，未予重视，仅购眼水点用，仍忙于结核的治疗。后眼痛加剧，经某院诊为双眼全葡萄膜炎，治疗半月，未见明显好转，经介绍至我处求治。刻诊双眼红赤肿胀，疼痛流泪，畏光颇甚，右眼视力由病前的1.2下降为0.3，左眼由1.0下降至0.1，舌红绛，苔黄干，脉弦劲。询知口干苦，喜冷饮，小溲短赤，大便秘结。显系肝郁太过，化火逆上攻目，予生地、生白芍、决明子、生石决明（打、先下）蔓30克，车前子（布包）、泽泻、楮实子、女贞子各20克，白蒺藜、蔓荆子、菊花、丹皮、焦栀各10克，生军、生草各7克。5帖药后红肿疼痛随二便畅行而渐减，它症亦稍松，去丹皮、女贞子、生军、加赤芍、桑椹子各20克，龙胆草7克。又进5剂，诸症续减。但因其过分性急，且畏药苦，乃听一包治眼科百病的游医之言，每日

购羊肝二两，将苍术，夜明砂各一两，布包与羊肝共燉，去药服羊肝，未半月，病甚而目盲矣。

(田爱华)

四 疑难医案二十五则

1、哮喘(肺气肿)

杨男，73岁，军队干部，1996年7月25日初诊。

慢性支气管炎二十余载，肺气肿亦十多年，近数载每至冬令气候暴冷时则需住院，甚至一年住院数次，但均仅缓解一时，无法根治。今夏因外出淋雨，致咳喘胸闷，痰少难咯，喉间哮喘有声，口和纳可，便日二行，偏溏，卧寐欠宁，舌淡紫暗，苔白腻，脉濡滑。此脾肾两虚，湿盛气滞，血缓凝瘀，痰瘀交阻，逆上犯肺也：熟附片(先下)、姜夏、炙远志、桔梗、三七(杵碎)、当归各10克，朱茯神、陈皮各15克，莪术、棉花根(先煎半小时)各20克，熟地、炒苡米各30克，生草5克。10帖。8月12日痰减口干，纳可寐安，胸闷稍减，汗多乏力，便日2行。舌红，苔白稍糙，脉濡缓：减桔、莪、棉、苡，加黄芪20克，郁金15克，紫菀、苏子各10克，桂枝7克。10帖。8月26日诸症显减，但仍气急眩晕，便溏乏力，右尺脉弱，舌淡紫。拟肺脾肾同调：熟地、首乌、茯神各30克，生黄芪、紫菀、香附各20克，白术、百部、当归各15克，附子、姜夏、陈皮、萸肉、苏子、补骨脂各10克。10帖。9月10日：诸症平稳，要求成药缓图，上方加蛤蚧二对，以10剂量共末蜜丸，日3服，每次10克，空腹淡盐汤下。12月25日：药后体质渐壮，咳嗽仅小发一次，略配对症治疗之西药，即可控制。五个月中从未

住院,要求续用成药。考虑已进入严冬,故改膏剂滋养之:熟地、茯神、山药、黄芪、太子参各 30 克,冬花、阿胶、归身、白术芍各 20 克,远志、陈皮、川贝各 15 克,姜夏、礞石、五味子各 10 克,沉香 5 克。10 帖加蜜 3 公斤熬膏。

后每年长夏作料丸剂,进九熬料膏剂,至今不但未再住院,且可从事买菜、烧饭等家务活。

按:此案始终以张景岳金水六君煎加味,该方采用二陈汤加熟地、当归组成,原治肺肾阴虚,水泛成痰之证。而二陈汤本为运脾燥湿祛痰剂,故金水六君煎实乃肺、脾、肾三脏同调之方,与患者诸症极合。且又参入温阳化瘀之附子、三七等,促进血循,对减轻主症更有裨益矣。棉花根为李传方教授治肺系疾病虚证的常用药,味微辛辣,可止咳、祛痰、平喘,并有治疗疝气及子宫脱垂的益气作用。因其气微弱,先煎促其有效成分易发挥也。后数诊渐加入纳气归肾之萸、味、沉香、补骨脂,咳喘则逐步平伏矣!另礞石为坠痰下气要药,膏剂中略配之,一可排痰,二可助纳气药平喘,三可防滋补药壅脾,该药虽性峻烈,但在成药中小量用之,则无碍也。

(马璇卿)

2、咳血(支气管扩张,肺结核)

胡男:27 岁,工人,1989 年 9 月 9 日初诊。

素体尚健,84 年 11 月 19 日,因右胸闷痛,咳嗽咯血数口,被诊为右上肺结核(增殖灶),服用抗结核及止血中西药而效。但 85 年 11 月 20 日、86 年 11 月 29 日和 12 月 4 日,又三次咯血,每次约 100~200ml,遂住院全面检查,确诊为支气管扩张伴右上肺结核。19 天后出院,减少抗结核药,加用麦的霉素等,中医改投知柏地黄汤合润肺止咳药百余剂,似乎尚安。而 87 年 12 月

12日晚,因送弟参军陪客饮葡萄酒一口,当即咯血200ml,翌日凌晨又咯血200ml,胸透以支扩咯血伴肺部感染住院16天。延医改用血腑逐瘀汤合三七、煅自然铜、没药、苏木、黛蛤散及清解润肺,凉血止咳药等近百剂。88年6月中旬因略负重又感胸痛,摄片(6083号)见“两横膈下降至第11后肋,心影滴形改变,提示轻度肺气肿”,易医改用四君子、萎蕤半夏汤、桃红四物汤合养阴止血药,症尚稳定。然12月27日又咳痰带血数口,伴胸闷肋胀,咽痛喉痒,急改二至丸、泻白散合大剂凉血止血,并冲服羚羊粉、三七粉而血止。今年2月1日其顶风外出,返回即剧咳胸痛,血出如涌,再次住院月余。西医劝其手术,父母未肯接受。遂函请海外亲友和沪上名医求药,然终难急切见功,故经友人介绍,请马继松老师诊治。

刻诊:面色黯红,目光灼灼,鼻旁有红色丘疹甚多,神情消索,沉默少语,右胸隐痛,时发闷咳,痰少难咯,两胁时胀,两额亦胀,口苦咽燥,卧寐欠宁,二便不畅,时有遗精,腰酸膝软,所咯血先鲜后紫黯,略有小块。右脉重按无力,左弦滑,舌淡红,苔薄黄。胃纳颇旺,血化验均正常。马师思忖良久,断为乃水不涵木,致木火刑金,且夹痰瘀作祟。予:生赭石、生牡蛎、山药各30克,生白芍、酒怀膝、生地各20克,杏仁、丹皮、煅花蕊石、白芨各15克,降香、地龙、旋复梗、熟军各10克,肉桂4克(研冲)。因服后尚适,故一至三诊共进药25帖。四诊:随大便色微黑转溱,面色渐正,红疹显减,遗止寐安。以仙鹤草、茅根各30克,萸肉10克,易蕊石、降香、旋复。此方断续服30帖,曾易入天冬、百合、大贝、焦栀、炒知柏、枳壳、桑寄生、旱莲草、罂粟壳等,但地黄、山药、白芍、怀膝、白芨、赭石、大黄、肉桂始终用之(赭石最多为45克,大黄为20克)。大便虽溱至每日3行,但诸症渐退,未见明显不适。12月25日赴友人婚宴,被劝进葡萄酒3杯,翌日见少量鼻衄,

急服四诊方而定。考虑其上函大，且病情较稳，遂用四诊方10剂熬膏，日服四次，每次15ml，另以吴萸50克研末，每晚取约3克，醋调敷两侧涌泉穴。春节期间略饮果汁酒未再出血。春节后用白芨：百合：百部：三七按4：3：2：1之量研末，每日饭后服10克，共服两月余，立夏后停药。90年国庆后又按四诊方断续服药50帖，元旦前用10帖药熬膏，未再咯血。且性情渐开朗，形体较前为丰。91年4月28日胸部正位片加右侧位片(7076号)，除两下肺纹略深紊乱，其余已清晰矣。心影轮廓影正常，两膈光整，膈肋角锐，右侧位片见右上肺片状及模糊条状影均为伪影。

按：咯血为常见之病，然连续5年，且均发于11~12月，迭治难以控制者则鲜见矣。虽汪绮石在《理虚元鉴》中曰：“二十四候之间，有最与虚劳为仇者：一为初春，木盛火升；一为仲夏，湿热合行；一为夏秋之交，伏火烁金。劳嗽血证，每于此时转甚”，而患者却在冬至(12月21日~23日)前后发病，故马师考虑恐与“冬至一阳生”有关，盖患者好胜上进心较强，7年前高考时因十分数分之差而落选，情怀失畅，郁久化火，又在不知已患肺结核的情况下勉力劳作，遂致血络暗伤，肝肾之阴日耗，木少水涵，乘冬至阳生之机而蠢动上逆，咯血遂作。前两位中医根据肺癆之病机为阴虚内热，偏重养阴润肺，未顾及肝郁化火之实症，西医之抗癆消炎，也未抑制住上逆之肝火，故效欠理想。后两位中医改活血祛瘀，和胃平肝之法，寒温并用，标本兼顾，咯血日期逐渐推迟而好转，却因平肝之力不足而未痊愈。故马师改用大剂平肝养阴降逆，佐以活血化瘀(丁甘仁曰：“瘀去则新生，不止血而血自止”)，因而获效较佳。尤其是自始至终配用了张锡纯的秘红丹(张氏自谓赭石：“治吐衄之证，当以降胃为主，而降胃之药，实以赭石为最效。……有因热者，……而以萎仁、白芍佐之，……有

因下焦虚损，冲气不摄上冲，胃气不降者……而以生山药、生芡实佐之；其又云大黄“破一切瘀血；……又善清在上之热，……并能引胃气下行，故善止吐血”；至于方中的肉桂，朱丹溪认为：“入二、三分于补阴药中，则能行血药之凝滞而补肾”，而《本草述》则言：“肉桂能“导火归源”），及较大剂量的“性涩而收，故能入肺止血，生肌治疮”的白芨（《本草纲目》）乃是成功的关键。另用吴萸外敷，“其性虽热，而能引热下行，盖亦从治之义”（《本草纲目》），可能亦起到辅助作用。然此证已六载，故血止后，宗唐容川治血四法中的收功二法，用药研粉久服，以“宁血、补虚”而收全功。

支气管扩张症是常见的肺部感染性疾病，基本病因系感染和阻塞：感染使粘膜水肿、充血，且产生分泌物，造成支气管阻塞；阻塞使分泌物难以畅排，又加重感染，如此反复，使支气管壁组织破坏形成扩张，导致咳嗽，咳脓痰，反复咯血，并有反复急性感染史，中医将其列入咳（咯）血范畴。马师方中所用的大黄、丹皮、梔、贝、知、柏、桑蚕皮等，均可消炎、抗感染、排痰，对咯血的根治亦起了较好作用。

（孙秋生整理）

3、口疮（复发性口疮）

余男，49岁，工人，1996年5月7日初诊。

反复发作口腔溃疡已3年，一年中半年时间在发病。发时全身疲软，头昏心悸，甚至无力登楼。经多家医院中西医迭治未见显效。自认为“火气”而服凉性食品反剧，受寒后亦剧，极为苦恼，适我受聘至他厂任厂医，故抱一线希望请我试治。刻诊：面色红润，语音响亮，却白发满头。且纳呆畏寒，下肢冰冷，大便常溏。察舌淡紫，苔白厚腻，切脉洪大，重按若丝。细询昔有胃出血史，

RBC $2.7 \times 10^{12}/L$ 。辨证为元阳亏馁于下，虚火浮越于上，即经云：“至虚有盛候”是也。拟干姜、肉桂（后下）各6克，熟附、红参各10克，怀膝、炒归身各15克。6剂后症状控制，改拟：炒白术、茯苓各20克，桂枝、党参、熟地、酒怀膝各15克，苍术、姜夏、红参、当归、石菖蒲各10克，附子、干姜各6克。连用20余剂，手足汗出不断，白腻苔渐退，双下肢亦温，纳馨、便正、神旺，尤喜口疮得敛。后感寒太甚，口疮偶小发，自服红参立愈。

按：复发性口疮（recurrent aphthae）又称复发性阿弗它性溃疡（RAU），主要累及口腔粘膜并呈周期性复发，以唇粘膜、舌尖、舌侧缘、舌腹、颊粘膜最常见。其临床表现有五大特点：①假膜色黄、②溃疡内陷、③溃烂边缘红、④灼热疼痛、⑤反复发作，甚至旧疮未愈，新疮又起。西医将其列入自身免疫系统疾病，对病因无统一认识，用皮质激素配合局部治疗仅能暂缓。笔者认为：自身免疫性疾病，在自身抗体生成之前，先有一个免疫紊乱过程，由于紊乱原因现尚难查清，故西医对此病无根治之法，只有设法用中药调节整体免疫功能，使其不再紊乱，病方可愈。如何调节免疫功能，中医认为必需辨证施治。本案脉症似与李东垣所谓脾虚阴火之病机相符，李氏曰：“若饮食失节，寒温不适，则脾胃乃伤，喜怒忧恐，损耗元气……脾胃气虚，则下流于肾，阴火得以乘其土位。”故用附子理中汤加肉桂、怀膝引火归源，炒归身补血不滑泄碍胃而效。家父曾仿清医用三才封髓丹（天冬、熟地、人参、砂仁、黄柏、炙草）加味治愈此病十数例，今贤何绍奇研究员在其主编的《现代中医内科学》中，将此病虚证分阴虚火旺与气虚阴火两型，前者用其自拟的清热泻火汤（膏、知、银、草、生地、白芍、天冬、元参、黄柏、竹叶）；后者还可参用王肯堂的清热补气汤或缪仲淳的资生丸。对虚实夹杂者，他认为仲师甘草泻心汤为最好，读者临证可参考用之。至于实证因易于见效，则可辨

证而投以清热泻火，润肠通便等药了。

(马璇卿)

4、嘈杂(返流性食道炎)

于女，37岁，干部，1999年10月7日初诊。

慢性胃炎数载，近年来又被内窥镜检出患返流性食道炎。现食道内干燥紧压感明显，食后有堵塞感，时觉脘中嘈杂，舌中起裂如龟背，苔薄黄，脉细弱。先予清热、养阴、通降：北沙参、银花、蛇舌草各15克，黄芪、石斛、白芍、枳壳、八月札各10克，鹿衔草、生草各7克，马勃(包煎)5克。5帖。10月15日：食道紧压感较减，但胃觉有冷气，肛门坠胀，大便日2—3行，但不畅，脉舌如前。去八月札，加太子参10克、鹿衔草3克。7帖。10月27日：紧压感显减，冷气，肛坠亦除，但进热物觉食道烧灼感颇甚，又觉胃脘嘈杂，便溏欠畅，带黄稠粘。舌裂稍弥合，苔黄略退，脉仍细弱。去太子参，加党参15克，白芷、蒲公英(布包)各10克。7帖。11月6日：药后乏效，改方：南北沙参、米炒山药、银花各15克，威灵仙、藤梨根、蛇舌草、香元皮、黄芪、白芍、石斛、枳壳、蒲黄各10克，白芨、马勃(布包)、鹿衔草各7克。7帖。11月20日：诸症显松，要求续进7帖。12月1日：咽堵及烧灼感基本消失，食道偶感返流。咽仍时干，脘嘈减轻，龟背舌尚未全弥合，脉较前有力。因被分流待岗，欲去南方谋职，要求成药调理：北沙参、山药各20克，党参、八月札、蛇舌草、炒卜子各15克，生白术、藤梨根、黄芪、枳壳、杏仁各10克，威灵仙、姜夏、白芨、马勃各6克。6帖研末，每取5克，以蜂蜜调服，日4次。春节间遇之，云证未反复。

按：返流性食道炎是因胃、十二指肠内容物反流至食管引起烧心反酸、恶心呕吐、胸骨后疼痛等反流症状或组织损害，常合

并食管粘膜炎症性改变,西方人极常见,据报告为人群的 5—8%,(占内镜检查人数的 23%,而消化性溃疡仅占 18%),故对此病的治疗有引起重视的必要。〔注〕中医认为该病与七情内郁、烟酒过度、饮食失节有密切关系,故多以疏肝解郁、清热化湿(酒能助湿生热,烟亦助热)、健脾消导等为施治主法。田师对于女的治疗初期亦大抵如此,但效不尽如人意。四诊时,她考虑到食管粘膜炎症性改变会导致组织损害,故加入白芨、马勃、炒蒲黄,以弥合损害的粘膜组织;又佐入能加强括约肌紧张度的威灵仙,症状很快好转。这足以说明当按常规治疗无效时,必需进一步分析疾病的因、机,并针对此因、机而适当的改变治法,方可取得佳效也。

〔注〕:陈文渊:常见食管良性疾病的中医药治疗概况,《中医杂志》2000(3)181。

(田爱华主治,储成志整理)

5、呕吐(贲门失弛缓症)

江女,45岁,农民,1998年4月1日初诊。

食后呕吐近15载,伴进食稍硬则疼,近几年以半流质为主,形瘦如削,大便颇坚,嗝逆多,矢气少,冬畏寒,夏恶热,中脘胀满,右肋亦时牵及不适,脉细弦滑,舌淡红苔薄黄浊,舌下静脉如蚓。在老家徽州地区迭治未明显好转,遂来芜进一步诊治。经皖南医学院附院X线示:钡剂通过食道下段受阻,局部呈向心性狭窄,如鼠尾状,边缘光滑,管壁尚柔软,钡剂可少量间歇地通过狭窄,其上食道中度扩张,并见大量食物残渣潴留,其余部位无特殊。确诊为贲门失弛缓症(X线号056725)。经友人介绍至马继松老师处诊治。马师考虑其以呕吐为主症,故投旋复代赭汤加味,但效亦欠佳。他思忖贲门失弛缓其实即痉挛太过也,故又加入钩藤20克(后下)、僵蚕、威灵仙各10克以解痉,症状虽渐见

好转,然仍欠满意。三诊时马师见其长吁短叹,眉结紧锁,询其故却不答。其夫乃告:其家境本贫寒,生病更债台高筑,现两个女儿随老乡来芜打工,经济略好转;但其见社会治安欠佳,又怕女儿误入歧途。马师劝慰良久,并考虑此呕吐与肝郁化火亦有关,更方如下:生赭石(先下)、党参、钩藤(后下)各 20 克,炒白术芍、郁金、八月札各 15 克,姜夏、旋复梗、枳壳、刀豆子(打)、归身、香附、威灵仙、内金各 10 克,酒连、白蔻(杵、后下)、柴胡各 5 克,生麦芽、山药各 30 克。5 帖。药后呕吐明显好转。因其欲返里,上方续购 7 帖。端午节时其女探亲返告,患者服后在当地又配药 7 帖,现进普食如细嚼慢咽基本不吐,如感觉要吐,喝汤、水两口即可止,人亦较前为胖,精神亦好转。并让以 10 剂为其配制膏药一料。国庆节该女再次探亲,告其母已能参加轻微劳动矣。

按:贲门失弛缓症,属动力障碍性食管病之范畴,此病临床虽不多见,且为食管的良性疾病,但常因患者呕吐较甚,营养无法吸收,每易变生它疾,亦需引起重视。旋复代赭汤估计患女在家乡已服用过,故初诊用之未效,即加入解痉之钩、僵、灵仙(药理试验证实:威灵仙直接作用于平滑肌,使兴奋性增强,节律收缩变成蠕动,故可用于解痉);三诊在得悉病发与忧虑太过有关后,马师又及时参入自拟的复方四逆散,防柴胡过升,仅用 5 克合入大队理气药,以疏肝解郁,且佐入白蔻、黄连、辛开苦降和顺胃气,终收全功矣!

(贺建军整理)

6、胃痛(胃下垂)

许女,43 岁,干部,1995 年 12 月 9 日初诊。

慢性胃病二十多年,经多家医院中西医迭治,时缓时甚。刻诊胀痛,嗝气颇甚,泛酸涌涎,纳差消瘦,X 光示钩状胃,严重下

垂。伴畏寒腰酸，乏力便溏。舌暗红、苔薄白，脉微。暂予温肾健脾：党参、附片（先煎半小时）各 30 克，苍白术、补骨脂、巴戟天、茯苓、桂枝各 20 克，炮姜、仙茅、厚朴、甘草各 10 克，丁香、吴萸各 7 克。7 帖。12 月 17 日复诊：畏寒腰酸渐减，眠较安，纳亦增，它症依旧，去仙茅、巴戟，加姜夏、苏梗各 10 克。7 帖。12 月 25 日：噯、胀显松，酸涎减少，大便渐正，脉舌好转。去丁香、苏梗，另附、桂各减 5 克，加黄芪 30 克。7 帖。后以此方加减连服近 30 帖（党参易为红参 10 克），不仅症状基本消失，X 光示胃下垂亦明显上升。

按：患者前所服之中西药，近半为苦寒沉降胃气之品或西药抗生素、消炎药（重在治噯气与肠炎），致脾、胃阳气受戕损极重，故笔者初诊即放手重用一派温扶脾气，辛通胃阳之药，乃“矫枉必需过正”之意也。然附子因含乌头硷，若大剂用之，必以先煎为妥。另本病用附子理中汤原为正法，但为提高疗效，还当掌握对该方的变化应用。清代名医曹仁伯极擅用此方，今将《柳选四家医案·继志堂医案》中曹氏用该方心得摘录于下：“理中是足太阴极妙之方，如中宫阳气不舒，用干姜者取其散；少腹之阳气下陷，用炮姜者取其守；其变换在大便之溏与不溏。若湿甚而无汗者用茅术，湿轻而中虚者用冬术；其变换在舌苔之浊与不浊。……设脾家当用理中，而胃家有火，则古人早定连理一方矣。设气机塞滞，古人早定治中一方矣。其肾中真阳衰者，加附子固然矣；其衰之甚者，古人又有启峻一方矣。此外，加木瓜则名和中汤，必兼肝病；加枳实、茯苓，治胃虚挟实”，谨供道友参考。

（马璇卿）

7、泄泻（慢性结肠炎，肠痉挛）

贺男，38 岁，1993 年 5 月 7 日初诊。

一年前行阑尾手术后腹部常牵拉疼痛，感寒或食油腻则加甚，并腹泄。自购治肠炎的抗菌西药服，初有效，继少效，后无效。换一种抗菌素，亦如此。再换药，初服效亦不显了。两个月后不得已去医院诊治。初疑为肠粘连，但用糜蛋白酶等，却初有效后乏效。经钡剂灌肠造影拍片，诊为降结肠中上部痉挛，慢性结肠炎。拍片时感寒，腹泻加甚并发热，医生用抗菌素等暂愈出院。未久复泻，日4~6次，呈青绿色似夹蔬菜样粪便，遂不敢吃绿色蔬菜，但泻却未减，有时夹粘液或脓血，并时发低热，半年体重减轻9公斤，自疑为结肠癌，焦虑万分，转请中医诊治。初诊之医根据其情绪紧张，且受过经商失败的打击，疑其为慢性非特异性溃疡性结肠炎，予白头翁汤合痛泻要方，初效未久又不效；易医见其肛坠，神疲、心悸、汗多，改补中益气汤，加地榆、黄连等亦仅获效半月；复更医考虑过敏为主，予徐长卿、地肤子、荆芥、防风、蝉衣、乌梅、合银花、黄连等，亦时缓时甚。遂劝其作直肠、乙状结肠镜检，因其怕被确诊为癌，拒不去作，后经友人介绍至马继松老师处。马师详询知其近因筹办公司，常陪客宴饮（过去一餐喝半斤烈酒，现改饮啤酒），辛辣甘肥迭进，纳可，却继续消瘦（比一年前轻14公斤），察颜面唇偏红，舌胖而嫩，有齿印，中裂似龟背，苔白黄腻，脉弦滑重按无力。叩腹呈鼓音。思忖良久，疑中西医结合迭进抗菌消炎，致脾之气阴双戕颇甚，肝木遂横逆犯土而难制也。遂予：党参、米炒山药、茯苓、芡实各30克，炒白术芍、炒枣仁、炒扁豆各20克，石斛、银花各15克，木香、木瓜、元胡、焦查各10克，柴胡、生草各7克。5帖。并嘱少进甘肥辛辣。5月14日二诊，大便由日6次减为3次，疼胀及它症均松，要求原方续进6帖。5月21日三诊：便虽仍3行，但基本成形，色转淡黄，舌上裂纹随口干之好转而略弥合，苔稍化。去木香、木瓜，改乌梅、砂仁各7克。12帖。6月7日四诊：因去青岛出差，进食海鲜，又

致泻甚，但返回服药3帖遂减。去枣仁，加内金15克、焦查5克。12帖。后遂以该方出入，因进入梅雨季，曾参以藿香、苍术、厚朴、炮姜、炒黄芩、神曲、炒苡米等，进入盛夏又参入过葛根、桔梗、米炒北沙参等。至7月20日诸症基本平稳，改：米炒山药、米炒北沙参、芡实、苡米各30克，炒白术芍、炒扁豆、石斛、银花各20克，葛根、焦查、内金各15克，木香、木瓜、黄芩各10克，柴胡、生草各7克。10帖，水泛丸，每服10克，3餐饭前及临卧各服1次。9月又作料散剂。后非饮食不慎或感大寒、或情绪极差，已不再泻，体重亦增近5斤。

按：贺男所患可能为慢性非特异性溃疡性结肠炎，本病是一种原因不明的慢性结肠炎，以溃疡为主，病位在直肠和乙状结肠的粘膜和粘膜下层或遍结整个结肠，西医认为病前有肠道感染史，故用抗菌素为主，自己在去医院治疗前，又盲目地服用近三个月多种抗生素，前三位中医也用了一些清热解毒之黄连等，使肠道正常的有益消化，助便成形的大肠杆菌亦被杀灭，反使肠中难辨梭形杆菌迅速繁殖，致腹泻难愈。有资料表明，70%的暴泄与滥用抗菌素有关。由于久泄不愈，致脾之气阴大伤，故马师初诊即采用甘平酸润略偏温的治疗大法，取南宋陈无择六神散（四君子加山药、扁豆）合石斛、芡实配芍、查、乌梅、木瓜，且将此法贯串至始终，以峻补脾之气阴；且滋脾阴药多味甘，《内经》曰：“肝苦急，急食甘以缓之”，故可解除对肠痉挛。佐柴、元胡，疏肝和血止痛。仅用甘寒之银花清解，该药且有一定养阴作用，1~4诊均未用苦寒之品，盖气阴之复本难，岂能再为苦寒所伤？7月迨症状明显缓解，方根据节令之变参黄芩及苦辛温燥湿之品。张锡纯曾引陈修园之言曰：“脾为太阴，乃三阴之长，故治阴虚者，当以滋脾阴为主，脾阴足，自能灌溉诸脏腑也。”另84年春，一沈姓男孩因病过用抗生素，致腹泻3个月不愈，饮食入腹末1小时

即几乎完谷排出，烦渴不止，形瘦如猫，虽已岁半，却无力支撑站立，迭治少效，其外婆劝其父母弃之，以利再次生育。其大伯为中医骨科医生，将其带至马师处，他与田爱华老师采用大剂养脾阴合收敛药并结合外敷，半年始愈。结合本案观之，当知养脾阴对慢性泄泻确有佳效，亦可引伸治其它慢性病也。

（郎晓闽整理）

8、便秘

裴女，27岁，农民，1998年10月6日初诊。

5年前产后大出血，家贫未能调治，遂患便秘。以为小恙，非但不治，且辛辣迭进，终致近周始一更衣，又致内痔发生，每入厕则需强力努挣，肛门裂破，鲜血淋漓，痛似刀割。故95年在一乡医院行痔疮手术。术后约半年大便尚正常，后因随夫经商，收入渐丰，营养改善，形体日肥。为减肥每日均作健美操三次，大汗淋漓方歇，未3月，腹收形瘦，颇为欣喜，但便秘复作矣。易医数人，迭进峻下攻便，滋阴清热、养血润肠、益气通幽、顺气导滞，温通开秘等法，初效，继则少效，终则不效矣。转请予治，翻阅其病历，几乎治便秘之法悉皆用过，故予亦颇感无着。适友人湖北英山县舒鸿飞主任医师将其所著《中医临证发微》惠赠予，拜读书中便秘变治四法一文后，恍然有所悟，患女之病恐与汗出过多有关，舒君所言用“调和营卫止汗法”治便秘，似乎可适合于该女。遂书：生芪、糯稻根、浮小麦各30克，生白术、芍、当归、姜仁各15克，麻黄根、肉苁蓉各10克。防风、桂枝、甘草各7克，姜3片、枣3枚。3剂后汗略收，便3日一行，解时仍要用力，续进7帖，大便基本正常。后以十剂配蜜熬膏而收功。

按：便秘用止汗法，似乎颇奇，但扪心问之，乃未深究仲景书

也。考《金匱·婦人產後病脈証篇》第一节：問曰：“新產婦人有三病，一者病瘕，二者病郁冒，三者大便難，何謂也？”師曰：“新產血虛，多汗出……”，此處實已寓含便秘常因多汗所致，故止其汗，令津液還歸大腸，則每可液增舟行，腸潤便暢，因筆者疏懶，極少看書，故臨証乏術，不知用此法也。近因編著此書，方又查閱一些資料，見友人江蘇靖江中醫院賈美華學兄，91年惠贈我所著《菁菁園診余筆談》書中，載有“便秘治療十二法”，亦言及固表還津法，只是當時讀後已忘却。另還提及縮泉回津、酸甘化陰可治此病。今賢還有提出固帶通便、秘精通便等，雖在於醫者臨証獨運匠心，但為醫者若不讀書，焉望提高臨証水平哉！

（馬繼松）

9、腹痛（慢性附件炎、蟲証）

谷女，34歲，農民，1999年12月18日初診。

臍周及兩側少腹脹疼，月經愆期量少色黑夾塊已四載，據述為產後上環前過用活血藥所致。曾在我市一老中醫處服中藥30余劑，經色轉紅，量亦稍多，但停藥未久又復作。西醫根據其黃帶粘稠味腥，腰酸墜脹及婦檢所查，診為慢性附件炎，予金剛藤糖漿，桂枝茯苓膠囊而未见顯效。刻診除上述症外，尚有納少畏寒，消瘦乏力，交睫則夢，面有多處明顯黃褐斑。舌偏紅苔黃濁，脈細滑，改請馬繼松老師診治。馬師認證為濕熱乘陰虛而下注也，現經淨16日，先予滋陰活血，清化濕熱，佐以行氣：山藥、苡米各30克，女貞子、赤白芍各20克，懷膝、香附、白朮、元胡、烏賊骨各15克，當歸、茜草、白芷、郁金各10克，6帖。12月25日：雖帶減腰酸略緩，但感滿腹氣窸攻撐，以臍圍為甚，後陰墜脹，大便漸瀉：此氣分薄弱已極，無力鼓氣外出，反逆上引動蛔蟲作祟（15歲曾患膽蟲症），當參入溫扶脾家氣陽藥：去茜、郁、烏賊、赤芍，

加党参 30 克,青广木香各 10 克,白术、炮姜各 5 克,6 帖。2000 年 1 月 4 日:前日经至(仅愆期两天),大便排蛔一条,腹痛缓,腰不酸,胃纳增。但仍畏寒便溏,苔白浊滑略黄,乃过去凉药过服,阳气戕伐太甚也。效方略予进退:去贞、膝,加乌梅、煨益智仁各 10 克,当归改炒用。10 帖。1 月 18 日:它症皆缓,带黄增多,味仍略腥,苔未尽化,脉细弦。继予温肾脾之阳,化下焦湿瘀:党参、苡仁、山药各 30 克,土茯苓、鸡冠花,郁内金各 15 克,鹿角霜、补骨脂、川芎、白芷、焦查、椿根皮各 10 克,炮姜 7 克,10 帖。6 月 30 日:昨日常至(日期已正常),量可色红,脐围腹胀基本平伏,除仍时感腰酸及带下(已不太黄腥),余无明显大苦,尤喜面色渐华,黄褐斑退大半。原方加当归,三七、白芍各 10 克,10 帖共未,以药头煎浓汁泛丸,日 4 次,空腹淡盐汤下。药后追访,一切尚安。

按:谷女初诊效差,马师自认为乃忽略了其阳为过多苦寒药戕伤已虚也,复诊摒弃了用苦寒清化药治此症的常法,加入炮姜、党参等,症则显著好转。近代章次公治妇科月经不调,极喜用善用仲景温经汤,盖前人曾云:“寒则气滞血凝,温则消而去之”,确有至理,若一遇所谓“炎”证,则投大剂清化消散,难免僨事焉!另马师初诊所用系《内经》十三方之一的四乌贼一芦茹丸,此方乃治血虚精亏气伤而致的血枯经闭等症,但对阳虚伴湿热瘀凝致经少愆期者,效欠满意。复诊加入鹿角霜、补骨脂、炮姜、益智等温补肾督药,与西医“月经正常与否有赖于大脑皮层一下丘脑—垂体—卵巢、子宫功能协调”这一观点极其吻合,且又配入了清化湿瘀的苡米、牛膝、土茯苓、椿根皮及行血化瘀的芷、芎、香附等,用药照顾全面,获效也就较快了。

(夏小艾整理)

10、胁痛(肝内胆管结石)

叶女, 23 岁, 农民, 1989 年 4 月 17 日初诊。

儿时曾患过胆道蛔虫症。春节后感厌食油腻, 右胁时胀痛, 并牵及脘腹不舒, 时向肩部放射, 痛剧则泛恶呕吐, 服用消炎利胆片后疼可略缓。大便溏秘欠畅, 小溲黄短, 口时干苦, 但饮水不多。3 天前 B 超检查, 示空腹胆囊 $4.8 \times 1.9\text{cm}$, 囊壁光滑, 透声好, 未见异常。胆总管内径 0.8cm , 内未见结石。于肝左外叶上段支胆管内见数枚结石, 堆积长为 1.6cm , 肝内胆管均见轻度扩张, 确诊为肝内胆管结石伴胆管轻度扩张(超声号 89858) 西医主张手术, 颇感畏惧, 其舅乃马继松老师学生, 故介绍于马师诊治。马师察其舌边偏红, 苔黄腻, 切脉弦滑, 重按少力, 且纳少神疲, 体丰带多, 遂诊为肝胆湿热久蕴成石, 乘脾虚作祟也。予金钱草、山药、苡米各 30 克, 党参、郁内金、生山查、白术芍、海金沙、香附各 15 克, 枳壳、元胡、当归、姜夏各 10 克, 柴胡 7 克。6 帖。4 月 24 日复诊: 诸症显减, 要求原方续进 15 帖。5 月 10 日三诊: 诸症基本平伏, 因农事渐忙, 要求改成药缓图。考虑便溏较甚, 苔黄渐化, 去当归、香附、姜夏, 加炒归身、木香、炒黄芩各 10 克。10 帖量共末, 以药头煎水泛丸, 如绿豆大, 每服 10 克, 日 4 次, 空心下。6 月 20 日四诊: 神旺纳振, 已无苦楚, 舌脉亦可, 要求续进药丸一料: 去山药、元胡、黄芩, 加党参、留行子各 15 克, 虎杖、石苇各 20 克, 10 帖。为丸, 服法如前。7 月 30 日: 喜告丸药服完检查, B 超示: 空腹胆囊 $6.4 \times 2.0\text{cm}$, 囊壁光滑规则, 内透声好, 未见结石, 胆总管内径 0.8cm , 肝内胆管未见扩张(超声号 97646)。

按: 现代医学认为胆结石之发生是由于胆汁郁积, 胆道细菌和寄生虫感染及胆固醇代谢失调而引起, 发作期与缓解期表现不同, 前者多呈急性发作, 以汤药荡之为好。多数医家喜用大柴胡汤, 但大黄峻下怕患女体虚难耐, 故马师改用自拟复方四逆散

合大剂四金汤,并配入党参、山药、苡米健脾祛湿。三诊症已稳定,疾病进入缓解期,改用丸剂缓图,以收全功。金钱草、海金沙、鸡内金均有极强的溶石,排石作用,郁金虽不直接溶石,但能调节胆内类脂质代谢,降低胆固醇,并使胆道奥狄氏括约肌明显松弛^[注],故四药相合而成的四金汤,成为今人最常用的排石之方了。

[注]:孙亮亭等,辨证分型治疗胆结石 50 例临床观察。《亚洲医药》1998(10)1287。

(孙华荣整理)

11、急黄(急性黄疸性肝炎)

奚女,37岁,工人,1973年2月15日初诊。

春节前去外地探亲,未料感受时邪,复因饮食不谨,致大年初7壮热($T38.9^{\circ}\text{C}$)烦渴,胁痛腹胀,纳少便干,溲短灼热而黄,尤惊恐于遍身黄染,遂被亲戚送医院急治,经检为急性黄疸性肝炎,经公社医院治疗两天,未效,由亲属护送返家,延请田师诊治。田师至其家见其身目深黄似金, $T39.4^{\circ}\text{C}$,渴欲饮冷,呕恶不食,五日未更衣,小便极少,色如浓茶,胁腹胀痛拒按,日暮时有谵语,齿鼻时有渗血,肌肤亦现瘀斑。肝大两指,有压痛,舌红绛,苔灰黄,干而起芒刺,脉弦细数。知系急黄之证,建议转市级医院抢救。但患者限于经济,恳请先用中药试治两日,勉拟一方以观进退再商:犀角粉0.5克(冲)、生地、银花、茵陈、茅根、垂盆草各30克,丹参、赤白芍、板兰根各20克,生军(后下)、石斛、泽泻各15克,黄连、生草各10克。2帖。因犀角粉无法购得,让其夫去刻章店急购水牛角1个,用3000ml水煎1小时,以此水煎药。当天将2帖药服完,即每隔6小时需服药300ml左右。药后腹痛颇甚,解先硬后溏大便颇多,臭秽不可近人,小溲之色亦如

血, $T38.7^{\circ}\text{C}$, 黄疸略退, 它症稍减。减生军为 10 克, 加香元皮 10 克。2 帖。仍用新购水牛角煎汤代水, 将两帖药各煎 2 次, 一天分 4 次服完。第 3 天患者由其夫搀扶至屋外, 神情较前为安, 告知饥欲食, $T38.1^{\circ}\text{C}$, 黄色进一步减退。舌红苔黄仍较干, 但芒刺已消, 脉数略减。嘱略进陈米烫饭。去黄连、生军, 易黄芩、熟军各 10 克。2 帖。另购只水牛角, 煎、服药之法同前。三天进药 6 剂, 诸症显见好转: $T37.7^{\circ}\text{C}$, 黄色已由金黄转成橘子色, 肝大不显, 压痛消失。苔虽仍黄却不干, 脉转弦滑。其畏药苦, 且腹泻难受。以焦栀、丹皮各 10 克, 虎杖 20 克, 苡米 50 克, 易黄芩、丹参、大黄、泽泻。3 帖, 以牛角煎汤代水, 日服 1 帖, 煎饮 3 次。后在此方基础上, 渐去苦寒, 加北沙参、麦芽、枳壳等调理两旬始痊。

按: 奚女所患系甲肝, 虽现热入营血之症, 但因体质素佳, 且和田师同在一厂居住, 故方敢勉力救治。按理可用牛黄丸等三宝以急救, 憾无此成品, 只得用吴瑭清营汤损益, 日服 2 剂, 以利清解凉血, 养阴护心。水牛角代犀角, 亦无奇特。取效较快之关键, 窃以为与连用 6 天大黄, 迅速排毒有关。80 年夏初, 芜湖县医院收治一例因穿背心撒农药, 使肌肤接触较多农药, 导致剥脱性皮炎之男青年, 亦现典型的热入营血症状, 请余会诊, 开始投用清营汤, 但效不明显。翌日加用大黄, 随二便畅行, 邪毒尽祛, 很快逆转病势, 足见中医非不能治急性病, 只是难遇此类病也, 诚为一憾!

(田爱华主治, 马继松整理)

12、胸痹(冠状动脉粥样硬化性心脏病)

周男, 80 岁, 干部, 1990 年 2 月 25 日初诊。

冠心病 17 载, 长期服中西药尚安。春节期间, 去老家探亲, 且进甘肥辛辣较多, 加之天气寒温易变, 致近感胸闷眩晕, 纳少

寐难，烦躁便干，日暮觉心前区隐痛。其子与马师颇熟，故邀马师出诊，我亦随往。马师观其形瘦气怯，面色萎黄，虽舌尚可，但舌下静脉如蚓，两脉弦硬少力。故认证为气阴两虚，无力推动血运，而致瘀滞作痛。予：制首乌、鸡血藤、党参各 25 克，丹参、朱茯神 20 克，生地、白术芍、柏枣仁各 15 克，当归、麦冬、天麻（另炖兑入）、钩藤、郁金各 10 克，五味子 7 克。5 帖。3 月 3 日复诊：药服 2 帖，即腹泻，且脘胀太息，身困肢沉。自觉药力过峻将每帖药连煎 3 次，混匀，日喝两次，三天服两剂。第三日虽不再泻，但便不成形，眠、晕略缓，胸痛、纳呆更甚，晨起咳嗽，吐痰白稠却难出。察苔黄白厚浊，改投薤白、姜夏、元胡、川芎各 10 克，内金、丹参、郁金、炒白术各 15 克，党参、鸡血藤各 20 克，炙萆皮、京菖蒲、三七、桂枝、生草各 7 克。5 帖。3 月 10 日：药后颇适，随痰咳较畅，胸闷渐松，纳增神振，脉亦稍扬。但仍目力昏，胸微痛。去菖、草，加葛根、杞子各 10 克。5 帖。后因自感效可，遂以上方出入：晕甚加天麻、钩藤；耳鸣加白蒺藜、石菖蒲；便秘加桑椹子、枳壳；腰酸加怀膝、杜仲等。6 月中旬入梅后，配丸药，盛夏改粉剂，冬至用膏剂调补。至今仍健在。

按：我问马师：“患者初诊为何少效？”他告：“冠心病之轻证，相似于中医之胸痹，其病机乃阳微阴盛，本虚标实。初诊按当时症状，诊断并无大误，但忽略了八旬老人，虽虚有时却难耐峻补，且春寒未尽，未加阳和温通之品，气血运行迟滞，故尔效差也。”并言：虽古人曾云治急性病需治病留人（即以祛邪为主），治慢性病当留人治病（即以扶正为要），但也应活看，不可见年老、体弱或病久即浪投峻补，以滞其邪。且要注意节令、气候与病的关系。笔者后来临证，常思其言，避免了一些不必要的失误，故录于此，供道友参酌也。

（郎晓闽整理）

13、不寐(失眠)

李男,76岁,外科主任医师,1998年11月20日初诊。

失眠十多年,每晚服4片舒乐安定仅睡1—2小时,近一周服女儿从美国带回的松果体素片,虽能入睡,但恶梦不已。另患糖尿病多年,一直靠达美康控制血糖,致两腿无力,难以站立,故始终住院治疗。因西医对失眠无更好治疗方案,故请余用中药试治。刻诊:形体丰盛,精神萎靡,面色苍白,却油脂分泌颇重(西医诊为脂溢性皮炎)。两目圆睁,急躁易怒,渴喜饮冷,寒冬亦然。便秘常7日始行。察舌红绛,苔灰黑燥厚,脉滑数。乃断为痰火壅盛,心神被扰,拟清泄痰火,养阴安神:生地、百合、生白芍、枣仁、茯神、炒蚕沙(包)各30克,玄参、花粉各20克,瓜蒌皮、麦冬各15克,大贝、胆星、知母、天竹黄、石菖蒲各10克,生草5克。2剂。11月22日复诊:因患者饮水量极大,21日将2帖中药服尽,致处于昏睡状态,呼之能醒,问答切题,俄顷便又复睡。西医误为病重,急送抢救室观察,但除嗜睡外并无其它病情恶化表现,直睡至今日近中午方醒,足有15小时。醒后解先硬后溏之便颇多,精神遂振,行走较利。然苔虽转润,黑亦渐淡,但未能尽退,口仍偏干,脉数稍缓。知痰火泄而未尽,去萎皮、胆星,易茵陈、虎杖各20克,继进5帖以善后。

按:患者住院期间,适值我在该院实习西医,患者之女为我带教老师,其婿颇信中医,和家父熟识,知我系中医之后,对我开方较放心,故方敢投以大剂清化痰火之品。然考虑患者毕竟望八高龄,苦寒太过恐致变端,因此治以仲师百合知母汤合吴瑭增液汤,取甘寒养阴生津,以助清化痰火之用。另生白芍、茯神、枣仁既可直接安神,更可补益心脾。蚕沙可泄湿通便解毒,使长期因便秘产生的毒素由二便排出,但辛甘平和力薄,非大剂难为功,

故用 30 克。《本草备要》言石菖蒲可“补肝益心，……，除痰消积”，《朱良春用药经验》则云该药：“安神益志，宁心化痰并重，在补益中寓宣通之意”。在大剂清凉泄化药中配之，其辛温之性还可起反佐作用，使脾胃不受寒药之伤也。

(马璇卿)

14、中风(脑血栓形成)

薛女，58 岁，工人，1989 年 8 月 26 日初诊。

素体胖壮，能操持 9 口之家的繁重家务，未料四天前晨醒后突左半身不用，右侧鼻唇沟变浅，咀角轻度右歪，但神志正常，语言尚清。经市某院诊为脑血栓形成，住院 3 天未见大效而返，遂求马继松老师诊治。予随师至其家，见其虽卧于床，却面红润，语声响，而切脉却弦细滑、重按无力，察舌红嫩，苔少色黄，舌下静脉紫粗如蚓。询其眩晕耳鸣，口苦烦躁，溲黄便干，筋惕肉瞤，尤苦于内热目胀，测 BP160/100mmHg。知其辛辣迭进，家务过劳，肝肾阴精双戕，内风乘虚阳之逆上而犯脑作乱。症虽重，仍属风中经络，且饮啖尚可，病发未久，宗叶氏法，可保无虞：生牡蛎、生赭石（两味先煎）、生白芍、朱茯苓、鸡血藤各 30 克，制龟板、钩藤（后下）、怀膝、寄生、白蒺藜各 15 克，天麻（另炖兑入）、地龙、当归、焦栀各 10 克，5 帖症颇减。后以上方进退，服药月余能在室内拄杖缓行矣，它症亦基本平伏。

按：此病极常见，且多现气虚血脉不利之症，为医者颇喜用王清任补阳还五汤。但马师认为薛女虽肥胖，但无明显气虚痰盛之象，且反现一派阴虚阳亢症状，故当遵叶桂“肝阳偏亢，内风时起，治以滋液熄风，濡养营络，补阴潜阳”（《临证指南·中风·华岫云按》）之法，以蛎、赭、龟、芍滋阴潜降以治本，归、膝、地龙、寄生、蒺藜、二藤等养血通络以顾标，苓、栀、天麻，清化痰火而共奏

其功。马师告曰：文革时他曾治一例与薛女症状类似之王男，因体胖过投温燥化痰药，且重用黄芪 30 克，症反转危，几致不救，故强调治此病勿浪用辛窜之品。

（黄宗炎整理）

15、水肿一（急性肾炎？）

潘女，61 岁，家庭主妇。

1967 年夏正值文革武斗期间，该女突患遍身洪肿，因几无医院上班，故我一邻居邀我出诊。见其仰卧于床，面白少华，气息奄奄。其女于旁缝制孝衣，哭告曰：“我母素体虽弱，但似无太重之病，一周前洗浴之水偏凉，又当风而卧，遂恶寒发热，咳嗽喘急，关节疼重酸胀，因武斗无法求医，自用生姜红糖煎汤，但服后仍无汗，热不退，反烦躁溲少，后眼睑、面部浮肿，渐及全身，纳谷少进，饮水亦胀，日差一日，坐以待毙”。我按其肌肤，凹陷颇深，但却易恢复，切其脉浮数，重按尚有根，舌偏红有薄黄苔，知病在肺脾，尚未入肾，仍属风水泛滥。故翻阅教材后，疏：麻黄 5 克，生石膏（先下）、生白术、泽泻各 20 克，连皮苓 50 克，防风己、杏仁、腹皮各 10 克，鲜薄荷 7 克（后下），姜 3 片，枣 3 枚。3 帖。谁知药店亦关门，其邻居告我：“我院中有紫苏，小时我浮肿曾用它外洗而愈，能否试用？”我闻之颇喜，让其女急取二两，并去附近塘中捞浮萍二两，并加姜、葱各五钱，闭户煎汤，遍体擦浴，翌日遂汗出溲畅，洪肿渐退，嘱进粥自养，以助汗、溲之出。隔日复取诸药擦浴，3 次后肿消近半矣。后武斗略平，我以五苓五皮加黄芪、防风己、薄荷、枣等数帖收功。

按：本病诊为风水泛滥不难，关键是在无法服用药时，当如何救治？幸其邻略懂医，提及紫苏外用，才挽救了患女性命，原以为乃侥幸耳。后读《柳选四家医案·爱庐医案》时，见清代名医张

仲华早有用麻黄等外洗配内服药治遍体俱肿案。80年代我在编著《现代名医医案选析》时,亦见外治法退肿之案。但需要注意的是:虽清代吴尚先《理渝骈文》曰:“外治可与内治并行,而能补内治之不及”,但亦应审证酌情而投。取外洗法消肿,多用于阳水之风水泛滥型,且伴无汗或少汗之表证,得汗肿稍退即不可过用,并应时时补充汗源,谨防阴竭阳散之变端。另患者病中无法进行确诊,但从肿退之速及患病之因考虑,可能为急性肾炎也。

(马继松)

16、水肿二(肾性高血压)

陈女,36岁,农民,2000年2月10日初诊。

肾性高血压五年,断续服西药时缓时甚。去岁连服中药四个月,遂控制在130~150/85~105mmHg。后停药4个月,加之春节期间过于劳累,进食辛咸较甚,血压又急升至230/140mmHg,伴头痛烦躁,脘嘈口苦,渴欲饮而不多,便秘溲少,心悸寐难,腰酸腿肿。月经常愆期,且量少色紫挟块,舌红苔腻略黄,脉弦细数。阅前医方多为天麻钩藤饮合养阴利尿,虽颇平稳,但收效欠速。所喜日能啖谷6两,尿检尚好(仅蛋白+),故改投朱师方:穿山龙、益母草各50克、金钱草、泽兰泻、接骨木、土茯苓、丹参、山药、寄生各30克,生地、黄芪、怀膝、竹叶各15克,当归10克,生草6克。2月25日复诊:7剂后尿量颇增,月经较多,血压180/125mmHg,它症亦减。但时眩晕,有低热,大便溏秘交替,日暮腿肿腰酸,舌淡苔黄腻,脉细数弱。上方去泽兰、金钱草、土茯苓、竹叶加鸭跖草、决明子、茯苓、鸡血藤各30克,生地、黄芪、怀膝、当归复各加5克。15帖,每帖煎4次,每次令得药汁500ml,混匀,两天内作6次分服。3月26日三诊:尿量续增,大便日2行,略溏,腿肿渐消,月经转红,紫块已少。血压150/

100mmHg,尿蛋白(+),因农事渐忙,且经济较紧,要求原方作丸药缓图,遂用上方10帖共研,以药头煎浓汁泛丸,每服15克,日4服,空心下。

按:朱良春主任医师治肾性高血压兼尿少浮肿者,喜用大剂清热利尿,活血解毒之品,佐以益气养阴,随二便畅行(尤其是小便),血压很快下挫,它症亦会轻减。余随师进修期间,见不少用它法效不显的顽固病人,一般服药20帖,皆取彰彰之效,故向道友介绍之。其中接骨木为忍冬科植物接骨木的茎枝,甘苦平,可祛风利湿,活血止痛。除擅治骨折、风湿痛外,对肾炎水肿亦有奇效。穿山龙的功用可参见《朱良春对痹证之建树》一文。鸭跖草甘寒,可行水清热,凉血解毒,对肾性高血压极合,且夏季常可自采泡饮代茶。

(马璇卿)

17、热淋(急性尿路感染)

王女,35岁,商人,1997年6月5日初诊。

因淋雨发热两天, $T39^{\circ}\text{C}$,稍畏寒,伴腰膝酸痛,尿频急短赤,淋漓涩痛,少腹坠胀,近周末更衣。双目赤,口干苦,舌红绛、苔薄黄,脉弦数。诉为扩大业务,日前多次陪客饮酒,且迭进辛辣甘肥,不仅使习惯性便秘日趋严重,且上月月经量少色紫挟块。西医静滴三天并予抗生素口服,热仍未显退。舌偏红有齿印、苔白黄浊腻,脉濡滑。此系热淋发热,又触暑湿,当兼顾之:金钱草、生军、佩兰、竹叶各20克,川膝、青蒿、枳实、生白术、苏叶、薄荷、石苇各15克,炒知柏、焦栀、生草各10克。2帖。6月8日复诊:前日排便两次仍偏干,昨日腹痛排溏便三行,尿频急痛渐缓,色先黄如浓茶,今日渐清。尤喜随二便畅行,目赤口苦均缓,肌肤亦汗出溱溱,热降($T37.8^{\circ}\text{C}$)寒散。然感泛恶欲呕,乏力嗜睡。效方

出入：去生军、青蒿、枳实、薄荷、知柏，加茅根 30 克，银花 20 克，姜夏、厚朴、党参各 10 克。复进 3 帖，诸症基本平伏，5 日后行经，量渐多，趋于正常，色亦转红，惟仍腹痛夹块，予当归养血膏两瓶而痊。

按：本案辨证不难，药亦无奇，而获效颇速之因：一系初诊即重用大黄，且生用。虽医者皆知其为峻下通大便之药，但李时珍却明言可治“小便淋沥”，故热淋用之堪为对症之选。二系用了大剂佩、蒿、苏、薄等辛散走表之品以驱外邪，此类药药效极易挥发，少用乏效，多用还可对抗大黄之峻下，亦可防利尿通淋等里药量重而引邪内陷也。

（马璇卿）

18、石淋（输尿管结石）

陶男，49 岁，木工，1998 年 5 月 5 日初诊。

腰部酸痛沉重如捆已半月，经查左肾盂轻度积水，左侧输尿管有 6×6mm 结石，输尿管管径 9mm，要求服中药排石。刻诊舌淡红略暗、苔黄腻，脉濡左尺弱，畏寒便秘，时心悸口苦。曾有嗜酒与夏天睡水泥地史。予温肾益气，利尿排石：党参、黄芪、苡米各 30 克，留行子、生白术、香附各 20 克，川膝、杜仲、苁蓉、石苇、虎杖各 15 克，苍术、桂枝、木通各 10 克。10 帖。5 月 14 日：腰痛显减，大便渐正，苔腻亦化，仍畏寒脉弱：去党、杜、苁、虎加附子、石苇、莪术各 15 克，黄芪，巴戟天各 20 克，金钱草、瞿麦各 50 克。10 帖。5 月 25 日：腰痛明显下移，并向少腹放射，畏寒显退，精神略振。舌正红，苔薄黄，脉略扬起。B 超示：结石向下移至输尿管下端第三狭窄处。效方更进一筹：熟附子（先下）、桂枝、熟军、川膝、莪术各 15 克，冬葵子、香附、留行子各 20 克，党参、生白术、石苇各 30 克，瞿麦、黄芪、金钱草各 50 克，木贼草 10 克。

10 帖，嘱每帖以 2000ml 水浸泡 1 小时，煎约 800ml，一次性空腹顿服，服后上下跳动一刻钟，若有尿意尽力忍之，待忍耐不住时猛力排出。每日服 3 次。至第 6 剂时，感排尿时尿道堵塞，胀痛难耐，后憋劲猛解，排出一粒黄豆大小石块，顿感全身轻松。嘱将另 4 帖药合并用大锅浓煎两次，得药汁 3000ml，贮藏冰箱中，每天分三次饮用，每次 300ml，以清余邪。

按：尿石属石淋证，故一般医者习用一派清热利尿通淋之品，加入内金、琥珀等溶石药，然有效有不效。愚见对肾虚夹湿，还得参以温肾益气之品，因温肾可助膀胱气化，益气可扶正以利驱石。在体质尚好的情况下，还可适当配入大黄，盖大肠蠕动加快，亦会有助于输尿管的蠕动，有利结石的下行。另在结石下移输尿管末端或为膀胱、尿道结石，可配入“提壶揭盖”之品，如木贼草、桔梗、升麻等，因上窍开则下窍自通，小溲得畅，石遂易出也。

(马璇卿)

19、石淋二(输尿管结石)

章女，30 岁，干部，1998 年 1 月 16 日初诊。

前天上午因突发右肾区明显压痛，叩击痛，右下腹亦明显压痛伴轻度肌紧张，而去医院急诊，经 X 线示：右输尿管下段有一 $1.3 \times 0.7\text{cm}$ 阴影，B 超又提示右肾轻度积水，遂按输尿管结石留院观察治疗两天，昨晚症状基本消失而返家。未料今日晨起入厕，因便秘努挣，右侧腰腹复痛如前日，其父与马继松老师为世交，急领其至马师家。刻诊除上述症状外，尚伴面色㿖白，冷汗阵阵，表情痛苦，诊脉弦紧，舌淡紫有齿印，苔黄浊。细询因常赴宴，辛辣甘肥迭进，致月经亦渐少，并挟紫块，形体胖。马师断为湿热夹痰瘀久留下焦而凝结为石，予：黄芪、金钱草、石苇各 30

克,冬葵子、海金沙各 20 克,郁内金、威灵仙、槟榔、川膝、留行子各 15 克,炒五灵脂、地龙、木贼草各 10 克,肉桂 5 克(研,后下)。3 帖。并嘱药泡半小时,用大锅煎汁 800ml,空腹顿服,日 3 次,服后上下跳跃 15 分钟,强忍小溲至非排不可时方用力排之。第四日晚 9 时许服三帖药第三煎后,感腰腹痛突剧,且向前阴放射,自知有石将出,后在痰盂内小溲,排出一 $1.2 \times 1.0 \times 0.6\text{cm}$ 表面呈桑椹状之灰白和黑褐相兼之石。此时之尿液淡红,尿道灼热略痛,改予清化湿热,凉血滋阴 3 剂善后。

按:患女求诊时,我因赴芜公干顺道看望马师,适在其旁,见其所开治结石方与教材出入较大,故询之。师曰:此乃自拟之芪槟威五四金汤加味也。重用黄芪,通过补气,加强正向内压力,促使输尿管蠕动;槟榔为下气利水要药,通过肠道的蠕动,小溲的增多,亦有利尿石的下行;药理证实威灵仙对平滑肌有明显的兴奋作用,且有较强镇痛之功,并能软骨(《药品化义》),故可移用治尿石;五灵脂为行血止痛要药,尤善止心腹血气诸痛,故以上四药配常用的排石四金汤合成此方。若患者纳可,每伍入地龙,以解除输尿管痉挛而止痛,并能利尿促石下行。当结石降至膀胱或尿道,则配木贼草与肉桂这组“药对”,一以提壶揭盖,一以宣化膀胱气机。临床用此方辨证诊治数十例泌尿系结石,取效尚称满意。然章女获效如此之快,与尿石已至输尿管下端,女性尿道较宽敞,且其能“药灌满肠”,并辅以跳跃,忍尿急排亦有关。

(黄宗炎整理)

20、消渴(糖尿病)

金男,46 岁,工人,1990 年 3 月 9 日初诊。

糖尿病近三年,开始多饮、多尿,胃纳亦旺于平日,且消瘦快,3 年减重 7 公斤,经服降糖灵、达美康,且控制主食,日仅进

半斤，症状好转，但血糖仍 $180\sim 220\text{mg}\%$ ，尿糖 $++\sim +++$ ，故找马继松老师诊治。刻诊尚有烦躁寐难，脘嘈口苦，腰酸膝软，视物昏花，夜尿频多，足跟时痛，畏寒神疲，面色浮红。舌淡苔灰白略滑，脉沉弱。细问知三年自然灾害，其正值发育之时，因之体弱多病，加之结婚偏早，生活又差，体力远不及同年人。马师诊为肾阴肾阳双亏，气血津精欠盈，当予峻补，稍参苦寒坚肾：炒熟地、山药、女贞子各 30 克，党参、复盆子、楮实子各 20 克，菟丝子、粉芡实、酒怀膝各 15 克，泔苍术、五味子、山萸肉各 10 克，炒知柏、熟附子各 7 克，7 帖。另每日以玉米须 30 克泡茶饮服。复诊觉方颇适，遂以此方增损，先后用过麦冬、玉竹、黄精、百合、杞子、菊花、黄芪、龟板（研吞）、苁蓉、巴戟等药，但主药熟地、山药、菟、味、萸、附等始终用之。断续诊治近百日，服药 50 余剂，尿糖、血糖先后降至正常，它症亦基本恢复。

按：消渴病之病机，中医多责之阴虚燥热，病变脏腑主要在于肺、胃（脾）、肾，尤以肾为关键。故前贤与今人所创治消渴名方，不外甘凉清润，甘温益气，或佐以泻火，固涩，而用辛热燥烈之附子等药极少。然张仲景早在《金匱》中即明言：“男子消渴，小便反多，以饮一斗，小便一斗，肾气丸主之”，故马师遇肾阳虚症状较明显之患者，每喜用该方，金男虽以右归丸加味，实已寓含肾气丸之意。但他强调，本病毕竟系燥热致疾，附、桂刚烈量不宜大，仅求“少火生气”耳！另他主张同时辅以小量之知柏，一可养阴坚肾，二能防辛热药之“壮火食气”。

全国治糖尿病的名家祝谌予主任医师，极喜用自拟的四对降糖药（即黄芪配山药；苍术配玄参；生地配熟地；丹参配葛根）。另有人统计治此病最常用的 12 味中药为花粉、麦冬、元参、黄芪、山药、地黄、知母、五味子、黄连、党参、枸杞、石膏，马师认为临证不妨参考之。

21、鼻咽癌

钱男,53岁,工人,1996年5月27日初诊。

50天前被确诊为鼻咽癌,一个月前放疗一次,感咽干渴饮,神疲烦躁,二便均少,耳底胀痛,精力不支而请予诊治。刻诊口极干,日饮水三暖瓶仍不解渴,鼻中脓涕不断,阻塞难闻香臭,有时甚至回吸从口中排出。嗜眠却梦多,便艰耳胀痛。舌偏绛,略胖嫩,有齿印,苔黄燥起刺而厚,脉细滑。详问有酗酒嗜烟史,因家境较贫,下班后常蹬三轮车至夜。知其劳累致气阴双戕,烟酒复助湿生热,法当补气益阴,清解燥湿,佐以活血化痰:北沙参、生白芍、蛇舌草、石见穿、龙葵、党参、银花、茯苓各30克,黄芩、丹参、枣仁、花粉、天葵子、八月札各20克,姜夏、橘皮、藿香各10克。10帖诸症颇减,但涕仍多,鼻阻塞,苔不化。以生麻黄、石菖蒲、知母各15克,易枣仁、藿香、陈皮。又10帖,涕渐少,鼻窍通,嗅觉敏,但苔腻虽渐化,色绛依旧。将白芍、丹参各加至60克。更进10帖。舌遂渐红,苔化殆尽,脉亦扬起,神情颇振,当加重抗癌之品:八月札、花粉各加至60克和30克,以玄参、苍术易黄芩、麻黄,诸症基本稳定。后以此方出入,每月服药20剂(3天服两帖),现不仅仍健在,且可骑车外出,并在某外资企业值保卫班。

按:癌为当今谈虎色变之疾,中医治疗大法不外益气养阴,清热解毒、活血祛瘀、行气化痰、软坚散结与以毒攻毒6法。钱男因初诊时为长夏梅雨之季,且体丰涕多,舌胖有齿印,苔厚,故又参入燥湿,初用藿、橘等效不显,改用大剂麻、菖,方使涕少窍通,苔浊得化。《滇南本草》言麻黄:“治鼻窍闭塞不通,香臭不闻”,不欺人也!天葵子俗称千年老鼠屎,甘苦而寒,为清热解毒,消肿散结之要药,主治各种疮痈,如《医宗金鉴》之五味消毒饮,现移治

于各种肿瘤。所憾未被五版大教载录,善用者不多,使明珠投暗矣!八月札系木通果实,甘寒,有舒肝理气,活血止痛,利尿除烦之功。近贤用于治肿瘤,临床时有报道,然药性平和,非重用难为功也。另根据我随名老进修所见,对肿瘤的治疗,一定要在扶正(尤其是益气养阴)的前提下进行祛邪,否则一味蛮攻,难免坏事,故患者自始至终均用了较多的补益之品。

(马璇卿)

22、颈痈(急性淋巴结炎)

林男,45岁,工程师。1991年5月21日初诊。

过嗜辛辣,致颈部右侧发生一硬肿,疼剧,发热恶寒,西医诊为淋巴结急性炎症,输液3天,并配用抗菌消炎药,未见显效。故转请马继松老师诊治。刻诊:局部肿大如鸭蛋,色未变,质较硬,触痛明显, T38.3℃。伴眼干口渴,烦躁, WBC 11300/mm³, N 81%。舌偏红,苔黄腻,脉滑数。急于清解活血,化痰散结:银花、赤芍、连翘各30克,元参、大贝、黄芩、花粉、生牡蛎、白芥子各15克,僵蚕、归尾、山慈菇、生草各10克,夏枯草、升麻各7克。5帖。5月28日复诊:寒热渐退,肿块略红软小,仍疼胀,头艰于转动:去郁、升、慈、草,加北沙参20克,山栀、蚤休、野菊花各15克。7帖。6月4日三诊:肿块明显变红,中央黄软,似有脓,胀甚于痛,泛恶纳减。去蛎、芥、蚤、菊加陈皮、白芷、皂刺、生草各10克。7帖。6月11日四诊:胃纳复旺,肿之中央有黄稠脓液溢出,周边亦黄软,按之应指,并缩至鸡蛋大,前方沙参改党参20克,迭进7帖,并以黄纱布引流。6月18日五诊:随脓液外泄,肿块渐缩至鸽蛋大,去连翘,党参加蒲公英、黄芪各20克。7帖。续用黄纱布引流,后遂愈。

按:此为中医典型之颈痈,马师考虑颈部归属肝经,初诊即

用牡蛎平肝，黄芩、夏枯草清散肝火，复诊还加山梔平肝；另因肿块颇硬，初诊、二诊均用了咸寒软坚可治一切瘰癧肿块之消瘰丸；并注意顾护胃气，当二诊药后胃纳呆钝，及时用芳化行气排脓之白芷、陈皮易苦寒伤胃之蚤休、野菊与牡蛎，加之脓成又立即佐参、芪扶正，皂刺排脓，辅以引流，故尔取效较快。

（汪晓辛整理）

23、瘰癧（甲状腺功能亢进）

鲁男，53岁，工人，1998年11月7日初诊。

双眼半年前有硷外伤史，此后五个月间，双眼胞睑红肿，球结膜充血水肿，视物模糊，视力明显下降，左0.4，右0.3，右眼视物变形变小，舌红苔黄腻，脉弦滑，拟清热利湿消肿：苡仁30克，丹参、茅根、首乌各20克，白术芍、泽泻、葛根、黄芩、山梔、青箱子、丹皮各10克，防风7克。7帖。11月14日复诊：充血渐轻，自觉视力较前为好，黄腻苔稍化，但眼球突出肿胀如前，且时觉脘嘈易饥，烦躁心悸，乏力汗多，虽甲状腺外观或触诊均未见较明显增大，但亦不能排除甲亢，改予健脾化痰，软坚镇静：党参、白术芍、茯苓、海藻、生牡蛎、柏子仁各15克，丹皮、大贝、玄参、姜夏、菊花、僵蚕各10克。7帖。11月25日三诊：双眼球突出略平，且转动稍灵活，脘嘈较缓，它症依旧。经检验确诊为甲亢，药既有效，略可改弦：党参、茯苓各加15克，以枣仁20克易柏子仁。7帖。12月7日四诊，突出之眼球渐收，红肿亦退，它症皆松，患者嫌效慢，要求用峻药治之，去菊花、丹皮，改黄药子、山梔各10克。7帖。12月14日：药后腹泻脘嘈，乏力汗多，纳谷不思，苔又腻厚，复按三诊方去贝、蛎，加陈青皮各10克。7帖。12月24日：诸症继续好转，限于经济，要求成药调理，遂以三诊方加黄药子、青皮各10克，10帖共末，以夏枯草100克煎浓汁泛丸、梧子

大,每服10克,日3次,两餐饭中间及睡前各一次。春节期间见之,眼球已如常人,它症基本平伏,但双眼视力仅略提高(左0.6,右0.5)。

按:甲状腺机能亢进症是由于自身免疫反应等因素致使甲状腺腺泡细胞分泌过多的相应激素而引起的疾病,多数伴发于甲状腺肿,少数诱发于强烈的精神刺激,男女之比约1:4。由于患者甲状腺肿大不显,故田师初诊时,仅根据眼的局部症状对症用药,效欠理想。复诊时考虑为甲亢,改用消瘰丸合化痰软坚健脾之品,效果明显提高,说明治病求本的重要。但因患者性急,四诊只好加入治甲亢的“特效药”黄药子,而此药过苦寒,且山栀亦苦寒下泄,反致腹泻等副作用,说明对慢性病的治疗切不可操之过急。在最后用丸剂调理时,仍加用了该药,缘制成成药后,所含黄药子的量较小,不致于引起太大的副作用。不过为防止该药引起药物性肝炎,最好定期复查肝功能。另海藻、昆布等含碘较多的药,只能抑制甲状腺素的释放,而不能抑制其合成,忌长期大量多味应用,故田师在复方中仅用一味海藻,其理即在于此。

(田爱华主治,储成志整理)

24、乳疔(少男乳房发育症)

张男,15岁,1989年4月5日初诊。

半月前右乳头正中与左下方,各长一枚 $2 \times 1.5\text{cm}$ 之硬结,胀痛颇甚,推之难移,但表面光滑,西医诊为少男乳房发育症,囑勿治,久则自消,若不消再酌情考虑手术或服药,因其外祖母患乳癌去世,其与马师原为近邻,遂求马师诊治。马师观其形瘦性急,每日饮牛奶,并喜食辛辣炙烤之物,且初三学习紧张,成绩欠佳,时虑升学之事,结合干咳盗汗,便艰口苦,舌红脉弦滑,断为阴虚肝郁,痰瘀交阻,予赤白芍、留行子、生麦芽、茯苓、元参各

20克,归尾、白蒺藜、白薇、青皮、炒牛子各15克,大贝、炮甲、猫爪草、夏枯草各10克。5帖后症减,以生牡蛎、连翘各20克,易白薇、白蒺藜。复进5剂,右乳肿块渐平,痛亦大缓,但左乳头下,又起小核如黄豆大。因便溏日3行,故去归尾、牛子,加橘核20克、白芥子10克,5帖后两乳正常,它症亦除,后又购药3帖以求全功。

按:此患儿来诊时,余恰在马继松老师家有事,对此病颇感奇,故后将病历抄录。马师告少男乳房发育症中医称之为乳病,临床较为少见,上海中医学院所编《中医外科临床手册》主张调理冲任,开郁化痰,外用阳和解凝膏敷贴。马师认为程钟龄治疗痈之妙方消瘰丸,所主治症的病机与此儿较同,似可移治此病,但患儿从未服过中药,马师怕牡蛎味腥碍纳,故初诊未用,并佐以养阴、化痰、活血之品。我不知猫爪草为何物,马师告乃毛茛科植物小毛茛之块根,甘辛而温,治疗痈、结核等特效,美国将其作为最常用草药且引伸治肿瘤,但教材上均未载,颇憾!又告穿山甲乃虫药中消肿溃痈的最佳珍品,惜价昂难购,最好研末装胶囊吞,可避免浪费且效更佳,且可防其咸腥对胃的刺激。他还指出:对麦芽不可轻视之,因其生用疏肝消滞之力颇强,“凡佛郁所致膨膈等症,用之甚妙”(《本草求原》),但需大剂方效。临行,他一再提醒我,对一些诊断难明或少见报导的疑难怪病,不妨先宗痰瘀同源、同病、同治的相关学说立法,常可获意外之效。

(方六文整理)

25、面尘(黄褐斑)

陆女,44岁,工人,1988年7月27日初诊。

近数月面部色素沉着,发展较快,请马继松老师诊之。细询其经量多且挟小块,经期腹痛颇甚,大便干,尿频急,淋沥涩痛,

色深黄混浊，舌淡紫红，苔薄黄，脉细滑重按无力，平素嗜食辛辣甘肥，形瘦神旺，夜卧欠宁，乃阴虚又为湿热化火伤络致瘀，拟养阴清热，凉血化瘀：生地、生首乌、生白芍、银花藤各 20 克，野菊花、鸡冠花、炒茜草、丹参各 15 克，焦栀、丹皮、紫葳花各 10 克，柴胡、熟军、生草各 6 克。6 帖。复诊：色素沉着略淡，二便较畅，但身起红色痒疹，下肢尤多，此乃血热外泄也。去丹参、山栀、生草，加赤芍、紫草、白蒺藜各 15 克。6 帖。三诊：适值经至，量可块减。红疹渐退，痒亦大止，但胃纳欠佳，大便溏泄，舌脉如前，上方去大黄、茜、紫草、紫葳花、易木贼草、僵蚕各 10 克，香附 15 克，苡米 50 克。6 帖。四诊：色素沉着渐退，面部已有华彩，要求效方迭进，以白芷 10 克易野菊花。6 帖。五诊：面色将近正常，因南下打工，要求作成药。四诊方加薄荷 10 克，10 帖共末，取夏枯草、益母草、白茅根各 100 克，煎浓汁泛丸，每次 10 克，三餐饭后及卧前各服 1 次。国庆返芜见色素沉着已淡，不在意已觉察不出矣。

按：黄褐斑俗称肝斑，是颜面部位一种常见的色素沉着性皮肤病，中医对此认识极早，自《素问·至真要大论》首次提出“面尘”病名后，历代医家又相继提出许多病名，传今最多的为明代陈实功《外科正宗》的“黧黑斑”。对本病的辨治，当代最著名的皮肤科专家、武汉市中医院徐宜厚主任医师提出应从肝（胆）、脾（胃）、肾（膀胱）三经论治的学说，将该病分为肝郁血滞不华、脾虚痰湿凝聚、肾亏本色外露 三型去辨治，收效颇佳。马师根据治疗数十例此病的体会，认为此病多发于女性，且不少患者伴有经血紫黯或挟血块的症状，故指出从活血疏肝入手每可成功。他翻阅部分资料发现野菊花、鸡冠花、紫葳花有较好养颜美容之效，所憾野菊花过苦，紫葳花酸寒，脾胃不健或虚寒体质者不宜。陆女显系血热且纳可，故连续投之，故尔获效较佳。另白僵蚕、白蒺

藜、白芍、白芷均为清医赵学敏《串雅外编》所载金国宫女洗面要方八白散中的药物，当然亦有益于美容。但马师仍强调治此病应以辨证论治为要，不可凭一方一法而望侥幸成功。

（方六文整理）

跋

医道修远 执着求真

——记马继松高级讲师

我的老师——安徽省中医药学校高级讲师马继松先生，60年考入内蒙古师范学院中文系，后因故转而业医，从事中医教学、临床工作三十余年，淡泊名利，默默奉献，在我们长期交往中，其对中医药事业的执着追求和教书育人、诲人不倦、愿作人梯的高尚风格，给我留下了深刻的印象。

作为一名中医教师，先生先后担任过《伤寒论》、《金匱要略》、《中医内科学》、《中国医学史》等多门中医主干课程的教学工作。不仅认真备课，且能努力克服教学中的困难。如1976年文革后，因当时没有《伤寒论》教材，他不畏严寒酷暑，编写了十余万字的讲义，并将相关内容编写成55份图表，便于学生理解和记忆。为进一步让学生掌握和使用该书方剂，他还选编了一百则运用伤寒论方的病案，汇集成《伤寒论医案选粹》，撰写了《伤寒论五言歌括》，使这门令初学者感到乏味、枯燥的课程变得生动有趣，易于掌握。其中《歌括》曾受到当代伤寒大家刘渡舟教授的赞许。

先生深感近现代名医之经验和学术思想缺乏系统的整理和研究，难以继承和发扬，为配合中医临床学科的教学，他邀数名同道反复披阅百余册医案医话集，穷十年不寻常的辛苦历程，撰成22万字的《现代名医医案选析》一书，成为海内系统研究现代名医经验之第一人。该书高度概括了解放后尚健在的40余位名医之学术思想，一时纸贵洛阳，求者如云。先生将书中名家之经

验,结合现代医学研究进展,用于配合中医内科的教学,使年轻一代的中医学子汲取了诸多名医的经验精华。对他们今后的临证大有裨益,且在如何继承和发展中医的问题上探索出了一条新路子。

先生一贯强调学习中医应从基础着手,诸如经典原文、方药歌诀等必须熟记于心,临证方能得心应手。在长期的教学实践中,他对学生基础课程之学习要求很高,不仅让学生背诵经典中重要的原文,方药歌诀等,对历代医家论述某病,某方的具有实用意义的名篇名段名句等,亦要求熟读,直至背诵。先生自己亦率先垂范,讲授《伤寒论》时,他能背诵百余条原文;讲授中涉及《温病学》时,他能背诵诸如叶天士《外感温热篇》等著名篇章。课堂上的学生除惊叹其对条文的娴熟外,常报以热烈的掌声。笔者在临床工作和多次考试中,常得益于先生当年这些“苛刻”的要求。

先生在教学和研究中医学的同时,还非常重视临证。他常告诫后来成为研究生、教师的学生们:脱离了临床工作去研究中医,即成为无源之水,无本之木。他本人亦在教学之余,积极临证。由于其系统研究过前贤的医案医话,故临证思路常较广,对疑难病症,能另辟蹊径。记得八十年代后期,我随先生侍诊,遇一失眠二十余年之六旬老翁,每日仅能入睡1~2小时,苦不堪言,求治多处,前医或以滋养,或投重镇,或予西药调整植物神经功能,均未能奏效或偶而缓解而复如初。先生细询病由,家人告知系文革中遭批斗后遂不寐,又诊得舌黯红,边有瘀斑,脉象细涩,断为气郁日久,心血瘀阻致心神不宁,投以王清任血府逐瘀汤,三帖药后,每日即能入睡3~5小时,后改制丸药,睡眠保持在每日6小时左右。我感甚奇,先生告我清末名医范文虎的医辑中则

有用血腑逐瘀汤治顽固失眠案，非其首用也，使我深感读书对临证之重要。先生对待病人，无论贵贱，一视同仁，尽心诊治，有时出诊达十数公里之遥，亦从不计较报酬，其医德之高尚，可窥一斑。

中医学的发扬光大，关键是人才的培养，这也是先生毕生的追求。他不仅自己酷爱中医事业，为之辛勤耕耘，呕心沥血，而且对热爱中医、追求理想的年轻学生，他总是竭力相助。安徽省中医药学校是一所中专学校，主要是培养面向基层的普及型人才，在众多毕业生中，不乏求学上进的年轻人，自 80 年代中期至 90 年代中期，该校毕业生中有 60 余人考取研究生（其中博士生近 10 名），这些人中不少曾受到他的热心帮助：或解学业之疑，或指点考试门径，或引荐研究生导师，或推荐论文发表，或赠送书籍和资料，甚则解决生活困难等。湖南中医学院的毛以林博士、苏州医学院的俞能宝博士、浙江中医学院的解光尧硕士、辽宁中医学院的李开屏硕士、解放军 301 医院的黄国峰硕士……，当他们谈起自己的成长历程时，无一能忘怀马老师当年无私的帮助。我本人即是当年受益者之一，直至目前仍经常得到先生在学习、生活上给予的帮助。

先生对特困生常慷慨解囊，对工作无着落的学生，还四处奔波为他们联系单位。1997 年盛夏，为一特困特优生的分配，他两次陪其去市委书记家，并又找了八位处级领导，在副校长马波及学校与社会不少热心人关怀、帮助下，使其终于被安排在一医院工作，当别人赞扬他“爱生如子”时，他只是淡淡的说：“不愿看到中医事业后继乏人”，这就是先生作为一个平凡的中医教师的博大胸怀！

对于学生取得成果或事业上的成功，先生均由衷地感到高

兴，他常引用韩愈“弟子不必不如师，师不必贤于弟子，闻道有先后，术业有专攻，如是而已”这句名言来勉励学生，表现出了先生朴实无华和容纳百川的高尚的情操。他还常将成功的例子反复在课堂上进行举证，激发年轻学生的上进心，在他的鼓励下，很多学生在校时即着手准备报考大专院校或研究生。正是先生和该校诸多老师的正确引导和不懈努力，安徽省中医药学校的毕业生中涌现出了一大批热衷中医药事业的年轻学者，遍及大江南北，为该省中医药事业的发展做出了贡献。现该校已成为国家重点中专和省文明单位。

发展中医事业，除了人才的培养外，尚需社会各界的关注和支持，先生系中国农工民主党党员，又是芜湖市连续四届的政协委员和市少数民族知识分子联谊会副会长，社会活动很多，他总是利用一切机会，为中医事业的发展而奔走呼号。在担任芜湖市中医学会副秘书长期间，先生积极组织学术活动，促进了芜湖市中医学术的繁荣。

我与先生交往久矣，先生不嫌我出身农家，视我如子，在学业上给予了极大的帮助和鼓励，使我顺利地考取硕士、博士。在我成长的道路上，先生的教诲和帮助令我受益无穷。饮水思源，师恩难忘！

今先生将数十年的经验，汇成《闻过喜医辑》，内容涉及经典著作研究、前贤学术评析、名医经验精华与先生与其他作者的临证经验及学术探讨等。篇秩虽不宏伟，但是书或论某病之诊治，阐前人之未发，如《论肝咳》；或论某方之运用，述己之所得，如《新制八白汤的运用摭拾》；或论某药之功效，以广其用，如《大黄在中医五官科疾病中的应用》；或论某家之经验，以启迪后学，如《程钟龄治痰探析》等，均有一定实用价值，绝非泛泛空谈之文。

尤值一提的是，书中还将他行医过程中的疏漏、差错和感慨如实载录，这与当今社会一些刻意包装自己的“医生”们形成了鲜明的对比。书名《闻过喜医辑》，其内涵实可鉴也。想是书之蕴，非止学术，更有益夫生民。

陶夏平

2000年6月20日

写于南京中医药大学陋庐

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名=闻过喜医辑

作者=马继松 彭绍荣 刘燕玲 马璇卿
田爱华等著

页数= 3 1 0

S S 号= 1 1 2 8 0 0 9 9

出版日期= 2 0 0 0 年 0 9 月第 1 版